Dicen que los usaron

DR. ENZO PASCIUTI

Dicen que los usaron

La psicología oculta de la colaboración con los alineadores y los protocolos clínicos que hacen funcionar el tratamiento

ENZO PASCIUTI ACADEMY

© 2026 Enzo Pasciuti
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede reproducirse sin la autorización por escrito del autor.

Primera edición.

Índice

	Introducción: Por qué he escrito este libro	**1**
1	**El día en que comprendí que no bastaba con saber mover los dientes**	**3**
	Empecemos por el principio	4
	En busca de la respuesta	5
	El problema tenía que ser yo	6
	La respuesta estaba delante de mí	8
	Empezar a fijarme en las personas	10
2	**Entender a quién tenemos delante**	**13**
	El paciente Dominante	15
	El paciente Influyente	17
	El paciente Estable	18
	El paciente Concienzudo	19
	Un mapa, no una etiqueta	20
3	**¿Miente el paciente?**	**23**
	La memoria reconstructiva	25
	La disonancia cognitiva	25
	La deseabilidad social	26
	El sesgo de autoservicio	27
	El sesgo de confirmación	27
	El optimismo irrealista y el descuento temporal	28
	Entonces, ¿el paciente miente?	29
4	**El coste invisible de la falta de colaboración**	**33**
	¿Cuánto colaboran realmente nuestros pacientes?	34
	No todos los refinamientos son iguales	37
	El verdadero precio de la falta de colaboración	40

5 **Introducción a los protocolos** 43
Antes de los protocolos: planificar la colaboración 44
Las tres palancas de la colaboración 46
La estructura fundamental del protocolo 47
1. Reducir la actitud defensiva 48
2. Proteger la imagen sin mantener el comportamiento 50
3. Hacer concretas las consecuencias 51
4. Reducir la ambigüedad del comportamiento futuro 54
5. Facilitar el comportamiento y comprobar su efecto 56
Responsabilidad compartida, funciones distintas 57
Un protocolo debe ser de toda la clínica 58
De los principios a las estrategias 59

6 **El paciente que no usa los alineadores** 63
El comportamiento que debemos cambiar 65
El error que cometía: intentar convencer al paciente 65
La paciente a la que no creía 66
Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todos los pacientes 67
No tengo que demostrar que el paciente miente 70
En esta fase, la palanca más poderosa es el Tiempo 72
Una estrategia que funciona en ambos casos 73
La confesión no mueve los dientes 73

7 **El paciente que lleva los alineadores, pero no los elásticos** 81
Cuando los alineadores funcionan y los elásticos no 82
Los elásticos funcionan si se usan según la pauta prescrita 85
Antes de intentar motivar al paciente, procuro entender por qué no los usa 87
El paciente ve los dientes rectos, no ve la clase II 88

8 **El refinamiento fisiológico** 97
El 80 % 100
La paradoja del refinamiento 101

9 **Las consecuencias contraproducentes del refinamiento** 111
El caso de Alessandro 112
Cuando una segunda oportunidad se convierte en una regla 113
Del relato del paciente a un resultado verificable 116

10 **El paciente que desaparece** 125
El equívoco de los cinco años 127
Cuando vuelve, aún no sabemos si está continuando 128
Hay que avisar al paciente mientras va desapareciendo 130
Cuando el paciente reaparece 131

11 **El paciente que nunca está satisfecho** 137
Cuando mejorar no basta 138
Cuando cambia el punto de referencia 139
Cuando las explicaciones no bastan 143

12 **El paciente del 95 %** 151
Definir el objetivo antes de empezar 153
Preservar el 95 % 158

13 **Cuando terminar no significa haber acabado** 165
Nueve meses que antes no existían 167

14 **La entrega de los retenedores** 177
Diez horas, todas las noches 179
Cuando una férula de retención se pierde o se rompe 182

15 **Una cita virtual a la semana** 189
Reconstruir el momento en que se perdió el tracking 191
El protocolo durante la fase activa 195
El seguimiento durante la retención 196

16 **Cuando hay que terminar de verdad** 203

17 **El coste que aún no habíamos contado** 213
Por eso existen los protocolos de este libro 217

INTRODUCCIÓN

Por qué he escrito este libro

Hay un momento, durante un tratamiento con alineadores, en el que nos damos cuenta de que el problema no está en el movimiento planificado. El paciente no lleva los alineadores el tiempo acordado, deja de usar los elásticos o interrumpe la retención. Podemos explicarle una vez más lo que debería hacer. Pero si esa explicación no ha funcionado hasta ahora, ¿por qué iba a funcionar precisamente hoy?

He escrito este libro para responder a una pregunta que me acompaña desde hace años: **¿qué puedo hacer, en la práctica, cuando un paciente no colabora?** Quería ir más allá de constatar el problema y encontrar una manera de abordarlo durante la consulta, cuando tengo al paciente delante y debo decidir qué palabras usar y qué paso proponerle.

Durante un tiempo pensé que las dificultades con las que me encontraba se debían sobre todo a mí. Quizá no sabía comunicarme de la manera adecuada. En Italia, al menos en las conversaciones con otros ortodoncistas en las que participaba, se hablaba mucho de movimientos, protocolos y resultados clínicos, pero poco de qué decir cuando el paciente no colaboraba.

Después descubrí *Aligner Insider*, el grupo de Facebook de Barry Glaser. Al leer sus publicaciones, las de Adam Goodman y los debates entre colegas con mucha más experiencia que yo, me di cuenta de que ellos también se enfrentaban a los mismos problemas. Muchos trabajaban en Estados Unidos, donde se presta mucha atención a la comunicación con el paciente. Y, aun así, buscaban, igual que yo, mejores palabras y estrategias. En fin, *en todas partes cuecen habas*. Aquel descubrimiento hizo que me sintiera menos solo y me animó a compartir lo que, a lo largo de los años, había funcionado en mi consulta.

Los guiones que se presentan en este libro nacen de dieciocho años de experiencia con los alineadores. No son frases inventadas sobre el papel. Son el resultado de conversaciones reales, intentos que salieron bien e intentos que salieron mal. Con el tiempo he cambiado las preguntas, las explicaciones y la forma de presentar las consecuencias de una decisión, tratando de entender qué ayudaba de verdad a un paciente a volver a colaborar.

También me di cuenta de que muchas de aquellas conversaciones se repetían. Cambiaban los pacientes y sus explicaciones, pero a menudo me encontraba ante los mismos problemas y tenía que decidir de nuevo cómo abordarlos. Así que empecé a ordenar las respuestas que habían funcionado, intentando entender no solo qué palabras utilizar, sino también cuándo decirlas, qué comprobar y cómo actuar en la siguiente revisión. Así fue como los guiones pasaron a formar parte de protocolos: pautas que nos ayudan a mi equipo y a mí a mantener un rumbo común. No eliminan la necesidad de valorar cada caso por separado, pero nos permiten abordarlo con un punto de partida más claro y dejando menos decisiones en manos del cansancio o de las prisas del día a día.

En estas páginas se incluyen también algunos recursos de comunicación. A veces uso lo que, con toda sinceridad, llamaría una *mentira piadosa*: un motivo sencillo, capaz de apelar a lo que importa a ese paciente, aunque no sea una explicación científica del problema. He optado por decirlo abiertamente porque no quiero que esas frases se confundan con evidencias clínicas. Nunca deben servir para ocultar un riesgo, alterar un diagnóstico o impedir que el paciente tome una decisión informada. Su propósito es ayudarle a hacer algo útil que ya sabe que debe hacer, pero que le cuesta mantener en el tiempo.

Ningún guion funciona siempre con todo el mundo, y ninguno garantiza la colaboración al cien por cien. Las estrategias propuestas deben elegirse y adaptarse al contexto social y cultural en el que trabajamos. No hace falta utilizarlas todas ni repetirlas palabra por palabra: pueden darnos una idea para abordar una situación que, hasta ese momento, no hemos conseguido desbloquear.

Me gustaría que este libro fuera una herramienta que tener a mano en la práctica diaria: una colección de ideas entre las que elegir, que adaptar y poner a prueba. **El objetivo es salir de la consulta con una posibilidad más de ayudar al paciente a colaborar y llevar el tratamiento a una conclusión consensuada.**

CAPÍTULO

1

El día en que comprendí que no bastaba con saber mover los dientes

«El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en mirar con nuevos ojos».

— MARCEL PROUST

Si has decidido leer este libro, probablemente ya utilizas alineadores transparentes o te estás planteando seriamente incorporarlos a tu práctica clínica. En cualquiera de los dos casos, antes de contarte mi historia, me gustaría hacerte una pregunta.

¿Te ha pasado alguna vez que, al volver a casa después de un día de trabajo, no podías dejar de darle vueltas a un caso?

Quizá era un tratamiento que habías planificado con muchísimo cuidado. Habías dedicado horas a diseñarlo, revisado cada detalle, modificado el setup varias veces y, cuando por fin habías pulsado el botón de aprobación, estabas convencido de que

habías hecho un trabajo excelente. Luego el paciente vuelve al cabo de unos meses, le preguntas cómo va todo y te responde con esa frase que todo ortodoncista oye al menos una decena de veces al día:

«Muy bien, doctor».

Le invitas a sentarse en el sillón, empiezas la revisión y en cuestión de segundos comprendes que algo no cuadra. Yo también he tenido esa sensación muchas veces. Durante años, sin embargo, ante situaciones como esa, mi reacción fue siempre la misma: buscar una explicación técnica. Pensaba que había cometido un error en la planificación, que había subestimado un movimiento, elegido un atache poco eficaz o planteado una biomecánica no lo bastante refinada. Estaba convencido de que, si seguía estudiando, encontraría la respuesta.

No sabía que la pregunta adecuada era otra.

Empecemos por el principio

Cuando pienso en el joven que era hace más de veinte años, me doy cuenta de que tenía una convicción tan sencilla como tranquilizadora: para llegar a ser un buen ortodoncista bastaba con seguir aprendiendo. No era una idea ingenua ni superficial; al contrario, era el motor de todo lo que hacía. Me daba una extraordinaria sensación de control, porque significaba que mi futuro dependía casi exclusivamente del esfuerzo que estuviera dispuesto a dedicar a mi formación.

Si algo no funcionaba como había previsto, la explicación me parecía siempre la misma: aún no había adquirido todos los conocimientos necesarios. Si me encontraba con una dificultad, significaba que había un libro que todavía no había leído, un congreso al que no había asistido o un colega del que aún podía aprender algo. Incluso cuando veía que otros obtenían mejores resultados que yo, me convencía de que simplemente habían descubierto algo que yo todavía desconocía y que, tarde o temprano, también llegaría a comprenderlo.

Al pensarlo hoy, me doy cuenta de que esa convicción me ha acompañado durante buena parte de mi carrera y, en el fondo, sigue acompañándome. De hecho, creo que dedicar tiempo al estudio es una de las mayores muestras de respeto que un ortodoncista puede tener hacia sus pacientes. Lo que ha cambiado con el tiempo no es el valor que doy a la formación, sino el propio significado de la palabra aprender. Al principio estaba convencido de que aprender significaba acumular conocimientos técnicos; tardaría muchos años en comprender que existía otro tipo de aprendizaje, quizá aún más importante, del que nadie me había hablado nunca.

Cuando daba mis primeros pasos en la profesión, la ortodoncia estaba experimentando una profunda transformación. Entre todas las novedades de aquellos años, hubo una que captó por completo mi atención: los alineadores transparentes. Algunos los miraban con curiosidad, otros con muchísima desconfianza y otros los consideraban poco más que una alternativa estética al social-six con brackets. Yo, en cambio, tuve desde el primer momento la sensación de que estaba ocurriendo algo mucho más importante. Por primera vez no cambiaba solo una herramienta terapéutica: cambiaba la propia manera de razonar del ortodoncista.

Con la ortodoncia fija era posible corregir el rumbo continuamente durante el tratamiento; con los alineadores, en cambio, había que imaginar el resultado antes incluso de empezar. Era un cambio radical de perspectiva, que obligaba a planificar el futuro en lugar de limitarse a gestionar el presente, y probablemente fue ese reto intelectual lo que hizo que me apasionaran desde el primer momento.

En el fondo, siempre me han atraído las cosas difíciles. No porque me gustara complicarme la vida, sino porque cada vez que me encontraba con algo que parecía imposible, me surgía espontáneamente la misma pregunta: «*¿Cómo puedo hacer que funcione?*»

En busca de la respuesta

Fue precisamente esa curiosidad la que me llevó a sumergirme de lleno en el mundo de los alineadores. Acababa subrayando todos los artículos científicos, leía todos los libros con el lápiz en la mano y cada congreso se convertía en una oportunidad que no podía dejar pasar. Si oía hablar de un colega que había desarrollado una biomecánica interesante o de un ponente capaz de abordar un problema desde otra perspectiva, enseguida empezaba a informarme, estuviera donde estuviera. Con los años he recorrido buena parte del mundo con esa actitud. No me interesaba coleccionar diplomas para colgarlos en la pared: quería volver a casa con al menos una idea que, el lunes por la mañana, pudiera mejorar aunque solo fuera un tratamiento respecto a cómo lo habría hecho el viernes anterior.

Cada viaje suponía una inversión de tiempo, energía y dinero. Significaba dejar la consulta, reorganizar el trabajo, renunciar a pasar tiempo con la familia, pasar horas en los aeropuertos, afrontar vuelos interminables y, a menudo, volver el domingo por la noche para estar de nuevo en la consulta el lunes por la mañana. Y, sin embargo, nunca viví todo aquello como un sacrificio. Era simplemente el precio que pagaba encantado por seguir creciendo.

En mi interior estaba convencido de que, si seguía reuniendo todos aquellos fragmentos de experiencia, tarde o temprano conseguiría completar el puzle. De verdad pensaba que en algún lugar existía una fórmula capaz de hacer que todos los tratamientos fueran perfectamente predecibles y que mi tarea consistía, sencillamente, en encontrarla.

Después empecé a vivir algo que creo que comparten todas las personas sinceramente apasionadas por su trabajo: cuanto más aprendía, más preguntas me hacía. Cada respuesta abría inevitablemente una nueva pregunta, cada certeza quedaba en entredicho con el siguiente paciente y, cada vez que creía haber comprendido por fin un tema a fondo, llegaba un caso que me obligaba a replanteármelo todo.

Por supuesto, entonces no vivía todo aquello con la serenidad con la que lo vivo hoy. Cada vez que un tratamiento tomaba un rumbo distinto del que había imaginado, mi reacción era casi automática: estaba convencido de que el error era mío. Si el resultado no coincidía con lo que había planificado, significaba que aún me faltaba alguna competencia. En mi cabeza, la solución era siempre la misma: estudiar más, hacer otro curso, leer otro libro, subirme a otro avión para escuchar a alguien que quizá ya había encontrado la respuesta que yo seguía buscando.

Aquella convicción me había permitido crecer, pero también escondía una pequeña trampa: pensaba que todos los problemas tenían necesariamente una solución técnica. Sin darme cuenta, buscaba respuestas biomecánicas incluso a preguntas que pertenecían a un mundo completamente distinto.

El problema tenía que ser yo

Mientras tanto, mi actividad crecía, los casos eran cada vez más numerosos y complejos y empezaron a llegar las primeras invitaciones para hablar en congresos. Me encantaba enseñar, porque preparar una clase me obligaba a ordenar mis ideas y a comprender aún mejor lo que hacía. Sin embargo, justo cuando desde fuera mi carrera parecía darme cada vez más motivos para confiar en mí mismo, por dentro seguía teniendo una sensación difícil de explicar.

La primera vez que alguien le puso nombre, no estaba en una consulta médica, en un congreso ni en una sesión con un psicólogo. Estaba en mi casa, cenando con dos amigos.

Alice y Federico son los fundadores de Geldis, una empresa nacida de una idea muy cercana a mi mundo: crear un gel específico para la limpieza diaria de los alineadores. Con el tiempo, sin embargo, nuestra relación había ido mucho más allá del trabajo y nos habíamos hecho amigos.

No recuerdo exactamente cómo empezó la conversación. Probablemente hablábamos de trabajo, de cursos o de alguno de los muchos congresos en los que participaba como ponente. En un momento dado les conté algo que, hasta entonces, siempre había considerado una rareza de mi carácter.

Les expliqué que, pese a mis años de experiencia, seguía sin sentirme del todo cómodo cuando subía a un escenario. No era miedo a hablar en público ni tampoco inseguridad respecto a los contenidos: preparaba cada ponencia con una atención casi obsesiva y conocía a fondo los temas que trataba. Era algo distinto.

Podía tener delante a mil o dos mil personas que habían venido a escucharme, colegas que habían pagado un curso, hecho un viaje y dedicado un día de su vida a aprender algo de mí. Durante las pausas me paraban, me hacían preguntas y me contaban hasta qué punto alguna indicación mía había cambiado su forma de planificar los tratamientos. Y, sin embargo, una parte de mí seguía preguntándose si de verdad merecía estar allí. Cuando terminé de contárselo, Alice me miró como si la explicación fuera evidente.

«Enzo, tú tienes el síndrome del impostor».

Aquellas palabras me impactaron porque siempre había pensado que un impostor era alguien que engaña deliberadamente a los demás, se atribuye competencias que no tiene u ocupa un lugar que no le corresponde. Yo no intentaba engañar a nadie. Estudiaba, trabajaba y preparaba cada intervención con un cuidado casi maniático. Pero Alice no estaba diciendo que yo fuera un impostor. Estaba diciendo que, pese a todas las pruebas en contra, una parte de mí seguía temiendo serlo.

En los días siguientes empecé a informarme. Descubrí que las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes habían descrito el fenómeno a finales de los años setenta en mujeres brillantes, bien preparadas y reconocidas profesionalmente que, pese a sus logros, tenían dificultades para atribuirlos a sus propias capacidades. Podían atribuir sus éxitos a la suerte, a que el momento había sido propicio, a la ayuda recibida o al esfuerzo extraordinario que habían hecho para compensar supuestas carencias, mientras que las dificultades adquirían un peso desproporcionado y parecían confirmar de inmediato la falta de capacidad que temían tener.

Reconocí enseguida aquel mecanismo. Una invitación a un congreso podía deberse a mi relación con una empresa; que una ponencia saliera bien, a la preparación casi maniática que le había dedicado; los elogios de mis colegas, a su generosidad. Siempre encontraba una explicación que restaba importancia a mis logros. Una dificultad clínica, en cambio, no necesitaba interpretaciones: en mi cabeza, la culpa era mía.

Hoy la literatura prefiere hablar del fenómeno del impostor, porque no se trata de una enfermedad ni de un diagnóstico psiquiátrico, sino de una forma recurrente de interpretarse a uno mismo. También se ha observado entre médicos, dentistas y otros profesionales sanitarios, ámbitos en los que los altos estándares y las responsabilidades concretas hacen indispensable cuestionarse continuamente.

Aquella predisposición también había tenido un lado positivo. Me había impulsado a estudiar, viajar, intercambiar ideas con profesionales más experimentados y no conformarme con las primeras respuestas. El problema aparecía cuando la autocrítica dejaba de ayudarme a entender una dificultad y se convertía en un juicio sobre mi identidad profesional.

Hay una diferencia enorme entre preguntarse por qué no se ha producido un movimiento y preguntarse si de verdad somos capaces de utilizar los alineadores. La primera es una pregunta clínica: permite recabar información, examinar las causas y corregir el rumbo. La segunda convierte un episodio concreto en una sentencia sobre toda la valía del profesional.

Fue entonces cuando comprendí hasta qué punto aquella sensación había condicionado también mi trabajo en la consulta. Cuando un tratamiento no avanzaba según lo previsto, centraba casi toda mi atención en lo que podía controlar directamente: mi trabajo. Lo que contaba el paciente quedaba en segundo plano, como un dato que daba por bueno, y, si me decía que había seguido todas las indicaciones, la conclusión parecía inevitable: el error era mío.

Era como evaluar la eficacia de un medicamento sin saber si el paciente lo había tomado. En el día a día, corría el riesgo de cambiar el tratamiento antes de haber comprobado esa premisa.

La respuesta estaba delante de mí

Fue precisamente esa idea la que me llevó a observar con más atención algunos casos que seguían sin cuadrarme. Cuanta más experiencia adquiría, más me daba cuenta de que los tratamientos que no lograba explicarme casi nunca eran los más complejos. A veces trataba maloclusiones extremadamente difíciles que evolucionaban exactamente como había planificado, mientras que tratamientos aparentemente sencillos parecían atascarse sin una explicación lógica.

Al principio lo descarté todo como una serie de coincidencias. Después empecé a prestar más atención y, casi sin darme cuenta, comencé a mirar hacia otra parte. Durante años había observado casi exclusivamente los dientes, los escaneos, los ataches, la biomecánica y los movimientos programados. Toda mi atención se cen-

traba ahí, porque estaba convencido de que ahí se escondían todas las respuestas. Comprendí, en cambio, que la variable que llevaba tanto tiempo buscando no estaba en la pantalla de la computadora; estaba sentada en el sillón, justo delante de mí.

No eran los dientes. Eran las personas.

Recuerdo perfectamente una mañana en la que tenía programadas dos revisiones seguidas. Eran dos chicos casi de la misma edad, con una maloclusión muy similar, un plan de tratamiento casi idéntico y el mismo tiempo transcurrido desde la última visita. Desde el punto de vista clínico, parecían dos casos calcados.

Entró el primero. Me saludó con entusiasmo y, antes incluso de que le preguntara cómo iba todo, sacó del bolsillo una bolsita de elásticos.

«Doc, creo que he gastado más de los previstos. ¿Me puede dar algún paquete más?»

Lo examiné y encontré exactamente lo que esperaba ver. El tratamiento avanzaba según lo previsto. Pocos minutos después entró el segundo chico. También era educado y también sonreía. A la misma pregunta respondió con la misma seguridad:

«Todo muy bien. Uso siempre los elásticos».

Lo examiné y me bastaron unos segundos para ver que el tratamiento no avanzaba como esperaba. Eso, por supuesto, no demostraba que no estuviera usando los elásticos: podía haber varias explicaciones. Hasta entonces, sin embargo, mi mente habría empezado automáticamente a buscar una causa biomecánica. Aquella vez me sorprendí haciéndome otra pregunta: ¿y si el problema no estuviera en la planificación del tratamiento?

No busqué una respuesta de inmediato. Simplemente seguí observando y, en los meses siguientes, empecé a reconocer situaciones similares con una frecuencia sorprendente. Cambiaban las caras, las edades y las maloclusiones, pero ciertas actitudes parecían repetirse. Había pacientes extremadamente meticulosos y otros incapaces de recordar una indicación que habían recibido poco antes; personas que hacían preguntas hasta entender exactamente qué debían hacer y otras que asentían durante la visita, pero volvían a la siguiente revisión sin haber seguido las indicaciones; padres que convertían el tratamiento de su hijo en un proyecto compartido y otros que, después de la primera cita, parecían desentenderse por completo de cómo iba.

Fue entonces cuando empecé a comprender que confiar y comprobar no eran actitudes incompatibles. La relación entre el profesional sanitario y el paciente se basa necesariamente en la confianza y no podemos convertir cada cita en un interrogatorio, pero comprobar no significa acusar. Una decisión clínica rigurosa no

puede depender únicamente de una información que no hemos tenido ocasión de verificar.

Así, pequeños episodios empezaron a adquirir otro significado: un alineador que esperaba que el paciente llevara semanas utilizando y que parecía nuevo, un paquete de elásticos todavía sin abrir, un paciente que no recordaba qué alineador estaba usando o que acudía a la revisión sin llevarlo consigo. Ninguno de aquellos detalles bastaba, por sí solo, para determinar hasta qué punto el paciente había seguido las indicaciones, pero, vistos en conjunto, me obligaron a preguntarme cuántas veces había buscado una solución biomecánica a un problema de comportamiento.

Empezar a fijarme en las personas

A partir de aquel momento empecé a mirar a los pacientes con otros ojos. Por supuesto, seguía analizando fotografías, escaneos, relaciones oclusales y movimientos programados, pero cada vez dedicaba más atención a otra cosa.

Me di cuenta de que personas a las que daba exactamente las mismas indicaciones reaccionaban de formas completamente distintas. Algunas querían conocer todos los detalles; a otras parecían molestarles las explicaciones demasiado largas. Algunas necesitaban que las tranquilizara; otras querían saber, sobre todo, cuánto tiempo haría falta y qué pasaría si algo no funcionaba. Había quien seguía las indicaciones con una precisión casi maniática y quien, pese a haberlas entendido perfectamente, las adaptaba a su vida hasta convertirlas en algo muy distinto de lo que yo había prescrito.

Durante los años de universidad y de especialización había estudiado anatomía, biomecánica, crecimiento craneofacial, diagnóstico, cefalometría, materiales y planificación. Había aprendido a medir ángulos con una precisión casi maniática y a discutir durante horas sobre la inclinación de una raíz o la programación de un desplazamiento de unas décimas de milímetro. Pero nadie me había enseñado a reconocer al paciente que asentiría durante toda la visita para después seguir solo la mitad de las indicaciones recibidas, ni a entender por qué dos personas a las que había explicado exactamente lo mismo podían comportarse de formas completamente distintas.

Era como si toda nuestra formación terminara justo en la puerta de la consulta. A partir de ahí comenzaba un terreno abandonado casi por completo a la experiencia personal, hecho de intentos, errores e intuiciones.

Fue entonces cuando empecé a sospechar algo que, en aquel momento, me pareció casi una herejía: quizá la predictibilidad de un tratamiento no depende solo

de la calidad de su planificación. Quizá exista una variable que ningún programa informático puede calcular, que no aparece en una cefalometría, no se mide con un calibre y no puede planificarse delante de una pantalla y que, sin embargo, está presente en todos y cada uno de los tratamientos que abordamos.

Aquella variable se sentaba cada día delante de mí. Tenía un rostro, una historia, un carácter, unas convicciones, unos miedos y una manera muy suya de interpretar lo que le sucedía. En otras palabras, tenía una mente.

Había pasado años intentando que la biomecánica de mis tratamientos fuera cada vez más predecible. Ahora empezaba a comprender que solo había visto una parte del problema. Podía planificar con extrema precisión lo que quería conseguir con los dientes, pero entre ese plan y el resultado final seguía habiendo una persona que, cada día, tendría que tomar decisiones capaces de favorecerlo, ralentizarlo o modificarlo.

Aquello no me dio respuestas de inmediato. Me dio algo más importante: un nuevo campo que explorar. Durante años, ante un tratamiento que no avanzaba, mi primera pregunta había sido «*¿En qué me he equivocado?*». Esa pregunta sigue formando parte de mi análisis, porque sería peligroso dejar de hacérmela, pero no puede ser la única y, sobre todo, no puede ir antes de otra aún más importante:

¿Qué ha pasado realmente?

Solo después de reconstruir lo sucedido podemos determinar qué parte de la responsabilidad corresponde a la planificación, cuál a la biología y cuál, en su caso, al comportamiento del paciente.

Había pasado años estudiando el movimiento de los dientes. Ahora había comprendido por fin que, para entender de verdad lo que ocurre durante un tratamiento, también tendría que empezar a estudiar a las personas que lo viven día tras día.

Y era un mundo mucho más complejo de lo que imaginaba.

BIBLIOGRAFÍA

Clance PR, Imes SA. *The imposter phenomenon in high achieving women: dynamics and therapeutic intervention.* Psychotherapy. 1978;15(3):241-247.

Gottlieb M, Chung A, Battaglioli N, Sebok-Syer SS, Kalantari A. *Impostor syndrome among physicians and physicians in training: a scoping review.* Med Educ. 2020;54(2):116-124.

Bravata DM, Watts SA, Keefer AL, Madhusudhan DK, Taylor KT, Clark DM, Nelson RS, Cokley KO, Hagg HK. *Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: a systematic review.* J Gen Intern Med. 2020;35(4):1252-1275.

CAPÍTULO

2

Entender a quién tenemos delante

«Cuando tratamos con personas, recordemos que no tratamos con criaturas lógicas, sino con criaturas emocionales».

— DALE CARNEGIE

Estaba acostumbrado a hablar con pacientes muy distintos utilizando casi siempre las mismas palabras. Explicaba el tratamiento, exponía los objetivos y daba indicaciones precisas. Si lo habían entendido, consideraba que mi tarea había terminado.

Con el tiempo he comprendido que entender una información no significa darle el mismo valor. Si personas distintas escuchan, deciden y reaccionan de maneras distintas, ¿por qué iban a colaborar todas de la misma manera?

Algunos pacientes desean conocer todos los detalles, mientras que otros se sienten abrumados cuando reciben demasiada información. Hay quien toma una decisión rápidamente y quien, antes de elegir, necesita tiempo, que lo tranquilicen

y que le confirmen las cosas. Algunas personas quieren saber, sobre todo, cuánto durará el tratamiento; otras piden ver fotografías, simulaciones y radiografías; otras parecen interesadas, sobre todo, en cómo encajará ese tratamiento en su vida cotidiana.

Por tanto, la comunicación eficaz no consiste solo en saber qué decir. Consiste también en entender cómo decírselo a la persona que tenemos delante.

Con el tiempo, psicólogos, investigadores del comportamiento, expertos en gestión y formadores han desarrollado numerosos modelos para describir estas diferencias. Algunos surgieron de la investigación científica sobre la personalidad; otros se crearon como herramientas prácticas para mejorar el liderazgo, el trabajo en equipo, las ventas o la gestión de las relaciones.

Ninguno de estos modelos puede abarcar por completo la complejidad del ser humano. Somos el resultado de nuestra historia, de la educación que hemos recibido, de las experiencias que hemos vivido, del contexto en el que nos encontramos, de las emociones del momento y de las personas con las que interactuamos. Una misma persona puede comportarse de maneras muy distintas en el trabajo, en casa, durante una negociación económica o sentada en el sillón de una consulta dental.

Por tanto, sería simplista pretender encasillar a todos los seres humanos en categorías rígidas. Y, sin embargo, precisamente esa capacidad de simplificar es también el punto fuerte de algunos modelos de comportamiento. No sirven para determinar cómo es realmente una persona ni para formular un diagnóstico psicológico, pero pueden ayudarnos a reconocer ciertas tendencias predominantes y a elegir con más rapidez el lenguaje, el ritmo y la cantidad de información más adecuados para nuestro interlocutor.

Entre estos modelos, uno de los más conocidos y utilizados es el DISC.

Sus orígenes suelen atribuirse al psicólogo estadounidense William Moulton Marston, que en 1928 publicó *Emotions of Normal People*, un libro en el que analizaba las formas en que las personas reaccionan al entorno que perciben a su alrededor.

Las personas pueden tender a responder de forma más activa o más reflexiva, orientándose principalmente hacia los resultados o hacia las relaciones y buscando, en distinta medida, control, aprobación, estabilidad o precisión. De estas tendencias se derivan cuatro estilos que hoy suelen identificarse con las letras D, I, S y C: Dominancia, Influencia, Estabilidad y Concienzudez.

El DISC se ha ido utilizando en la selección de personal, el liderazgo, la formación de equipos, las ventas y la gestión de conflictos, pero no debe considerarse una verdad absoluta sobre la personalidad humana: es, más bien, un mapa práctico de los estilos de comportamiento y comunicación.

De hecho, la psicología moderna no reconoce una clasificación universal en cuatro tipos de personalidad. El modelo que cuenta con mayor respaldo científico es el **modelo de los cinco grandes**, que describe a las personas a partir de cinco grandes dimensiones: extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo o inestabilidad emocional y apertura a la experiencia. La diferencia fundamental es que el modelo de los cinco grandes no asigna a cada persona una categoría rígida: todos poseemos esas dimensiones en distinta medida, y su combinación contribuye a configurar nuestro perfil individual.

Por tanto, el modelo de los cinco grandes tiene una base científica más sólida para describir la personalidad. El DISC, en cambio, ofrece un lenguaje más inmediato para observar cómo interactúan las personas, y eso es precisamente lo que nos interesa. Nuestro objetivo no es hacer una evaluación psicológica completa del paciente ni pasarle un cuestionario antes de cada visita de ortodoncia. Necesitamos una herramienta sencilla que nos ayude a reconocer ciertas formas de comunicarse y a adaptar nuestra conversación.

De hecho, una persona rara vez encaja por completo en uno solo de los cuatro perfiles. Lo más habitual es que presente una combinación de características, con uno o dos estilos predominantes, y su comportamiento puede cambiar según la situación. Un paciente normalmente sociable puede volverse extremadamente analítico cuando tiene que someterse a una intervención quirúrgica; una persona habitualmente prudente puede mostrarse dominante cuando cree que el tratamiento de su hijo avanza demasiado despacio; un paciente muy meticuloso puede volverse de pronto emotivo cuando se le plantea una extracción.

Nuestra tarea, por tanto, no es poner etiquetas, sino observar. ¿Qué preguntas hace? ¿Con qué rapidez quiere ir al grano? ¿Necesita sobre todo datos, que lo tranquilicen, tener el control o establecer una relación? ¿Cómo expresa sus dudas? ¿Cómo plantea una objeción? Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarnos a elegir la forma más eficaz de dialogar con él.

El paciente Dominante

El paciente Dominante se orienta hacia los resultados. Le gusta tener el control, decide rápidamente y tiende a valorar las situaciones en términos de objetivos, plazos, costes y consecuencias.

A menudo llega a la consulta con una idea bastante clara de lo que quiere. Puede haber visitado a otros profesionales, leído información de distintas fuentes o decidido de antemano qué resultado considera aceptable. No es necesariamente

agresivo, pero se comunica de forma directa y puede tener poca paciencia con las explicaciones que le parecen innecesariamente largas.

Durante la visita tiende a ir rápidamente al grano y puede hacer preguntas como: «*¿Cuánto durará?*», «*¿Cuál es el sistema más rápido?*», «*¿Podemos evitar la cirugía?*», «*¿Cuál es la mejor solución?*», «*¿Cuánto me cuesta en total?*» o «*¿Qué pasa si no conseguimos el resultado?*».

Estas preguntas pueden parecer bruscas, pero no debemos interpretarlas de inmediato como un ataque. Muy a menudo son su manera de comprobar si el profesional tiene competencia, seguridad y claridad. El Dominante no quiere solo una respuesta: quiere saber si la persona que tiene delante es capaz de dirigir el tratamiento sin vacilar.

Con este paciente conviene empezar por la conclusión y explicar después el razonamiento. En lugar de comenzar con una larga descripción de la maloclusión, podemos decir:

> «*En su caso tenemos dos opciones realistas. La primera es más sencilla, pero exige aceptar un compromiso en el resultado. La segunda requiere un tratamiento más complejo, pero nos permite corregir también el problema esquelético. Le explico brevemente las ventajas y las limitaciones de ambas*».

El Dominante valora las alternativas claras. Esto no significa dejarle elegir un tratamiento clínicamente inapropiado, sino hacerle partícipe de la decisión distinguiendo con precisión qué es posible y qué no. Siempre que podamos, conviene relacionar las indicaciones con consecuencias concretas:

> «*El tratamiento durará aproximadamente dieciocho meses, siempre que utilice los alineadores según las indicaciones. Si los utiliza menos de lo indicado, la duración aumentará y podría ser necesario volver a planificar algunas fases*».

Una formulación de este tipo suele ser más eficaz que una indicación vaga como «*debe intentar utilizarlos todo lo posible*», porque la primera vincula el comportamiento a una consecuencia, mientras que la segunda deja mucho más margen a la interpretación.

Cuando el Dominante plantea una objeción, es importante no entrar en una competición. Ante la pregunta «*¿No hay forma de hacerlo más rápido?*» una respuesta a la defensiva como «*No, porque los tiempos biológicos son los que son y tiene que confiar*» puede convertir la conversación en un enfrentamiento. En cambio, podemos responder:

> «*Podemos reducir algunos tiempos de espera organizativos, pero no podemos acortar los tiempos biológicos más allá de cierto límite sin aumentar el riesgo. En*

su caso, esta es la forma más rápida y segura. Donde más podemos influir es en la regularidad con la que utiliza los alineadores».

Así mantenemos la autoridad sin convertirla en un pulso. Por tanto, con un paciente de este tipo es preferible evitar las largas introducciones, las respuestas vagas, las promesas absolutas y los tonos paternalistas. Ser directos no significa ser fríos; significa respetar su necesidad de claridad.

El paciente Influyente

El paciente Influyente suele dar importancia a las relaciones, las emociones y la experiencia en su conjunto. Se comunica con facilidad, cuenta episodios de su vida, comparte lo que siente y tiende a establecer rápidamente una relación personal con el profesional y con el equipo.

A menudo es el paciente que entra sonriendo, habla con el personal de recepción, comenta cómo es la consulta y cuenta cómo ha llegado hasta ella. Durante la visita puede pasar rápidamente de un tema a otro y dejarse llevar por el entusiasmo.

Sus preguntas suelen referirse no solo al tratamiento, sino también a cómo encajará en su vida: «¿Se notarán mucho?», «¿Qué hago cuando salgo a cenar?», «¿Puedo hacerme fotos sin que se noten?», «¿Podré hablar con normalidad?», «¿Conocen a otras personas que los hayan utilizado sin problemas?» o «¿Cómo será mi sonrisa al final?».

El paciente Influyente puede aceptar rápidamente el plan porque se siente implicado y confía en el profesional, pero esa facilidad inicial no debe confundirse con la certeza de que haya asimilado todas las indicaciones. Una conversación agradable puede dar a ambos la sensación de que todo ha quedado perfectamente claro, mientras algunas informaciones importantes corren el riesgo de quedar en segundo plano.

Con él conviene relacionar las prescripciones con su experiencia concreta y el resultado que desea, utilizando un lenguaje sencillo, ejemplos fáciles de visualizar y objetivos reconocibles. Podemos implicarlo, mostrarle fotografías, enseñarle los progresos y aprovechar la relación personal como un recurso, sin permitir, sin embargo, que la relación sustituya a la claridad.

Si tenemos que explicarle la importancia de utilizar los alineadores con regularidad, por ejemplo, podríamos decirle:

«Lo más importante para conseguir la sonrisa que hemos planificado es mantener la constancia. Si utiliza los alineadores menos de lo necesario, los dientes pueden

empezar a quedarse atrás respecto a la secuencia y corremos el riesgo de tener que detenernos y volver a planificar una parte del tratamiento».

Con un paciente Influyente, conviene especialmente comprobar que el entusiasmo se haya traducido en una comprensión concreta. Al terminar la explicación, podemos pedirle que resuma los puntos esenciales o darle unas pocas indicaciones muy claras, sin abrumarlo con detalles que probablemente no recordará. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir una buena relación con una buena comunicación. Son dos cosas distintas.

El paciente Estable

El paciente Estable tiende a buscar seguridad, continuidad y armonía. Por lo general, no le gustan las presiones, los cambios repentinos ni las situaciones en las que siente que debe tomar una decisión demasiado rápido.

Puede ser el paciente que escucha con atención, interrumpe poco y parece extremadamente colaborador durante la visita. Suele ser amable, paciente y respetuoso con las indicaciones del profesional, pero precisamente esa buena disposición puede llevarnos a sobrevalorar hasta qué punto está realmente convencido o tranquilo con lo que le proponemos.

Si tiene una duda, quizá no plantee una objeción de inmediato. Puede asentir, dar las gracias y salir de la consulta sin haber expresado una preocupación que solo aflorará más adelante, tal vez en una llamada a recepción o al hablar con un familiar.

Con este perfil conviene reducir el ritmo de la conversación, explicarle de antemano qué va a ocurrir y reducir la incertidumbre. Una frase como:

«Hoy no tiene que decidir nada. Le explico cuáles son las opciones y los pasos del tratamiento; después se toma el tiempo que necesite para pensarlo y, si le surge alguna duda, la comentamos»,

puede ser mucho más eficaz que pedirle que tome una decisión de inmediato.

Durante el tratamiento es importante crear un espacio en el que el paciente sienta que también puede contarnos lo que no va bien. Preguntas como «¿Todo bien?» suelen propiciar una respuesta afirmativa. Puede ser más útil preguntar: «¿Qué ha sido lo más difícil de llevar esta semana?» o «¿Hay alguna indicación de las que le he dado que le haya resultado más difícil seguir?».

Así no estamos dando a entender que el paciente haya hecho algo mal, sino que normalizamos la posibilidad de que se haya encontrado con alguna dificultad.

Con el paciente Estable, tranquilizarlo no debe llevarnos a restar importancia a las cosas. Si una determinada condición es indispensable para el tratamiento,

debemos comunicárselo con claridad, pero sin crear una presión innecesaria. La estabilidad no significa ausencia de normas; significa hacer que esas normas sean comprensibles y previsibles.

El paciente Concienzudo

El paciente Concienzudo tiende a buscar precisión, lógica y coherencia. Quiere entender el porqué de las decisiones y puede hacer preguntas muy detalladas antes de sentirse lo bastante seguro.

Suele ser el paciente que llega a la primera visita después de haber leído mucho, trae radiografías o documentación previa, compara la información que recibe y quiere saber no solo qué vamos a hacer, sino por qué hemos elegido precisamente esa opción.

Sus preguntas pueden ser extremadamente concretas: «¿Hasta qué punto es predecible este movimiento?», «¿Por qué utiliza este atache?», «¿Qué probabilidad hay de que haga falta un refinamiento?», «¿Cómo podemos saber si el diente seguirá exactamente la simulación?».

Ante estas preguntas es natural sentirse puesto a prueba, pero a menudo no es esa su intención. El paciente Concienzudo utiliza la información para reducir la incertidumbre. Cuanta más vaguedad perciba, más preguntas hará.

Por tanto, con él conviene hacer visible el razonamiento clínico y distinguir con claridad lo que sabemos de lo que no podemos predecir con certeza:

> *«Estos son los movimientos más predecibles, mientras que en estos dientes hay más posibilidades de que tengamos que hacer un refinamiento. Por eso controlaremos algunos parámetros concretos durante el tratamiento».*

Una respuesta así puede tranquilizarlo más que una promesa absoluta, porque no pretende eliminar artificialmente la incertidumbre, sino que muestra que sabemos dónde puede surgir y cómo pensamos gestionarla. Si pregunta:

> *«¿Cómo puede garantizarme que el resultado será exactamente el de la simulación?»*

una respuesta comercial sería: *«No se preocupe, quedará exactamente así»*. Una respuesta más correcta y, probablemente, más eficaz podría ser:

> *«La simulación representa el resultado planificado, no una garantía matemática. La biología y la colaboración pueden modificar la respuesta. Nuestra tarea es supervisar la evolución e intervenir cuando el movimiento real se aparte del planificado».*

Con el paciente Concienzudo, ser sinceros sobre las limitaciones aumenta nuestra credibilidad. Si no sabemos responder a una pregunta muy concreta, es mejor reconocerlo y comprobar la respuesta que improvisar. Por tanto, debemos evitar las respuestas imprecisas, las promesas absolutas, los datos que no podamos verificar y mostrar irritación ante sus preguntas. La precisión al comunicarnos es especialmente importante porque este paciente tiende a recordar lo que se le ha dicho y a compararlo con lo que ocurre después.

Un mapa, no una etiqueta

Llegados a este punto, podría parecer que basta con observar a un paciente durante unos minutos, asignarle una letra y aplicar automáticamente una forma de comunicarnos, pero no es así.

El DISC no debería convertirse en una nueva forma de estereotipar. El paciente que hace muchas preguntas no es necesariamente Concienzudo: puede que simplemente tenga miedo. Quien quiere decidir rápidamente no siempre es Dominante: puede que tenga poco tiempo o que ya haya consultado a otros profesionales. La persona que habla mucho no es necesariamente Influyente y quien permanece en silencio no pertenece automáticamente al perfil Estable.

Los cuatro estilos deben utilizarse como hipótesis de trabajo, no como diagnósticos. Podemos empezar la conversación de una manera y cambiarla según la respuesta del paciente. Si le ofrecemos un resumen y sigue pidiendo detalles, probablemente quiera una explicación más a fondo; si empezamos con una explicación larga y notamos impaciencia, quizá debamos llegar antes a las conclusiones.

La comunicación eficaz no es, por tanto, un guion inmutable, sino una adaptación continua: el DISC me había enseñado a explicar el mismo concepto de distintas maneras, pero también me había mostrado sus límites. El estilo comunicativo de una persona no permite predecir si colaborará. Un paciente Dominante puede seguir las indicaciones rigurosamente u oponerse a las normas; uno Concienzudo puede ser impecable o utilizar cada detalle para eludir su responsabilidad.

Por eso, en las páginas siguientes, el DISC seguirá acompañándonos, pero continuará siendo lo que debe ser: un mapa de la comunicación, no una clasificación de los pacientes. Nos ayudará a elegir las palabras, el nivel de detalle y el ritmo de la conversación; el punto de partida seguirá siendo siempre el comportamiento que observamos.

Podemos aprender a comunicarnos mejor, pero ningún modelo de personalidad puede darnos certeza sobre lo que hará el paciente cuando salga de la consulta con una caja de alineadores en la mano y nosotros no estemos allí para verlo.

BIBLIOGRAFÍA

Marston WM. Emotions of Normal People. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.; 1928.
McCrae RR, John OP. An introduction to the Five-Factor Model and its applications. J Pers. 1992;60(2):175–215.
Street RL Jr, Makoul G, Arora NK, Epstein RM. How does communication heal? Pathways linking clinician-patient communication to health outcomes. Patient Educ Couns. 2009;74(3):295–301.

CAPÍTULO

3

¿Miente el paciente?

«La confianza que las personas depositan en sus creencias no mide la calidad de las pruebas, sino la coherencia de la historia construida por la mente».

— DANIEL KAHNEMAN

«Si el paciente me dice que siempre utiliza los alineadores, ¿por qué el tratamiento no avanza según lo previsto?».

Es una pregunta que me hice muchas veces durante las visitas de seguimiento. El paciente me aseguraba que había seguido las indicaciones, pero lo que observaba clínicamente contaba otra historia. Durante mucho tiempo, en estas situaciones, mi primera reacción fue buscar un error en el tratamiento. Como ya he contado, solo con los años empecé a considerar otra posibilidad: que parte de la explicación pudiera estar en el comportamiento del paciente, además de en la biomecánica.

Todavía recuerdo muy bien uno de los casos que contribuyó a cambiar mi perspectiva.

Laura tenía unos treinta años. Era abogada, madre y, en apariencia, una paciente muy meticulosa. Habíamos iniciado un tratamiento para corregir una clase II mediante distalización superior y el uso de elásticos.

Durante el tratamiento, los alineadores funcionaban bien: el apiñamiento anterior iba resolviéndose y el ajuste era excelente. La clase II, sin embargo, no mejoraba. En cada revisión le preguntaba a Laura si utilizaba los elásticos y ella me respondía: «*Sí, por supuesto. Siempre*».

Durante casi dos años no conseguimos ninguna corrección significativa de la clase II. Yo seguía buscando la explicación en el tratamiento: revisaba la biomecánica, modificaba la planificación y llegué a hacer cuatro refinamientos. Mientras tanto, los incisivos superiores seguían desplazándose hacia delante. Entonces, en una revisión, encontré por fin a Laura en clase I. Le pregunté qué había cambiado. Me contó que se casaría nueve meses después y que quería terminar el tratamiento antes de la boda. Por eso había decidido utilizar los elásticos *de verdad*. Solo entonces me explicó que hasta ese momento los había usado sobre todo por la noche y muy poco durante el día.

Para mí, aquella confesión fue más importante que la corrección de la clase II. Había buscado durante mucho tiempo una explicación biomecánica a un problema que, en gran parte, dependía del comportamiento de Laura. Ella conocía mis indicaciones y siempre me había asegurado que las seguía. Fue entonces cuando empecé a hacerme una pregunta sencilla, pero incómoda:

¿Laura me había mentido?

A primera vista, parecía que sí. Sin embargo, llamarlo mentira no me ayudaba a entender qué había pasado. ¿Por qué una paciente que conocía las indicaciones me había dado, revisión tras revisión, una respuesta tan distinta de sus hábitos reales?

Podría haber decidido no decirme la verdad. Pero también podía haber algo en su manera de recordar y contar sus hábitos que yo no había tenido en cuenta. Desde entonces empecé a preguntarme: **¿por qué lo que cuenta un paciente puede ser distinto de lo que hace?**

Si pensamos de inmediato que miente, intentaremos demostrar que no dice la verdad. Si, en cambio, tratamos de entender cómo ha llegado a darnos esa respuesta, tendremos más posibilidades de descubrir qué ocurre realmente y de ayudarlo a cambiar. En las páginas siguientes exploraremos algunos de los mecanismos que pueden crear esa distancia entre lo que hace y lo que cuenta. A menudo actúan a la vez: cada uno puede ayudar a explicar una parte de lo que observamos.

La memoria reconstructiva

Tendemos a imaginar la memoria como un gran archivo en el que los acontecimientos se guardan de forma ordenada, listos para recuperarlos cuando hace falta. Sin embargo, la investigación científica nos dice que no funciona así. Recordar no significa abrir de nuevo un cajón y sacar una copia perfecta del pasado, sino reconstruirlo combinando fragmentos de experiencias, conocimientos previos, expectativas y significados personales.

Si alguien nos preguntara cuántas horas hemos dormido cada noche durante el último mes, difícilmente sabríamos responder con precisión. Probablemente recordaríamos algunas noches concretas y, a partir de ellas, intentaríamos calcular una media.

Lo mismo puede ocurrir cuando preguntamos a un paciente cuántas horas ha utilizado los alineadores en las semanas anteriores. Ponérselos y quitárselos son gestos que se repiten todos los días: es difícil recordar la duración exacta de cada intervalo. Por tanto, el paciente puede darnos una estimación imprecisa sin tener ninguna intención de engañarnos.

Frederic Bartlett describió el recuerdo como un proceso reconstructivo. Más adelante, los estudios de Elizabeth Loftus mostraron que la información recibida después de un acontecimiento puede influir en cómo lo recordamos. Daniel Schacter describió diversas distorsiones de la memoria como parte de su funcionamiento normal.

Cuando pedimos a un paciente que nos cuente cómo se ha comportado en las semanas anteriores, recogemos, por tanto, una reconstrucción, no un relato exacto de cada día. Eso no significa que su respuesta sea necesariamente falsa. Significa que es humana.

La disonancia cognitiva

La memoria reconstructiva nos ayuda a entender por qué un paciente puede recordar su comportamiento de forma imprecisa. Pero hay situaciones en las que esta explicación, por sí sola, parece insuficiente. El paciente está sentado frente a nosotros. Algunos movimientos no se han producido según lo previsto. Le preguntamos cómo le va con los alineadores y responde sin vacilar:

«Los he utilizado siempre».

En esos momentos es natural preguntarse si el paciente intenta convencernos a nosotros o, al menos en parte, a sí mismo. Esta pregunta nos lleva a la **disonancia**

cognitiva, descrita por Leon Festinger en 1957. Tendemos a buscar la coherencia entre lo que pensamos de nosotros mismos y lo que hacemos. Cuando ambas cosas entran en conflicto, podemos sentir una tensión y buscar la manera de reducirla.

Imaginemos a un paciente que se considera meticuloso, fiable y colaborador. Sin embargo, durante el tratamiento se olvida varias veces de ponerse los alineadores, alarga las comidas, se los deja quitados durante una cena con amigos o decide no usarlos en toda una velada. Entonces tiene que conciliar dos pensamientos: *soy una persona responsable* y *en algunas ocasiones no he seguido las indicaciones*. Puede reconocer esas ocasiones y decidir cambiar su comportamiento. O puede restarles importancia para sí mismo:

«Al fin y al cabo, los he utilizado casi siempre». O «Solo fue una noche».

Así, las excepciones encuentran su lugar en un relato que le permite seguir considerándose colaborador. No tiene por qué hacerlo conscientemente: cuando habla con nosotros, puede estar sinceramente convencido de haber seguido las indicaciones mucho más de lo que lo ha hecho en realidad.

La deseabilidad social

Hay otro elemento que debemos tener en cuenta. El paciente no solo intenta recordar lo que ha hecho: está hablando con nosotros y sabe qué respuesta esperamos. La **deseabilidad social** es la tendencia a presentarse de forma favorable ante los demás, sobre todo cuando una pregunta se refiere a un comportamiento por el que uno puede sentirse juzgado.

El paciente conoce las indicaciones que le hemos dado. Sabe cuántas horas debería utilizar los alineadores y que los elásticos forman parte del tratamiento. Reconocer que no ha seguido esas indicaciones puede incomodarlo. Así, cuando le preguntamos cómo le va, el deseo de parecer un buen paciente puede influir en su respuesta. No hace falta inventarse una historia. Puede bastar con un pequeño ajuste: «*bastante a menudo*» se convierte en «*casi siempre*», y «*casi siempre*» se convierte en «*siempre*».

Es un fenómeno conocido en los estudios basados en lo que las personas cuentan sobre su propio comportamiento. Para nosotros tiene una consecuencia práctica: una pregunta como «*Estás utilizando los alineadores, ¿verdad?*» ya sugiere la respuesta esperada y puede hacer que al paciente le resulte más difícil contarnos lo que ocurre realmente.

El sesgo de autoservicio

Otro mecanismo tiene que ver con cómo nos explicamos los resultados a nosotros mismos. El **sesgo de autoservicio** es la tendencia a atribuir los éxitos a nuestras propias acciones y los fracasos a causas externas.

Cuando el tratamiento avanza bien, el paciente puede pensar: «*He hecho bien en seguir las indicaciones*». Cuando un movimiento no se produce, en cambio, puede pensar: «*Estos alineadores no funcionan*».

En este caso no cambia necesariamente el recuerdo de lo que hemos hecho, sino cómo interpretamos lo que ha ocurrido. Atribuir una dificultad a una causa externa puede protegernos de la idea de haber contribuido al problema. Por supuesto, a veces la causa está realmente en el tratamiento: puede que un movimiento se haya planificado mal, que un atache no sea adecuado o que la respuesta biológica sea distinta de la prevista. Por tanto, este mecanismo no nos autoriza a responsabilizar automáticamente al paciente.

Sin embargo, me ayuda a reconsiderar lo que ocurría en casos como el de Laura. Yo tendía a buscar el error en mi planificación; ella podía buscarlo en los alineadores. Así, yo modificaba el tratamiento mientras ella podía seguir convencida de que había colaborado tal como se le había pedido.

El sesgo de confirmación

En 1960, Peter Wason describió otro fenómeno que llegaría a ser fundamental en el estudio del razonamiento humano: el **sesgo de confirmación**, es decir, la tendencia a buscar e interpretar con más facilidad la información que encaja con lo que ya creemos.

El paciente también puede observar su tratamiento a través de este filtro. Quien está convencido de haber colaborado muchísimo tenderá a dar más importancia a los días en que utilizó los alineadores perfectamente, al sacrificio que hizo durante una cena o a las veces que se los volvió a poner inmediatamente después de comer. En cambio, apenas tendrán cabida el fin de semana en que los dejó en la mesilla de noche, la larga comida del domingo o las vacaciones durante las cuales fue menos riguroso con los horarios.

También puede ocurrir lo contrario. Un paciente convencido de que el tratamiento no funciona tenderá a fijarse sobre todo en el diente que aún está rotado o en la pequeña imperfección que queda, mientras que todos los movimientos ya completados irán pasando a un segundo plano.

Así, la creencia inicial se convierte en el filtro a través del cual interpretamos lo que ocurre. Y esto, naturalmente, también nos pasa a los profesionales. Si estamos convencidos de que el problema es biomecánico, buscaremos sobre todo los elementos que confirmen esa explicación. Si estamos convencidos de que el paciente no colabora, correremos el riesgo contrario.

Conocer el sesgo de confirmación no sirve, por tanto, para demostrar que el paciente se equivoca. Sirve también para recordarnos lo fácil que es que nos equivoquemos nosotros.

El optimismo irrealista y el descuento temporal

Hay otra pregunta que todo ortodoncista se ha hecho al menos una vez: ¿por qué un paciente sigue comportándose de una manera contraria a sus propios intereses aunque conozca perfectamente las normas del tratamiento? El **optimismo irrealista** puede ayudarnos a entender parte de la respuesta.

En los años ochenta, Neil Weinstein observó que tendemos a considerar algunos acontecimientos negativos menos probables para nosotros que para los demás y, por el contrario, a percibir los positivos como relativamente más probables. En otras palabras, conocemos el riesgo, pero tendemos a sentirlo más lejano cuando nos afecta a nosotros.

El paciente sabe que utilizar los alineadores menos horas de las necesarias puede retrasar el tratamiento, pero piensa que unas horas de menos no supondrán una diferencia real en su caso. Sabe que no utilizar los elásticos puede impedir algunos movimientos, pero imagina que aun así podrá recuperar el tiempo perdido. Sabe que la retención es importante, pero considera improbable que precisamente sus dientes puedan desplazarse de forma significativa. Por tanto, no hace falta que el paciente no haya entendido la información: puede haberla entendido perfectamente. Lo que cambia es la importancia que atribuye a la posible consecuencia.

A este mecanismo puede sumarse otro, bien descrito en los estudios sobre el **descuento temporal**: tendemos a dar más importancia a los costes y beneficios inmediatos que a las consecuencias más lejanas en el tiempo. Para el paciente, esto significa comparar continuamente una pequeña incomodidad presente con un beneficio futuro. Quitarse los alineadores durante una velada, no volvérselos a poner justo después de cenar o prescindir de los elásticos le aporta un beneficio pequeño pero inmediato; en cambio, el posible retraso del tratamiento parece lejano, incierto y difícil de percibir en el momento de tomar esa decisión.

Es precisamente la interacción entre estos dos mecanismos lo que hace que una consecuencia futura tenga tan poco peso: no solo está lejos, sino que el paciente también puede estar convencido de que probablemente no le afectará a él.

Este punto será especialmente importante cuando empecemos a elaborar los protocolos, porque nos obligará a distinguir entre informar al paciente de una consecuencia y conseguir que esa consecuencia tenga un peso real en el momento en que deba tomar una decisión.

Entonces, ¿el paciente miente?

Llegados a este punto, podemos volver a la pregunta con la que empezamos: **¿el paciente miente?** A veces sí. Sería ingenuo dedicar todo un capítulo a los mecanismos cognitivos para eludir esa posibilidad. Hay personas que saben perfectamente que no han seguido las indicaciones y deciden contarnos deliberadamente lo contrario, quizá para evitar una reprimenda, proteger su imagen o eludir su responsabilidad. Pero quedarse ahí sería igual de ingenuo.

Entre la realidad objetiva y el relato que hacemos de ella hay un espacio mucho más complejo, en el que la memoria reconstruye lo ocurrido, la disonancia nos ayuda a conservar una imagen coherente de nosotros mismos, la deseabilidad social modifica lo que estamos dispuestos a admitir ante los demás, el sesgo de autoservicio influye en cómo atribuimos las responsabilidades y el sesgo de confirmación selecciona la información que mejor encaja con lo que ya creemos, mientras que el optimismo irrealista y el descuento temporal pueden hacer que las consecuencias futuras de nuestras decisiones nos parezcan menos relevantes. Estos mecanismos no convierten automáticamente una respuesta falsa en verdadera, pero nos ayudan a entender por qué la distancia entre el comportamiento real y el que se cuenta puede ser mucho más compleja que una simple elección entre la sinceridad y la mentira.

Y es precisamente esta distinción la que cambia nuestra manera de situarnos frente al paciente. Si nuestro objetivo es determinar quién tiene razón, cada incongruencia se convierte en el inicio de una discusión: nosotros mostramos lo que observamos, el paciente defiende lo que recuerda, nosotros insistimos y él se reafirma en su postura. Cuanto más intentamos demostrar que no dice la verdad, más nos arriesgamos a empujarlo a defender la versión que acaba de contarnos. Pero nuestro objetivo no es conseguir una confesión, sino lograr que se comporte de otra manera a partir de ese momento.

Esta es probablemente la consecuencia más importante de todo lo que hemos visto en este capítulo. Ante un paciente que afirma haber utilizado los alineadores según las indicaciones cuando el cuadro clínico nos sugiere lo contrario, no tenemos por qué decidir si miente, recuerda mal o protege inconscientemente la imagen que tiene de sí mismo. Lo que debemos hacer es encontrar la manera de llevar la conversación a lo que ocurrirá **de hoy en adelante**.

Al final, ¿Laura me había dicho la verdad? ¿Me había mentido deliberadamente durante meses o estaba realmente convencida de que su uso de los elásticos se ajustaba lo suficiente a lo que yo le había pedido? No lo sé y, con los años, me he dado cuenta de que quizá ni siquiera sea la pregunta más importante. Lo que sí sé es que, cuando la boda transformó una consecuencia lejana y abstracta en un objetivo concreto, cercano e importante para ella, su comportamiento cambió. Los elásticos eran los mismos, la biomecánica era la misma y yo era el mismo ortodoncista: **lo que había cambiado era el significado que tenía para ella esa colaboración.**

Y es justo ahí donde comprender la mente del paciente deja de ser solo interesante y empieza a tener utilidad clínica. Porque cuando el paciente no colabora, las consecuencias no afectan únicamente al resultado clínico: suponen más tiempo, más citas, más refinamientos y más recursos empleados para llegar al mismo resultado. En el siguiente capítulo intentaremos, por tanto, mirar la falta de colaboración desde otra perspectiva, mucho más concreta: **¿cuánto cuesta realmente un paciente que no colabora?**

BIBLIOGRAFÍA

Bartlett FC. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology.* Cambridge: Cambridge University Press; 1932.

Loftus EF. Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory. *Learning & Memory.* 2005;12(4):361-366.

Schacter DL. *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers.* Boston: Houghton Mifflin; 2001.

Schacter DL, Guerin SA, St Jacques PL. Memory distortion: an adaptive perspective. *Trends Cogn Sci.* 2011;15(10):467-474.

Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow.* Nueva York: Farrar, Straus and Giroux; 2011.

Tversky A, Kahneman D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science.* 1974;185(4157):1124-1131.

Stanovich KE. *Rationality and the Reflective Mind.* Oxford: Oxford University Press; 2011.

Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. *Acad Med.* 2003;78(8):775-780.

Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance.* Stanford: Stanford University Press; 1957.

Harmon-Jones E, Mills J, editores. *Cognitive Dissonance: Reexamining a Pivotal Theory in Psychology.* 2.ª ed. Washington, DC: American Psychological Association; 2019.

Vaidis DC, Bran A. Respectable challenges to respectable theory: Cognitive dissonance theory requires conceptualization clarification and operational tools. *Front Psychol.* 2019;10:1189.
Freijy T, Kothe EJ. Dissonance-based interventions for health behaviour change: A systematic review. *Br J Health Psychol.* 2013;18(2):310-337.
Crowne DP, Marlowe D. A new scale of social desirability independent of psychopathology. *J Consult Psychol.* 1960;24:349-354.
van de Mortel TF. Faking it: Social desirability response bias in self-report research. *Aust J Adv Nurs.* 2008;25(4):40-48.
Latkin CA, Edwards C, Davey-Rothwell MA, Tobin KE. The relationship between social desirability bias and self-reports of health, substance use, and social network factors among urban substance users in Baltimore, Maryland. *Addict Behav.* 2017;73:133-136.
Althubaiti A. Information bias in health research: definition, pitfalls, and adjustment methods. *J Multidiscip Healthc.* 2016;9:211-217.
Krumpal I. Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. *Qual Quant.* 2013;47:2025-2047.
Miller DT, Ross M. Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction? *Psychol Bull.* 1975;82(2):213-225.
Mezulis AH, Abramson LY, Hyde JS, Hankin BL. Is there a universal positivity bias in attributions? A meta-analytic review of individual, developmental, and cultural differences in the self-serving attributional bias. *Psychol Bull.* 2004;130(5):711-747.
Campbell WK, Sedikides C. Self-threat magnifies the self-serving bias: A meta-analytic integration. *Rev Gen Psychol.* 1999;3(1):23-43.
Wason PC. On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. *Q J Exp Psychol.* 1960;12(3):129-140.
Nickerson RS. Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Rev Gen Psychol.* 1998;2(2):175-220.
Klayman J. Varieties of confirmation bias. *Psychol Learn Motiv.* 1995;32:385-418.
Oswald ME, Grosjean S. Confirmation bias. En: Pohl RF, editor. *Cognitive Illusions: A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory.* Hove: Psychology Press; 2004.
Weinstein ND. Unrealistic optimism about future life events. *J Pers Soc Psychol.* 1980;39(5):806-820.
Weinstein ND. Unrealistic optimism about susceptibility to health problems. *J Behav Med.* 1982;5(4):441-460.
Shepperd JA, Klein WMP, Waters EA, Weinstein ND. Taking stock of unrealistic optimism. *Perspect Psychol Sci.* 2013;8(4):395-411.
Frederick S, Loewenstein G, O'Donoghue T. Time discounting and time preference: A critical review. *J Econ Lit.* 2002;40(2):351-401.

CAPÍTULO

4

El coste invisible de la falta de colaboración

«Cuidado con los pequeños gastos: una pequeña vía de agua puede hundir un gran barco».

— BENJAMIN FRANKLIN

Hay pacientes a los que recuerdo por la complejidad de su maloclusión, otros por lo difícil que fue conseguir un determinado resultado y otros porque, cuando pienso en su tratamiento, lo primero que me viene a la cabeza no son los dientes, sino el tiempo. No necesariamente porque el tratamiento hubiera sido largo en términos absolutos: algunos casos complejos requieren tiempo y eso forma parte de la ortodoncia. Me refiero más bien a esa sensación tan distinta que se tiene cuando, al llegar al final, uno mira atrás y se da cuenta de que una parte considerable de ese tiempo no habría sido necesaria.

Un nuevo escaneo porque los alineadores habían dejado de ajustarse bien, una nueva planificación, otra serie de alineadores, una entrega que no estaba prevista y alguna revisión más. Luego, quizá, otro escaneo, porque tampoco la nueva secuencia había dado el resultado que esperábamos. Entretanto, habían pasado varios meses más y el tratamiento, que sobre el papel ya debería haber estado cerca de concluir, seguía ocupando huecos en la agenda de la clínica.

Por separado, estos pasos parecen casi inofensivos. Un escaneo solo lleva unos minutos, una revisión más puede encajarse entre dos citas, una nueva planificación forma parte de nuestro trabajo y, cuando utilizamos paquetes que permiten solicitar más series de alineadores durante un periodo determinado, incluso la fabricación de nuevas férulas puede dar la impresión de no tener un coste real. Solo cuando empezamos a sumarlo todo cambia la perspectiva: ¿cuántas horas de sillón dedicamos a ese paciente por encima de las previstas? ¿Cuántas veces reabrimos el caso, modificamos la prescripción, revisamos un nuevo setup o añadimos una cita que no debería haber hecho falta? Y, sobre todo, ¿qué parte de ese trabajo adicional era realmente inevitable y qué parte se había vuelto necesaria porque el paciente no había colaborado?

Hasta entonces había observado el problema sobre todo a través de casos clínicos concretos. Tenía delante pacientes cuyos alineadores perdían el tracking, tratamientos que se alargaban y refinamientos que se acumulaban, pero aún no había intentado mirar el fenómeno en su conjunto. En el capítulo anterior vimos por qué lo que una persona recuerda y cuenta de su propio comportamiento puede no coincidir del todo con lo que ocurrió realmente; ahora, sin embargo, la pregunta es otra. Si dejamos de basarnos únicamente en lo que cuenta el paciente y empezamos a medir lo que hace de verdad, **¿de cuánto es esa diferencia?**

¿Cuánto colaboran realmente nuestros pacientes?

En ortodoncia estamos acostumbrados a utilizar el término *cumplimiento terapéutico*, aunque en los últimos años la literatura tiende a preferir *adherencia*, un término que describe de forma menos paternalista hasta qué punto el comportamiento del paciente se ajusta a las indicaciones recibidas.

El problema es que todavía no existe una definición universalmente aceptada de la adherencia en ortodoncia. Una de las revisiones más completas sobre el tema, publicada en 2024 por Van der Bie y colaboradores, identificó 3 284 trabajos e incluyó 60 en el análisis final. Los autores mostraron lo fragmentada que está la literatura y lo difícil que resulta comparar estudios que miden comportamientos distintos

con instrumentos distintos. En la práctica, sin embargo, se distinguen tres grandes ámbitos en los que podemos observar la colaboración: utilizar los aparatos según las indicaciones, acudir a las citas y mantener una higiene oral adecuada durante el tratamiento.

Esto significa que probablemente tampoco tiene mucho sentido dividir a los pacientes sin más entre «colaboradores» y «no colaboradores». Un paciente puede utilizar los alineadores con gran regularidad pero olvidarse de los elásticos, puede ser impecable con la higiene y faltar a las citas, o puede empezar el tratamiento con entusiasmo y perder constancia poco a poco al cabo de muchos meses. La colaboración no es, por tanto, una cualidad inmutable de la persona, sino un conjunto de comportamientos que pueden cambiar a lo largo del tratamiento.

Durante muchísimo tiempo, la forma más sencilla de saber cuánto utilizaba un paciente un aparato removible era preguntárselo: «*¿Cuántas horas lo llevas?*», «*¿Te lo pones todas las noches?*», «*¿Estás usando los elásticos?*». Hoy podemos contrastar esas respuestas con sistemas capaces de registrar objetivamente el tiempo de uso y, cuando lo hacemos, aparece una diferencia que merece atención.

En 2017, Al-Moghrabi y colaboradores publicaron una revisión sistemática con metaanálisis sobre el cumplimiento terapéutico con aparatos de ortodoncia removibles en la que comparaban el tiempo prescrito por el ortodoncista, el declarado por el paciente y el registrado objetivamente. Los resultados apuntaban en una dirección bastante clara: la colaboración real era menor que la prescrita y los pacientes tendían a sobrestimar su tiempo de uso. En los seis estudios que comparaban el tiempo prescrito con el registrado objetivamente, los pacientes utilizaban el aparato de ortodoncia una media de **5,81 horas menos al día** de las indicadas. Aún más interesante para lo que nos ocupa era la diferencia entre lo que declaraban y lo que registraban los dispositivos: el tiempo declarado superaba al registrado en **5,02 horas al día**.

Cinco horas.

Una diferencia que, repetida cada día durante semanas o meses, cambia por completo las condiciones en las que debería producirse el movimiento ortodóncico. La revisión de Van der Bie de 2024 confirma lo difícil que es evaluar la colaboración basándose exclusivamente en lo que cuenta el paciente y destaca la mayor fiabilidad de las mediciones objetivas cuando se dispone de ellas.

La situación se vuelve aún más delicada durante la adolescencia. Una revisión publicada en 2025 sobre la colaboración de los adolescentes con los aparatos de ortodoncia removibles mostró una gran variabilidad en la adherencia e identificó numerosos factores que podían modificarla, entre ellos la motivación, los olvidos,

las molestias, el apoyo familiar y las presiones sociales. En uno de los estudios incluidos, alrededor del 40 % de los adolescentes utilizaba el retenedor termoformado menos de 18 horas al día durante una fase en la que debían llevarlo 22 horas. No se trata de considerar a los adolescentes pacientes menos fiables, sino de reconocer lo difícil que es pedirle a una persona que mantenga el mismo comportamiento todos los días, durante meses o incluso años. Sobre el papel, «*póntelo todas las noches*» parece una indicación sencillísima; en la vida real, es una petición mucho más compleja de lo que esas cuatro palabras dan a entender.

También con los alineadores, la posibilidad de medir objetivamente el tiempo de uso nos permite comparar lo que prescribimos con lo que el paciente hace realmente. En 2026, Sabbagh y colaboradores publicaron un ensayo controlado aleatorizado en el que se registraba el tiempo de uso mediante microsensores integrados en los alineadores. Cuarenta y tres pacientes adultos, a quienes se les había prescrito un uso de veinte horas diarias, fueron divididos en dos grupos: en el primero, los pacientes no sabían que los datos recogidos se utilizarían para evaluar su cumplimiento terapéutico, mientras que en el segundo se les había informado expresamente de ello.

El **67,5 % de los participantes utilizaba los alineadores entre diez y veinte horas al día**, por debajo, por tanto, de las veinte horas prescritas. Pero quizá el dato aún más interesante era el efecto del seguimiento: saber que se controlaba su tiempo de uso aumentaba el uso medio de los alineadores en **4,41 horas al día**. Entre los dos grupos no cambiaban el aparato, la prescripción ni el tratamiento; solo cambiaba el hecho de saber que se mediría su comportamiento.

Este resultado introduce un principio que retomaremos más adelante en los protocolos: entender perfectamente una indicación no significa necesariamente seguirla. El contexto en el que pedimos un determinado comportamiento, la forma en que comprobamos si se cumple y el modo en que hacemos visibles sus consecuencias pueden modificar lo que el paciente hará realmente.

Cuando la colaboración modifica el tratamiento

Llegados a este punto, sería fácil concluir que, si el paciente colabora menos, el tratamiento dura inevitablemente más. La relación, sin embargo, no es tan sencilla, porque la duración de un tratamiento de ortodoncia depende de la complejidad de la maloclusión, de la respuesta biológica individual, de los movimientos programados, de las decisiones terapéuticas, de la planificación y de muchas otras variables independientes del comportamiento del paciente. La propia revisión de Van der Bie

señala que la relación entre el grado de adherencia y el resultado del tratamiento todavía no está del todo clara.

Hay, no obstante, datos que muestran que algunos comportamientos del paciente se asocian con la duración del tratamiento. Beckwith y colaboradores analizaron 140 tratamientos completados en cinco clínicas de ortodoncia y tuvieron en cuenta treinta y una variables. Seis factores explicaban, en conjunto, más de la mitad de la variabilidad observada en la duración del tratamiento y, entre ellos, tres estaban relacionados con el comportamiento del paciente: las citas a las que no había acudido, los brackets o las bandas que había sido necesario sustituir y los problemas de higiene oral. Unos años más tarde, Skidmore y colaboradores, al analizar a 366 pacientes tratados con aparatología fija, volvieron a encontrar una asociación entre una mayor duración del tratamiento y comportamientos como el uso insuficiente de los elásticos, una higiene deficiente y la rotura de brackets.

Se trata principalmente de estudios sobre aparatología fija y sería incorrecto extrapolar automáticamente sus resultados al tratamiento con alineadores. Sin embargo, el principio que se desprende de ellos sigue siendo importante: la duración del tratamiento no depende solo de lo que planificamos y hacemos nosotros, sino también de lo que hace el paciente durante las semanas que transcurren entre una cita y la siguiente. **En el tratamiento con alineadores, este aspecto cobra especial importancia, porque el tiempo de uso diario es una de las condiciones sobre las que construimos todo el tratamiento.** Y aquí nos encontramos con un fenómeno muy familiar para quienes trabajan a diario con alineadores: **los refinamientos.**

No todos los refinamientos son iguales

Antes de relacionar los refinamientos con la colaboración, es indispensable hacer una distinción: no todos los refinamientos son consecuencia de una falta de colaboración, y necesitar una nueva secuencia de alineadores no significa necesariamente que el tratamiento haya fracasado. Hay movimientos menos predecibles, distintas respuestas biológicas, limitaciones biomecánicas, problemas de planificación y muchas otras circunstancias clínicas que pueden hacer que un refinamiento sea necesario incluso en un paciente impecable. A nosotros nos interesa un grupo mucho más concreto: **los refinamientos evitables**, en particular aquellos que se han vuelto necesarios porque el comportamiento real del paciente ha sido distinto del que habíamos tomado como base para planificar el tratamiento.

La distinción es fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta lo frecuentes que son los refinamientos, independientemente de su causa. Kravitz y colaboradores

analizaron a 500 pacientes tratados con Invisalign en dos clínicas de ortodoncia y encontraron una media de **2,5 escaneos para refinamientos por paciente**. Solo el 6 % había terminado el tratamiento sin ningún escaneo adicional, mientras que la duración media real había sido de 22,8 meses, 5,1 meses más de lo previsto inicialmente. Además, el 17,2 % de los pacientes había tenido que pasar a la aparatología fija para completar el tratamiento.

Estas cifras **no nos dicen cuántos de esos refinamientos se debieron a la falta de colaboración**, porque el estudio no se diseñó para determinarlo. Sin embargo, sí nos muestran lo grande que puede ser la distancia entre el tratamiento que imaginamos al principio y el que realmente hace falta para llevarlo a término. En 2025, un consenso internacional sobre las indicaciones y los límites del tratamiento con alineadores llamó la atención precisamente sobre este problema: más del 10 % de los pacientes del estudio de Kravitz había necesitado cinco o más refinamientos, con el consiguiente aumento del tiempo y los recursos necesarios para completar el tratamiento.

Otro trabajo nos ayuda a entender por qué merece la pena prestar atención al número de refinamientos. Abu Arqub y colaboradores analizaron a 355 pacientes tratados con alineadores y estudiaron la relación entre la complejidad inicial, el número de refinamientos, la duración y el resultado. La mejoría más notable se concentraba en el **primer refinamiento**. Entre los pacientes que aún no habían alcanzado el umbral de mejoría establecido por los autores, la probabilidad de alcanzarlo disminuía progresivamente a medida que aumentaba el número de refinamientos; en la muestra analizada, después de más de tres refinamientos no se observó que ningún otro paciente alcanzara por primera vez ese umbral de mejoría.

Es importante no atribuirle a este resultado algo que el estudio no dice. **No significa que, después de tres refinamientos, un tratamiento sea inútil ni que deba evitarse el cuarto refinamiento.** Un caso complejo puede requerir más fases perfectamente justificadas. Sin embargo, el dato sugiere algo sumamente interesante: aumentar el número de refinamientos no garantiza un beneficio clínico proporcional, y es justo aquí donde el problema clínico empieza a encontrarse con el económico.

El coste invisible de los refinamientos

Para mí, esto cambia la forma de ver una frase que en la práctica diaria podemos decir con toda facilidad: «*Hagamos otro escaneo*». Desde el punto de vista clínico puede parecer una decisión relativamente pequeña; desde el organizativo y el económico, sin embargo, no lo es en absoluto.

Muchos sistemas de alineadores ofrecen modalidades comerciales que permiten solicitar más series durante un periodo determinado después de adquirir el tratamiento, sin tener que pagar cada vez un nuevo coste de fabricación. Es un modelo muy cómodo, sobre todo en tratamientos complejos, pero precisamente esta característica puede alterar, sin que nos demos cuenta, nuestra percepción del coste de un refinamiento. Si tras un nuevo escaneo no llega otra factura de la empresa, es fácil tener la sensación de que esa secuencia es, en la práctica, gratuita. El paciente también puede percibirlo así: si hacen falta más alineadores, simplemente llegarán más.

Ahí nace el equívoco.

El precio de la nueva serie solo representa una parte de lo que implica decidir hacer un refinamiento. Hay que averiguar por qué el tratamiento ha perdido el tracking, realizar un nuevo escaneo, actualizar la documentación cuando sea necesario, replantear la prescripción, revisar y aprobar el nuevo setup, organizar la entrega y programar más revisiones. Gran parte de este coste no aparece en ninguna factura, porque corresponde al recurso más valioso y limitado que tenemos en la clínica: **el tiempo**.

Pero, cuando hablamos del coste económico, debemos volver a la distinción anterior. Un refinamiento clínicamente necesario forma parte del trabajo que exige completar el tratamiento; uno evitable, en cambio, consume recursos que podríamos habernos ahorrado. Puede que el tiempo empleado no aparezca como una partida separada en las cuentas de la clínica y que no recibamos a final de mes una factura que nos lo recuerde, pero eso no significa que no tenga un coste.

Una hora dedicada a encauzar de nuevo un tratamiento puede ser una hora en la que podríamos haber hecho una primera visita, empezado un nuevo caso o realizado un procedimiento programado. Cuando ocurre lo mismo con decenas de pacientes, esas horas empiezan a acumularse. Si supusiéramos, por ejemplo, que un refinamiento evitable requiere en total tan solo una hora adicional de trabajo clínico y organizativo, **cincuenta refinamientos supondrían cincuenta horas de trabajo**; si hicieran falta dos horas, serían cien.

Sin embargo, sería incorrecto asignar a esas horas un valor económico universal. Una clínica que genera 300 euros por hora no tendrá el mismo coste de oportunidad que otra que genera 1 000, del mismo modo que un escaneo realizado íntegramente por el personal tendrá un impacto distinto al de un procedimiento en el que interviene directamente el ortodoncista. Pero el principio no cambia: **cada refinamiento evitable consume una parte de la capacidad de trabajo de la clínica que no podrá destinarse a otra cosa.**

Cuando busqué en la literatura una cifra que permitiera establecer cuánto costaba de media un refinamiento evitable, no la encontré, y probablemente no podría existir un valor universal, porque depende de la organización de la clínica, del coste del personal, del sistema de alineadores utilizado, del tiempo dedicado a la planificación y del valor del tiempo clínico. La literatura sí nos permite reconstruir la cadena que conduce al problema: la adherencia real puede ser menor que la prescrita y la declarada, algunos comportamientos del paciente se asocian con tratamientos más largos y los refinamientos son muy frecuentes en el tratamiento con alineadores, mientras que el beneficio que aportan no aumenta necesariamente en proporción a su número. Lo que ningún artículo puede decirnos es **cuánto cuesta todo esto en nuestra clínica: eso tenemos que calcularlo nosotros.**

La cuestión no es, por tanto, determinar qué modalidad comercial es mejor, sino entender una distinción mucho más importante: **el precio de una nueva serie de alineadores y el coste de gestionar esa nueva fase del tratamiento no son lo mismo.** El primero puede estar ya incluido en el paquete adquirido; el segundo sigue existiendo cada vez que la clínica tiene que volver a intervenir.

El verdadero precio de la falta de colaboración

Llegados a este punto, la falta de colaboración adquiere otro significado. Ya no se trata solo de que el paciente no siga una indicación nuestra, sino de una variable capaz de cambiar de forma concreta las condiciones sobre las que hemos planificado el tratamiento. Si los alineadores se usan menos de lo necesario, si los elásticos no se utilizan según las indicaciones o si el paciente falta repetidamente a las citas, el plan que hemos diseñado sigue siendo el mismo, pero las condiciones en las que debería funcionar ya no lo son.

Cuando esto provoca una pérdida de tracking, movimientos incompletos o la necesidad de replantear el tratamiento, hay que recuperar una parte del trabajo. Aumentan las citas, el tiempo dedicado al paciente, la duración total del tratamiento y los recursos necesarios para alcanzar un resultado que habíamos previsto obtener en otros plazos y en otras condiciones. Pero quizá la conclusión más importante de este capítulo no tenga que ver con el coste, sino con la **previsibilidad**.

Si sabemos que la adherencia real puede ser menor que la prescrita, que lo que cuenta el paciente puede sobrestimar lo que hace realmente y que incluso saber que se le hace un seguimiento puede modificar en varias horas al día el tiempo de uso de un alineador, resulta difícil seguir considerando la colaboración como algo que basta con prescribir para darlo después por hecho. Esto no significa eximir al

paciente de responsabilidad, sino reconocer que la colaboración es una **variable clínica** y, como todas las variables que pueden influir en el resultado, hay que tenerla en cuenta, observarla y gestionarla.

Fue este cambio de perspectiva el que modificó la pregunta que me hacía ante un paciente que no colaboraba. Ya no solo «*¿Por qué no hace lo que le he dicho?*», sino «*Si sé que esto puede ocurrir, ¿qué puedo hacer para detectarlo antes, reducir la probabilidad de que ocurra e intervenir cuando ocurra?*»

No puedo saber con certeza cuántas horas llevará el paciente los alineadores una vez que salga de mi clínica, ni puedo estar presente cuando tenga que decidir si se pone los elásticos, cambia de alineador o sigue una indicación concreta. Pero sí puedo decidir cómo prepararlo para tomar esas decisiones, cómo comprobar lo que ocurre durante el tratamiento y, sobre todo, cómo intervenir cuando reconozco uno de esos comportamientos que, a lo largo de los años, he visto repetirse una y otra vez.

Y aquí es donde el problema de la colaboración se encuentra por fin con el tema central de este libro: reconocer los comportamientos recurrentes nos permite prepararnos y sustituir la improvisación por un método. **De esta idea nacieron los protocolos que veremos en los próximos capítulos.**

BIBLIOGRAFÍA

van der Bie RM, Bos A, Bruers JJM, Jonkman REG. Patient adherence in orthodontics: a scoping review. *BDJ Open.* 2024;10:58.

Al-Moghrabi D, Colonio Salazar F, Pandis N, Fleming PS. Compliance with removable orthodontic appliances and adjuncts: a systematic review and meta-analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2017;152(1):17-32.

Tiwari A, Fagundes NCF, Perez-Garcia A, et al. Adolescents' adherence to intraoral removable appliances: a scoping review. *Prog Orthod.* 2025;26:41.

Sabbagh H, Baumert U, Liedtke J, Thiem S, Venkova V, Wichelhaus A. Objective assessment of wear time during orthodontic aligner therapy using microsensors: a randomized controlled trial. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2026;169(3):272-284.

Beckwith FR, Ackerman RJ Jr, Cobb CM, Tira DE. An evaluation of factors affecting duration of orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1999;115(4):439-447.

Skidmore KJ, Brook KJ, Thomson WM, Harding WJ. Factors influencing treatment time in orthodontic patients. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006;129(2):230-238.

Kravitz ND, et al. What percentage of patients switch from Invisalign to braces? A retrospective study evaluating the conversion rate, number of refinement scans, and length of treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2023;163(4):526-530.

D'Antò V, et al. Indications and limits of clear aligner therapy: an international modified Delphi consensus study. *Prog Orthod.* 2025;26:28.

Abu Arqub S, Banankhah S, Sharma R, Da Cunha Godoy L, Kuo CL, Ahmed M, Alfardan M, Uribe F. Association between initial complexity, frequency of refinements, treatment

duration, and outcome in Invisalign orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2022;162(3):e141-e155.

CAPÍTULO

5

Introducción a los protocolos

«Para todo problema humano existe siempre una solución bien conocida: ordenada, plausible y equivocada».

— H. L. MENCKEN

Tarde o temprano volveremos a encontrarnos con el paciente que se olvida de los elásticos, lleva los alineadores menos tiempo del necesario o asegura haber seguido todas las indicaciones mientras el tratamiento cuenta una historia distinta.

La cuestión ya no es saber si ocurrirá, sino decidir si, cuando ocurra, volveremos a improvisar. Cada comportamiento recurrente nos ofrece la posibilidad de preparar una respuesta reconocible, verificable y compartida por toda la clínica: un protocolo.

Durante muchos años, en cambio, seguí improvisando. Cuando algo no funcionaba, buscaba la frase adecuada, intentaba explicarlo mejor, añadía información, enseñaba fotografías, insistía en las consecuencias o cambiaba por completo de

enfoque según la persona que tuviera delante. A veces funcionaba muy bien; otras, bastante menos. Con algunos pacientes conseguía un cambio inmediato; con otros acababa en conversaciones interminables y con otros salía de la visita con la sensación de haber explicado perfectamente el problema sin haber conseguido cambiar nada. En la siguiente visita, si el comportamiento se repetía, volvía prácticamente a empezar de cero.

Con el tiempo me he dado cuenta de que había algo paradójico en esta forma de trabajar. En ortodoncia utilizamos protocolos prácticamente para todo: estandarizamos la recogida de registros, el diagnóstico, la planificación, los procedimientos clínicos, las revisiones y muchas de nuestras decisiones biomecánicas porque sabemos que, cuando una situación tiende a repetirse, definir de antemano cómo abordarla reduce la variabilidad y aumenta la previsibilidad. En cambio, cuando la variable que se desvía de lo planificado es el comportamiento del paciente, seguimos reaccionando muy a menudo caso por caso, aunque también aquí las situaciones se repiten con una regularidad sorprendente.

Cambian los nombres, las edades, las maloclusiones y las justificaciones, pero las estructuras que sostienen muchos problemas de colaboración son mucho menos numerosas de lo que podría parecer. Probablemente fue este el descubrimiento más importante: **los comportamientos problemáticos son numerosos, pero no infinitos y, sobre todo, no del todo imprevisibles**. Si aprendemos a reconocer los patrones que tienden a repetirse, también podemos dejar de improvisar nuestras respuestas y empezar a planificarlas.

De esta necesidad nacieron los protocolos.

Antes de los protocolos: planificar la colaboración

En el capítulo 2 vimos que comunicarse eficazmente no consiste solo en saber qué decir, sino también en adaptar el lenguaje, el ritmo y la cantidad de información a la persona que tenemos delante. Esto puede ayudarnos a que una explicación sea más clara, creíble y significativa. Sin embargo, incluso una comunicación perfectamente adaptada tiene un límite: puede favorecer la comprensión, pero no garantizar el comportamiento.

Un paciente puede haber entendido perfectamente lo importante que es llevar los alineadores, usar los elásticos o seguir las pautas de retención y, unas horas después, actuar de otra manera. Incluso puede salir de la clínica sinceramente convencido de que a partir de ese momento hará exactamente lo que le hemos pedido

y luego volver poco a poco a sus hábitos cuando la vida cotidiana retome su curso. **Informar a una persona y cambiar su comportamiento no son lo mismo.**

La psicología lleva mucho tiempo estudiando esta distancia entre la intención y el comportamiento. Entre los modelos más interesantes para lo que nos ocupa están las *intenciones de implementación* estudiadas por Peter Gollwitzer, en las que una intención general se convierte en un plan mucho más concreto que vincula una situación determinada con una acción específica: no simplemente «*tengo que acordarme de hacer esto*», sino «*cuando se dé esta situación, haré esto*». Es una distinción especialmente útil en ortodoncia, porque muchos problemas de colaboración no se deben a la falta de intención de colaborar, sino a la dificultad de convertir esa intención en una rutina diaria lo bastante estable.

Pero esto es solo una parte del problema. Facilitar un comportamiento puede ayudarnos cuando el paciente quiere colaborar, pero le cuesta convertir esa intención en un hábito; en otras situaciones, antes tenemos que conseguir que el comportamiento que le pedimos tenga suficiente valor para que el paciente decida cambiar de verdad. Y aquí entra otro elemento importante en la elaboración de mis protocolos: la **persuasión**.

Curiosamente, no era en absoluto un tema nuevo para mí. Mucho antes de convertirme en ortodoncista me fascinaban la magia, la prestidigitación, el mentalismo y la hipnosis. Me interesaba entender por qué dos personas podían observar la misma escena y percibir cosas distintas, cómo se podía dirigir la atención hacia ciertos elementos y hasta qué punto el contexto en el que se presenta una información podía modificar su interpretación. Con los años, esa curiosidad me llevó a profundizar también en la comunicación y la persuasión, al principio por interés personal y, solo mucho más tarde, a preguntarme si algunos de esos principios podían tener una aplicación concreta también en la relación con los pacientes.

La palabra *persuasión* puede causar cierta incomodidad cuando se asocia con la medicina, como si implicara necesariamente la intención de convencer a alguien de hacer algo contrario a sus intereses. Sin embargo, creo que el problema no es la persuasión en sí, sino el fin para el que se utiliza. Toda comunicación modifica en cierta medida la percepción de quien escucha: elegir una palabra en vez de otra, presentar una consecuencia en términos de lo que se puede ganar o perder, enseñar una fotografía, utilizar una cifra o formular una pregunta ya supone crear un marco desde el que nuestro interlocutor interpretará lo que estamos diciendo.

La persuasión se vuelve éticamente problemática cuando sirve para ocultar información, alterar los hechos, aprovecharse de una vulnerabilidad o llevar a una persona a tomar una decisión que nos beneficia a nosotros, pero no a ella. Puede

adquirir un significado completamente distinto cuando se utiliza para ayudar a un paciente a mantener un comportamiento que él mismo ha aceptado como necesario para alcanzar el objetivo terapéutico que ha elegido. Si una persona decide libremente iniciar un tratamiento con alineadores y sabe que el resultado dependerá también de su comportamiento, ayudarla a llevar los alineadores el tiempo necesario, usar los elásticos o seguir correctamente las pautas de retención no significa restarle libertad, sino reconocer que entre saber lo que deberíamos hacer y conseguir hacerlo de verdad todos los días hay un espacio enorme, lleno de hábitos, olvidos, gratificaciones inmediatas, resistencias y justificaciones.

Es precisamente en ese espacio donde deben actuar los protocolos.

Las tres palancas de la colaboración

Cuando empecé a pensar de este modo, me di cuenta de que no necesitaba encontrar cada vez una fórmula distinta para convencer al paciente de que colaborara. Primero tenía que entender **qué tenía realmente valor para la persona que tenía delante**, porque no todo el mundo desea las mismas cosas con la misma intensidad y, sobre todo, no todo el mundo da la misma importancia a las consecuencias de un comportamiento.

Con el tiempo empecé a reconocer tres grandes palancas que hoy encuentro una y otra vez en mis protocolos: **el tiempo, el resultado y la inversión**. No son tres técnicas de persuasión, sino tres formas distintas de hacer que una consecuencia llegue a ser verdaderamente significativa para el paciente.

La primera palanca es el **tiempo**, un recurso limitado, fácil de entender y que se puede relacionar de inmediato con las consecuencias de nuestras acciones. Además, en ortodoncia tiene una particularidad: el paciente suele percibir la duración del tratamiento como algo que depende principalmente del médico, cuando muchos tratamientos incluyen un componente relacionado con su comportamiento capaz de modificarla considerablemente. Para algunas personas, terminar seis meses antes o seis meses después supone una diferencia enorme: puede haber una boda, un viaje, una mudanza, el comienzo de la universidad o simplemente el deseo de librarse por fin de los alineadores. En estos casos, mostrar claramente la relación entre lo que el paciente haga hoy y lo que podría ocurrir en los meses siguientes puede tener mucho más significado que una nueva explicación biomecánica.

La segunda palanca es el **resultado**. Algunos pacientes dan tanto valor al resultado final que aceptan sin demasiada dificultad incluso un tratamiento más largo, siempre que les permita alcanzar exactamente el objetivo deseado. En estos casos,

hablar continuamente de meses adicionales puede tener muy poco efecto; en cambio, es mucho más importante relacionar el comportamiento que les pedimos con la calidad del resultado que quieren obtener y ayudarles a comprender que un determinado movimiento podría no producirse por completo o que una colaboración insuficiente podría obligarnos a aceptar un compromiso que al principio no estaba previsto.

La tercera palanca es la **inversión**, término con el que no me refiero solo al dinero. Un tratamiento de ortodoncia supone, sin duda, una inversión económica, pero también meses o años de tiempo, citas, organización familiar, atención diaria, renuncias y confianza. Todo lo que el paciente ya ha dedicado al tratamiento tiene un valor y puede cobrar especial importancia cuando un comportamiento amenaza con poner en peligro lo que ya se ha conseguido o con obligarnos a repetir una parte del proceso.

El tiempo, el resultado y la inversión estarán presentes en prácticamente todos los protocolos que veremos más adelante, pero no habrá que recurrir necesariamente a los tres a la vez, ni hay una palanca que sea siempre mejor que las demás. Serán **el contexto clínico y la persona que tenemos delante** los que nos indiquen qué consecuencia puede ser más significativa en ese momento. Nos interesa, por tanto, establecer un principio general: **la comunicación solo puede influir en un comportamiento cuando logra relacionar lo que pedimos con una consecuencia que el paciente considera verdaderamente importante**.

La estructura fundamental del protocolo

Cuando empecé a reunir estos principios, me di cuenta de que, más allá de las técnicas concretas, las conversaciones que mejor funcionaban tendían a seguir una estructura bastante constante. No se trataba de encontrar palabras especialmente brillantes en cada ocasión, sino de seguir una serie de pasos en un orden que redujera las probabilidades de enfrentamiento y aumentara las de conseguir un cambio concreto.

El primer paso consiste en **reducir la actitud defensiva**, planteando el problema mediante observaciones clínicas, preguntas concretas y datos verificables, en lugar de emitir juicios sobre la persona. El segundo consiste en permitir que el paciente, cuando sea posible, **conserve una buena imagen de sí mismo sin mantener el comportamiento problemático**: no necesitamos necesariamente que admita haberse equivocado o haber mentido, pero sí que reconozca que algo tiene que cambiar. El tercero consiste en hacer **concretas las consecuencias**, relacionando el comporta-

miento con los efectos que realmente puede producir y eligiendo, según la persona, cuál de las tres palancas —el tiempo, el resultado o la inversión— tiene más importancia. El cuarto paso consiste en **reducir la ambigüedad del comportamiento futuro**, convirtiendo un genérico «*tienes que colaborar más*» en algo lo bastante concreto como para poder observarlo y comprobarlo. Por último, debemos **facilitar el comportamiento y comprobar su efecto**, reduciendo los obstáculos que puedan impedir al paciente pasar de la intención a la acción y estableciendo una evaluación lo bastante próxima en el tiempo como para saber si lo que hemos cambiado funciona de verdad.

Esta estructura no debe convertirse en una camisa de fuerza. La función del protocolo no es conseguir siempre la misma respuesta del paciente, algo imposible, sino hacer más previsible **nuestra respuesta** ante problemas con los que ya nos hemos encontrado. En las próximas páginas veremos, por tanto, una serie de principios psicológicos y comunicativos que podremos utilizar para elaborar los guiones según la situación clínica y la persona que tengamos delante. **Después los veremos aplicados de forma concreta en los protocolos de los capítulos siguientes.**

1. Reducir la actitud defensiva

En las conversaciones difíciles empezaba por lo que me parecía más lógico: el problema. Si el paciente no usaba los elásticos, hablaba de los elásticos; si llevaba poco los alineadores, hablaba de las horas de uso; si no se ponía la férula de retención, explicaba el riesgo de recidiva. Desde mi punto de vista, era una forma de proceder perfectamente racional, pero con el tiempo me di cuenta de que las primeras palabras de la conversación podían influir mucho en cómo interpretaría el paciente todo lo que yo dijera después.

Si empezamos una revisión diciendo «*No estás haciendo lo que te pedí*», ya hemos definido implícitamente los papeles en la conversación: nosotros somos quienes acusan y el paciente es quien tiene que defenderse. Podemos tener toda la razón desde el punto de vista clínico, pero, a partir de ese momento, parte de la energía de la conversación se dedicará a determinar responsabilidades, justificar lo ocurrido o proteger la imagen que el paciente tiene de sí mismo.

Si, en cambio, empezamos diciendo «*Veamos juntos cómo están respondiendo los dientes en relación con lo que habíamos planificado*» o «*Hay un movimiento que no está avanzando como esperábamos y me gustaría entender qué podemos hacer para volver a encauzarlo*», no hemos cambiado el problema clínico ni hemos ocultado lo que pensamos, pero hemos creado un contexto distinto para abordarlo.

La petición no empieza cuando la formulamos, sino cuando preparamos la conversación en la que vamos a hacerla. El principio del **encuadre**, estudiado por Tversky y Kahneman, describe precisamente cómo la forma de presentar una información o un problema puede influir en cómo se perciben y en las decisiones que se toman después, aunque los elementos fundamentales no cambien. Por eso, cuando tengo que abordar una colaboración insuficiente, ahora procuro no empezar por la culpa, sino por el tratamiento. No significa evitar la confrontación, sino crear las condiciones para que sea más probable que dé lugar a un cambio en vez de a una reacción defensiva.

El mismo principio se aplica cuando el paciente plantea una objeción. Uno de los errores más naturales en la comunicación clínica es intentar corregir inmediatamente lo que nos dicen. Si afirma que algo le molesta, sentimos la tentación de explicarle que no debería molestarle tanto; si sostiene que no es capaz de hacer algo, empezamos a demostrarle que en realidad sí podría; si nos dice que siempre ha llevado los alineadores, intentamos explicarle que lo que observamos demuestra lo contrario.

El problema es que, en cuanto intentamos demostrar que la percepción de la otra persona es errónea, casi automáticamente la obligamos a defenderla. Si el paciente dice *«No consigo usar los elásticos porque me molestan demasiado»* y nosotros respondemos de inmediato *«Eso no puede ser, todos los demás pacientes los llevan»*, la conversación deja enseguida de tratar sobre los elásticos y pasa a tratar sobre la validez de su experiencia. El paciente tendrá que convencernos de que las molestias son reales, mientras que nosotros intentaremos convencerlo de que debería poder soportarlas, y al final puede que hayamos pasado diez minutos discutiendo sin acercarnos lo más mínimo al comportamiento que queremos conseguir.

Si el encuadre se refiere al marco desde el que presentamos un problema, el **reencuadre** consiste en intentar cambiar ese marco, dando al mismo hecho un significado distinto sin necesidad de negarlo. Si una parte del tratamiento resulta incómoda, puedo reconocer que lo es y después relacionar esa incomodidad con el papel que desempeña para alcanzar el objetivo; si un comportamiento exige un esfuerzo, puedo reconocerlo y ayudar al paciente a entender ese esfuerzo desde otra perspectiva.

Una objeción que se ha reconocido necesita menos defensa, y solo entonces es posible trabajar sobre el significado que le damos. Esto no significa darle la razón al paciente en todo. Significa elegir con cuidado en qué merece la pena discutir, porque nuestro objetivo no es ganar una disputa verbal, sino crear las condiciones para que sea más probable que adopte el comportamiento necesario.

2. Proteger la imagen sin mantener el comportamiento

En el capítulo dedicado a la mente del paciente vimos lo difícil que puede ser reconocer que nos hemos comportado de una manera que entra en conflicto con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Este principio cobra especial importancia cuando tenemos que intervenir para mejorar la colaboración.

Decirle a alguien «*eres un paciente poco colaborador*» significa convertir un comportamiento en una característica de la persona. El paciente ya no tiene que hablar solo de cuántas horas ha llevado los alineadores, sino también defender su identidad como persona responsable. A partir de ese momento, cualquier observación que hagamos corre el riesgo de percibirse como un juicio personal.

Por eso, poco a poco aprendí a separar a la persona de su comportamiento. Un paciente puede ser sumamente puntual a las citas y olvidarse de los elásticos, mantener una higiene impecable y usar mal los alineadores, o haber colaborado perfectamente durante un año y pasar por una etapa en la que su rutina se ha vuelto más difícil. Calificarlo, sin más, de «*no colaborador*» no nos ayuda a entender qué comportamiento debemos cambiar y, sobre todo, puede aumentar su necesidad de defenderse.

Cuando es posible, prefiero hacer lo contrario y partir de algo que el paciente ya esté haciendo bien. Si usa correctamente los alineadores, pero se olvida de los elásticos, puedo reconocer esa primera parte de su colaboración y tomar esa capacidad como punto de partida para la segunda. No se trata de adularlo ni debemos atribuirle cualidades que no tiene; se trata de reconocer un comportamiento real y apoyarnos en él para desarrollar el que falta. El mensaje implícito no es «*eres una persona incapaz de colaborar*», sino «*ya has demostrado que puedes ocuparte de una parte exigente del tratamiento; tenemos que aplicar esa misma precisión también aquí*». **Proteger a la persona no significa mantener el comportamiento que debemos cambiar.**

Esta misma lógica cobra aún más importancia cuando lo que cuenta el paciente no coincide con lo que observamos clínicamente. Le preguntamos «*¿Los has llevado?*» y él responde «*Sí*». Intentamos entonces ser más precisos: «*¿Cuántas horas?*». «*Siempre, prácticamente todo el día*». En ese momento, ante algo que clínicamente no nos parece posible, podríamos sentir la tentación de responder: «*No puede ser, porque de lo contrario este diente se habría movido*». El problema es que, a partir de ahí, la conversación cambia de objetivo: en lugar de buscar una solución al problema clínico, nosotros intentamos demostrar que el paciente no ha colaborado y él intenta demostrar lo contrario.

Pero, para cambiar el comportamiento, no necesitamos necesariamente una confesión. Si lo que observamos basta para entender que algo debe cambiar, podemos utilizar esa información para decidir qué hacer sin obligar al paciente a admitir que se ha equivocado o que nos ha dado una información incorrecta. **El protocolo debe permitirnos salir de la disyuntiva entre demostrar que el paciente se equivoca y aceptar su versión de los hechos:** podemos reconocer que el comportamiento debe cambiar sin tener que determinar antes quién tiene razón sobre lo ocurrido.

No se trata de ignorar lo que ha pasado ni de aceptar cualquier explicación. Significa, sencillamente, distinguir entre la información que necesitamos para tomar una decisión clínica y la que buscamos solo para determinar responsabilidades. Una vez reunida la primera, prefiero llevar la conversación del pasado al futuro. No siempre necesitamos determinar con absoluta precisión cuántas horas llevó el paciente los alineadores hace tres semanas, mientras que sí necesitamos establecer cómo deberá llevarlos a partir de mañana y cómo comprobaremos si el cambio funciona.

El pasado nos sirve para tomar una decisión, no para ganar una discusión.

3. Hacer concretas las consecuencias

Una vez reducida la necesidad de defenderse, debemos hacer comprensible por qué tiene que cambiar ese comportamiento. Aquí es donde entran realmente en juego las tres palancas: **el tiempo, el resultado y la inversión**.

Una de las cosas que más cambió mi forma de hablar con los pacientes fue comprender que una motivación expresada por el propio paciente puede tener mucho más significado que una que le dé yo. Durante años intenté explicar por qué era importante colaborar, cuando a menudo habría sido más útil detenerme antes y entender qué era realmente importante para la persona que tenía delante. La diferencia puede parecer mínima, pero cambia el equilibrio de la conversación: en el primer caso, soy yo quien le dice al paciente por qué debería querer algo; en el segundo, intento entender qué quiere ya y relaciono el comportamiento necesario con ese objetivo.

Este principio se acerca a lo que la literatura sobre influencia social describe en términos de **compromiso y coherencia**: las personas tienden a preferir comportamientos acordes con las posturas, los objetivos o los compromisos que reconocen como propios. No se trata de atrapar al paciente en sus propias palabras, sino de tomar lo que él mismo considera importante como referencia para su comporta-

miento posterior. Si un paciente me dice que su prioridad es terminar antes de la boda, no necesito convencerlo de que el tiempo es importante, porque acaba de decírmelo él. Si me explica que no le importa cuánto dure el tratamiento siempre que el resultado sea perfecto, insistir en la duración significa recurrir a la palanca equivocada. Si, en cambio, tiene muy presente **la inversión que ya ha hecho en el tratamiento**, probablemente tendrá más sentido relacionar su colaboración con la posibilidad de proteger lo que ha conseguido. **Por tanto, antes de intentar cambiar un comportamiento, debemos entender qué consecuencia tiene verdadero valor para la persona que tenemos delante.**

En ese momento tenemos que conseguir que esa consecuencia resulte concreta. Los ortodoncistas tendemos inevitablemente a describir los problemas mediante las categorías que aprendimos durante nuestra formación: vemos tracking, torque, anclaje, recidiva, estabilidad y movimientos que no se han producido, porque interpretamos el tratamiento a través de estos conceptos. El paciente, sin embargo, no vive el tratamiento desde las mismas categorías. Decir *«este canino no está realizando correctamente el movimiento planificado»* puede ser clínicamente impecable, pero no necesariamente crea una imagen significativa en la mente de quien nos escucha. Explicar que, si ese movimiento sigue quedándose atrás, quizá tengamos que detener la secuencia, hacer un nuevo escaneo y añadir algunos meses al tratamiento hace que el mismo problema sea mucho más concreto. **El tiempo, el resultado y la inversión no cambian la realidad clínica, pero nos permiten traducirla a algo que el paciente pueda valorar mediante categorías que tienen sentido para él.**

Este paso cobra especial importancia porque muchas consecuencias ortodóncicas se manifiestan a largo plazo. El paciente que esta noche decide no volver a ponerse los alineadores después de cenar no ve de inmediato una pérdida de tracking; el que se olvida de los elásticos no percibe esa noche el movimiento que no se producirá. El beneficio de colaborar suele llegar más tarde, mientras que la ventaja de saltarse las indicaciones es inmediata: puede comer más cómodamente, no tiene que buscar los elásticos, puede irse a dormir sin pensar en el tratamiento. Hacer concreta una consecuencia significa, por tanto, acortar esa distancia, vinculando mentalmente el comportamiento de hoy con algo que el paciente desea conseguir o evitar mañana.

También la forma en que presentamos esa consecuencia puede cambiar su significado. Uno de los principios centrales de la *teoría de las perspectivas* es que las personas no valoran las ganancias y las pérdidas de manera perfectamente simétrica y que, en muchos contextos de decisión, una pérdida puede tener un peso psicológico especialmente elevado. Podemos explicarle al paciente que usar

correctamente los elásticos le permitirá seguir avanzando hacia el resultado planificado o hacerle entender que una colaboración irregular puede poner en peligro una corrección que ya ha conseguido; podemos mostrarle el beneficio de terminar en los plazos previstos o hacerle ver la posibilidad de perder parte del tiempo que ya ha invertido.

Este principio debe utilizarse con responsabilidad. Hacer más evidente una consecuencia no significa necesariamente describirle al paciente todos los escenarios posibles dándoles la misma importancia: podemos optar por destacar el que consideremos más útil para que entienda la importancia del comportamiento que le pedimos y, en algunos casos, presentar de forma más tajante una posible consecuencia precisamente para reducir el riesgo de que la subestime. Si una pérdida de tracking puede requerir un nuevo escaneo o una colaboración irregular puede alargar el tratamiento, podemos recurrir a estas posibilidades para hacer más concreto el mensaje, aunque no sepamos con certeza si se producirán. **Una consecuencia no tiene que ser segura para comunicarla, pero sí debe seguir siendo lo bastante plausible como para poder sostenerla clínicamente.**

Hacer concreta una consecuencia también significa elegir con cuidado cómo la representamos. Durante mucho tiempo estuve convencido de que una explicación más detallada era necesariamente una explicación mejor, pero con los años he aprendido que el paciente rara vez recuerda todo lo que decimos durante una visita, sobre todo cuando la información es abundante, técnica o ajena a su experiencia cotidiana. Es mucho más probable que recuerde una imagen, una comparación, una frase o un número que le haya permitido transformar un concepto abstracto en algo fácil de entender de inmediato. Por eso, las fotografías, los escaneos, las metáforas, las comparaciones e incluso las simples referencias numéricas pueden convertirse en herramientas sumamente útiles.

No todos los números que utilizamos durante una conversación tienen que representar necesariamente una medición científica. A veces, un número puede cumplir una función meramente comunicativa: hace más intuitiva una proporción, da una idea de la magnitud de una consecuencia o ayuda al paciente a recordar el mensaje. **Lo importante es distinguir entre una simplificación utilizada para comunicar y un dato clínico presentado como si se hubiera medido científicamente.** Si muestro un escaneo o cito un dato real, ese dato debe ser correcto, por supuesto; si, en cambio, utilizo un número, una metáfora o una simplificación para hacer comprensible un concepto, ese recurso forma parte de la comunicación.

Nuestro objetivo no es transmitir al paciente toda la complejidad de nuestro razonamiento clínico, sino conseguir que la idea importante perdure después de la

visita y pueda volverle a la mente unas horas más tarde, cuando tenga que decidir cómo actuar.

4. Reducir la ambigüedad del comportamiento futuro

Una vez entendido por qué tiene que cambiar algo, debemos establecer **qué cambiará en concreto**. Expresiones como «*casi siempre*», «*todo lo que puedo*», «*solo algunas veces*», «*prácticamente todo el día*» o «*no puedo*» son perfectamente normales en el lenguaje cotidiano, pero describen muy mal un comportamiento clínicamente relevante.

Para nosotros, «*llevar los alineadores*» puede significar llevarlos veintidós horas al día; para el paciente, puede significar haberlos llevado la mayor parte del día, habérselos vuelto a poner con cuidado antes de la cita o haberlos llevado siempre que ha podido. Por tanto, el profesional y el paciente pueden utilizar las mismas palabras y darles significados muy distintos.

Durante mucho tiempo, mi reacción fue discutir esas afirmaciones. Si lo que observaba clínicamente me indicaba algo distinto, intentaba convencer al paciente de que su «*siempre*» no era realmente siempre. Hoy prefiero hacer algo mucho más sencillo: intento **concretar lo que me cuenta**. No discuto sobre el significado de «*siempre*», sino que reconstruyo un día de su rutina; no intento determinar si «*no puedo*» es cierto o falso, sino entender en qué momento concreto aparece la dificultad.

Si el paciente me dice que siempre lleva los alineadores, puedo preguntarle a qué hora desayuna, cuánto tiempo se los quita, qué sucede durante la comida, si toma café por la tarde, cómo se organiza para cenar y a qué hora vuelve a ponérselos antes de acostarse. Si, en cambio, me dice que no consigue llevar los elásticos, puedo intentar averiguar cuándo le pasa: en el trabajo, mientras habla, por la noche o cuando sale; puedo preguntarle si se le olvidan, si no los lleva encima o si las molestias se vuelven excesivas al cabo de unas horas. No estoy montando un interrogatorio para pillarlo en una contradicción, sino transformando una valoración general y subjetiva en una secuencia de comportamientos que podemos observar y, si es necesario, cambiar. **Cuando el problema se concreta, muy a menudo también resulta más fácil de abordar.**

El mismo principio debe aplicarse cuando definimos qué tendrá que suceder a partir de ese momento. Cuanto más importante sea una indicación para el resultado, menos debería depender de la interpretación personal. «*Intenta llevar los elásticos todo lo que puedas*» deja muchísimo margen a la ambigüedad; definir cuándo

debe ponérselos, cuándo puede quitárselos y qué hacer si se le olvidan convierte, en cambio, una recomendación genérica en un comportamiento observable. Aquí es donde resultan útiles las *intenciones de implementación* de las que hablamos al principio del capítulo. Decirle al paciente «*tienes que acordarte de los elásticos*» le deja la tarea de recordarlo cada vez; establecer con él una regla como «*cuando termino de lavarme los dientes por la noche, me pongo los elásticos*» vincula, en cambio, el comportamiento a una situación fácil de reconocer. No hemos cambiado la indicación, pero sí hemos facilitado que se convierta en una rutina.

Reducir la ambigüedad también significa prestar atención a cómo formulamos nosotros mismos las indicaciones. En una relación terapéutica hay inevitablemente una diferencia de conocimientos: el paciente acude a nosotros precisamente porque espera que sepamos distinguir lo necesario de lo facultativo. Sin embargo, en nuestro comprensible intento de no parecer autoritarios, a veces somos nosotros mismos quienes hacemos que parezca negociable algo que, desde el punto de vista clínico, no lo es.

Expresiones como «*a lo mejor puedes probar*», «*sería mejor*», «*intenta hacerlo*» o «*a ver si puedes*» son perfectamente adecuadas cuando de verdad estamos proponiendo algo opcional, pero se vuelven problemáticas cuando se refieren a un comportamiento que consideramos necesario para que el tratamiento funcione. Tener autoridad no significa ser duro ni valerse de nuestra condición de médicos para obtener obediencia ciega, sino asumir la responsabilidad de decir con claridad cuándo una determinada condición es necesaria para alcanzar el objetivo que hemos acordado.

Esto cobra especial importancia cuando el paciente busca, como es comprensible, una solución más sencilla. Si nos pregunta si puede llevar los alineadores menos horas, prescindir de los elásticos o reducir una indicación que consideramos necesaria, el deseo de mantener una relación agradable puede llevarnos a hacer que parezca negociable algo que, desde el punto de vista clínico, no lo es. La solución que me ha resultado más útil consiste en distinguir el **qué** del **cómo**. El *qué* corresponde a la indicación clínica: si un determinado comportamiento es necesario para el tratamiento, no tiene sentido fingir que no lo es. El *cómo*, en cambio, a menudo puede decidirse junto con el paciente, dejándole margen para organizarse, establecer una rutina y encontrar la manera de integrar ese comportamiento en su vida cotidiana.

Por tanto, el paciente no decide si un elemento clínicamente necesario del tratamiento lo es o no, pero sí puede participar en la decisión de cómo hacerlo compatible con su día a día. Es un equilibrio que considero fundamental: **autoridad respecto a la necesidad clínica y autonomía para elegir la estrategia de comportamiento**.

5. Facilitar el comportamiento y comprobar su efecto

Haber definido con precisión qué debe hacer el paciente no significa todavía que vaya a conseguirlo. El problema no siempre se debe a la falta de motivación: puede que un comportamiento sea difícil de incorporar a la rutina, exija tomar demasiadas decisiones, dependa de acordarse en el momento menos oportuno o esté ligado a una situación en la que el paciente no tiene a mano lo que necesita.

En estos casos, insistir más sirve de relativamente poco, mientras que puede resultar mucho más útil modificar el entorno en el que debería producirse ese comportamiento. Es uno de los conceptos en los que se basa la **arquitectura de la elección**: la idea de que toda decisión se toma en un contexto y de que la forma de organizarlo puede facilitar o dificultar determinadas acciones.

En esta lógica se inscribe el principio del *nudging*: pequeñas intervenciones que facilitan un comportamiento beneficioso sin impedir las alternativas. Un recordatorio, una revisión más próxima, un paquete de elásticos guardado en el lugar adecuado o una rutina vinculada a un hábito que ya existe pueden acortar la distancia entre la intención que el paciente expresa y lo que hace cada día.

El paciente que se olvida de los elásticos antes de acostarse podría, por ejemplo, vincular el momento de ponérselos a algo que ya hace todas las noches, como lavarse los dientes o dejar el teléfono en la mesilla. Quien tiende a dejar los alineadores en casa podría organizar su rutina para llevar siempre consigo lo que necesita. En estos casos no hemos aumentado necesariamente la motivación, pero sí hemos reducido las dificultades que impedían convertir la intención en acción. **Por tanto, nuestro objetivo no es solo convencer al paciente de que haga algo, sino conseguir que ese comportamiento sea lo bastante sencillo como para formar parte de su vida cotidiana.**

En este punto, sin embargo, aún falta un elemento: **el feedback**. Uno de los problemas de los tratamientos ortodóncicos es que muchas consecuencias tardan en aparecer. El paciente puede llevar los alineadores menos tiempo del necesario durante varios días sin notar ninguna diferencia evidente y puede olvidarse de los elásticos durante semanas sin percibir de inmediato lo que está ocurriendo. Cuando por fin el problema se hace visible clínicamente, puede que haya pasado mucho tiempo desde el comportamiento que lo causó y la relación entre causa y efecto resulta mucho menos evidente.

Por eso, mostrar una fotografía anterior, comparar dos escaneos, señalar un punto en el que el alineador ya no se ajusta correctamente o enseñarle que un movimiento se ha quedado atrás puede ser mucho más eficaz que repetir por enésima vez

la misma recomendación. El feedback hace visible algo que, de otro modo, seguiría siendo abstracto y permite al paciente relacionar más fácilmente lo que hace cada día con lo que está ocurriendo durante el tratamiento.

El feedback, sin embargo, no debe convertirse en una prueba para un juicio. No mostramos el escaneo para decir «*¿Ve que yo tenía razón?*», porque en ese momento habríamos convertido un instrumento clínico en un arma dentro de la discusión. Lo utilizamos para hacer visible la relación entre lo que está ocurriendo y lo que tendrá que cambiar.

Pero el feedback no solo le sirve al paciente. **También nos sirve a nosotros para comprobar si la hipótesis en la que basamos nuestra intervención era correcta.** Si hemos identificado un comportamiento problemático, hemos intentado modificarlo y, tras un intervalo adecuado, el tratamiento sigue sin responder como esperábamos, no podemos limitarnos a concluir que el paciente sigue colaborando mal. Debemos estar dispuestos a reconsiderar lo que habíamos supuesto y preguntarnos si existe un problema clínico, biológico o biomecánico que no habíamos detectado.

El feedback cierra, por tanto, el protocolo y, al mismo tiempo, puede hacer que vuelva a empezar. Desplaza la conversación de la confianza personal a los elementos observables: no tenemos que decidir si creemos o no al paciente, sino que podemos observar juntos lo que está sucediendo, decidir qué modificar y comprobar lo bastante pronto si la nueva estrategia funciona. **Un protocolo no termina cuando le hemos dicho al paciente qué debe hacer, sino cuando hemos comprobado que lo que hemos decidido juntos está produciendo el efecto que buscábamos.**

Responsabilidad compartida, funciones distintas

Un tratamiento ortodóncico es inevitablemente una colaboración en la que el profesional y el paciente participan en un mismo proceso con responsabilidades diferentes. Nosotros somos responsables del diagnóstico, la planificación, las decisiones clínicas, las revisiones y los cambios necesarios durante el tratamiento; el paciente tiene otras responsabilidades, entre ellas seguir las indicaciones, llevar correctamente los alineadores y los elásticos, acudir a las citas y avisarnos cuando algo no funciona.

Por tanto, responsabilidad compartida no significa responsabilidad indiferenciada. Decir simplemente «*el resultado depende de los dos*» solo es correcto si después somos capaces de aclarar qué parte depende de nosotros y cuál del paciente. Esto nos permite evitar dos extremos opuestos: atribuir automáticamente al paciente

cualquier problema o asumir nosotros la responsabilidad incluso de comportamientos sobre los que no tenemos ningún control directo.

También es uno de los motivos por los que los protocolos deberían comenzar **antes de que surja el problema**. Definir las funciones cuando todo va bien es mucho más sencillo que intentar establecerlas cuando el tratamiento ya ha perdido el tracking y el profesional y el paciente intentan averiguar de quién es la responsabilidad.

Lo mismo ocurre con las consecuencias. Si un determinado comportamiento puede hacer necesario un nuevo escaneo, alterar los plazos o cambiar la forma en que tendremos que proceder, es preferible que el paciente lo sepa antes de que se produzca esa situación. **Una consecuencia explicada después del problema puede percibirse como un castigo; esa misma consecuencia, definida de antemano, se convierte en una condición del proceso terapéutico.**

Un protocolo debe ser de toda la clínica

Por último, hay un aspecto que considero indispensable: un protocolo no puede existir solo en la cabeza del ortodoncista, porque durante un tratamiento el paciente habla con el personal de recepción, con las auxiliares, con los higienistas, con otros profesionales y con todas las personas que participan en su tratamiento. Si cada una le comunica una regla distinta, esa regla deja enseguida de ser una regla.

No hace falta que todos utilicen exactamente las mismas palabras. Una repetición demasiado rígida podría resultar artificial e impedir que cada miembro del equipo se comunique con naturalidad. Lo indispensable es que **el significado de la respuesta no cambie**.

El personal de recepción debe saber qué citas se pueden cambiar, qué consecuencias organizativas debe comunicar y qué decisiones corresponden exclusivamente al clínico. Las auxiliares deben conocer el significado de las indicaciones y no convertir sin querer una condición necesaria en un simple consejo. El profesional, por su parte, no puede desautorizar delante del paciente una postura que el equipo ha mantenido correctamente conforme al protocolo compartido.

Así, el paciente puede hablar con distintas personas, pero debería seguir percibiendo **una única dirección clínica**. Si el profesional presenta una indicación como indispensable y la auxiliar como opcional, no podemos sorprendernos de que el paciente elija la interpretación que menos esfuerzo le exige. Del mismo modo, si una regla o una consecuencia cambia según la persona con la que hable, esa regla se vuelve inevitablemente negociable.

La coherencia del equipo no significa, por tanto, que todos repitamos las mismas frases, sino que compartamos las mismas condiciones, los mismos límites y la misma dirección. **Un protocolo solo lo es de verdad cuando deja de ser la respuesta personal del profesional y se convierte en la forma coherente en que toda la clínica aborda una situación que ya conoce.**

De los principios a las estrategias

Ninguno de los principios descritos en este capítulo es una fórmula mágica y ninguno, por sí solo, basta para construir un protocolo. No tendremos que utilizar siempre el encuadre, la aversión a la pérdida, el nudging, el feedback y todas las demás herramientas a la vez, porque una conversación planteada así resultaría artificial y probablemente también ineficaz.

Cada estrategia deberá seleccionar únicamente los elementos útiles para el problema que tengamos delante. En algunos casos tendremos que centrarnos en reducir la actitud defensiva; en otros, en hacer más concreta una consecuencia, reducir la ambigüedad, facilitar un comportamiento o establecer con mayor claridad una condición clínica. La psicología cognitiva y la economía conductual no nos proporcionan, por tanto, un guion que recitar, sino herramientas que pueden ayudarnos a comprender por qué algunas respuestas facilitan el cambio mientras que otras nos llevan más fácilmente al enfrentamiento.

También la forma deberá adaptarse a la persona que tengamos delante. Un paciente directo puede necesitar una explicación breve y orientada a tomar una decisión, mientras que uno más analítico requerirá información y pasos más detallados, y una persona más insegura podría necesitar que avancemos de forma más gradual y le transmitamos más tranquilidad. Lo que no debería cambiar es la lógica del protocolo: **reducir la actitud defensiva, proteger a la persona sin justificar su comportamiento, hacer concretas las consecuencias, definir con precisión el comportamiento futuro, facilitar que lo lleve a cabo y comprobar su efecto**.

Los protocolos que presento en las próximas páginas nacen de observar situaciones clínicas con las que me he encontrado repetidamente, de las respuestas que al principio no funcionaron y de los cambios que fui introduciendo con el tiempo. No deben interpretarse como fórmulas universales capaces de provocar siempre la misma reacción, porque el comportamiento humano conserva inevitablemente cierto grado de variabilidad y ninguna secuencia de comunicación puede garantizar la colaboración. Su valor no reside en eliminar esa variabilidad, sino en permitirnos abordar situaciones similares mediante un método reconocible, que podamos

observar, debatir y mejorar. **Una respuesta improvisada desaparece con esa conversación concreta; un método que se puede repetir, en cambio, permite que toda la clínica aprenda.**

Por eso, en los capítulos siguientes, cada protocolo seguirá una estructura reconocible. Partiremos de la situación clínica y de las señales que nos permiten identificarla, determinaremos qué comportamiento debe cambiar y cuáles son los errores más frecuentes que pueden aumentar la resistencia del paciente; después definiremos la secuencia de actuación, las preguntas que debemos hacer, los elementos que hay que comprobar y las consecuencias que conviene anticipar. El diálogo clínico mostrará cómo expresar esa estructura con palabras concretas, mientras que el recuadro **«Por qué funciona este protocolo»** nos permitirá volver, cuando resulte útil, a los principios psicológicos que acabamos de describir.

Esta distinción entre procedimiento y explicación es importante, porque el compañero debe saber qué decir y qué hacer, pero también debería comprender por qué una determinada secuencia puede ser más eficaz que acusar al paciente, darle una reprimenda genérica o limitarse a repetir las instrucciones. Solo si comprendemos el mecanismo podremos cambiar las palabras sin alterar la función del protocolo.

El objetivo, por tanto, no es crear una colección de «*frases ingeniosas*» ni convertir al ortodoncista en un experto en persuasión. Me gustaría llegar a algo mucho más sencillo y útil: conseguir que, ante un paciente que no colabora, nuestro primer pensamiento deje poco a poco de ser «*¿cómo se lo explico otra vez?*» y pase a ser «*¿qué le impide a esta persona hacer lo que ya sabe que debe hacer, qué consecuencia tiene verdadero valor para ella y qué protocolo puedo utilizar para aumentar la probabilidad de que cambie ese comportamiento?*»

Durante muchos años hemos planificado con suma precisión el movimiento de los dientes, pero hemos dejado a la improvisación las conversaciones necesarias para proteger esa planificación. Hemos repetido las instrucciones, intentado motivar al paciente y buscado cada vez una frase nueva; cuando el problema reaparecía, volvíamos a empezar de cero.

Los protocolos cambian esta perspectiva. No pretenden hacer predecible el comportamiento del paciente y, desde luego, no pueden controlarlo, pero nos permiten hacer más predecible **nuestra respuesta**. Si algunos comportamientos siguen patrones reconocibles, podemos aprender a reconocerlos; si podemos reconocerlos, podemos prepararnos para abordarlos y, si podemos prepararnos para abordarlos, nuestra respuesta puede dejar por fin de ser una improvisación y convertirse en un método.

Aquí comienza la parte más práctica de este libro.

BIBLIOGRAFÍA

Gollwitzer PM. Implementation intentions: strong effects of simple plans. *Am Psychol.* 1999;54(7):493-503.

Tversky A, Kahneman D. The framing of decisions and the psychology of choice. *Science.* 1981;211(4481):453-458.

Cialdini RB. *Influence: The Psychology of Persuasion.* Rev ed. New York: Harper Business; 2006.

Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica.* 1979;47(2):263-291.

Thaler RH, Sunstein CR. *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.* New Haven: Yale University Press; 2008.

Thaler RH, Sunstein CR, Balz JP. Choice architecture. In: Shafir E, ed. *The Behavioral Foundations of Public Policy.* Princeton: Princeton University Press; 2013:428-439.

CAPÍTULO

6

El paciente que no usa los alineadores

«Hacer bien vale más que hablar bien».

— BENJAMIN FRANKLIN

Hay situaciones en las que basta con observar los alineadores en boca para darse cuenta de que algo no está yendo como habíamos planeado, pero no todas las pérdidas de ajuste tienen el mismo significado y, sobre todo, no todas requieren la misma respuesta clínica.

Si un solo diente no sigue perfectamente el alineador, no pienso automáticamente que haya un problema de colaboración y no interrumpo necesariamente la secuencia para hacer un nuevo escaneo. Sabemos bien que algunos movimientos son menos predecibles que otros: un incisivo lateral superior que debe realizar una rotación compleja, una extrusión difícil u otro movimiento especialmente compli-

cado puede quedarse atrás incluso en un paciente que usa los alineadores de forma impecable. Si ese movimiento no es decisivo para continuar el tratamiento y el hecho de que no se produzca no compromete los movimientos posteriores, muchas veces prefiero seguir con la secuencia programada y corregirlo más adelante, durante la fase de refinamiento.

La situación cambia cuando la pérdida de ajuste deja de afectar a un solo diente y empieza a generalizarse. **Por eso, normalmente programo la primera revisión durante la secuencia al cabo de unos dos meses.** Considero que es un intervalo lo bastante largo para saber cómo está usando realmente el paciente los alineadores y empezar a observar una posible pérdida de ajuste, pero al mismo tiempo lo bastante breve para permitirme intervenir, en la mayoría de los casos, antes de que la discrepancia sea demasiado grande. Si en esa revisión veo que varios dientes empiezan a quedarse atrás respecto a la posición programada, a menudo todavía estamos a tiempo de recuperar el ajuste cambiando el comportamiento del paciente o ralentizando temporalmente la secuencia, sin tener que interrumpirlo todo y hacer un nuevo escaneo.

Cuando en esta primera revisión observo una pérdida de ajuste que ya no afecta a un solo movimiento, sino que va implicando progresivamente a más dientes, la sospecha de que el paciente no lleva los alineadores el número de horas necesario se vuelve inevitablemente muy fuerte. Es justo entonces cuando surge uno de los problemas de comunicación más frecuentes en el tratamiento con alineadores y, para entender qué está pasando, empiezo con una pregunta muy sencilla:

> *«¿Cómo va con los alineadores? ¿En qué momento del día te cuesta más volver a ponértelos?»*

Esta pregunta me ayuda más que un genérico *«¿Consigues llevarlos siempre?»*, al que el paciente tiende casi inevitablemente a responder que sí. Entonces intento reconstruir mejor lo que ocurre a lo largo de un día normal: le pregunto cuándo se los quita, cuánto duran las comidas, qué pasa durante el trabajo, cuando sale por la noche o durante el fin de semana. Presto especial atención al tiempo que transcurre entre el final de la comida y el momento en que vuelve a ponerse los alineadores, porque a menudo es ahí, más que durante la propia comida, donde se acumulan las horas sin ellos.

No lo hago como si fuera un interrogatorio, sino intentando averiguar junto con el paciente si hay momentos en los que, sin darse cuenta, pasa más tiempo sin alineadores del que cree. Al final, sin embargo, puede ocurrir que siga completamente seguro de su respuesta:

«No, doctor. De verdad que los llevo siempre».

En ese momento tengo ante mí dos datos que parecen difíciles de conciliar: por un lado, lo que observo clínicamente me indica que los dientes no están siguiendo los alineadores como deberían; por otro, tengo delante a una persona que me asegura con total convicción que ha seguido escrupulosamente todas las indicaciones recibidas.

El comportamiento que debemos cambiar

El comportamiento sobre el que queremos intervenir no es simplemente «*colaborar más*». Debemos conseguir que el paciente lleve los alineadores el número de horas necesario, reduciendo sobre todo esos periodos del día en los que pasan fuera de la boca más tiempo del que él mismo cree.

Esto es importante porque muchas veces el problema no nace de una decisión consciente de llevar poco los alineadores, sino de la suma de muchos intervalos aparentemente insignificantes: un desayuno que dura más de lo previsto, el café después de comer, una llamada antes de volver a ponérselos, un aperitivo, una cena que se alarga o, simplemente, dejarlos encima de la mesa y acordarse de ellos una hora después. Por separado parecen episodios sin importancia; sumados a lo largo del día pueden reducir considerablemente el tiempo real de uso.

Por eso, el primer objetivo no es determinar si el paciente dice la verdad, sino convertir un genérico «*los llevo siempre*» en una descripción lo bastante concreta de su día como para permitirnos entender dónde puede estar el problema.

El error que cometía: intentar convencer al paciente

Ante estas situaciones elegía lo que me parecía más sencillo y lógico. Si veía una pérdida generalizada de ajuste, le explicaba al paciente que probablemente no estaba llevando los alineadores el tiempo suficiente e insistía en que tenía que aumentar las horas de uso. Le mostraba lo que observaba clínicamente y le decía algo así:

«Mira, aquí se ve claramente que los dientes no están siguiendo los alineadores. Tienes que intentar llevarlos más tiempo».

El problema era que casi siempre recibía la misma respuesta:

«Pero si yo los llevo».

Yo veía la pérdida de ajuste e insistía, mientras que el paciente reiteraba que había seguido las indicaciones. Cuanto más intentaba convencerlo de que el problema era

su falta de colaboración, más necesidad sentía él de defender su comportamiento y, al cabo de unos minutos, ya no discutíamos cómo reconducir el tratamiento, sino cuál de los dos tenía razón.

Esta dinámica puede hacerse aún más evidente cuando tenemos delante a un paciente adulto muy seguro de sí mismo, quizá alguien con un puesto profesional importante, acostumbrado a tomar decisiones, dirigir a otras personas y defender con firmeza sus opiniones. Decirle abiertamente a ese paciente «*No es verdad, no estás llevando los alineadores*» significa cuestionar no solo su colaboración, sino también su credibilidad.

En ese momento, el problema clínico corre el riesgo de convertirse en un enfrentamiento personal en el que ambos intentamos, de forma más o menos consciente, demostrar que tenemos razón. La paradoja es que, aunque consiguiera ganar esa discusión, no habría logrado necesariamente lo que de verdad me importa, porque mi objetivo no debería ser convencer al paciente de que se ha equivocado durante las semanas anteriores, sino conseguir que lleve correctamente los alineadores de ahí en adelante.

Tardé un tiempo en entenderlo y, probablemente, necesité encontrarme con una paciente en particular para cambiar por completo de perspectiva.

La paciente a la que no creía

Había tratado con alineadores primero al marido de Chantal y después a sus dos hijos. Los tres habían colaborado mucho y sus tratamientos habían concluido sin especiales dificultades, así que, cuando ella también decidió arreglarse los dientes, no tenía ningún motivo para esperar algo distinto. El suyo era, al menos en apariencia, un caso muy sencillo, con algo de apiñamiento sobre todo en los incisivos inferiores y nada que, desde el punto de vista biomecánico, me hiciera prever dificultades especiales.

Empezamos el tratamiento y, ya en las primeras revisiones, me di cuenta de que algo no iba según lo previsto: los incisivos se movían mucho menos de lo que esperaba y los alineadores iban perdiendo ajuste. Ella trabajaba en el mundo de la moda, viajaba muchísimo y tenía una vida profesional especialmente intensa, llena de eventos, aperitivos y otros encuentros en los que es fácil olvidarse de los alineadores. Por eso, para mí, la explicación parecía casi obvia: sencillamente, no los llevaba el tiempo suficiente.

Empecé entonces a insistir en que debía colaborar, recordándole que tenía que llevar los alineadores el número de horas prescrito y explicándole que, si seguía

así, los dientes no se moverían conforme a lo planificado. Ella, sin embargo, seguía repitiéndome lo mismo:

«Enzo, yo los llevo».

Yo seguía mirando aquellos incisivos y seguía sin creerla. La situación se prolongó durante más de seis meses, hasta que Chantal me dijo que al cabo de unos meses se trasladaría a Londres por trabajo y me pidió que termináramos el tratamiento antes de que se marchara. Entonces pensé en eliminar de una vez por todas lo que, para mí, seguía siendo la causa principal del problema y le propuse colocarle brackets en los incisivos inferiores, prometiéndole que en un par de meses estarían perfectamente alineados. Estaba bastante tranquilo, porque estaba convencido de que, una vez eliminada la variable de la colaboración, aquellos pocos dientes se alinearían rápidamente.

Después de dos meses, los incisivos seguían torcidos.

Fue probablemente la primera vez que consideré de verdad una posibilidad que hasta entonces casi había descartado: quizá aquella paciente nunca me había mentido y el problema que durante meses había atribuido a su falta de colaboración podía deberse, al menos en parte, a su respuesta biológica al movimiento ortodóncico.

Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todos los pacientes

Aquella experiencia me llevó a interesarme más por la variabilidad individual del movimiento ortodóncico y descubrí que lo que había observado clínicamente tenía una base biológica mucho más sólida de lo que imaginaba.

Cuando aplicamos una fuerza ortodóncica, en realidad no estamos desplazando mecánicamente un diente como desplazaríamos un objeto. La fuerza es el estímulo inicial de una compleja respuesta biológica en la que intervienen el ligamento periodontal, el hueso alveolar, los osteoclastos, los osteoblastos, los mediadores de la inflamación y numerosos mecanismos celulares y moleculares. La velocidad a la que se produce esta respuesta presenta una considerable variabilidad individual y, aunque intentemos estandarizar la fuerza aplicada, distintas personas pueden mostrar velocidades de movimiento muy diferentes.

Uno de los estudios que mejor demuestra este fenómeno lo publicaron Giannopoulou y sus colaboradores en el *European Journal of Orthodontics*. Los autores aplicaron un protocolo experimental estandarizado en el que se desplazaron en sentido vestibular dos premolares de cada participante durante ocho semanas con

una fuerza de 1 N. Pese a que la fuerza estaba estandarizada y se habían descartado obstáculos locales o funcionales para el movimiento, la magnitud del desplazamiento varió enormemente entre individuos: desde apenas 0,6 mm hasta 5,8 mm, con una media de 2,7 mm. Aún más interesante fue observar que los dientes de un mismo individuo tendían a comportarse de forma similar, con una elevada correlación intraindividual. Los propios autores concluyeron que esta amplia variabilidad permitía identificar, dentro de la muestra, sujetos *slow movers* y *fast movers*.

El concepto se ha retomado también en estudios clínicos posteriores. En un ensayo aleatorizado sobre el cierre de espacios tras extracciones, por ejemplo, los autores utilizaron expresamente las expresiones *fast movers* y *slow movers* para distinguir a pacientes que, en un mismo intervalo de tiempo, presentaban distintas magnitudes de movimiento dentario. En ese estudio concreto, se definió como *fast movers* a los casos con un movimiento de al menos 1 mm al mes. Naturalmente, este umbral no es una definición universal que podamos trasladar a la práctica clínica ni nos permite dividir sin más a todos nuestros pacientes en dos categorías, pero demuestra hasta qué punto la idea de que la velocidad de movimiento varía de una persona a otra es real y se utiliza en la propia literatura ortodóncica.

Las causas de esta variabilidad probablemente son múltiples y aún no se conocen por completo. El movimiento ortodóncico depende de la respuesta biológica de los tejidos a la fuerza y se han estudiado diferencias individuales en los sistemas moleculares que intervienen en la remodelación ósea y del ligamento periodontal. Algunas investigaciones también han analizado la posible contribución genética y, en particular, polimorfismos de genes implicados en los sistemas RANK, RANKL y OPG y en otros mediadores de la respuesta ortodóncica. Es interesante que, también en este ámbito, los autores hagan referencia explícita al fenómeno clínico de los *slow movers* y los *fast movers*, y planteen la hipótesis de que al menos parte de la diferencia en la velocidad de movimiento pueda deberse a las características biológicas de cada individuo.

Esta variabilidad biológica, naturalmente, también existía cuando realizábamos los tratamientos con aparatología fija. En ese contexto, sin embargo, un *slow mover* suponía sobre todo un problema de tiempo. Si un diente aún no había alcanzado la posición deseada, en la mayoría de los casos podíamos simplemente dejar actuar el mismo arco más tiempo y esperar a que la respuesta biológica siguiera su curso. Como siempre me ha dicho mi gran maestro Davide Mirabella: *«Let them cook».* Déjalos cocinar. A veces, lo mejor era simplemente dar a los dientes el tiempo necesario para que se produjera el movimiento.

Que aquel paciente necesitara más tiempo no nos obligaba necesariamente a modificar la secuencia del tratamiento: podíamos adaptar el ritmo del tratamiento a la velocidad a la que realmente se movían sus dientes.

Con los alineadores, el problema adquiere otra dimensión, porque ya no se trata solo de cuánto tarda el diente en moverse, sino de hasta qué punto su velocidad biológica puede mantenerse sincronizada con la secuencia programada. Cada alineador se diseña dando por supuesto que el movimiento previsto por el alineador anterior se ha producido en grado suficiente. Si el paciente es un *slow mover* y seguimos cambiando los alineadores a un ritmo demasiado rápido para su respuesta biológica, el diente puede ir quedándose atrás respecto a la posición prevista. El siguiente alineador intenta entonces ajustarse a una posición que el diente aún no ha alcanzado y esa discrepancia, cambio tras cambio, puede acumularse hasta hacerse clínicamente evidente en forma de pérdida de ajuste.

Esta es probablemente una de las razones por las que el concepto de *slow mover*, aunque no es en absoluto nuevo, cobra especial relevancia en el tratamiento con alineadores. Con la aparatología fija, a menudo podíamos permitirnos simplemente esperar más tiempo; con los alineadores, en cambio, debemos intentar acompasar el ritmo al que avanzamos en la secuencia con la velocidad a la que la respuesta biológica de ese paciente permite realmente que se produzca el movimiento.

Naturalmente, todo esto no significa que una pérdida generalizada de ajuste deba atribuirse automáticamente a la biología, ni que ser un *slow mover* sea la explicación más probable cada vez que un tratamiento con alineadores no avanza según lo previsto. La colaboración sigue siendo una de las primeras variables que debemos tener en cuenta cuando varios dientes empiezan a perder ajuste a la vez. Sin embargo, la literatura sobre los *slow movers* nos recuerda algo igual de importante: la observación clínica por sí sola no siempre nos permite saber con certeza hasta qué punto lo que vemos se debe al comportamiento del paciente y hasta qué punto puede influir su respuesta biológica individual.

Al final, Chantal me había enseñado precisamente eso. En su caso, había eliminado la variable de la colaboración al pasar a la aparatología fija y los dientes habían seguido moviéndose lentamente: **realmente era una *slow mover*.** Pero aquella experiencia también me hizo entender otra cosa. Si una respuesta biológica más lenta podía explicar realmente una pérdida de ajuste, también podía recurrir a esa posibilidad clínica cuando tenía delante a un paciente del que sospechaba firmemente que, en realidad, el problema era la colaboración, sin tener que acusarlo ni demostrar que lo que me contaba no se correspondía con lo que hacía en realidad.

De ahí surgió, con los años, una de las estrategias que utilizo con más frecuencia.

No tengo que demostrar que el paciente miente

Hoy, cuando veo a un paciente con una pérdida generalizada de ajuste, ya no empiezo acusándolo ni intento convencerlo de inmediato de que no está llevando los alineadores. Primero intento reconstruir con él lo que está ocurriendo, repasando sus hábitos diarios y buscando posibles momentos en los que los alineadores pasan fuera de la boca más tiempo del que el propio paciente cree. Este paso también es importante por todo lo que hemos visto en la primera parte del libro sobre la memoria reconstructiva y la diferencia que puede existir entre el comportamiento real y la forma en que cada uno de nosotros recuerda y cuenta su propio comportamiento.

Si, después de esta conversación, el paciente sigue asegurándome que lleva los alineadores exactamente como se le ha indicado, ya no intento demostrarle lo contrario, sino que decido deliberadamente aceptar su versión e introduzco otra posible explicación:

> «*Mira, tenemos dos datos que debemos encajar. Yo veo que tus dientes no siguen los alineadores a la velocidad que habíamos previsto y tú me dices que los estás llevando correctamente. Si es así, tenemos que considerar otra posibilidad*».

Normalmente, en este punto el paciente presta mucha atención, porque no se siente acusado y quiere entender cuál puede ser esa otra explicación. Continúo:

> «*Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todas las personas. La mayoría de los pacientes responde en los plazos que solemos utilizar, pero hay un pequeño porcentaje de personas cuya respuesta biológica es mucho más lenta. En la literatura también se utilizan los términos fast movers y slow movers. Si de verdad estás llevando los alineadores como me dices y los dientes siguen quedándose atrás, tenemos que considerar la posibilidad de que seas un slow mover*».

En este punto no he contradicho al paciente ni le he pedido que admita nada. Al contrario, he dado por buena su versión de los hechos, pero precisamente porque la he aceptado debo extraer de ella una consecuencia clínica coherente:

> «*Si tus dientes se mueven más despacio, puede que una semana no sea suficiente para que sigan por completo el movimiento programado en cada alineador. Si aun así siguiéramos cambiándolos cada siete días, correríamos el riesgo de acumular progresivamente un retraso entre la posición prevista y la posición real de los dientes, empeorando cada vez más el ajuste*».

La consecuencia que planteo es sencilla:

«Por eso, al menos de momento, en vez de cambiar de alineador cada semana deberíamos hacerlo cada tres semanas. Después comprobaremos cómo están respondiendo los dientes y, si vemos que el ajuste mejora, podremos probar a acelerar progresivamente y pasar, por ejemplo, a cambiarlo cada dos semanas».

El cambio cada tres semanas es una decisión clínica prudente por mi parte, no un intervalo que la literatura haya identificado como necesario para todos los pacientes con una respuesta biológica más lenta. Para el paciente, sin embargo, pasar de siete a veintiún días hace inmediatamente concreta una consecuencia que hasta entonces podía haberle parecido abstracta: si necesitáramos tres veces más tiempo del previsto para cada alineador, de mantener ese ritmo, la duración total del tratamiento podría llegar a triplicarse.

Y es precisamente en ese momento cuando, muy a menudo, ocurre lo más interesante.

El paciente se queda pensándolo unos segundos y empieza espontáneamente a reconstruir su comportamiento de otra manera:

«Bueno, doctor, la verdad es que veintidós horas todos los días, quizá no. Los fines de semana a veces los llevo menos y, cuando salgo, puede que esté más tiempo sin ellos. Si me esfuerzo de verdad por llevarlos siempre, ¿podemos seguir cambiándolos cada semana?».

Es importante entender que no le he pedido que confiese nada. No le he dicho que no le creo ni he intentado demostrar que me estuviera mintiendo. Simplemente he tomado en serio lo que me contaba y le he mostrado cuál sería la consecuencia clínica lógica si de verdad, pese a llevarlos correctamente, sus dientes no pudieran seguir el ritmo programado.

En cuanto entiende que eso podría significar pasar de siete a veintiún días y, por tanto, alargar enormemente el tratamiento, también cambia su forma de valorar esas horas sin alineadores. Lo que hasta unos minutos antes resumía con *«los llevo siempre»* puede convertirse en *«la verdad es que los fines de semana los llevo un poco menos»*, o en *«cuando salgo, a veces estoy bastante tiempo sin ellos»*.

Y, cuando eso ocurre, en la mayoría de los casos **no paso a cambiarlos cada tres semanas**. Si el paciente reconoce espontáneamente que los ha llevado menos horas de las prescritas y me dice que quiere intentar ser más riguroso, mantengo el cambio semanal y le doy la oportunidad de demostrarlo con lo que ocurra en las semanas siguientes. En cambio, el cambio cada tres semanas sigue siendo la consecuencia clínica lógica cuando el paciente continúa asegurándome que ha llevado correctamente los alineadores.

En otras palabras, no utilizo la ralentización como castigo. Utilizo el Tiempo para hacer concreta la consecuencia de lo que estoy observando y permitir que el paciente decida si cambia su comportamiento.

En esta fase, la palanca más poderosa es el Tiempo

Como ya he explicado, el Tiempo, el Resultado y la Inversión son tres de las palancas que utilizo con más frecuencia al comunicarme durante un tratamiento con alineadores, pero no todas tienen el mismo peso en cada momento del tratamiento.

Cuando el paciente lleva solo unos meses de tratamiento, recurrir a la palanca de la Inversión suele tener poco sentido, porque el tratamiento acaba de empezar y el paciente acaba de afrontar su coste económico. El Resultado también sigue siendo importante, por supuesto, pero en esta fase aún puede parecerle relativamente lejano y al paciente puede costarle percibir hasta qué punto una colaboración insuficiente hoy puede poner en peligro algo que no verá hasta dentro de muchos meses. El Tiempo, en cambio, se entiende de inmediato.

Si una persona ha comenzado un tratamiento sabiendo que cambiaría de alineador cada semana y que duraría aproximadamente quince o dieciocho meses, oír que a partir de ese momento quizá tenga que llevar cada alineador durante tres semanas hace que la consecuencia resulte muy concreta. Ya no hablamos en términos generales de la posibilidad de que *«el tratamiento se alargue»*: el paciente ve enseguida que el ritmo al que avanza podría ser tres veces más lento de lo que había imaginado al principio.

Por eso le explico:

> *«Inevitablemente, tenemos que contar con que el tratamiento pueda alargarse mucho. Si tus dientes de verdad necesitan dos o tres veces más tiempo para seguir cada alineador, no podemos esperar que el tratamiento dure lo que habíamos previsto al principio. Primero tenemos que averiguar a qué ritmo pueden seguir realmente tus dientes los alineadores y después podremos hacer una previsión más fiable».*

No necesito decirle al paciente que un tratamiento de dieciocho meses durará sin duda cuatro años y medio, porque no puedo saberlo y no sería correcto convertir una posible consecuencia en una previsión segura. Pero sí puedo hacerle entender que, **si el ritmo siguiera siendo realmente de un alineador cada tres semanas en vez de cada siete días, el tiempo necesario podría llegar a ser incluso tres veces mayor**.

Y es precisamente la diferencia entre una consecuencia genérica y una concreta lo que hace tan eficaz la palanca del Tiempo. Decir *«si no los llevas, el tratamiento durará más»* es algo que el paciente probablemente ya ha oído y que puede resultarle completamente abstracto. Pasar de siete a veintiún días, en cambio, significa traducir esa misma consecuencia en algo que puede ver, medir y relacionar con su propio objetivo.

Una estrategia que funciona en ambos casos

Lo que más me interesa de este enfoque es que no necesito saber con absoluta certeza cuál de las dos explicaciones es la correcta.

Si el paciente lleva realmente los alineadores veintidós horas al día y tiene una respuesta biológica especialmente lenta, espaciar los cambios y volver a evaluar el ajuste es una decisión prudente y coherente con lo que observo clínicamente.

Si, en cambio, como probablemente ocurre en la mayoría de las situaciones en las que utilizo esta estrategia, el paciente lleva los alineadores muchas menos horas de las que dice, no lo he acusado de mentir ni lo he obligado a defenderse. Simplemente le he mostrado una consecuencia de su comportamiento actual que para él tiene una importancia inmediata.

Muy a menudo, eso es precisamente lo que lo lleva a revisar espontáneamente su versión. El paciente no necesita pasar bruscamente de *«los llevo siempre»* a *«te estaba mintiendo»*. Puede simplemente detenerse, repasar mentalmente su semana y reconocer que quizá ese *siempre* no significaba realmente veintidós horas cada día. Si entonces decide esforzarse más, puedo mantener el cambio semanal y comprobar si a sus palabras les sigue de verdad un comportamiento distinto.

Si, por el contrario, sigue sosteniendo que ya los lleva las horas indicadas, no tengo motivo para discutir: acepto esa explicación, espacio los cambios y compruebo la respuesta.

En ambos casos he conseguido lo que de verdad me interesaba: **una decisión concreta sobre lo que ocurrirá a partir de ese momento.**

La confesión no mueve los dientes

Creo que este ha sido uno de los cambios más importantes en mi forma de comunicarme con los pacientes poco colaboradores. Durante mucho tiempo pensé que mi tarea era conseguir que el paciente entendiera que no estaba haciendo lo que le había pedido, casi como si admitir el error fuera una condición necesaria para

poder retomar bien el tratamiento. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que conseguir esa admisión no era en absoluto lo que necesitaba.

Paradójicamente, hoy esa especie de confesión llega con más frecuencia precisamente porque he dejado de buscarla. Cuando el paciente no se siente acusado y entiende, en cambio, la consecuencia concreta de lo que estamos observando, puede permitirse reconsiderar su comportamiento sin vivir ese cambio de versión como una derrota.

Si me dice «*La verdad es que los fines de semana los he llevado menos, pero a partir de hoy voy a esforzarme de verdad*», esa información sin duda me resulta útil, porque me permite mantener el cambio semanal y comprobar si una mejor colaboración basta para recuperar el ajuste. Pero no es la confesión lo que tiene valor terapéutico: es lo que el paciente haga después.

Si, en cambio, después de diez minutos de discusión consiguiera obligarlo a admitir «*Tienes razón, en realidad los llevaba doce horas al día*», quizá tendría la satisfacción de saber que había interpretado correctamente el ajuste, pero desde el punto de vista clínico aún no habría conseguido lo que de verdad me interesa. **La confesión no mueve los dientes; un cambio de comportamiento, sí.**

La estrategia del *slow mover* permite al paciente cambiar su comportamiento sin obligarlo a admitir que lo que me había contado hasta unos minutos antes no era del todo cierto. Le ofrece la posibilidad de salvar la cara, pero al mismo tiempo le hace mucho más difícil ignorar la consecuencia de seguir actuando igual.

Si ponemos a una persona en la tesitura de elegir entre admitir que no ha seguido nuestras indicaciones y continuar defendiendo su versión, puede elegir la segunda opción aunque eso no la ayude en absoluto a conseguir el resultado que desea. Si, en cambio, evitamos esa discusión y centramos la atención en las consecuencias clínicas y las posibles soluciones, le permitimos cambiar de comportamiento sin tener que reconocer abiertamente antes que se ha equivocado.

Por eso, cuando los datos clínicos y lo que cuenta el paciente no coinciden, hoy intento mucho menos establecer quién tiene razón y mucho más encontrar una estrategia que pueda funcionar independientemente de cuál sea la explicación. **No necesitamos demostrarle al paciente que tenemos razón; necesitamos crear las condiciones para que pueda empezar a hacer lo correcto.**

GUION OPERATIVO

Cuando observo una pérdida generalizada de ajuste, después de repasar con el paciente sus hábitos y de que me confirme que lleva correctamente los alineadores, puedo plantear la conversación así:

> *«Veo que varios dientes no están siguiendo los alineadores al ritmo que habíamos previsto. Hemos repasado juntos cómo los llevas y me confirmas que lo haces correctamente, así que tenemos que considerar otra posibilidad. Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todas las personas y hay pacientes cuya respuesta biológica al movimiento ortodóncico es más lenta. En la literatura también se utilizan los términos fast movers y slow movers y, si realmente llevas los alineadores como me dices, es posible que pertenezcas a este segundo grupo.*
>
> *Si tus dientes se mueven más despacio, puede que una semana no baste para que alcancen del todo la posición prevista por cada alineador. Si siguiéramos cambiándolos cada siete días, ese pequeño retraso podría acumularse y el ajuste empeoraría cada vez más. Por eso, si de verdad los llevas las horas que me has indicado, tenemos que dar más tiempo a los dientes y pasar, al menos al principio, de una semana a tres semanas con cada alineador.*
>
> *Eso significa que el tratamiento avanzaría a un ritmo tres veces más lento. No puedo decirte hoy que todo el tratamiento vaya a durar tres veces más, porque primero tenemos que ver cómo responden los dientes y quizá podamos volver a acelerar, pero, si tuviéramos que mantener ese ritmo durante todo el tratamiento, la duración total también podría aumentar mucho. Ahora tenemos que averiguar a qué ritmo pueden seguir realmente tus dientes los alineadores».*

En ese momento dejo hablar al paciente. Si me dice:

> *«Doctor, la verdad es que quizá no siempre son veintidós horas. Si me esfuerzo de verdad, ¿podemos intentar mantener el cambio semanal?».*

Mi respuesta puede ser igual de sencilla:

> *«Claro. Si crees que hay horas que podemos recuperar, prefiero darte esa oportunidad. Seguiremos con el cambio semanal, pero a partir de hoy tenemos que ser muy rigurosos. En la próxima revisión, el ajuste nos dirá si ese cambio ha sido suficiente».*

Si, por el contrario, sigue confirmándome que ya los lleva las horas indicadas, no insisto ni intento hacerle cambiar de versión: espacio los cambios como le he explicado y compruebo después cómo responde.

Por qué funciona este protocolo

- **Reducción de la reactancia**

Contradecir directamente al paciente y decirle que no está llevando los alineadores como afirma puede llevarlo a defender aún más su postura. Aceptar de entrada su versión y proponer una explicación alternativa evita el enfrentamiento y mantiene la conversación centrada en resolver el problema.

- **Salvar la cara**

La estrategia del *slow mover* permite al paciente que ha llevado poco los alineadores cambiar su comportamiento sin verse obligado a admitir que ha mentido. Puede simplemente reconsiderar qué quería decir con «*siempre*» y reconocer que ha habido horas en las que no los ha llevado. Así, cambiar de comportamiento no exige pasar antes por una derrota personal.

- **Saliencia de la consecuencia**

Decir «*tienes que llevarlos más*» indica lo que debería hacer, pero no le muestra necesariamente por qué debería hacerlo. Pasar de siete a veintiún días, en cambio, convierte la consecuencia en algo que se entiende de inmediato.

- **La palanca del Tiempo**

En las primeras fases del tratamiento, el paciente acaba de afrontar la Inversión y el Resultado final aún puede quedarle lejos, mientras que el Tiempo representa una consecuencia cercana y fácil de entender. La perspectiva de avanzar a un ritmo tres veces más lento puede cambiar rápidamente el valor que atribuye a esas horas en las que no lleva los alineadores.

- **Información para evaluar la respuesta**

El protocolo no termina con la conversación. Si el paciente decide mantener el cambio semanal y se compromete a esforzarse más, el ajuste en la siguiente revisión nos permite comprobar si ese cambio de comportamiento ha sido suficiente. Si, por el contrario, espaciamos los cambios y el ajuste sigue sin mejorar, también debemos estar dispuestos a reconsiderar nuestra hipótesis clínica.

BIBLIOGRAFÍA

Giannopoulou C, Dudic A, Pandis N, Kiliaridis S. Slow and fast orthodontic tooth movement: an experimental study on humans. *European Journal of Orthodontics.* 2016;38(4):404-408.

Bertl K, Neuner H, Meran A, et al. Does the time-point of orthodontic space closure initiation after tooth extraction affect the incidence of gingival cleft development? A randomized controlled clinical trial. *Journal of Periodontology.* 2020;91(5):572-581.

Küchler EC, Schröder A, Corso P, et al. Genetic polymorphisms influence gene expression of human periodontal ligament fibroblasts in the early phases of orthodontic tooth movement. *Odontology.* 2020;108:493-502.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Palanca principal: tiempo y control.

Con un paciente Dominante evitaría el enfrentamiento directo, porque cuestionar abiertamente lo que nos cuenta podría convertir rápidamente la conversación en un pulso. Es más eficaz presentar las dos posibilidades con claridad y dejar que su comportamiento posterior determine qué camino podremos seguir.

> *«Si ya los llevas las horas indicadas, tenemos que espaciar los cambios porque tus dientes necesitan más tiempo. Si, en cambio, crees que puedes ser más riguroso, podemos mantener el cambio semanal y comprobar enseguida si recuperamos el ajuste. En la próxima revisión tendremos la respuesta».*

I

Influyente

Palanca principal: resultado y motivación.

Con un paciente Influyente evitaría una explicación demasiado larga o técnica y me centraría más en la posibilidad de reconducir rápidamente la situación y mantener el ritmo inicial si consigue cambiar de verdad su comportamiento.

> *«Todavía podemos intentar mantener el cambio semanal. Si sabes que algunos días los has llevado menos, a partir de hoy recuperamos esas horas y vemos cómo responden los dientes. Si en la próxima revisión hemos recuperado el ajuste que buscamos, seguimos así».*

S

Estable

Palanca principal: tranquilidad y seguimiento.

Con un paciente Estable es importante evitar que interprete la situación como una señal de que el tratamiento está fracasando. Le explicaría, por tanto, que tenemos dos caminos posibles y que podemos hacer un seguimiento de ambos.

> *«No significa que el tratamiento no esté funcionando. Solo tenemos que averiguar si los dientes necesitan más tiempo o si podemos recuperar algunas horas de uso. Si crees que puedes ser más riguroso, de momento mantenemos el cambio semanal y en la próxima revisión vemos juntos cómo están respondiendo».*

Adaptar la comunicación al perfil DISC

CONTINÚA

C

Concienzudo

Palanca principal: datos y explicación.

Con un paciente Concienzudo me apoyaría más en lo que podemos observar clínicamente: le mostraría el ajuste y le explicaría con precisión las dos hipótesis y cómo la siguiente revisión nos permitirá distinguir entre ellas.

> «*Clínicamente vemos que los dientes se han quedado atrás con respecto a la posición prevista. Si ya los llevas las horas indicadas, tenemos que considerar que la respuesta biológica sea más lenta y aumentar el tiempo de uso de cada alineador. Si, en cambio, crees que ha habido horas en las que no los has llevado, podemos mantener por ahora el cambio semanal, corregir eso y comprobar en la próxima revisión si la discrepancia se reduce*».

CAPÍTULO 6

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	En la primera revisión de la secuencia, normalmente al cabo de unos dos meses, cuando aparece una pérdida progresiva y generalizada de ajuste. Valorar también la planificación y la respuesta biológica antes de atribuirla a la colaboración del paciente.
OBJETIVO	Recuperar el ajuste modificando el comportamiento o el intervalo entre cambios y comprobando la respuesta.
QUÉ HACER	1. Repasar cómo transcurre el día: comidas, trabajo, salidas nocturnas, fines de semana y tiempo que tarda en volver a ponerse los alineadores. 2. Si el paciente confirma que los lleva correctamente, considerar también una respuesta biológica más lenta. 3. Plantear el paso de siete a veintiún días y explicar que ralentizaría considerablemente el tratamiento. Los veintiún días son una elección del protocolo descrito, no una pauta universal. 4. Si reconoce que no los lleva lo suficiente, acordar que cumpla las horas prescritas y mantener el cambio semanal cuando las condiciones clínicas lo permitan. 5. Si confirma que los lleva correctamente, espaciar los cambios y volver a evaluar el ajuste para decidir después si mantener ese ritmo o acelerar. 6. Si el ajuste no mejora, reconsiderar también la hipótesis clínica inicial.
QUÉ COMPROBAR	Distribución de la pérdida de ajuste, horas y rutina de uso, intervalo entre cambios y respuesta en la siguiente revisión. Una promesa de esforzarse más debe ir seguida de un cambio comprobable.

CAPÍTULO

7

El paciente que lleva los alineadores, pero no los elásticos

«Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil».

— PROVERBIO INGLÉS

Cuando empecé a utilizar elásticos intermaxilares junto con los alineadores, hace ya muchos años, todavía eran relativamente pocos los clínicos que los integraban sistemáticamente en sus mecánicas, sobre todo para corregir las clases II mediante distalización u otras **mecánicas sagitales**. Para mí eran un componente fundamental del tratamiento y, como me ocurría a menudo cada vez que incorporaba algo nuevo a mi forma de trabajar, observaba cada caso con muchísima atención para entender qué mecánicas funcionaban mejor y qué movimientos eran más predecibles.

Algunos tratamientos avanzaban exactamente como había previsto, mientras que otros parecían seguir un curso completamente distinto. Iniciaba una distalización, esperaba unos meses y, en la revisión, me encontraba con una situación aparentemente contradictoria: los alineadores se ajustaban perfectamente a los dientes, el ajuste era excelente, el apiñamiento se iba resolviendo, las rotaciones mejoraban y todo lo que dependía directamente de la acción de los alineadores parecía avanzar en la dirección correcta. **La clase II, en cambio, no mejoraba.**

Con el tiempo empecé a reconocer un patrón que se repetía con cierta regularidad: **un paciente podía llevar correctamente los alineadores y, al mismo tiempo, ser mucho menos constante con los elásticos.** Así me di cuenta de que había cometido un error conceptual muy sencillo: tendía a considerar la colaboración como una característica general del paciente, cuando llevar correctamente los alineadores y utilizar correctamente los elásticos son dos comportamientos completamente distintos. Hoy esta distinción me parece casi obvia, pero durante muchos años no lo fue en absoluto.

Cuando los alineadores funcionan y los elásticos no

En mi práctica utilizo los elásticos intermaxilares principalmente para la corrección sagital y transversal. En las mordidas cruzadas pueden ser muy útiles, aunque generalmente los introduzco en una fase más avanzada del tratamiento y, por eso, el problema de la colaboración presenta características algo distintas. La situación en la que su uso cobra especial importancia, y en la que más he aprendido a observar el comportamiento del paciente, es la corrección sagital.

Cuando realizo una distalización, prescribo los elásticos desde el principio y espero que la corrección sagital avance en paralelo a los movimientos programados de los alineadores. Si al cabo de unos meses veo que se están abriendo espacios entre los dientes posteriores y que los alineadores siguen ajustándose bien, pero la clase II molar no mejora y, al mismo tiempo, empiezan a aparecer efectos anteriores que no buscaba, sospecho con bastante fundamento que el paciente no lleva los elásticos con la constancia necesaria. Es, en esencia, lo que habíamos visto en el caso de Laura, que conté en la primera parte del libro.

En cambio, cuando utilizo una mecánica interarcadas, introduzco los elásticos después de haber alineado, nivelado y coordinado transversalmente las arcadas. También en este caso la señal es bastante evidente, porque los alineadores siguen ajustándose bien y todo avanza según lo previsto, pero la corrección sagital no se manifiesta como yo esperaba.

Es, por tanto, una situación muy distinta de la del paciente que no lleva correctamente los alineadores. En el capítulo anterior, la pérdida generalizada de ajuste era una de las principales señales de alarma; aquí, en cambio, el ajuste puede ser perfecto y el paciente puede mirarse al espejo cada día y ver cómo sus dientes están cada vez más rectos, convencido de que el tratamiento funciona exactamente como debería. Y esa es, paradójicamente, una de las razones por las que puede resultar tan difícil hacerle entender la importancia de los elásticos.

Los alineadores, una vez puestos, pueden permanecer en la boca durante muchas horas sin exigir ninguna otra decisión. El paciente se los quita para comer, generalmente los tiene delante y, al terminar, solo tiene que acordarse de volver a ponérselos.

Los elásticos, en cambio, exigen una serie de pequeños gestos adicionales que deben repetirse varias veces a lo largo del día. Hay que quitarlos y cambiarlos con regularidad, acordarse de llevar siempre un paquete encima y, sobre todo al principio, ponerlos puede resultar menos sencillo y más molesto. Cada comida, cada salida, el trabajo, el colegio, el deporte o un viaje pueden convertirse en momentos en los que esa rutina se interrumpe.

La literatura específica sobre los elásticos confirma hasta qué punto pueden importar estos pequeños obstáculos. Veeroo y sus colaboradores entrevistaron a pacientes a quienes se había prescrito el uso de elásticos intraorales a tiempo completo e identificaron, entre las principales barreras para la colaboración, los olvidos, las comidas, el dolor o las molestias, las situaciones sociales, el deporte, la pérdida o la rotura de los elásticos y la escasa percepción del beneficio obtenido.

No basta con saber si un paciente colabora. Tenemos que entender con qué parte del tratamiento está colaborando y, sobre todo, en qué momento deja de seguir la pauta que le hemos indicado.

La primera forma de averiguarlo es evitar la pregunta que parece más natural y que probablemente es también la que menos información nos aporta. Si pregunto «*¿Estás usando los elásticos?*, la respuesta casi siempre es previsible: «*Sí, doctor. Siempre*».

Pero si intento reconstruir un día normal, ese *siempre* suele dejar de ser tan absoluto. Entonces empiezo a preguntar: «*Cuando desayunas, ¿te los quitas? Y en cuanto terminas, ¿qué haces? Después de comer, ¿te los vuelves a poner enseguida? ¿Los llevas también en el trabajo o en el colegio? ¿Y cuando sales por la noche? ¿Los fines de semana? ¿Llevas siempre un paquete encima?*».

En ese momento puede salir a la luz que «*siempre*» significa en realidad por la noche y buena parte del día, pero no cuando el paciente está trabajando; o entre

semana, pero mucho menos los fines de semana; o que, después de comer, pasan varias horas antes de que se acuerde de volver a ponérselos. Esto no significa necesariamente que antes me estuviera mintiendo deliberadamente. Como ya vimos en la primera parte del libro, la idea que tenemos de nuestro comportamiento puede ser distinta de lo que hacemos en realidad a lo largo del día, y sabemos que el tiempo de uso que refieren los pacientes tiende a ser superior al medido objetivamente. Por eso no me interesa preguntar diez veces «*¿Seguro que los usas?*». No solo necesito saber si los usa, sino **cuándo los usa, cuándo se los quita y, sobre todo, cuándo no vuelve a ponérselos**.

Hay, además, algunas pequeñas señales que con los años he aprendido a observar y que pueden ayudarme a reconstruir mejor lo que hace realmente el paciente. Una frase que he oído tantas veces que se ha convertido casi en un clásico es la del paciente que llega a la revisión sin elásticos y, cuando le pregunto por qué no se los ha puesto ese día, me responde: *«No me los he puesto porque total, tenía que venir aquí».* Entonces le contesto sencillamente: *«¿Y eso qué tiene que ver? Si tienes que llevarlos siempre, también tienes que llevarlos cuando vienes a verme».*

No me preocupa especialmente esa hora que ha pasado sin elásticos antes de la revisión, sino el razonamiento que hay detrás de esa decisión. Si al paciente le parece de lo más natural dejar de ponérselos precisamente el día que viene al ortodoncista, probablemente todavía no ha interiorizado lo fundamental de la pauta. Los elásticos no son algo que se usa cuando uno se acuerda o cuando no molesta demasiado: si se prescriben para llevarlos de forma continuada, deben formar parte del tratamiento igual que los alineadores.

Otro pequeño indicador que en la práctica me resulta sumamente útil es observar **cómo** se pone el paciente los elásticos. Cuando tengo alguna duda, se los doy y le digo simplemente *«Enséñame cómo te los pones»*. Un paciente que lleva de verdad semanas o meses usando elásticos suele tener ese gesto automatizado: conoce los enganches, sabe cómo colocar los dedos y, por lo general, consigue ponérselos rápidamente, muchas veces sin siquiera usar un espejo. En cambio, cuando alguien que debería llevar meses usándolos me pide el espejo, tarda en encontrar los enganches, necesita la herramienta o emplea varios minutos en conseguir ponérselos, se me enciende otra pequeña luz de alarma.

El mismo principio se aplica a otro indicador de comportamiento que utilizo desde hace muchos años: **cuántos elásticos se gastan realmente**. Cuando los prescribo, normalmente entrego dos paquetes, unos doscientos elásticos, y pido al paciente que los cambie al menos tres veces al día. No le digo que esa cantidad no le

bastará hasta la siguiente revisión, que por lo general programo para tres o cuatro meses después, porque quiero observar qué ocurre sin haberle advertido.

Si el paciente sigue de verdad la pauta, esa cantidad debería agotarse mucho antes de la cita y, por tanto, tendrá que ponerse en contacto con la clínica y decir algo como «*Doctor, se me están acabando los elásticos. ¿Puedo pasar a recoger más?*». Esa llamada no me permite, naturalmente, saber cuántas horas al día los ha llevado, pero es un comportamiento coherente con lo que le había prescrito y, sobre todo, se produce espontáneamente, sin que yo le haya adelantado que esperaba esa petición.

La situación contraria es aún más interesante. Al cabo de tres o cuatro meses, el paciente vuelve a la revisión, le pregunto cuántos elásticos le quedan y quizá me responde: «*Muy bien, doctor. Todavía tengo un paquete casi lleno*». En ese momento no necesito ponerme a discutir cuántas horas los ha llevado realmente. Si le había dado unos doscientos elásticos y le había pedido que los cambiara al menos tres veces al día, esa cantidad sencillamente no es compatible con varios meses de uso según la pauta prescrita.

Es interesante que Veeroo y sus colaboradores también utilizaran el número de elásticos gastados como indicador del cumplimiento terapéutico, pidiendo a los participantes que guardaran y devolvieran los usados. Mi forma de hacerlo no pretende ser una medición científica de la colaboración, pero el principio es parecido: **a veces, lo que el paciente gasta dice más sobre su comportamiento que lo que recuerda haber hecho.**

Naturalmente, ninguno de estos indicios demuestra por sí solo que el paciente no esté colaborando. La dificultad para ponerse los elásticos puede deberse a la destreza manual, la vista, la edad o la complejidad de la pauta; el número de elásticos que quedan puede depender de que el paciente haya perdido algunos, haya recibido más o haya usado otro paquete. Lo que me interesa es la **convergencia de los indicios**: una corrección sagital que no avanza como estaba previsto, un relato poco coherente de lo que hace a lo largo del día, poca soltura al ponerse los elásticos y un consumo incompatible con la pauta prescrita. **Cuando varios elementos empiezan a contar la misma historia, el conjunto adquiere mucho más peso.**

Los elásticos funcionan si se usan según la pauta prescrita

Una vez que entiendo **dónde** suele interrumpirse la colaboración, hay un segundo paso que considero igual de importante: asegurarme de que el paciente haya entendido de verdad qué significa la pauta que le he indicado. Si prescribo los elásticos para llevarlos durante todo el día, el paciente no puede decidir por su cuenta que va

a usarlos solo por la noche o únicamente cuando le resulte más cómodo. Ponérselos solo por la noche no significa seguir el mismo tratamiento un poco peor, sino **seguir una pauta distinta de la que he planificado**.

Para que este concepto resulte fácil de entender, llevo años utilizando un ejemplo muy sencillo: «*Imagina que vas en un coche cuesta arriba y no tienes frenos. Cuando te pones los elásticos, es como si aceleraras: el automóvil sube, sube y sube, y poco a poco conseguimos la corrección que buscamos. Pero cuando te quitas los elásticos, el automóvil no se queda parado donde ha llegado: empieza a retroceder y pierdes parte de lo que habías ganado. Por eso, basta un solo día sin elásticos para perder lo que hemos conseguido en los tres o cuatro días anteriores. Pero no debemos pensar solo en días enteros, porque el mismo problema puede darse durante varias horas cada día. Piensa, por ejemplo, en lo que pasa si los llevas bien puestos desde la tarde, durante la noche y hasta la mañana siguiente, pero luego vas al colegio y no vuelves a ponértelos hasta las cinco de la tarde. O si te los pones por la mañana, te los quitas en el recreo para comer algo y después, como no llevas un paquete nuevo, pasas el resto del día sin elásticos. Durante esas horas no nos limitamos a poner el tratamiento en pausa: corremos el riesgo de perder parte del efecto conseguido en las horas anteriores. Lo mismo ocurre el fin de semana. Si de lunes a viernes los llevas bien puestos, pero el sábado y el domingo sales, haces deporte, ves a tus amigos y decides no ponértelos, corremos el riesgo de perder en esos dos días gran parte de lo ganado durante la semana. Así que la cuestión no es solo cuántas horas de uso de los elásticos acumulas al final del día, sino hasta qué punto conseguimos mantener su acción de forma continua. Por eso insisto tanto: no quiero que uses los elásticos solo cuando te venga bien, porque tienen que acompañar de forma continua la corrección que estamos intentando conseguir*».

La relación numérica que utilizo con el paciente —un día sin elásticos puede hacerle perder lo conseguido en los tres o cuatro días anteriores— **no procede de una cuantificación experimental y no debe interpretarse como tal**. No hay datos que permitan establecer con esa precisión cuánta corrección se pierde tras un día o un determinado número de horas sin elásticos. Y, sin embargo, llevo años usando deliberadamente esa frase porque ayuda a entender de forma intuitiva la importancia de que la fuerza actúe sin interrupciones y, sobre todo, porque **quiero que al paciente le preocupe la posibilidad de dejar de llevar los elásticos**.

Es, en cierto modo, otra de las **mentiras piadosas** de las que hablamos en la primera parte del libro: no me invento un riesgo inexistente, porque el uso intermitente de los elásticos puede comprometer de verdad la continuidad de la mecánica que he planificado, pero convierto deliberadamente ese riesgo en un mensaje más sencillo, rotundo y fácil de recordar de lo que la literatura me permitiría cuantificar. **Lo hago con un objetivo concreto: aumentar la probabilidad de que el paciente**

siga la pauta prescrita. Decirle que un día sin elásticos puede costarle varios días de corrección hace que la consecuencia de su comportamiento resulte mucho más concreta que una recomendación genérica de usarlos con mayor constancia.

Hay, además, otro aspecto que considerar: la fuerza que ejercen los elásticos no se mantiene constante con el tiempo. En un estudio *in vivo* con pacientes que utilizaban elásticos de clase II, Qodcieh y sus colaboradores observaron una pérdida progresiva de fuerza, especialmente evidente ya en las primeras horas de uso. **También por eso, en mi práctica pido al paciente que cambie los elásticos al menos tres veces al día.**

Antes de intentar motivar al paciente, procuro entender por qué no los usa

Cuando me doy cuenta de que el paciente no está usando los elásticos según la pauta prescrita, no pienso automáticamente que el problema sea una falta de motivación, sino que primero intento entender qué ocurre realmente. Hay una gran diferencia entre quien no ha comprendido su importancia, quien solo los usa por la noche porque ha decidido por su cuenta que ocho horas son suficientes, quien los encuentra demasiado molestos durante el trabajo y quien, en cambio, querría sinceramente usarlos, pero cada día termina de comer, vuelve a su mesa y se olvida de ellos hasta la noche.

En este último caso, seguir explicándole lo importantes que son los elásticos sirve de poco, porque el problema no es convencer aún más al paciente, sino **hacer que le resulte más fácil ponérselos**. Puedo sugerirle que deje un paquete de elásticos en la mesa de trabajo, otro en el bolso y quizá otro en el automóvil o en algún otro lugar donde suela pasar el día. También puedo recurrir al principio de las **intenciones de implementación**, ya descrito en el capítulo 5, vinculando el momento de volver a ponerse los elásticos con algo que hace siempre y convirtiendo una recomendación vaga como «*Acuérdate de volver a ponértelos*» en una regla mucho más concreta: «*Cuando termines de comer, lávate los dientes y vuelve a ponerte los alineadores y los elásticos*».

Los recordatorios digitales también pueden ser útiles cuando el problema es, sencillamente, acordarse de repetir una acción. Leone y sus colaboradores, en un estudio con 42 pacientes de clase II, enviaron al grupo experimental mensajes motivacionales y de recordatorio dos veces por semana durante tres meses y observaron una corrección de la clase II 3,7 veces mayor que en el grupo de control. Más recientemente, Şenocak y Camcı estudiaron a 124 adolescentes, 68 de ellos evalua-

dos específicamente en cuanto al uso de elásticos de clase II, y compararon los recordatorios por escrito, los recordatorios en vídeo y la ausencia de recordatorios. **Cuando el problema es acordarse de repetir una acción, aumentar la motivación no siempre basta; a veces tenemos que establecer mejor la rutina.**

Muy distinta es la situación del paciente que no se olvida de los elásticos, sino que **decide conscientemente no usarlos en determinados momentos del día**. Se los pone en casa y por la noche, pero se los quita en el trabajo, en el colegio o cuando sale porque se ven, le dificultan hablar o le hacen sentirse incómodo. En este caso, los recordatorios y los paquetes de repuesto sirven de poco, porque el problema no es que se olvide de volver a ponérselos: el paciente ha decidido que, en determinadas situaciones, el coste social o las molestias de llevar los elásticos pesan más que la pauta que le hemos prescrito.

Y es precisamente ahí donde también cambia nuestra forma de intervenir. No basta con facilitarle las cosas: debemos hacer que **la consecuencia de no seguir la pauta le resulte más importante**. El problema, de hecho, no es solo que el tratamiento pueda durar más. Si los elásticos se usan únicamente durante las horas que pasa en casa, la corrección puede avanzar más despacio, quedar incompleta y afectar también al resultado final. En ese momento tengo que explicarle al paciente que puede elegir: seguir la pauta que hemos planificado, valorar si existe una alternativa clínicamente adecuada o aceptar que el tratamiento pueda alargarse, volverse menos predecible y dar un resultado potencialmente distinto del previsto al principio.

El paciente ve los dientes rectos, no ve la clase II

En cambio, cuando me doy cuenta de que el problema es sobre todo de motivación, la palanca a la que más recurro vuelve a ser el **Tiempo**. Podríamos pensar que, con los elásticos, sería más eficaz recurrir al Resultado, porque lo que corremos el riesgo de perder es precisamente la corrección sagital, pero en la práctica hay un problema muy sencillo: **el paciente muchas veces no ve lo que vemos nosotros**.

Nosotros observamos una clase II, valoramos la relación molar y canina y sabemos exactamente cuánta corrección falta. El paciente, en cambio, se mira al espejo y ve sobre todo que los incisivos están cada vez más rectos, que el apiñamiento disminuye y que su sonrisa mejora poco a poco. Desde su punto de vista, el tratamiento está funcionando y, por tanto, le cuesta entender por qué seguimos insistiendo tanto con dos pequeños elásticos.

Por eso le explico: *«Los dientes están cada vez más rectos y eso también lo ves tú, porque esa parte del tratamiento depende sobre todo de los alineadores. Los elásticos, sin embargo, hacen otro trabajo: sirven para corregir la relación entre la arcada superior y la inferior. Si esa parte se queda atrás, corremos el riesgo de llegar más adelante con los dientes perfectamente alineados, pero con la oclusión aún por corregir. Entonces tendremos que seguir trabajando precisamente en lo que se ha quedado atrás y* ***el tratamiento durará más de lo que habíamos previsto****».*

El **Tiempo** hace así tangible una consecuencia que al paciente le cuesta percibir cuando se mira al espejo: puede que no reconozca una clase II residual, pero entiende perfectamente lo que significa **tener que continuar el tratamiento durante más tiempo**.

En este punto suele surgir una pregunta totalmente comprensible: *«¿Pero durante cuánto tiempo tendré que llevarlos?».* Si insisto en que los elásticos deben usarse de forma continua y en que una colaboración insuficiente puede alargar el tratamiento, es natural que el paciente quiera saber hasta cuándo tendrá que seguir llevándolos.

Aquí es donde, en mi práctica, **Dental Monitoring**, del que hablaremos en un capítulo posterior, supone una ventaja enorme. Le explico al paciente que no debe decidir por su cuenta cuándo reducir o dejar de usar los elásticos y que no hace falta esperar a la siguiente cita en la consulta, porque las imágenes periódicas me permiten seguir a distancia la evolución de la corrección. Le digo: *«Tú no te preocupes por saber cuándo llegará el momento de reducir su uso o dejar de llevarlos. Sigue usándolos exactamente como te he indicado porque, aunque no volvamos a vernos en la consulta hasta dentro de tres, cuatro o quizá seis meses, yo seguiré la evolución a través de las imágenes que me envíes y, cuando vea que hemos conseguido la corrección que buscamos, te diré cómo modificar su uso. No tienes que decidir tú cuándo los elásticos han terminado su trabajo».*

Este paso no solo sirve para tranquilizar al paciente, sino también para **eliminar cualquier ambigüedad de la pauta prescrita**: hasta que yo le indique otra cosa, debe seguir usando los elásticos exactamente como se los he prescrito. Así reduzco también el riesgo de que empiece a llevarlos menos horas por su cuenta simplemente porque crea que ya los ha usado bastante.

Todos estos elementos me sirven, por tanto, para entender dónde se interrumpe la colaboración y elegir la estrategia más adecuada para recuperarla. **Como en el protocolo anterior, mi objetivo no es conseguir una confesión ni demostrarle al paciente que no está usando los elásticos como dice, sino crear las condiciones para que, a partir de ese momento, cambie su comportamiento.**

GUION OPERATIVO

Cuando los alineadores están haciendo su trabajo, pero la corrección sagital no avanza como estaba previsto, puedo plantear la conversación de esta manera:

> *«Los alineadores están funcionando bien y, de hecho, los dientes están cada vez más rectos. Los elásticos, sin embargo, tienen una función distinta y, ahora mismo, esa parte del tratamiento no avanza como espero. Antes de cambiar nada, quiero entender contigo cómo los usas en un día normal. No me interesa solo saber si te los pones, sino, sobre todo, cuándo no los llevas: ¿qué pasa después de comer? ¿Vuelves a ponértelos inmediatamente? ¿Los llevas en el trabajo o en el colegio? ¿Y cuando sales por la noche? ¿Y el fin de semana?».*
>
> *«Si el problema es que en algunos momentos simplemente se te olvidan, tenemos que hacer que te resulte más fácil acordarte de ponértelos: deja un paquete en el trabajo o en el colegio, lleva siempre otro contigo y establece una regla fija. Cuando termines de comer, lávate los dientes y vuelve a ponerte los alineadores y los elásticos. Si, en cambio, decides no usarlos en algunas situaciones porque se ven, te molestan o te dificultan hablar, tenemos que plantearlo de otra manera, porque usarlos solo cuando te viene bien significa seguir una pauta distinta de la que hemos planificado».*
>
> *«Los dientes están cada vez más rectos y, por eso, al mirarte al espejo puedes tener la impresión de que todo avanza perfectamente. Los elásticos, sin embargo, sirven para corregir la relación entre la arcada superior y la inferior. Si esa parte se queda atrás, corremos el riesgo de llegar más adelante con los dientes perfectamente alineados, pero con la oclusión aún por corregir, y el tratamiento podría durar más de lo que habíamos previsto. Por eso, a partir de hoy quiero que los elásticos formen parte del tratamiento tanto como los alineadores».*

Por qué funciona este protocolo

■ **Reconstrucción del comportamiento**

Preguntar simplemente *«¿Llevas los elásticos?»* favorece una respuesta general y previsible, mientras que repasar los distintos momentos del día permite identificar las situaciones en las que el paciente deja de seguir la pauta prescrita. Así, la conversación deja de girar en torno a la sinceridad del paciente y se centra en el comportamiento que debemos modificar.

■ **Indicadores de comportamiento**

La evolución de la corrección sagital, la presencia de los elásticos en el momento de la revisión, la naturalidad con la que el paciente consigue ponérselos y el consumo de los paquetes, considerados en conjunto, pueden aportar información mucho más útil que una simple declaración verbal. No sirven para demostrar que el paciente miente, sino para ayudarnos a reconstruir lo que está ocurriendo realmente.

■ **Reducción de la fricción**

Si el problema es práctico, limitarse a aumentar la motivación sirve de poco. Dejar elásticos en varios lugares estratégicos y tener siempre un paquete disponible reduce el riesgo de que el paciente deje de usarlos porque se ha olvidado la bolsita o no tiene ninguna a mano.

■ **Intenciones de implementación**

Una regla como «*Cuando termines de comer, lávate los dientes y vuelve a ponerte los alineadores y los elásticos*» se basa en el principio de las **intenciones de implementación**, ya descrito en el capítulo 5, al vincular la acción con un hecho concreto que se repite cada día y facilitar que se convierta en una rutina.

■ **Saliencia de la consecuencia**

Cuando el problema no es olvidarse de los elásticos, sino decidir conscientemente no usarlos en determinados momentos, facilitar su uso no basta. Es necesario hacer que la consecuencia de esa decisión le resulte más importante al paciente, convirtiendo algo que difícilmente puede ver en algo que tenga para él un significado concreto.

■ **La palanca del Tiempo**

El paciente ve fácilmente que los incisivos están cada vez más rectos, pero puede no percibir en absoluto que la corrección sagital se ha quedado atrás. Por eso, el **Tiempo** suele ser una palanca más eficaz que el Resultado: explicarle que podría llegar a tener los dientes alineados, pero con una parte del tratamiento aún por completar, le permite entender enseguida por qué debe mejorar su colaboración ahora y no al final del tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

Al-Moghrabi D, Colonio Salazar F, Pandis N, Fleming PS. Compliance with removable orthodontic appliances and adjuncts: a systematic review and meta-analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2017;152(1):17-32.

Leone SMM, de Souza-Constantino AM, Conti ACCF, Capelozza Filho L, Almeida-Pedrin RR. The influence of text messages on the cooperation of Class II patients regarding the use of intermaxillary elastics. *Angle Orthod.* 2019;89(1):111-116.

Qodcieh SMA, Al-Khateeb SN, Jaradat ZW, Abu Alhaija ESJ. Force degradation of orthodontic latex elastics: an in-vivo study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2017;151(3):507-512.

Şenocak I, Camcı H. Effect of various active reminders via mobile phone on cooperation of orthodontic teenage patients regarding oral hygiene and Class II elastics use: a three-month follow-up prospective cohort study. *J Orofac Orthop.* 2025;86(Suppl 1):39-47.

Veeroo HJ, Cunningham SJ, Newton JT, Travess HC. Motivation and compliance with intraoral elastics. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2014;146(1):33-39.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Palanca principal: tiempo y control.

Con un paciente Dominante evitaría largas discusiones sobre cuántas horas ha usado realmente los elásticos y le mostraría directamente lo que no está ocurriendo desde el punto de vista clínico, relacionándolo con la posibilidad de alargar innecesariamente el tratamiento.

> *«Los alineadores están haciendo su trabajo, pero la clase no se está corrigiendo como debería. Si esta parte se queda atrás, llegaremos a tener los dientes rectos, pero aún nos quedará una parte del tratamiento por completar y perderemos tiempo. Por eso, a partir de hoy tenemos que usar los elásticos con la constancia que habíamos acordado».*

I

Influyente

Palanca principal: sencillez y resultado.

Con un paciente Influyente intentaría, sobre todo, establecer una rutina sencilla y compatible con una vida social activa, recurriendo a unas pocas reglas concretas en lugar de darle largas explicaciones técnicas.

> *«Vamos a hacerlo fácil: lleva siempre una bolsita contigo y deja otra en el trabajo o en el colegio. Y sigue una regla fija: cuando termines de comer, lávate los dientes y vuelve a ponerte los alineadores y los elásticos. Así no tienes que pensarlo cada vez y hacemos que funcionen a la vez las dos partes del tratamiento».*

S

Estable

Palanca principal: rutina y tranquilidad.

Con un paciente Estable evitaría que interpretase la falta de corrección como un fracaso del tratamiento y me centraría en establecer una rutina previsible y fácil de repetir.

> *«Los alineadores están funcionando bien y no tenemos que cambiarlo todo. Simplemente tenemos que conseguir que uses los elásticos con más regularidad. Veamos juntos en qué momentos tiendes a olvidarte de ellos, establezcamos una rutina que se vuelva automática y después comprobemos cómo evoluciona la corrección».*

Adaptar la comunicación al perfil DISC

CONTINÚA

C Concienzudo

Palanca principal: evidencia clínica y precisión.

Con un paciente Concienzudo le mostraría directamente la relación sagital y distinguiría con claridad lo que están consiguiendo los alineadores de lo que depende en mayor medida de los elásticos.

> *«Mira aquí: la alineación avanza bien y el ajuste es correcto, pero la relación sagital no ha cambiado tanto como esperábamos. Son dos componentes distintos del tratamiento y por eso necesitamos que sigas la pauta de uso de los elásticos con más constancia. En las próximas imágenes comprobaremos si la corrección vuelve a avanzar como estaba previsto».*

CAPÍTULO 7

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Cuando los alineadores mantienen un buen ajuste y los movimientos avanzan, pero la corrección sagital que depende de los elásticos se queda atrás.
OBJETIVO	Identificar en qué momentos se deja de seguir la pauta prescrita y conseguir un uso más constante de los elásticos.
QUÉ HACER	1. Repasar cómo usa los elásticos durante las comidas, en el trabajo, en el colegio, al salir por la noche y los fines de semana. Preguntar cuándo se los quita y cuánto tiempo pasa antes de volver a ponérselos. 2. Observar si lleva los elásticos, la naturalidad con la que se los pone y el consumo de los paquetes, e interpretar estos datos junto con el cuadro clínico. 3. Distinguir los olvidos y las dificultades prácticas de la decisión consciente de no usarlos. 4. Si el problema es práctico, dejar paquetes en los lugares habituales, vincular el momento de volver a ponérselos a una rutina y utilizar recordatorios cuando sea necesario. 5. Si el problema es de motivación, explicar que los dientes pueden alinearse mientras la corrección sagital sigue incompleta, lo que puede hacer necesario prolongar el tratamiento. 6. Reiterar que debe usarlos y sustituirlos según la pauta prescrita; comprobar la respuesta en las siguientes revisiones o a través de las próximas imágenes.
QUÉ COMPROBAR	La evolución de la corrección sagital, la constancia en el uso, la rutina y la respuesta a la medida acordada. Ningún indicador indirecto demuestra por sí solo la falta de colaboración.

CAPÍTULO

8

El refinamiento fisiológico

«Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles».

— GEORGE BOX

Cada vez que planifico la primera serie de alineadores, añado siempre al final de la secuencia **cuatro alineadores pasivos**. Los llamamos pasivos porque, al menos sobre el papel, no incorporan nuevos movimientos programados, pero lo cierto es que siempre me ha parecido una definición un tanto simplista. Si los movimientos programados en los alineadores anteriores no se han producido por completo, incluso un alineador definido como pasivo en el setup puede no serlo del todo desde el punto de vista clínico. Puede seguir manteniendo lo que hemos conseguido y, en algunos casos, dar más tiempo a que se completen los movimientos anteriores.

Pero esa no es la razón principal por la que los incluyo.

La razón más importante tiene que ver con algo de lo que hemos hablado muchas veces en este libro: el **comportamiento**. No quiero llegar al final de la fase activa de la primera serie, hacer un nuevo escaneo y decirle al paciente que ahora tendrá que llevar el mismo alineador durante dos o tres semanas mientras esperamos a que se planifique y fabrique el refinamiento. Durante meses le he pedido que establezca una rutina precisa: cada semana toma un alineador nuevo, sustituye el anterior y continúa el tratamiento. Si interrumpo de repente esa rutina y le digo que mantenga el mismo alineador durante semanas, estoy alterando precisamente el hábito que hasta ese momento me ha ayudado a conseguir su colaboración.

No es solo una impresión clínica mía. Los estudios sobre los hábitos muestran que los comportamientos repetidos tienden a asociarse progresivamente con las señales y el contexto en los que se llevan a cabo. Wood y sus colaboradores observaron que, cuando estos elementos se mantienen estables, es más probable que un hábito siga guiando el comportamiento, mientras que un cambio de contexto puede interrumpir su expresión automática. Posteriormente, Verplanken y Wood desarrollaron este concepto y mostraron que la desaparición de las señales que sostienen un hábito puede ser precisamente uno de los momentos en los que el comportamiento vuelve a depender en mayor medida de procesos intencionales.

Naturalmente, eso no significa que, si el paciente pasa unas semanas sin cambiar de alineador, olvide de repente todo lo que ha hecho durante los meses anteriores. Significa algo mucho más sencillo y, para mí, clínicamente relevante: **si una rutina funciona, prefiero no interrumpirla sin motivo.**

Por eso programo desde el principio cuatro alineadores pasivos y fijo la revisión para cuando el paciente llegue al primero. En ese momento compruebo la oclusión, verifico qué movimientos se han producido correctamente y cuáles necesitan perfeccionarse y, si estamos ante lo que considero un refinamiento fisiológico normal, hago un nuevo escaneo. Mientras planifico la siguiente fase y esperamos a que lleguen los nuevos alineadores, el paciente sigue con su rutina: pasa al segundo alineador pasivo, luego al tercero y, por último, al cuarto, y continúa cambiando de alineador con la misma frecuencia que hasta ese momento.

Puede parecer un detalle organizativo, pero para mí no lo es en absoluto. **No utilizo los alineadores pasivos solo para mantener la posición de los dientes: también los utilizo para mantener el hábito del paciente.**

Y es precisamente en esa cita, cuando el paciente ha llegado al primer alineador pasivo y ha terminado la parte activa de la primera serie, cuando a lo largo de los años me han hecho muchísimas veces la misma pregunta. El paciente se sienta en el sillón sabiendo que es una revisión importante. Ha cambiado treinta, treinta y

cinco, quizá cuarenta alineadores, uno tras otro. Mira sus dientes y, en la mayoría de los casos, ve una sonrisa mejor, muy distinta de la que tenía al empezar. Compruebo la oclusión, verifico qué movimientos se han producido correctamente y cuáles necesitan perfeccionarse, y después le explico que haremos un nuevo escaneo. Y entonces llega la pregunta:

«¿Cómo? ¿No hemos terminado?»

Al principio me sorprendía. En la primera visita le había explicado que el tratamiento duraría, por ejemplo, entre quince y dieciocho meses. Era solo una previsión, naturalmente: algunos tratamientos pueden durar doce meses; otros, veinticuatro o más. Pero habíamos hablado de la duración total y el paciente la había aceptado.

Después habían llegado los alineadores. Una larga secuencia de alineadores, cada uno con su número impreso. Y a partir de ese momento empezaba, casi sin darse cuenta, una nueva cuenta atrás: 12 de 40, 18 de 40, 25 de 40, 32 de 40... Cada semana completaba uno y se acercaba un poco más a aquel número que tenía delante de los ojos.

Mientras tanto, los quince o dieciocho meses de los que habíamos hablado en la primera visita quedaban cada vez más lejos. No porque el paciente hubiera olvidado necesariamente lo que le había dicho, sino porque aquella previsión expresada en meses había sido sustituida poco a poco por algo mucho más concreto, que podía ver, tocar y contar cada semana. El tratamiento había dejado de ser un periodo de tiempo y se había convertido en una secuencia con un principio y, sobre todo, un final perfectamente visible.

Cuando se acercaba a los últimos alineadores, en su cabeza no estaba terminando simplemente la primera serie: estaba terminando el tratamiento. Por eso, cuando le explicaba que haríamos un nuevo escaneo para pedir un refinamiento, su sorpresa era del todo comprensible. En ese momento podría haberme limitado a recordarle lo que le había dicho meses antes:

«¿Te acuerdas? Habíamos hablado de quince a dieciocho meses».

Y, de hecho, durante un tiempo lo hice. Después me di cuenta de que estaba intentando corregir al final una expectativa que había dejado que se formara durante meses. Si aquella reacción se repetía, el problema no era encontrar una respuesta mejor cuando el paciente llegaba al final de la serie, sino evitar que llegara a ese momento convencido de que el último alineador marcaba el final del tratamiento.

Por tanto, tenía que intervenir ya al entregarle la primera serie, cuando el paciente empezaba a hacerse una idea de cuánto duraría su tratamiento. Necesitaba una

forma sencilla de hacerle entender que aquellos alineadores representaban solo la primera gran fase. Así fue como empecé a hablar del 80 %.

El 80 %

Empecé, pues, a cambiar lo que decía en el momento de la entrega. Ya no quería que el paciente identificara el número de alineadores recibidos con la duración total del tratamiento y necesitaba un concepto lo bastante fácil de recordar incluso muchos meses después. Decidí utilizar un número porque, con los años, me he dado cuenta de que los números hacen más concreta una información que, de otro modo, corre el riesgo de quedar vaga, y también le dan una mayor apariencia de precisión.

Decir «*probablemente, después de esta primera serie, todavía tendremos que hacer algo más*» es muy distinto de decir «*con esta primera serie haremos aproximadamente el 80 % del trabajo*». La segunda frase es más directa y, sobre todo, más fácil de recordar.

Elegí deliberadamente un número sencillo: el 80 %. No es un dato científico ni pretende predecir matemáticamente cuánto conseguiremos con la primera serie; es una referencia que utilizo para transmitir una idea muy sencilla: **la primera caja no es todo el tratamiento**. Cuando se la entrego, siempre digo:

> *«Estos son los primeros alineadores del tratamiento. Con esta primera serie haremos la parte más importante del trabajo y nuestro objetivo es alcanzar aproximadamente el 80 % del resultado. Cuando lleguemos al final, haremos un nuevo escaneo, veremos qué movimientos se han producido exactamente como queríamos y utilizaremos una segunda serie para trabajar los detalles y los movimientos que requieran más precisión».*

Desde que empecé a anticipar esta idea, la conversación al final de la primera serie se ha vuelto mucho más sencilla. Cuando el paciente llega a la última parte de la secuencia, el refinamiento ya no le sorprende: sabe desde el principio que la primera serie representa la parte más importante del tratamiento, pero no necesariamente la última.

Anticipar el refinamiento desde el principio también permite aclarar otra idea importante: **un refinamiento no significa, por sí mismo, que el tratamiento haya fracasado**. Ningún sistema biológico reproduce necesariamente cada movimiento con la misma precisión con la que lo hemos programado en la pantalla. Algunos dientes siguen perfectamente la secuencia, otros pueden necesitar una corrección adicional; algunos movimientos se producen por completo, otros no tanto. El refinamiento sirve precisamente para eso: partir de lo que hemos conseguido realmente y planificar una nueva serie para completar lo que falta y perfeccionar el resultado.

El problema es que, justo cuando llegamos a esta fase, ocurre algo que puede poner en peligro la colaboración del paciente.

La paradoja del refinamiento

El paciente se mira los dientes y, muy a menudo, ya está contento. Lo que ve es enormemente distinto de la situación inicial: los incisivos están alineados, la sonrisa ha cambiado y puede que sus amigos y familiares ya le hayan dicho que tiene los dientes preciosos. Nosotros, en cambio, seguimos viendo lo que falta: una rotación que no se ha producido por completo, un torque que hay que perfeccionar, un movimiento vertical que hay que completar, algunos contactos que hay que ajustar.

Ahí surge una diferencia importante entre lo que vemos nosotros y lo que ve el paciente. Nosotros sabemos que estamos entrando en la fase en la que debemos ser aún más precisos; él puede tener la sensación de que ya está prácticamente todo hecho.

Y es precisamente ahí donde a menudo también cambia su comportamiento. Si percibo que la parte importante del trabajo ya está hecha y que solo faltan unos pocos detalles, tenderé, como es natural, a dar menos importancia a cada hora de uso. Esas veintidós horas que durante el tratamiento parecían imprescindibles empiezan a convertirse en veinte, luego en dieciocho; puede que alguna noche el alineador se quede fuera un poco más de tiempo porque, al fin y al cabo, los dientes ya están rectos.

El problema es que el razonamiento clínico debería ser casi el contrario. Si algunos movimientos han quedado incompletos después de la primera serie, son precisamente aquellos en los que debemos centrar nuestra atención durante el refinamiento. No puedo esperar que un movimiento que ya ha demostrado ser menos predecible se produzca mejor mientras el paciente reduce las horas durante las que le aplicamos la fuerza necesaria.

Esta es la idea que quiero darle la vuelta en su cabeza: **el refinamiento no es el momento en el que podemos colaborar menos porque queda poco; es el momento en el que debemos colaborar más precisamente porque lo que falta exige mayor precisión.** Y de esta paradoja nacen dos de las objeciones que más me han repetido a lo largo de los años. La primera surge casi siempre cuando el paciente ve la nueva serie:

«Pero entonces, ¿por qué siguen siendo tantos?»

El paciente ha recibido, por ejemplo, cuarenta alineadores en la primera serie y ahora le entregamos un refinamiento de quince, dieciocho o veinte. Los mira y hace un cálculo perfectamente comprensible:

> *«Pero si con cuarenta alineadores hemos hecho casi todo, ¿por qué ahora necesito tantos para hacer tan poco?»*

Con el tiempo, esta pregunta también me ha obligado a precisar mejor mi explicación.

La primera razón es que en el refinamiento trabajo precisamente en los movimientos que más dificultades han tenido para producirse. Si un movimiento no ha seguido el primer setup como esperaba, no tendría mucho sentido volver a planificarlo simplemente a la misma velocidad. Puedo decidir ralentizarlo, repartirlo entre más etapas y hacer que la fuerza se aplique de forma más gradual. Por tanto, un movimiento aparentemente pequeño puede requerir más alineadores de los que el paciente imagina al fijarse únicamente en la posición de los dientes.

La segunda razón es que no pienso solo en los dientes que aún tienen que moverse. Mientras trabajo en los detalles que faltan, también quiero mantener y consolidar todo lo que ya he conseguido. Por tanto, el tiempo dedicado al refinamiento no sirve exclusivamente para producir nuevos movimientos, sino también para preservar los que ya se han producido correctamente.

Hay una tercera razón, mucho más sencilla y casi aritmética, que puede alterar bastante la percepción del número total de alineadores y que está directamente relacionada con los cuatro pasivos de los que hablamos al principio del capítulo. Si la primera serie contiene cuarenta alineadores y cuatro son pasivos, significa que treinta y seis corresponden a la fase activa: los cuatro pasivos representan el 10 % de toda la secuencia y, por tanto, su peso en el número total es relativamente pequeño. En un refinamiento corto, en cambio, esa proporción cambia por completo. Si tuviera, por ejemplo, doce alineadores activos y añadiera cuatro pasivos, la secuencia pasaría a tener dieciséis y una cuarta parte de los alineadores entregados serían pasivos. El paciente ve dieciséis alineadores y piensa que todos servirán para mover esos pocos dientes que aún quedan por corregir, cuando una parte de la secuencia tiene una función completamente distinta. Por eso también le explico el número:

> *«No te asustes por el número que ves en la caja. No significa que necesariamente tengas que utilizar todos esos alineadores. Los movimientos que aún tenemos que conseguir son pocos, pero los hemos ralentizado porque son los que requieren más precisión. Además, al final he añadido cuatro alineadores pasivos que no incorporan nuevos movimientos programados y que nos sirven, sobre todo, para*

que no interrumpas tu rutina mientras preparamos, si hace falta, la siguiente fase. Así que el número que ves no equivale al número de alineadores activos que nos separan del final del tratamiento».

Esta explicación tiene también otra ventaja: le quita al paciente otra posible justificación para colaborar menos. Quince o veinte alineadores nuevos no significan que el tratamiento haya retrocedido de repente; significan que hemos entrado en una fase distinta, en la que trabajamos más despacio y con objetivos más selectivos.

Pero hay otra interpretación que puede llevar exactamente al mismo resultado. Esta vez no nace del número de alineadores, sino de lo que siente el paciente al utilizarlos:

«Doctor, estos alineadores no aprietan».

O bien:

«Doctor, estos alineadores me aprietan mucho menos».

Al principio, mi respuesta era simplemente técnica. Le explicaba al paciente que era normal, porque la nueva serie se había fabricado a partir del escaneo que acabábamos de hacer. El primer alineador, por tanto, partía de una posición muy próxima a la real de sus dientes y no necesariamente iba a producir la misma sensación que recordaba de otras fases del tratamiento.

La explicación era correcta, pero en un momento dado me di cuenta de que no resolvía del todo el problema.

Para el paciente, la sensación de presión se había convertido, con el paso de los meses, en una especie de prueba física de que el alineador funcionaba. Cuando notaba que apretaba, pensaba que el alineador estaba haciendo su trabajo; cuando apenas notaba nada, podía llegar fácilmente a la conclusión contraria. Y si parece que algo no está haciendo su trabajo, resulta mucho más fácil permitirse utilizarlo menos.

Así que empecé a ser mucho más explícito también en este punto:

«Al principio, puedes notar que estos alineadores aprietan menos, y es normal. Se han fabricado a partir del escaneo que acabamos de hacer, así que la primera parte de la secuencia parte exactamente de la posición en la que están tus dientes hoy. Pero los movimientos que tenemos que conseguir son precisamente los que necesitaron más ayuda en la primera serie. Por eso, en esta fase, las veintidós horas son aún más importantes que antes».

Esta explicación me permite anticiparme a esa interpretación equivocada antes de que el paciente pueda convertirla en un motivo para reducir las horas de uso. Con los años, también he buscado una solución que no dependiera solo de la comunicación.

Desde que utilizo un sistema que me permite elegir entre materiales con distintas características, he empezado a usar el más rígido en los refinamientos. Para mí, la elección también tiene una justificación biomecánica, sobre todo cuando debo trabajar en el control radicular, pero con el tiempo me di cuenta de que producía otro efecto interesante: el paciente notaba más la presencia del alineador y seguía teniendo la sensación de que aún tenía un trabajo que hacer.

Naturalmente, esto no significa que un alineador que «*aprieta más*» sea necesariamente más eficaz, ni que la sensación que describe el paciente pueda utilizarse para medir la fuerza ortodóncica. La ventaja que me interesa en este caso es, sobre todo, conductual: notar el alineador refuerza en el paciente la sensación de que el tratamiento sigue activo y, por tanto, la necesidad de seguir utilizándolo con la misma atención.

Es una de esas observaciones que nacen más del trabajo en el sillón que de los libros y que, con el tiempo, acabé resumiendo en una frase muy sencilla: si el paciente no siente que los alineadores trabajan, corre el riesgo de dejar de considerarlos importantes y colabora menos.

Y es precisamente durante un refinamiento, cuando el paciente ya ve el resultado y podría tender de forma natural a colaborar menos, cuando no quiero que eso ocurra.

GUION OPERATIVO

Todas estas observaciones, acumuladas a lo largo de los años, han ido cambiando mi forma de entregar un refinamiento. Hoy no espero a que el paciente me diga que pensaba que había terminado, que son demasiados alineadores o que no nota que aprieten. Si sé que son objeciones recurrentes, prefiero abordarlas antes.

La conversación puede ser más o menos así:

> *«Hemos llegado exactamente a la fase de la que hablamos al principio. Con la primera serie hemos hecho la mayor parte del trabajo y hemos alcanzado más o menos el 80 % del resultado que buscábamos. Ahora tenemos que trabajar en los detalles y, sobre todo, en los movimientos que no se han producido con la misma precisión que los demás.*
>
> *Precisamente por eso, esta fase no es menos importante que la primera. De hecho, algunos de los movimientos que tenemos que conseguir ahora son los que ya han demostrado necesitar más atención, y los hemos ralentizado a propósito para*

> *hacerlos más graduales. Para que se produzcan, seguimos necesitando lo mismo que hasta hoy: una fuerza constante y, por tanto, las veintidós horas.*
>
> *También verás que el número de alineadores puede parecerte alto para las pocas cosas que aún tenemos que corregir, pero eso no significa que haya que repetir medio tratamiento. Hemos repartido algunos movimientos entre más alineadores precisamente porque queremos hacerlos más despacio y, además, al final he añadido cuatro alineadores pasivos que nos permiten no interrumpir tu rutina mientras preparamos, si hace falta, la siguiente fase.*
>
> *Al principio puede que también tengas la sensación de que estos alineadores aprietan menos. Es normal, porque se han fabricado a partir del escaneo de tus dientes tal como están hoy. Pero no lo interpretes como que necesitas llevarlos menos tiempo: los movimientos que buscamos ahora son precisamente aquellos para los que quiero la máxima constancia.*
>
> *Ya hemos recorrido la mayor parte del camino y el resultado se ve. Ahora sería una pena aflojar precisamente con los movimientos que nos permiten convertir un buen resultado en el resultado que habíamos planificado».*

Esta conversación no nace de una única teoría de la comunicación. Es el resultado de muchas pequeñas objeciones que he escuchado a lo largo de los años y de la necesidad de dejar de responder a ellas cuando ya habían surgido.

Con el tiempo he aprendido que, cuando una objeción se repite con suficiente frecuencia, mejorar cada vez más mi respuesta no es necesariamente la mejor solución. Prefiero hacer que esa objeción tenga menos posibilidades de surgir.

Si sé que el paciente podría pensar que ha terminado, preparo esa expectativa desde que le entrego la primera serie. Si sé que podría considerar excesivos quince o veinte alineadores, le explico de dónde sale esa cifra. Si sé que podría interpretar una menor sensación de presión como una menor necesidad de utilizarlos, despejo esa ambigüedad antes de que se convierta en una justificación para cambiar de comportamiento.

Ese es, en definitiva, el verdadero objetivo del protocolo: **dejar el menor margen posible a interpretaciones que puedan justificar una menor colaboración y dejar claro, en cambio, qué parte del resultado sigue dependiendo del comportamiento del paciente.**

El refinamiento no es un fracaso ni tampoco una fase en la que por fin podamos relajarnos. Es el momento en que pasamos de los grandes cambios a los detalles y, precisamente porque esos detalles suelen corresponder a los movimientos que más

dificultades han tenido para producirse, la calidad de la colaboración sigue siendo determinante.

El paciente ve que queda poco. Nuestra tarea es hacerle entender cuánto importa ese poco.

Por qué funciona este protocolo

- **Encuadre y gestión de las expectativas**

El refinamiento no se presenta como «*otra serie porque no hemos terminado*», sino como una fase prevista del tratamiento en la que pasamos de los grandes movimientos a la precisión. El hecho clínico no cambia, pero sí el marco desde el que el paciente lo interpreta: no estamos empezando de nuevo, estamos completando lo que habíamos planificado.

La referencia orientativa del 80 % refuerza esa expectativa. Decir «*probablemente, después de esta primera serie aún tendremos que hacer algo más*» deja una idea vaga, fácil de olvidar o reinterpretar con el paso de los meses. Decir, en cambio, «*con esta primera serie haremos alrededor del 80 % del trabajo*» ofrece una referencia concreta y más fácil de recordar. El 80 % no se utiliza como dato científico, sino como ancla comunicativa: cuando, meses después, el paciente se acerca al final de la primera serie y el número impreso en los alineadores le sugiere que el tratamiento ha terminado, podemos recordarle la expectativa que habíamos creado desde el principio.

- **Prevención de la ambigüedad**

Las principales objeciones se abordan antes de que surjan. El paciente ya sabe que la primera serie podría no coincidir con el final del tratamiento, por qué un refinamiento puede incluir un número aparentemente elevado de alineadores y por qué podría notar distintos los nuevos alineadores.

Anticipar estas explicaciones significa dejar menos margen a interpretaciones que podrían convertirse en una justificación para colaborar menos. Si sé que una objeción surge con suficiente frecuencia, prefiero prevenirla a mejorar cada vez más mi respuesta.

- **Gradiente de meta**

La literatura sobre el *gradiente de meta* muestra cómo la proximidad de un objetivo puede aumentar el esfuerzo dedicado a alcanzarlo. En mi experiencia clínica, sin embargo, durante un refinamiento también puede surgir otro problema: si el paciente considera que el resultado ya es suficientemente bueno, puede empezar a esforzarse menos justo cuando se acerca al final.

El protocolo busca, por tanto, evitar que la proximidad del resultado se interprete como una razón para relajarse. Que quede poco no significa que ese poco importe menos. Al contrario: precisamente porque trabajamos en los movimientos que más dificultades han tenido para producirse, los últimos detalles requieren la misma constancia que la fase anterior, si no más atención.

Compromiso y coherencia

Durante el refinamiento no le pedimos al paciente que adopte un comportamiento nuevo, sino que mantenga el que ya ha seguido durante meses. Las veintidós horas siguen siendo las mismas y se presentan como la continuación natural del esfuerzo que le ha permitido alcanzar el resultado que ve en el espejo.

El mismo principio explica por qué incluyo cuatro alineadores pasivos en lugar de dejar al paciente durante semanas con el mismo alineador. Si una rutina funciona, prefiero protegerla antes que interrumpirla sin necesidad. Con el primer alineador pasivo hago la revisión y el escaneo; durante la espera, el paciente pasa al segundo, al tercero y, por último, al cuarto. Sigue cambiando de alineador cada semana y, desde su punto de vista, la rutina se mantiene prácticamente igual.

Saliencia del resultado

A estas alturas, el paciente ya ha conseguido gran parte del resultado y precisamente lo que ha logrado puede convertirse en la palanca principal del protocolo. El mensaje no se centra simplemente en que aún queden algunos detalles, sino en el valor de esos detalles y en la necesidad de llevar hasta el final lo que ya se ha construido.

Decir simplemente «*tienes que seguir utilizando los alineadores veintidós horas*» enuncia una norma. Explicar, en cambio, que los movimientos pendientes son precisamente los que más dificultades han tenido para producirse deja claro por qué esa norma sigue siendo importante. La perspectiva cambia: no le estamos pidiendo al paciente que empiece de nuevo, sino que complete el resultado en el que ya ha invertido meses de tratamiento.

El refinamiento, por tanto, no debe convertirse en el momento en que el paciente sienta que el tratamiento va perdiendo fuerza poco a poco. Desde el punto de vista de la comunicación, debemos conseguir exactamente lo contrario: que perciba que hemos entrado en la fase en la que el resultado está cerca, pero en la que, precisamente por eso, cada detalle cuenta.

Cuando, en cambio, un refinamiento no forme parte del curso normal del tratamiento, sino que se haya hecho necesario porque el paciente no ha colaborado, el problema será completamente distinto. En ese caso no solo tendremos que explicar

una nueva serie de alineadores: tendremos que gestionarla sin enseñarle al paciente que no colaborar no tiene consecuencias.

Pero eso merece un protocolo aparte.

BIBLIOGRAFÍA

Wood W, Tam L, Guerrero Witt M. Changing circumstances, disrupting habits. *Journal of Personality and Social Psychology.* 2005;88(6):918–933. doi:10.1037/0022-3514.88.6.918.

Verplanken B, Wood W. Interventions to Break and Create Consumer Habits. *Journal of Public Policy & Marketing.* 2006;25(1):90–103. doi:10.1509/jppm.25.1.90.

Kivetz R, Urminsky O, Zheng Y. The Goal-Gradient Hypothesis Resurrected: Purchase Acceleration, Illusionary Goal Progress, and Customer Retention. *Journal of Marketing Research.* 2006;43(1):39–58. doi:10.1509/jmkr.43.1.39.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Palanca principal: tiempo y resultado.

Con un paciente Dominante evitaría extenderme en la fisiología del refinamiento y me centraría, sobre todo, en que la parte principal ya está hecha y en que mantener la misma precisión nos permite completar los últimos movimientos sin perder tiempo innecesariamente.

> *«La parte principal ya está hecha. Ahora tenemos que completar bien los últimos movimientos sin perder tiempo: veintidós horas y llegaremos al resultado planificado».*

I

Influyente

Palanca principal: resultado y motivación.

Con un paciente Influyente recurriría más a lo que ya puede ver en el espejo y convertiría la proximidad del resultado en una razón para seguir colaborando, en lugar de una justificación para relajarse.

> *«Mira cuánto ha cambiado tu sonrisa. Estamos muy cerca, pero son precisamente estos últimos detalles los que marcarán la diferencia. No aflojemos ahora».*

S

Estable

Palanca principal: continuidad y tranquilidad.

Con un paciente Estable destacaría, sobre todo, que no le estoy pidiendo que vuelva a cambiar sus hábitos. Solo tiene que mantener la rutina que le ha funcionado hasta ese momento mientras cambian los objetivos clínicos de esta fase.

> *«No tienes que cambiar nada de la rutina que has seguido hasta hoy. Seguimos con las mismas veintidós horas y el mismo ritmo; lo único que cambia es que ahora trabajamos en los detalles finales».*

C

Concienzudo

Palanca principal: precisión y explicación clínica.

Con un paciente Concienzudo le mostraría lo que hemos conseguido y lo que aún falta por perfeccionar, y le explicaría por qué los movimientos pendientes se han reprogramado de forma más gradual.

> *«El nuevo escaneo nos ha permitido medir qué movimientos se han producido por completo y cuáles no. Los pendientes se han reprogramado de forma más gradual, así que mantener las veintidós horas sigue siendo fundamental».*

CAPÍTULO 8

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Desde la planificación de la primera serie, preparando al paciente para un posible refinamiento; el paso operativo tiene lugar al llegar al primer alineador pasivo.
OBJETIVO	Completar los movimientos pendientes manteniendo las horas de uso y la rutina establecidas durante la primera serie.
QUÉ HACER	1. Programar cuatro alineadores pasivos al final de la serie. 2. Al entregarla, explicar que la primera serie representa la parte principal, pero no necesariamente todo el tratamiento. La referencia al 80 % es un recurso comunicativo, no una medida científica. 3. Al llegar al primer alineador pasivo, revisar la oclusión y los movimientos conseguidos, realizar el escaneo y planificar el refinamiento cuando sea necesario. 4. Durante la espera, mantener los cambios pasando al segundo, al tercero y al cuarto alineador pasivo. 5. Explicar qué movimientos quedan pendientes y por qué se hacen más graduales en la nueva serie. 6. Aclarar que el número de alineadores no mide por sí solo el trabajo pendiente y que percibir menos presión no justifica reducir las horas de uso.
QUÉ COMPROBAR	La oclusión, los movimientos conseguidos y pendientes, las expectativas, la constancia en el uso y el ajuste de la nueva serie. La proximidad del resultado debe ayudar a mantener el esfuerzo, no convertirse en un motivo para reducirlo.

CAPÍTULO

9

Las consecuencias contraproducentes del refinamiento

«Las consecuencias de una acción influyen en la probabilidad de que se repita».

— B. F. SKINNER

Un refinamiento no solo corrige los dientes; por desgracia, también puede enseñarle al paciente que colaborar no es imprescindible.

Cuando aparece por primera vez una pérdida generalizada de ajuste, acepto que puede haber distintas explicaciones e intento recuperar la colaboración sin exigir una confesión, como expliqué en el capítulo 6. Pero, si el paciente ya ha interrumpido varias series, ha recibido otras nuevas y sigue volviendo con el mismo problema, ya no me enfrento únicamente a una colaboración insuficiente.

También me enfrento a lo que ha aprendido de los refinamientos anteriores: que un nuevo escaneo borrará las consecuencias y el tratamiento podrá empezar de nuevo en las mismas condiciones. Ahí es donde una posibilidad útil desde el punto de vista clínico corre el riesgo de resultar contraproducente.

El caso de Alessandro

Hace unos diez años empecé el tratamiento de Alessandro, un chico de trece años que presentaba agenesia de los dos incisivos laterales superiores y una maloclusión de clase II completa. El objetivo del tratamiento era corregir la clase II y crear los espacios necesarios para sustituir, llegado el momento, las piezas ausentes. Era un plan que requería una colaboración constante, porque el resultado dependía no solo del uso de los alineadores, sino también del de los elásticos.

Alessandro, sin embargo, prácticamente nunca llevaba los alineadores. Lo veía cada cuatro meses y siempre nos encontrábamos en la misma situación: el ajuste ya estaba comprometido, los movimientos no se habían producido y no era posible continuar con la serie que le habíamos entregado. Nos deteníamos, hacíamos otro escaneo y preparábamos un nuevo plan de tratamiento. Cada vez que volvíamos a empezar, le dábamos la misma explicación y él prometía que, esta vez, colaboraría en serio.

Durante los dos primeros años de tratamiento ya habíamos preparado cinco refinamientos, o al menos eso era lo que yo seguía considerando que eran. Cada nuevo escaneo parecía darnos la posibilidad de empezar de nuevo, pero en realidad no cambiaba el comportamiento de Alessandro, que había ido aprendiendo que, si no utilizaba los alineadores, siempre podíamos interrumpir la serie y preparar otra.

Después de casi dos años, por fin cambió algo. Alessandro empezó a utilizar los alineadores con más regularidad y, en unos seis meses, los dientes se alinearon de forma visible. Por primera vez habíamos conseguido un resultado clínico importante, aunque todavía faltaba completar la corrección de la clase II porque no había utilizado los elásticos con la misma constancia. Decidí entonces hacer un refinamiento y le expliqué que aquella nueva serie debía consolidar lo que habíamos conseguido y completar los movimientos que aún hacían falta.

Cuando volví a verlo cuatro meses después, la situación clínica me sorprendió. Los dientes no solo no se habían mantenido en la posición alcanzada con el refinamiento anterior, sino que estaban incluso más torcidos. Después de haber conseguido por fin alinearlos, habíamos vuelto prácticamente al punto de partida porque Alessandro no había utilizado ninguno de los nuevos alineadores.

Mientras mirábamos juntos las fotografías y comparábamos el escaneo con el anterior, su padre hizo una observación que cambiaría para siempre mi forma de gestionar estas situaciones:

> *«Vaya, esta vez los dientes están incluso más torcidos que antes. Imagino que ahora habrá algún coste, porque la empresa verá que Alessandro no ha colaborado. No creo que pueda seguir fabricando alineadores gratis si el paciente no los utiliza».*

En aquel momento se me encendió una bombilla. Hasta entonces había seguido presentando cada nuevo escaneo como una posibilidad incluida en el tratamiento, sin darme cuenta de que precisamente esa aparente ausencia de límites había contribuido a borrar las consecuencias de la falta de colaboración. El padre de Alessandro, en cambio, había señalado espontáneamente algo que yo todavía no había sabido convertir en una estrategia de comunicación: si una nueva serie no produce una mejora significativa, o si la situación incluso empeora, ya no puede seguir considerándose un refinamiento normal incluido en el plan de tratamiento. Le respondí:

> *«Así es. La empresa comparará este escaneo con el anterior y verá que durante la última serie no se ha conseguido ninguna mejora significativa. Si tenemos que fabricar más alineadores, la nueva fase tendrá un coste».*

Aquella respuesta surgió espontáneamente durante la conversación, pero me permitió comprender algo mucho más importante. Hasta ese momento, Alessandro había recibido cinco nuevas oportunidades, todas acompañadas de recomendaciones y promesas, pero ninguna había ido asociada a una consecuencia concreta. Por primera vez, en cambio, la posibilidad de un coste hacía visible que un nuevo escaneo no podría borrar una vez más lo ocurrido durante los meses anteriores.

No fue, por tanto, una teoría económica la que me sugirió esta estrategia, sino la observación espontánea de un padre que, al ver que los dientes de su hijo habían empeorado, consideró del todo natural que la falta de colaboración tuviera por fin una consecuencia.

Cuando una segunda oportunidad se convierte en una regla

Algunos pacientes admiten que han colaborado poco y acompañan cada nueva petición de una explicación creíble y una promesa aparentemente sincera. Otros, en cambio, siguen sosteniendo que han utilizado correctamente los alineadores incluso cuando la comparación entre los escaneos cuenta una historia completa-

mente distinta. Sin embargo, después de haber empezado de nuevo varias veces, determinar cuál de las dos versiones es más sincera pasa a ser menos importante que interrumpir el mecanismo por el que ambas conducen automáticamente al mismo resultado: otra serie de alineadores.

El paciente sincero puede aprender que basta con reconocer su dificultad y prometer que cambiará, mientras que el menos sincero puede entender que seguir negándolo no tiene consecuencias distintas. El problema, por tanto, no está solo en las palabras que utiliza el paciente, sino en la respuesta que recibe de la clínica. **Si cada explicación, sea verdadera o falsa, va seguida de un nuevo escaneo y de otro comienzo en las mismas condiciones, somos nosotros quienes hacemos que su colaboración importe cada vez menos.**

La primera vez quizá le hayamos ofrecido una segunda oportunidad; a la segunda o a la tercera, sin embargo, puede que hayamos empezado a enseñarle involuntariamente una regla: **colaborar es sin duda preferible, pero no es realmente imprescindible, porque siempre será posible empezar de nuevo.**

Ahí es donde el problema resulta interesante también desde el punto de vista del comportamiento. Cada decisión clínica que tomamos tiene una consecuencia, y esa consecuencia puede influir en lo que ocurra después. Cuando decimos *«No te preocupes, empezamos de nuevo»*, queremos tranquilizar al paciente y preservar la relación terapéutica, pero el mensaje que él puede recibir es otro: lo que ha ocurrido durante los meses anteriores no tiene una consecuencia concreta, porque una nueva serie le permitirá empezar de nuevo de todos modos.

Es uno de los principios en los que se basa el **condicionamiento operante**: las consecuencias de una conducta contribuyen a modificar la probabilidad de que se repita. Naturalmente, no estamos premiando intencionadamente la falta de colaboración, pero podemos crear sin darnos cuenta un sistema en el que sus consecuencias se eliminan cada vez mediante un nuevo escaneo. El mismo principio general sustenta las intervenciones de *gestión de contingencias*, utilizadas en otros ámbitos sanitarios en los que se recurre a consecuencias definidas de antemano y vinculadas a conductas verificables para favorecer la adherencia. Esto no demuestra que introducir un coste mejore automáticamente el uso de los alineadores, pero sí respalda un principio mucho más prudente y útil para nuestro protocolo: **las consecuencias funcionan mejor cuando son claras, se anuncian de antemano y se vinculan a algo verificable.**

En los tratamientos que incluyen series adicionales sin un nuevo coste de producción aparece también un segundo problema. Desde el punto de vista clínico, esta posibilidad supone una enorme ventaja, pero, desde el punto de vista del paciente,

puede hacer que la diferencia entre completar una serie y tener que repetirla porque en realidad no la ha utilizado resulte cada vez menos evidente. Los estudios sobre el *efecto del precio cero* muestran que aquello que tiene un precio de cero no se percibe simplemente como algo que cuesta muy poco, sino que se valora de una manera particular. Esto no significa que lo gratuito se considere automáticamente carente de valor ni, sobre todo, que un paciente utilice menos los alineadores porque sabe que los refinamientos están incluidos. El problema es más sutil: **si cada vez que se empieza de nuevo parece gratis, automático y potencialmente ilimitado, la consecuencia concreta de no haber completado la serie anterior se vuelve menos evidente.**

Un concepto utilizado en economía sanitaria que puede ayudarnos a comprender este mecanismo es el de *riesgo moral*. El ejemplo clásico es el de los seguros: cuando una persona sabe que está protegida frente a las consecuencias económicas de un posible daño, puede tener menos incentivos para prevenirlo que cuando sabe que esas consecuencias recaerán directamente sobre ella. Esto no significa que provoque el daño intencionadamente ni que actúe de mala fe: significa, sencillamente, que contar con esa protección puede modificar su comportamiento. En nuestro caso, el mecanismo puede ser parecido. El paciente no decide necesariamente utilizar menos los alineadores porque sabe que podrá recibir otros, pero puede ir aprendiendo que la falta de colaboración no cambia realmente lo que ocurre: si no utiliza una serie, sencillamente se fabricará otra. **El problema, por tanto, no es que el paciente se aproveche del sistema de forma consciente, sino que el sistema acabe haciendo que la falta de colaboración apenas tenga consecuencias.**

Y sería demasiado fácil atribuir toda la responsabilidad al paciente, porque a menudo somos precisamente nosotros, los médicos, quienes favorecemos este mecanismo sin querer. Programamos una cita de diez minutos para comprobar el ajuste y descubrimos que el paciente no ha colaborado, que los dientes no han mejorado y que no puede continuar con la serie. En ese momento deberíamos detenernos, documentar la situación, mostrarle la comparación con el escaneo anterior y afrontar una conversación que puede resultar incómoda, pero, para evitarla, lo más sencillo es hacer otro escaneo. Lleva pocos minutos, parece zanjar el problema y nos permite aplazarlo todo hasta la nueva serie. **Hacer un escaneo es fácil; cambiar una conducta lo es mucho menos.** Y así, lo que durante la revisión nos parece la solución más rápida puede convertirse, en los meses siguientes, en la menos eficiente: el paciente evita enfrentarse a las consecuencias de su falta de colaboración, nosotros aplazamos el problema y, unos meses después, corremos el riesgo de encontrarnos exactamente en la misma situación.

Esto no significa que esté mal ofrecer una segunda oportunidad. Un tratamiento de ortodoncia puede durar muchos meses y, durante ese tiempo, pueden surgir problemas personales, familiares o laborales que dificulten temporalmente la colaboración. Ser comprensivos también significa reconocer estas situaciones y aceptar que una sola etapa difícil no tiene por qué comprometer todo el tratamiento.

El problema no es ofrecer una segunda oportunidad. El problema es ofrecerla sin dejar claro que es una segunda oportunidad.

Si nos limitamos a hacer otro escaneo y a pedir una nueva promesa, nada distinguirá ese nuevo comienzo de los que puedan venir después. En cambio, podemos aceptar la explicación del paciente y, al mismo tiempo, establecer la regla que guiará el tratamiento a partir de ese momento:

> «*Entiendo que has pasado por una etapa difícil y esta vez podemos empezar de nuevo. Pero tengo que explicarte que este nuevo escaneo ha sido necesario sobre todo porque no has utilizado los alineadores como estaba previsto. Cuando termines la próxima serie, compararemos la nueva posición de los dientes con la de hoy y tendremos que observar una mejora significativa, compatible con una colaboración adecuada. Si no se produce esa mejora, no podremos seguir considerando automáticamente otra serie como un refinamiento normal incluido*».

Esta forma de plantearlo no culpabiliza al paciente ni convierte el refinamiento en un castigo. **Le concede una nueva oportunidad, pero al mismo tiempo establece que esa oportunidad tiene un límite y, sobre todo, define de antemano cómo comprobaremos si la ha aprovechado.**

Del relato del paciente a un resultado verificable

El caso de Alessandro, y sobre todo las palabras de su padre, me ayudaron a convertir una intuición en una regla muy sencilla que desde entonces empecé a aplicar en estas situaciones: cuando doy una nueva oportunidad, ya no quiero valorar solo la promesa del paciente, sino el resultado que esa promesa haya sido capaz de producir. Por eso explico desde el principio que el siguiente escaneo se comparará con el inicial y que no buscaremos que cada movimiento sea perfecto, sino un progreso clínicamente significativo y, en conjunto, compatible con un uso correcto de los alineadores.

Sabemos bien que incluso un paciente que colabora perfectamente puede llegar al final de una serie con una rotación incompleta, un movimiento pendiente o un diente en el que el alineador ha perdido el ajuste. Del mismo modo, puede ocurrir

que un paciente que antes casi nunca utilizaba los alineadores haya aumentado de verdad las horas de uso y perciba ese cambio como una colaboración ya adecuada. Hay que reconocer esa mejora, pero no podemos fijarnos solo en cuánto ha mejorado el paciente respecto a antes: también debemos valorar hasta qué punto su comportamiento se ajusta ahora a lo que exige el tratamiento. Es posible haber dado un gran paso adelante respecto al punto de partida y no haber alcanzado todavía una colaboración clínicamente suficiente.

De ahí surge una distinción que para mí se ha vuelto fundamental. Si en el siguiente escaneo observo un avance global evidente y solo quedan algunos movimientos incompletos, estoy ante un refinamiento normal: el paciente ha hecho su parte y ahora me toca a mí completar el tratamiento. Si, en cambio, veo solo movimientos mínimos, ningún avance sustancial o incluso un empeoramiento, la situación es completamente distinta, porque ya no estoy refinando un tratamiento que se ha llevado a cabo, sino intentando repetir una fase que el paciente en realidad no ha seguido. **El criterio, por tanto, no consiste en distinguir entre un movimiento perfecto y uno imperfecto, sino entre una serie que realmente se ha utilizado y otra que no ha producido un resultado compatible con una colaboración adecuada.**

La comparación entre los escaneos, naturalmente, no me dice cuántas horas ha utilizado realmente el paciente los alineadores ni pretende hacerlo. Pero sí me permite llevar la conversación a otro terreno: ya no tengo que discutir si han sido dieciocho, veinte o veintidós horas, ni intentar determinar hasta qué punto es sincero su relato, porque puedo comparar la situación inicial con la alcanzada. En otras palabras, **dejo de discutir la promesa y empiezo a observar el resultado.**

Una vez establecido que el nuevo escaneo deberá mostrar una mejora significativa, también tenemos que aclarar qué ocurrirá si no se produce esa mejora. **La posibilidad de seguir considerando cada nueva serie un refinamiento normal incluido en el tratamiento no puede ser ilimitada**, y esta regla puede vincularse al fabricante o presentarse como una decisión organizativa concreta de la clínica. En el primer caso, reducimos la posibilidad de que el paciente interprete la decisión como un castigo arbitrario del médico: el nuevo escaneo no se presenta como una simple imagen a partir de la cual empezar de nuevo, sino como un registro objetivo que puede compararse con el anterior para valorar el resultado alcanzado.

La regla puede explicarse así:

«Cuando enviemos el próximo escaneo, la empresa podrá compararlo con el de hoy y valorar el resultado global alcanzado. No será necesario que todos y cada uno de

los dientes hayan completado perfectamente los movimientos programados, pero deberá haber una mejora significativa y compatible con un uso correcto de los alineadores. Si esa mejora es evidente, los movimientos que queden incompletos podrán tratarse mediante un refinamiento normal; si, en cambio, los avances son mínimos, no hay ningún progreso sustancial o los dientes incluso han empeorado, la empresa podría no considerar la nueva serie un refinamiento normal incluido en el tratamiento y, por tanto, los alineadores adicionales podrían tener un coste añadido».

Como alternativa, el profesional puede presentar esta regla como una decisión de la clínica:

«Esta vez podemos hacer un nuevo escaneo y empezar de nuevo, pero al final de la próxima serie tendremos que observar una mejora significativa y compatible con un uso correcto de los alineadores. Si el tratamiento ha avanzado y solo quedan algunos movimientos incompletos, podremos completarlos mediante un refinamiento normal. Si, en cambio, no hay un avance sustancial, no podremos seguir repitiendo la misma fase y tendremos que valorar si interrumpimos el tratamiento o lo continuamos con un nuevo plan y un coste añadido».

Pedir un importe adicional no es un castigo, sino una forma de diferenciar en la práctica dos situaciones que ya son distintas desde el punto de vista clínico: completar un tratamiento que el paciente realmente ha seguido o repetir una fase que no ha dado resultados porque no ha utilizado los alineadores como se le indicó.

Como vimos en el capítulo 6, cuando nos encontramos por primera vez ante una pérdida generalizada de ajuste, buscamos sobre todo hacer tangible la consecuencia en el **Tiempo**: si el cambio semanal no es suficiente, el tiempo necesario para cada alineador podría aumentar y, con él, la duración total del tratamiento. En cambio, cuando el paciente ya ha pasado por dos, tres o cuatro intentos de empezar de nuevo, esta palanca puede ir perdiendo eficacia, porque esperar más tiempo y volver a empezar se han convertido en algo habitual. Es entonces cuando entra en juego la palanca de la **Inversión**, no para amenazar al paciente ni hacerle pagar por su falta de colaboración, sino para dejar claro que empezar de nuevo otra vez no es automático y que repetir una fase que no se ha llevado a cabo no equivale a completar algunos movimientos pendientes.

Pero, para que esta consecuencia sea adecuada y eficaz, debe comunicarse **antes** de la nueva serie, no introducirse en la siguiente revisión. Si el paciente la conoce antes de empezar de nuevo, constituye una condición clara de la nueva oportunidad que le ofrecemos; si, en cambio, no se entera hasta después de haber vuelto a

colaborar poco, puede percibirla como una regla inventada a posteriori. El paso decisivo consiste, por tanto, en sustituir la promesa por una condición verificable: ya no preguntamos *«¿Me prometes que esta vez colaborarás?»*, porque probablemente ya hemos oído esa promesa, sino que explicamos que continuar en las mismas condiciones dependerá del resultado que observemos en el siguiente escaneo.

Un nuevo escaneo registra la posición actual de los dientes y nos permite preparar más alineadores, pero no recupera el tiempo perdido ni, sobre todo, cambia por sí solo el comportamiento que ha causado el problema. Si seguimos empezando de nuevo sin cambiar las condiciones, repetimos el mismo tratamiento confiando una vez más en la misma promesa. En cambio, el refinamiento conserva todo su valor cuando sirve para completar un proceso que el paciente realmente ha seguido; cuando se utiliza para repetir continuamente fases que nunca se han llevado a cabo, deja de ser solo una herramienta de precisión clínica y corre el riesgo de convertirse en una forma de compensar la falta de colaboración.

Los refinamientos incluidos sirven para completar un tratamiento que se ha seguido, no para sustituir indefinidamente uno que en realidad nunca se ha seguido.

Ser comprensivos no significa eliminar todas las consecuencias. Podemos ofrecer una segunda oportunidad, y en muchos casos es justo hacerlo, pero, precisamente para que siga teniendo el sentido de una segunda oportunidad, no puede convertirse en una oportunidad infinita.

GUION OPERATIVO

En este punto, la conversación con el paciente debe convertir lo que acabamos de explicar en una regla sencilla, comprensible y, sobre todo, establecida antes de iniciar la nueva serie. No debemos pedir otra promesa ni intentar que admita que ha colaborado poco: debemos aclarar qué resultado esperamos y qué ocurrirá si no se alcanza.

> *«Esta vez podemos hacer un nuevo escaneo y empezar de nuevo, pero tengo que explicarte una regla importante. Cuando termines esta serie, compararemos el nuevo escaneo con el de hoy y tendrá que mostrar una mejora significativa, compatible con un uso correcto de los alineadores. Esto no significa que todos y cada uno de los dientes deban alcanzar perfectamente la posición programada, porque algunos*

> *movimientos pueden ser menos previsibles, pero el tratamiento en su conjunto deberá haber avanzado de verdad.*
>
> *Si has colaborado y solo quedan algunos movimientos incompletos, podremos hacer un refinamiento normal. Si, en cambio, no hay una mejora sustancial o los dientes incluso han empeorado, la empresa podría no considerar la nueva serie un refinamiento normal incluido en el tratamiento y, por tanto, los alineadores adicionales podrían tener un coste añadido. No es un castigo: sencillamente, no estaríamos completando un tratamiento que se ha seguido, sino repitiendo una vez más una fase que no se ha llevado a cabo».*

Por qué funciona este protocolo

- **Interrumpe el refuerzo involuntario**

Si cada episodio de falta de colaboración va seguido automáticamente de una nueva serie, **la posibilidad de empezar de nuevo sin ninguna consecuencia concreta puede favorecer que se repita la misma pauta**. Establecer un límite de antemano interrumpe este mecanismo sin convertir la revisión en un castigo.

- **Hace visible la consecuencia**

Una recomendación genérica de colaborar mejor sigue siendo abstracta, mientras que **la posibilidad de que una serie adicional ya no pueda considerarse un refinamiento normal incluido en el tratamiento** permite percibir de inmediato la diferencia entre completar un tratamiento y tener que repetir una de sus fases.

- **Desplaza la atención de las promesas a los resultados**

La comparación entre los escaneos evita basar la decisión exclusivamente en lo que declara el paciente e introduce un criterio clínico observable, sin pretender medir directamente las horas de uso.

- **Utiliza la palanca de la Inversión**

Cuando el Tiempo ya no basta para cambiar una conducta que se ha repetido, la posibilidad de un coste añadido devuelve valor a la nueva oportunidad y hace más difícil darla por automática.

- **Preserva la relación terapéutica**

La consecuencia se comunica de antemano, se vincula **a criterios definidos antes de la nueva serie** y se presenta como una condición para continuar, evitando que el paciente la interprete como una decisión personal o una reacción emocional del médico.

BIBLIOGRAFÍA

Staddon JER, Cerutti DT. Operant conditioning. Annual Review of Psychology. 2003;54:115-144.
Shampanier K, Mazar N, Ariely D. Zero as a special price: the true value of free products. Marketing Science. 2007;26(6):742-757.
Baicker K, Mullainathan S, Schwartzstein J. Behavioral hazard in health insurance. Quarterly Journal of Economics. 2015;130(4):1623-1667.
Koohi Rostamkalaee Z, Jafari M, Gorji HA. A systematic review of strategies used for controlling consumer moral hazard in health systems. BMC Health Services Research. 2022;22:1260.
Al-Moghrabi D, Colonio Salazar F, Pandis N, Fleming PS. Compliance with removable orthodontic appliances and adjuncts: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2017;152(1):17-32.
Van der Bie RM, Bos A, Bruers JJM, Jonkman REG. Patient adherence in orthodontics: a scoping review. BDJ Open. 2024;10:58.
Bolívar HA, Klemperer EM, Coleman SRM, et al. Contingency management for patients receiving medication for opioid use disorder: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021;78(10):1092-1102.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Palanca principal: control y consecuencia concreta.

Con un paciente Dominante es preferible comunicarse de forma directa, breve y orientada a la toma de decisiones, evitando explicaciones demasiado largas que podría percibir como una pérdida de tiempo.

> *«Podemos empezar de nuevo, pero a partir de ahora aplicaremos un criterio preciso: en el próximo escaneo tendrá que haber una mejora significativa. Si el tratamiento ha avanzado de verdad, completaremos con normalidad los movimientos que queden; si, en cambio, no hay un progreso sustancial, otra serie no podrá considerarse un refinamiento normal incluido y tendrá un coste añadido».*

I

Influyente

Palanca principal: motivación y resultado.

Con un paciente Influyente conviene mantener un tono positivo y cercano, sin permitir que el entusiasmo de una nueva promesa sustituya a un compromiso verificable.

> *«Esta puede ser de verdad la serie con la que volvamos a encauzar el tratamiento. Pero en el próximo escaneo tendremos que ver una mejora significativa, porque será el resultado lo que nos diga si esta vez la colaboración ha sido suficiente. Si el tratamiento ha avanzado de verdad, podremos completarlo con normalidad; si, en cambio, no vemos un progreso sustancial, otra serie no podrá considerarse un refinamiento normal incluido y tendrá un coste añadido».*

S

Estable

Palanca principal: tranquilidad y claridad.

Con un paciente Estable debemos evitar que perciba la regla como una amenaza, explicándosela con calma y subrayando que su finalidad es permitir que el tratamiento concluya de forma ordenada.

> *«Entiendo que estos meses han sido difíciles y podemos empezar de nuevo sin convertir esta revisión en una reprimenda. Pero quiero explicarte claramente qué ocurrirá: compararemos el próximo escaneo con el de hoy y tendremos que observar una mejora significativa. Si el tratamiento está avanzando de verdad, podremos completarlo con normalidad; si, en cambio, la mejora no es suficiente, antes de volver a empezar tendremos que valorar juntos cómo continuar y el posible coste de la nueva fase».*

Adaptar la comunicación al perfil DISC

CONTINÚA

C

Concienzudo

Palanca principal: criterio objetivo y distinción clínica.

Con un paciente Concienzudo conviene explicar con precisión que la comparación se refiere al resultado global y no exige que cada movimiento se corresponda perfectamente con el setup.

> «*La comparación no se hará valorando un solo diente, sino considerando el progreso global respecto a los movimientos programados. No exigimos una correspondencia perfecta con el setup, porque algunos movimientos pueden no completarse aunque los alineadores se utilicen correctamente. Sin embargo, tendrá que haber una mejora clínicamente significativa y coherente con una colaboración adecuada. Si no se produce ese progreso, la fase siguiente no podrá considerarse un refinamiento normal incluido*».

CAPÍTULO 9

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Cuando es necesario repetir una fase principalmente por una colaboración insuficiente y el paciente ya ha tenido una oportunidad de empezar de nuevo.
OBJETIVO	Condicionar la nueva oportunidad a un progreso verificable, poniendo fin a la dinámica de empezar de nuevo sin consecuencias.
QUÉ HACER	1. Reevaluar las causas de la falta de progreso, distinguiendo entre una colaboración insuficiente y otras dificultades clínicas. 2. Reconocer la dificultad y ofrecer una nueva oportunidad cuando sea adecuado. 3. Antes de la nueva serie, explicar que el siguiente escaneo se comparará con el inicial. 4. Aclarar que esperamos una mejora clínicamente significativa, no solo una nueva promesa de colaboración. 5. Si el tratamiento avanza y quedan movimientos pendientes, abordarlos como un refinamiento normal. 6. Si no hay un avance sustancial o la situación empeora, reevaluar cómo continuar. Otra serie podrá tener un coste añadido según las condiciones comunicadas de antemano.
QUÉ COMPROBAR	Ajuste, comparación entre escaneos, progreso global, movimientos pendientes, posible empeoramiento e historial de intentos de empezar de nuevo. Comprobar que el paciente ha entendido la diferencia entre completar el tratamiento y repetir una fase que no se ha llevado a cabo.

CAPÍTULO

10

El paciente que desaparece

«El tiempo perdido nunca se recupera».

— BENJAMIN FRANKLIN

Hay pacientes que deciden interrumpir o suspender un tratamiento y nos lo dicen abiertamente: vienen a la consulta, nos explican que por algún motivo no quieren o no pueden continuar en ese momento y decidimos juntos cómo gestionar la situación. **En mi consulta, cuando un paciente decide suspender el tratamiento, le pedimos que firme un consentimiento de suspensión en el que dejamos claro que el proceso terapéutico se interrumpe y establecemos las condiciones en las que podría retomarse.** Así no queda ninguna ambigüedad: nosotros sabemos que el tratamiento está suspendido y el paciente sabe que no se trata simplemente de saltarse alguna revisión. Luego hay otra clase de pacientes, probablemente mucho más

frecuente de lo que nos gustaría, que nunca interrumpe realmente el tratamiento, al menos no de palabra, sino que, en un momento dado, deja de venir y desaparece.

Al principio ni siquiera parece un problema especialmente grave. El paciente falta a una cita, el personal de recepción lo llama y a menudo recibe una respuesta de lo más tranquilizadora: «*Sí, ya lo sé, perdónenme, es que ahora mismo estoy hasta arriba. En cuanto pueda les llamo yo*». Por supuesto, no llama y, unas semanas después, desde la consulta intentamos contactar con él otra vez. Esta vez quizá responde: «*Mire, ahora mismo me resulta imposible. Quizá el mes que viene*». Pasa otro mes, luego dos; al principio seguimos intentando localizarlo, pero después, inevitablemente, los intentos se van espaciando, porque mientras tanto tenemos otros pacientes a los que atender, otras llamadas que hacer y otros problemas que resolver. Sin que nadie haya decidido formalmente interrumpir el tratamiento, ese nombre simplemente desaparece de la agenda y, con el tiempo, acaba desapareciendo también de nuestro día a día.

Puede pasar un año, pueden pasar dos, tres o incluso cuatro, hasta que una mañana la recepcionista entra en la consulta y nos dice: «*¿Te acuerdas de Mario Rossi? Ha llamado porque quiere pedir cita para continuar el tratamiento*». Y es precisamente esa palabra, *continuar*, la que, en mi opinión, encierra casi todo el problema de este capítulo.

Desde su punto de vista, en realidad puede que el tratamiento nunca haya terminado. Simplemente ha quedado suspendido, casi como una película que puso en pausa y que hoy cree que puede reanudar exactamente en el mismo fotograma. Sabe que no ha venido en tres años, por supuesto, pero eso no significa necesariamente que haya percibido esa larga ausencia como el final del tratamiento; puede estar convencido de que lo que contrató y pagó sigue ahí esperándolo.

El problema es que durante esos tres años su boca no ha estado en pausa. Los dientes pueden haberse movido, la oclusión puede haber cambiado, los últimos alineadores o la férula de retención pueden haberse utilizado de forma imprevisible, pueden haber aparecido restauraciones, caries o problemas periodontales e incluso lo que pide el paciente puede ser distinto de lo acordado al principio. También pueden haber cambiado las condiciones clínicas, organizativas y económicas en las que habíamos planificado aquel tratamiento.

El tiempo no congela un tratamiento de ortodoncia.

Beckwith y, posteriormente, Skidmore mostraron que la duración del tratamiento de ortodoncia también se ve influida por factores relacionados con la colaboración y la constancia del paciente; Melo y sus colaboradores pusieron de manifiesto la importancia de las citas perdidas en pacientes adultos, mientras que Bichara y

sus colaboradores observaron que los tratamientos duraban casi un año más en quienes habían faltado a más de dos citas. La literatura confirma, por tanto, algo que conocemos bien en la práctica clínica: perder la continuidad no es simplemente un problema de agenda.

Sin embargo, queda una pregunta que la literatura no puede responder por nosotros y que constituye el verdadero problema de este capítulo: **¿cuánto tiempo puede permanecer abierto un tratamiento cuando el paciente simplemente ha desaparecido?** Cuando ese paciente reaparece al cabo de tres años diciendo que quiere «continuar», antes incluso de decidir qué alineadores pedir tenemos que entender algo más importante: **¿estamos realmente continuando el tratamiento anterior o, entretanto, lo que tenemos entre manos se ha convertido en un tratamiento nuevo?**

El equívoco de los cinco años

En el mundo de los alineadores hay una razón muy concreta que puede haber contribuido a crear esa expectativa y, si queremos ser justos, probablemente parte de la responsabilidad también sea nuestra. Muchos paquetes comerciales permiten a la consulta, según condiciones que varían de una empresa a otra, solicitar series adicionales de alineadores sin costes añadidos dentro de un plazo determinado, que en algunos casos puede llegar, por ejemplo, a cinco años.

El problema surge cuando decidimos explicárselo al paciente y, como ocurre inevitablemente en la comunicación cotidiana, intentamos simplificar. Es probable que muchos de nosotros hayamos dicho alguna vez algo como: «*Con este tratamiento tienes los alineadores incluidos durante cinco años*», o incluso, más sencillamente: «*Tienes cinco años de tratamiento*». Nosotros sabemos a qué nos referimos, pero una frase que para nosotros describe una condición comercial puede convertirse fácilmente, en la cabeza del paciente, en algo muy distinto: «*He pagado un tratamiento que dura cinco años y, por tanto, hasta esa fecha, pase lo que pase, está todo incluido*».

Así, es comprensible que piense que puede parar unos meses, luego un año, quizá desaparecer por completo y finalmente reaparecer antes de que venza el plazo pidiendo simplemente retomar el tratamiento. Ahí es precisamente donde surge el equívoco, porque **el plazo comercial que la empresa concede a la consulta y la duración clínica del tratamiento no son lo mismo**. El primero indica durante cuánto tiempo puede la consulta solicitar más series de alineadores sin costes añadidos; la segunda, el tiempo necesario para completar el tratamiento.

Imaginemos a un paciente que reaparece al cabo de cuatro años con un paquete que contempla un plazo de cinco. Puede que aún podamos pedir una nueva serie, pero tenemos que volver a evaluarlo, hacer un nuevo escaneo, planificar de nuevo el caso y, sobre todo, averiguar cuánto tratamiento queda por delante. Si hicieran falta otros dieciocho meses, ese plazo podría vencer mientras el paciente aún está en tratamiento.

Por eso creo que el verdadero error es hablarle al paciente de «cinco años de tratamiento», porque **no le estamos vendiendo cinco años de tiempo**. Los cinco años son un plazo comercial, no la duración del tratamiento.

Cuando vuelve, aún no sabemos si está continuando

Cuando un paciente reaparece al cabo de tres o cuatro años, lo más natural es sentir la tentación de abrir enseguida el plan de tratamiento anterior e intentar averiguar por qué alineador podemos retomar el tratamiento. Al fin y al cabo, ya conocemos a ese paciente y todavía conservamos fotografías, escaneos y el setup. El problema es que todo lo que vemos en la pantalla corresponde al paciente de hace tres o cuatro años, mientras que en el sillón tenemos al paciente de hoy.

Durante ese tiempo, los dientes pueden haberse desplazado, la oclusión puede haber cambiado, pueden haber aparecido problemas dentales o periodontales y a menudo no sabemos exactamente qué ha hecho el paciente con los últimos alineadores. Puede que dejara de usarlos al cabo de unas semanas, que siguiera utilizando el mismo durante años, que los usara solo por la noche como una especie de retención o que continuara cambiándose por su cuenta los que aún tenía en casa. También puede haber cambiado lo que nos pide: quizá hace tres años estábamos cerca de terminar y él estaba satisfecho; hoy puede volver pidiéndonos que modifiquemos algo que ni siquiera formaba parte de los objetivos acordados al principio.

Por eso la primera pregunta no debería ser *«¿Por qué alineador podemos retomar el tratamiento?»*, sino más bien: **«¿En qué punto estamos hoy y qué tenemos que hacer a partir de ahora?»** Antes de decidir si estamos continuando el tratamiento anterior, tenemos que volver a explorar al paciente, reconstruir lo que ha ocurrido durante su ausencia, evaluar la situación clínica actual y compararla con la que dejamos.

El escaneo anterior, el setup anterior y todos los archivos siguen siendo sumamente útiles, porque nos permiten reconstruir desde dónde partimos y hasta dónde llegamos. **No es el archivo el que ha «caducado»: es la situación clínica la que puede haber cambiado.** Por eso considero que la visita después de una ausencia

prolongada es una verdadera reevaluación y no simplemente la primera revisión tras una pausa: **primero reevaluamos al paciente y solo después decidimos si lo que vamos a hacer todavía puede llamarse «continuar».**

Llegados a este punto, podríamos sentir la tentación de establecer una regla igual para todos: después de doce meses, el tratamiento se considera interrumpido; después de dos años, retomarlo conlleva un nuevo coste; después de tres, se empieza de cero. Sería sencillo, pero no creo que el tiempo transcurrido pueda ser el único criterio, porque tres años de ausencia pueden esconder historias completamente distintas. Un paciente puede haber colaborado poco desde el principio, haber faltado repetidamente a las revisiones y haber ido abandonando un tratamiento que ya avanzaba con dificultad; otro puede haber colaborado perfectamente hasta que una enfermedad, un problema familiar grave o una mudanza le impidieron continuar. En el calendario pueden haber pasado los mismos tres años, pero eso no significa necesariamente que debamos tomar la misma decisión.

No se trata de determinar quién merece ser premiado o castigado, sino de entender **qué parte del trabajo que tengo que hacer hoy puede seguir formando parte razonablemente del compromiso que asumí al principio y qué parte, en cambio, exige un nuevo compromiso por parte de la consulta**. Y es precisamente así como debemos abordar también la cuestión económica: **un posible nuevo coste no sirve para cobrarle al paciente lo que ocurrió en el pasado, sino el trabajo necesario de ahora en adelante**.

En mi práctica, agrupo el regreso de estos pacientes en tres grandes situaciones, no como reglas rígidas, sino como criterios que me ayudan a mantener cierta coherencia en mis decisiones.

En la **primera situación** todavía considero razonable retomar el tratamiento manteniendo las condiciones económicas originales. Podría ser el caso de un paciente que, antes de la interrupción, había colaborado bien, que tuvo que parar por un motivo grave e imprevisible y que vuelve con una situación clínica aún fácil de recuperar. Puedo decidir asumir el trabajo necesario porque considero que lo que tengo que hacer sigue estando suficientemente cerca del compromiso que asumí al principio.

En la **segunda situación** el tratamiento anterior aún se puede recuperar, pero la situación se ha vuelto más compleja. Han pasado varios años, tengo que volver a planificar una parte importante del caso o me encuentro cerca del final del plazo comercial original. Puedo decidir retomar el tratamiento estableciendo límites muy claros o pedir una aportación proporcional al nuevo trabajo necesario. No creo

que tenga sentido fijar una cantidad universal: lo fundamental, para mí, es que el paciente conozca las condiciones **antes** de volver a empezar.

En la **tercera situación**, por último, el vínculo con el tratamiento anterior se ha debilitado tanto que ya no podemos hablar simplemente de continuarlo. Pueden haber pasado muchos años, la situación clínica puede ser significativamente distinta, puede haberse perdido gran parte de lo que habíamos conseguido o puedo encontrarme ante la necesidad de repetir prácticamente el diagnóstico, la planificación y el tratamiento. En ese caso, considero más adecuado proponer un nuevo proceso terapéutico y establecer un nuevo acuerdo económico. También en esta tercera situación el mensaje sigue siendo el mismo: no le estoy pidiendo al paciente que pague porque haya desaparecido, sino porque **lo que tengo que hacer hoy ya no consiste simplemente en continuar lo que dejamos entonces**.

Hay que avisar al paciente mientras va desapareciendo

Hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en qué hacer cuando el paciente reaparece, pero una parte importante del problema surge mucho antes, durante el periodo en que va dejando de acudir a las revisiones. Es precisamente entonces cuando podemos evitar muchos malentendidos futuros.

Por supuesto, el primer objetivo debe ser conseguir que vuelva y recuperar la continuidad normal del tratamiento. La revisión sistemática con metaanálisis de Mohammed y sus colaboradores mostró que los sistemas de recordatorios pueden mejorar la adherencia a las citas de ortodoncia y reducir el riesgo de faltar a ellas. Sin embargo, cuando las ausencias empiezan a repetirse, el contenido de la llamada debe cambiar: ya no basta con preguntar cuándo quiere concertar la próxima revisión; tenemos que explicarle que una interrupción prolongada no es inocua. Desde recepción podrían decirle:

> *«Entiendo que ahora mismo te resulte difícil venir, pero no podemos dejar el tratamiento suspendido sin revisiones durante demasiado tiempo. Si la interrupción se prolonga, cuando quieras retomarlo el doctor tendrá que volver a evaluar la situación y también podrían cambiar las condiciones económicas del tratamiento. Por eso es mejor que veamos juntos ahora cómo gestionar este periodo».*

Prefiero que el paciente reciba este mensaje mientras el problema está empezando a surgir, en lugar de tener que explicárselo tres años después. No es una amenaza, sino avisarle de una posible consecuencia real para que pueda decidir si se organiza para continuar o acuerda con nosotros una suspensión propiamente dicha.

Si decide suspender el tratamiento, en mi consulta formalizamos esa decisión pidiéndole que firme un consentimiento de suspensión del tratamiento, de modo que ambas partes tengamos claro que el tratamiento no queda simplemente abierto a la espera de que el paciente decida por su cuenta cuándo volver. En realidad, esto debería explicarse desde el principio:

> *«Si durante el tratamiento pasara algo y necesitaras parar una temporada, no hay ningún problema, pero no desaparezcas. Llámanos y decidimos juntos cómo gestionarlo, porque dejar el tratamiento suspendido mucho tiempo sin revisiones puede cambiar tanto la situación clínica como las condiciones económicas en las que podremos retomarlo».*

El problema, por tanto, no es que un paciente necesite parar, sino que lo haga sin avisarnos. Si nos avisa, podemos evaluar la situación, proteger lo que hemos conseguido y acordar una suspensión; si, en cambio, sigue sin acudir y poco a poco deja incluso de responder, su silencio no puede convertirse en una forma implícita de mantener el tratamiento abierto indefinidamente.

Después de intentar contactar con él un número razonable de veces, considero útil enviarle una comunicación por escrito en la que dejemos claro que, sin las revisiones necesarias, ya no podemos supervisar activamente el tratamiento y que, si vuelve tras una interrupción prolongada, habrá que realizar una nueva evaluación clínica y revisar las condiciones en las que será posible retomarlo. En esa misma comunicación podemos indicarle qué hacer con los alineadores y con los dispositivos que aún lleve, si los hay, y recordarle que no debe continuar el tratamiento por su cuenta. Todos los intentos de contacto y las comunicaciones importantes deberían registrarse en la historia clínica. Si el paciente vuelve al cabo de tres años, tendremos que poder reconstruir cuándo se perdió la continuidad del tratamiento, qué intentos hicimos para recuperarla y qué información le dimos mientras el tratamiento se interrumpía.

La interrupción debe quedar clara mientras se produce, no reconstruirse tres años después.

Cuando el paciente reaparece

Cuando el paciente llama, quizá al cabo de tres años, diciendo que quiere «*continuar el tratamiento*», desde recepción no deben decidir si ese tratamiento sigue abierto, si todavía está incluido o cuánto costará retomarlo, porque en ese momento aún no tenemos los datos necesarios para saberlo. Del mismo modo, evitaría entrar por

teléfono en una discusión sobre lo que se dijo años atrás o sobre los motivos por los que el paciente desapareció. La respuesta puede ser muy sencilla:

> *«Claro, vamos a concertar una cita con el doctor. Ha pasado bastante tiempo desde la última revisión, así que primero tenemos que volver a evaluar la situación y después el doctor te explicará cómo podemos retomar el tratamiento y en qué condiciones».*

Cuando el paciente llega, reconstruyo lo ocurrido desde la última vez que lo vi, evalúo la situación clínica actual, la comparo con la que dejamos y determino hasta qué punto aún se puede recuperar el tratamiento anterior. **Solo entonces decido qué solución proponer y en qué condiciones podemos retomarlo.** De este modo, el posible nuevo coste no se presenta como una consecuencia de que el paciente haya desaparecido, sino **del trabajo que hoy es necesario para completar el tratamiento.**

GUION OPERATIVO

Una vez decidido en cuál de las tres situaciones nos encontramos, procuro seguir siempre el mismo orden: empiezo por la situación actual, explico qué hay que hacer para terminar el tratamiento y solo después aclaro en qué condiciones podemos retomarlo.

Si podemos retomarlo manteniendo las condiciones originales:

> *«He vuelto a evaluarlo todo y aún podemos retomar el tratamiento manteniendo las condiciones que acordamos al principio. Pero, a partir de ahora, tenemos que darle continuidad: si pasa algo que te impide seguir, llámanos y decidimos juntos cómo gestionarlo, pero no podemos volver a dejar el tratamiento suspendido durante años».*

Si el tratamiento anterior se puede recuperar, pero estamos cerca de los límites de las condiciones originales:

> *«Todavía podemos retomar el tratamiento, pero ya estamos cerca de que venza el plazo previsto en el paquete original. Si conseguimos terminar el tratamiento dentro de ese plazo, no cambia nada; si después de esa fecha hicieran falta más alineadores, podría haber costes adicionales. Prefiero decírtelo ahora, antes de volver a empezar».*

Si lo que tenemos que hacer ya es un tratamiento nuevo:

> *«Han pasado varios años y hoy la situación es distinta de la que dejamos. Para llegar al resultado no basta con pedir más alineadores y retomar el tratamiento donde lo dejamos: tengo que volver a planificar el caso y empezar un nuevo proceso. Por eso, lo que te propongo hoy es un tratamiento nuevo, con un nuevo acuerdo económico».*

En ninguno de los tres casos siento la necesidad de empezar recordándole al paciente cuántas veces faltó a una cita, cuántas llamadas hizo el personal de recepción o cuántas veces nos prometió que volvería. Esa información debe constar en la historia clínica, pero utilizarla para abrir la conversación solo supone el riesgo de centrarla en quién tiene razón y quién no. **Lo que me interesa es centrarlo en el presente: esta es la situación que tenemos hoy, esto es lo que debemos hacer y estas son las condiciones en las que podemos hacerlo.**

Al fin y al cabo, aquí también se aplica uno de los principios que ya hemos visto: **la confesión no mueve los dientes**. No necesito que el paciente admita que se equivocó; necesito que entienda dónde estamos hoy y, si decidimos retomar el tratamiento, sepa exactamente en qué condiciones lo hacemos.

Por qué funciona este protocolo

- **Traslada la conversación del pasado al presente**

No intentamos determinar quién tiene razón sobre lo ocurrido durante los años de ausencia. Partimos de la situación clínica actual y de lo que hay que hacer de ahora en adelante, evitando que la conversación se convierta en una discusión sobre las responsabilidades del pasado.

- **Elimina la ambigüedad al retomar el tratamiento**

Que el tratamiento no se haya dado formalmente por terminado no significa que pueda reanudarse en cualquier momento con las condiciones originales. La nueva evaluación permite determinar qué parte del tratamiento anterior aún se puede recuperar y en qué condiciones podemos retomarlo.

- **Vincula el coste al trabajo futuro**

El posible nuevo coste no se presenta como una sanción por haber desaparecido, sino como una consecuencia del trabajo clínico, organizativo y económico necesario a partir de ese momento. Esto permite utilizar la palanca de la Inversión sin convertirla en un castigo.

Anticipa las consecuencias

Avisar al paciente mientras va perdiendo la continuidad del tratamiento le permite saber que una ausencia prolongada puede cambiar tanto la situación clínica como las condiciones en las que podrá retomarlo. Una consecuencia comunicada de antemano es muy distinta de una condición impuesta cuando el paciente vuelve años después.

Por tanto, cuando años después vuelvo a ver ese nombre en la agenda, no considero automáticamente reabierto el tratamiento que habíamos dejado. Lo que considero abierta de nuevo es una posibilidad: la de volver a ver al paciente, entender dónde estamos hoy y decidir juntos si podemos retomar el tratamiento y cómo hacerlo.

El paciente puede desaparecer. El tratamiento no puede permanecer abierto para siempre.

BIBLIOGRAFÍA

Beckwith FR, Ackerman RJ Jr, Cobb CM, Tira DE. An evaluation of factors affecting duration of orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1999;115(4):439-447.

Skidmore KJ, Brook KJ, Thomson WM, Harding WJ. Factors influencing treatment time in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129(2):230-238.

Melo ACEO, Carneiro LOT, Pontes LF, Cecim RL, Mattos JNR, Normando D. Factors related to orthodontic treatment time in adult patients. Dental Press J Orthod. 2013;18(5):59-63.

Bichara LM, Aragón MLC, Brandão GAM, Normando D. Factors influencing orthodontic treatment time for non-surgical Class III malocclusion. J Appl Oral Sci. 2016;24(5):431-436.

Mohammed H, Rizk MZ, Wafaie K, Ulhaq A, Almuzian M. Reminders improve oral hygiene and adherence to appointments in orthodontic patients: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod. 2019;41(2):204-213.

Rischen RJ, Breuning KH, Bronkhorst EM, Kuijpers-Jagtman AM. Records needed for orthodontic diagnosis and treatment planning: a systematic review. PLoS One. 2013;8(11):e74186.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Palanca principal: decisión y condiciones.

Con un paciente Dominante evitaría reconstruir largamente el pasado e iría enseguida al grano:

> *«He vuelto a evaluar la situación y hoy estas son las opciones. Podemos recuperar una parte del tratamiento anterior en estas condiciones o, si es necesario, volver a planificar el caso por completo. Te explico las diferencias y decidimos cómo proceder».*

Si hay un nuevo coste: «*No es un coste por haber faltado, sino por el trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora para llegar al resultado*».

I

Influyente

Palanca principal: futuro y resultado.

Con un paciente Influyente evitaría que la conversación se convirtiera en un largo repaso de todo lo que no ha hecho. Puedo aprovechar que está dispuesto a volver a empezar para centrarlo de inmediato en el futuro:

> *«Perfecto, entonces miremos hacia delante. Veamos qué podemos recuperar, qué tenemos que volver a hacer y organicemos bien esta nueva fase».*

El contenido de la decisión no cambia, incluidas las posibles condiciones económicas, pero la comunicación se centra sobre todo en el resultado.

S

Estable

Palanca principal: tranquilidad y claridad.

Un paciente Estable puede llegar ya preocupado por si vamos a echarle la bronca o por si tendrá que empezar de cero:

> *«Primero vamos a ver con calma dónde estamos hoy y qué parte de lo que habíamos hecho podemos recuperar. Después te explico qué opciones tenemos y en qué condiciones podemos retomar el tratamiento».*

El objetivo es tranquilizarlo sobre cómo vamos a proceder sin hacerle promesas que todavía no sabemos si podremos cumplir.

C

Concienzudo

Palanca principal: datos y criterios.

Con un paciente Concienzudo recurriría más a la documentación disponible:

> *«Esta era la situación cuando paramos, esta es la de hoy y este es el trabajo que aún tenemos que hacer. Por estas razones puedo recuperar esta parte del tratamiento anterior, mientras que esta otra tengo que volver a planificarla».*

CAPÍTULO 10

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Cuando el paciente deja de acudir a las revisiones o vuelve tras una ausencia prolongada y pide continuar el tratamiento.
OBJETIVO	Recuperar la continuidad cuando sea posible y supeditar cualquier reanudación a la situación clínica actual.
QUÉ HACER	1. Contactar con el paciente cuando empieza a faltar a las citas e intentar comprender qué dificultades tiene. 2. Advertirle de que una ausencia prolongada puede cambiar la situación clínica y las condiciones para retomar el tratamiento. 3. Si decide parar, formalizar la suspensión con el consentimiento correspondiente. 4. Si desaparece, documentar los intentos de contacto y comunicarle la interrupción del tratamiento. 5. Cuando vuelva, evaluar de nuevo al paciente: la documentación anterior ayuda a reconstruir el proceso, pero no sustituye la evaluación actual. 6. Distinguir entre continuar el tratamiento original, continuarlo con nuevas condiciones e iniciar un tratamiento nuevo. 7. Aclarar los pasos que hay que seguir y los posibles costes antes de retomar el tratamiento. El coste corresponde al trabajo necesario, no es una sanción por la ausencia.
QUÉ COMPROBAR	Tiempo transcurrido, motivo de la interrupción, situación clínica, colaboración previa del paciente, posibilidad de recuperar el tratamiento, condiciones comerciales aún vigentes y trabajo pendiente.

CAPÍTULO

11

El paciente que nunca está satisfecho

«Nada es suficiente para quien considera demasiado poco lo que es suficiente».

— EPICURO

Hay un tipo de paciente al que, con los años, he aprendido a prestar especial atención. No son necesariamente pacientes difíciles, no son los que no usan los alineadores ni tampoco los que faltan a las citas o se olvidan sistemáticamente de los elásticos. De hecho, suelen estar muy pendientes del tratamiento: se miran los dientes continuamente, comparan fotografías tomadas con semanas de diferencia y llegan a las citas sabiendo exactamente qué detalle quieren enseñarme. El problema es que nunca están del todo satisfechos.

Una vez corregido aquello por lo que acudieron a nosotros, su atención tiende a desplazarse hacia detalles cada vez más pequeños, en los que probablemente ni siquiera se habían fijado al principio. Casi sin darnos cuenta, el tratamiento corre así el riesgo de convertirse en una búsqueda de una perfección cada vez más difícil de alcanzar y, a veces, imposible.

Con los alineadores, este riesgo se ha hecho aún más evidente, al menos en mi experiencia. Las simulaciones digitales permiten observar el resultado al detalle, las fotografías se comparan continuamente y la posibilidad de programar nuevos movimientos puede transmitir fácilmente la idea de que siempre queda algo por mejorar. A esto se suma una diferencia muy sencilla respecto a la ortodoncia fija: después de muchos meses de tratamiento, el paciente que lleva brackets normalmente está deseando quitárselos, mientras que seguir unos meses más con los alineadores suele percibirse como un sacrificio mucho menor. Por tanto, las ganas de terminar pueden disminuir justo cuando aumenta la atención a detalles cada vez más pequeños.

Durante mucho tiempo yo también lo vi así. Si un paciente me señalaba un detalle que podía mejorarse y creía que era posible hacerlo, intentaba complacerlo. Me parecía lo más lógico: mejorar aún más el resultado y, al mismo tiempo, aumentar su satisfacción. Con el tiempo comprendí que ambas cosas no van necesariamente de la mano y que, con algunos pacientes, cada corrección adicional puede limitarse a desplazar su atención al siguiente detalle.

Por tanto, la pregunta no es solo **cuánto más podemos mejorar un resultado**, sino **cuándo deja de ser realmente útil seguir intentando mejorarlo**.

Cuando mejorar no basta

Stefano tenía unos cuarenta años cuando llegó a mi consulta, después de haber visitado ya a varios colegas. Presentaba una maloclusión nada sencilla: una clase II subdivisión, con clase I a la derecha y clase II completa a la izquierda, una sobremordida de prácticamente el 100 % y un apiñamiento importante en la arcada inferior.

Planifiqué un tratamiento con alineadores y elásticos y le expliqué que necesitaríamos aproximadamente entre doce y quince meses. Stefano colaboró y, al terminar la primera serie de alineadores, el resultado era realmente muy bueno: habíamos conseguido una clase I perfecta también a la izquierda, abierto la mordida y logrado una alineación excelente. En aquella época aún estaba empezando a tratar casos complejos con alineadores y ese resultado tenía para mí un significado

especial. Me sentía orgulloso de haber conseguido corregir una maloclusión que muchos colegas ni siquiera habrían considerado tratar con alineadores.

Stefano, sin embargo, me señaló un pequeño detalle del incisivo lateral inferior izquierdo. Tenía razón: ese diente podía mejorarse, así que decidimos hacer un refinamiento. Quería terminar el tratamiento con el mejor resultado posible, pero también quería que Stefano quedara plenamente satisfecho. Pensaba que ambas cosas iban de la mano: **cuanto más mejorara el resultado, más aumentaría su satisfacción.**

Al terminar el primer refinamiento, ese detalle había mejorado, pero Stefano había empezado a fijarse en otro. Hicimos entonces otro escaneo, después otro refinamiento y más adelante otro más. Cada vez conseguíamos mejorar un detalle, pero su atención se desplazaba hacia algo nuevo. Al final llegamos a ocho refinamientos y el tratamiento, que en principio debía durar entre doce y quince meses, se prolongó hasta los veintiocho.

La paradoja era evidente: **el resultado clínico seguía mejorando, pero la satisfacción de Stefano no aumentaba con él**. Cada vez que corregíamos una imperfección, su atención se desplazaba hacia un detalle aún más pequeño. Ni siquiera después del octavo refinamiento estaba completamente satisfecho y me dijo, más o menos:

> *«Ahora ya casi está. Todavía habría alguna cosilla que mejorar, pero el tratamiento se está alargando demasiado y no me apetece seguir así».*

Por tanto, el tratamiento no terminó porque Stefano estuviera por fin satisfecho. Terminó porque, después de veintiocho meses, **ya no estaba dispuesto a invertir más tiempo en conseguirlo**. Si continuar no le hubiera supuesto ese coste, probablemente habríamos encontrado alguna otra cosa que modificar.

En aquel momento yo también estaba cansado y frustrado. Hacía tiempo que habíamos alcanzado el resultado clínico que buscábamos, pero cada nuevo detalle se había convertido en motivo suficiente para continuar. Me di cuenta de que había cometido un error: **había seguido preguntándome qué más podíamos mejorar, sin preguntarme si de verdad tenía sentido hacerlo.** Stefano me enseñó una lección que no he vuelto a olvidar:

Escuchar al paciente no significa dejarle el volante del tratamiento.

Cuando cambia el punto de referencia

Al principio del tratamiento, al paciente puede preocuparle un apiñamiento importante, una sobremordida o un incisivo claramente fuera de posición. Sin embargo,

cuando se corrigen esos problemas, su punto de referencia cambia. Con el paso de los meses, también tiende a olvidar lo distinta que era la situación inicial y acaba comparando el resultado, ya no con la sonrisa con la que llegó a nuestra consulta, sino con lo que aún podría mejorarse. Así, un detalle en el que probablemente ni siquiera se habría fijado al principio puede convertirse en el nuevo problema que hay que corregir.

La literatura sobre la percepción de la sonrisa nos muestra, además, que los ortodoncistas y los pacientes no conceden necesariamente la misma importancia a los mismos detalles y que existen distintos umbrales para detectar pequeñas asimetrías dentales y gingivales. Los estudios realizados con fotografías de sonrisas y, más recientemente, también con sistemas de eye-tracking han demostrado hasta qué punto puede volverse selectiva la atención cuando nos concentramos en detalles cada vez más pequeños.

En la práctica clínica, esto me ha llevado con los años a distinguir dos formas muy distintas de mirar un mismo resultado, que llamo **estética social** y **estética de inspección**. No son términos tomados de la literatura, sino dos expresiones que utilizo para describir algo que veo continuamente en mis pacientes.

La **estética social** es la de la sonrisa en la vida real: cuando una persona habla, ríe, se mueve e interactúa con los demás. Nadie observa un solo incisivo desde unos pocos centímetros; percibimos la sonrisa en su conjunto.

La **estética de inspección** aparece, en cambio, cuando dejamos de mirar la sonrisa y empezamos a examinarla. El paciente se acerca al espejo, inclina la cabeza, cambia la iluminación, amplía una fotografía o compara dos selfis buscando alguna diferencia. Cuanto más tiempo observa ese detalle, más importante puede llegar a parecerle.

El problema es que, una vez corregido ese detalle, esta forma de observar no tiene por qué cesar. La atención puede desplazarse sin más al siguiente detalle, exactamente como había ocurrido con Stefano. El resultado sigue mejorando, pero al mismo tiempo se vuelve cada vez más difícil llegar a un punto en el que el paciente ya no encuentre nada que modificar.

Por eso, **mejorar aún más el resultado no significa necesariamente que aumente también la satisfacción**.

Una de las situaciones en las que esta distancia entre el resultado clínico y la percepción del paciente se hace más evidente es una que encuentro con cierta frecuencia al terminar el tratamiento. Le muestro al paciente las fotografías finales o el escaneo digital y, al examinarlos juntos, él también reconoce que los dientes están correctamente alineados; luego se mira al espejo y me dice:

«En el monitor los veo rectos, pero cuando me miro siguen sin gustarme».

Responderle simplemente que los dientes están rectos no sirve de nada. Su insatisfacción es real, pero eso no significa necesariamente que siga debiéndose a la posición de los dientes. Lo que sigue sin convencerle puede estar relacionado con la forma de los dientes, el desgaste de los bordes, las diferencias anatómicas entre ambos lados, la relación con los labios o, sencillamente, la percepción global de su sonrisa.

Aquí es donde resulta fundamental distinguir entre dos afirmaciones que parecen similares: «*Los dientes no están rectos*» y «*No me gusta mi sonrisa*». En el primer caso, deberíamos poder identificar un diente, su posición y el movimiento necesario para modificarla. En el segundo, estamos describiendo una percepción estética más general, que no necesariamente puede corregirse moviendo más los dientes. Por eso, antes de planificar otro refinamiento, le pregunto al paciente:

«¿Puedes enseñarme exactamente qué diente no te convence y qué te gustaría cambiar? ¿Qué tendríamos que ver diferente al terminar el nuevo refinamiento para poder decir que ha funcionado?»

La respuesta a estas preguntas cambia por completo la situación. Si podemos identificar un diente, un movimiento y un resultado verificable, podemos valorar si tiene sentido intentar conseguirlo. Si, por el contrario, la petición sigue siendo «*me gustaría verlos más bonitos*», «*me gustaría que estuvieran aún más rectos*» o «*me gustaría gustarme más*», **todavía no hemos identificado un objetivo ortodóncico sobre el que plantear una nueva fase de tratamiento**.

Podemos planificar un movimiento dental, pero no podemos planificar cómo se verá el paciente al mirarse al espejo. Seguir moviendo los dientes con la esperanza de que cambie una sensación que no hemos conseguido traducir en un objetivo concreto puede llevarnos, sencillamente, a otro refinamiento y, unos meses después, a tener la misma conversación. Por eso, en estos casos intento no negar lo que siente el paciente, sino aclarar los límites de lo que otra serie de alineadores puede hacer realmente:

«No pongo en duda lo que ves cuando te miras al espejo. Pero tenemos que entender qué es exactamente lo que no te convence y si depende de la posición de los dientes. Si podemos identificar un movimiento concreto que pueda mejorarlo, podemos valorarlo. Si, en cambio, no conseguimos definir qué tendríamos que cambiar, otra serie de alineadores podría seguir moviendo los dientes sin cambiar lo que ahora no te gusta».

Escuchar lo que pide el paciente e intentar comprenderlo es fundamental. En los últimos años hemos procurado, con razón, que participe cada vez más en las decisiones sobre su tratamiento: debe comprender los objetivos, poder expresar sus expectativas y hablar con nosotros de las posibilidades para alcanzarlos. Sin embargo, hacerle partícipe no significa que cada petición deba convertirse automáticamente en una nueva fase de tratamiento. Sigue siendo responsabilidad nuestra valorar si lo que desea corregir constituye un objetivo clínicamente apropiado y si el beneficio esperado justifica continuar.

Durante mucho tiempo, al terminar un refinamiento, yo también preguntaba casi automáticamente: «*¿Hay alguna otra cosa que te gustaría cambiar?*». Es una pregunta que parece inofensiva, pero que ya lleva implícita una sugerencia: **que aún queda algo por buscar**. Para un paciente que se fija mucho en los detalles, puede ser casi una invitación a examinar todavía más de cerca su sonrisa hasta encontrar una nueva imperfección.

Con el tiempo he cambiado la forma en que llevo las últimas revisiones. Primero hago mi evaluación clínica y compruebo si hemos alcanzado los objetivos acordados: reviso la oclusión, la alineación, el overjet, el overbite, los contactos y todos los demás aspectos necesarios para poder dar por terminada la fase activa del tratamiento. **Solo entonces hago partícipe al paciente de la evaluación final**, le muestro lo que hemos conseguido y escucho cualquier aspecto del que todavía quiera hablar.

La diferencia puede parecer mínima, pero cambia por completo el sentido de la conversación. El paciente sigue participando y dispone de todo el espacio necesario para expresar lo que ve y lo que siente, **pero no le estamos pidiendo que busque algo que esté mal**. Nuestra responsabilidad sigue siendo valorar si lo que nos señala constituye todavía un objetivo clínico que justifique continuar el tratamiento.

Una de las cosas que hago ahora con más frecuencia con estos pacientes es **llevarlos de vuelta al punto de partida**. Con Stefano debería haberlo hecho mucho antes: en lugar de seguir examinando con él cada nuevo detalle, debería haber ampliado de nuevo la perspectiva y haberle mostrado cuánto había cambiado el resultado respecto a la situación inicial.

Por eso, vuelvo a sacar las fotografías iniciales y las comparo con las actuales. No lo hago para demostrarle al paciente que debería estar satisfecho, porque la satisfacción no se puede imponer, sino **para poner uno al lado del otro el detalle que ahora observa desde unos pocos centímetros y el problema en su conjunto que habíamos decidido tratar al principio.**

«Miremos juntos el resultado en su conjunto. Así estábamos cuando empezamos y estos eran los objetivos que nos habíamos marcado. Los hemos alcanzado. Yo también veo el detalle que me señalas, pero tenemos que preguntarnos si modificarlo aportaría un beneficio real o si estamos intentando mejorar algo que ya es clínicamente correcto».

De este modo no niego lo que ve el paciente ni le digo que ese detalle no existe. **Le devuelvo la perspectiva global del tratamiento**, después de meses en los que su atención se ha ido centrando cada vez más en detalles cada vez más pequeños.

Pero, llegados a este punto, tenemos que entender qué significa realmente que el paciente pida continuar, porque no todas las peticiones tienen el mismo significado.

Si no hemos alcanzado alguno de los objetivos que habíamos acordado, para mí no hay discusión posible: hay que completar el tratamiento y, si hace falta otro refinamiento, soy el primero en proponerlo.

También existe la situación contraria, en la que la petición del paciente **no responde a un objetivo ortodóncico concreto o requeriría un movimiento que considero inútil, impredecible o clínicamente inadecuado**. En ese caso no sigo adelante, por mucho que el paciente esté dispuesto a continuar.

Pero hay una tercera posibilidad, y es la que más dificultades suele plantear con el paciente que nunca está satisfecho. **Hemos alcanzado los objetivos del tratamiento y yo no considero necesario otro refinamiento, pero el paciente señala otro detalle, real, modificable y clínicamente aceptable, sobre el que todavía quiere intervenir.**

Esta es la situación más difícil de gestionar, porque no puedo decirle al paciente que lo que me señala no existe ni tampoco que no se pueda modificar. Pero sí puedo explicarle que **una cosa es completar los objetivos del tratamiento y otra decidir continuar más allá de esos objetivos para intentar perfeccionar aún más el resultado**.

Cuando las explicaciones no bastan

Durante mucho tiempo intenté gestionar estas situaciones apoyándome sobre todo en la comunicación. Mostraba las fotografías iniciales, recordaba los objetivos que habíamos acordado, comparaba el punto de partida con el resultado alcanzado y explicaba por qué otro refinamiento no necesariamente produciría una mejora significativa. Todo esto sigue siendo indispensable y aún hoy constituye la primera parte de mi forma de abordarlo, pero con algunos pacientes me di cuenta de que no era suficiente. Podía dedicar mucho tiempo a explicar que habíamos alcanzado los

objetivos y que el detalle que estábamos examinando no hacía necesaria otra fase de tratamiento, pero al final la pregunta era casi siempre la misma:

«Lo entiendo, doctor, pero si aún podemos intentarlo, ¿por qué no hacerlo?»

Desde el punto de vista del paciente, en realidad, era una pregunta perfectamente lógica. Si continuar no suponía pagar más, si llevar los alineadores unos meses más tampoco suponía ya un sacrificio especialmente importante y si, en cualquier caso, teníamos la posibilidad de fabricar otra serie, **¿por qué parar?** Aunque el beneficio esperado fuera mínimo e incierto, el coste que percibía por intentarlo era prácticamente nulo.

Eso era lo que no había comprendido durante mucho tiempo. Seguía buscando mejores argumentos para explicar por qué era razonable parar, mientras el paciente seguía viendo una posibilidad de mejora que, desde su punto de vista, apenas tenía consecuencias. Mientras las dos alternativas fueran *parar* o *volver a intentarlo gratis*, incluso un detalle muy pequeño podía parecer motivo suficiente para elegir la segunda. Así que comprendí que, en esta situación concreta, las explicaciones por sí solas no bastaban. **Tenía que hacer tangible la decisión de continuar.**

En mi consulta he optado por hacer tangible esa decisión introduciendo un coste para esa fase adicional de tratamiento, que suele ser de **1 000 euros.** La cifra en sí no es lo fundamental y, por supuesto, no pretende ser una regla aplicable a todos: cada compañero puede fijar un importe acorde con su propia realidad profesional. Lo que importa es que el importe sea lo bastante significativo para transformar lo que hasta ese momento se percibía como la simple posibilidad de *«volver a intentarlo»* en una verdadera decisión. Quiero ser muy claro en este punto, porque **no introduzco el coste con el objetivo de vender otro refinamiento; al contrario, cuando lo introduzco, mi esperanza es que el paciente decida no hacerlo. Su función es deliberadamente disuasoria**.

Hasta ese momento, el paciente se preguntaba «*Si aún podemos intentarlo, ¿por qué deberíamos parar?*». En cuanto continuar supone una nueva inversión, la pregunta pasa a ser «*¿Es este detalle de verdad tan importante como para justificar otros 1 000 euros y unos meses más de tratamiento?*». Ese es exactamente el cambio que busco: el detalle es el mismo, el movimiento que podríamos intentar conseguir es el mismo, pero **cambia el valor que el paciente atribuye a ese detalle cuando continuar deja de estar exento de consecuencias**. De hecho, muy a menudo, después de explicarle el coste, el paciente vuelve a mirarse la sonrisa y me pregunta: *«Pero ¿usted cree que de verdad merece la pena?»*. Para mí, ese es el momento en que la estrategia ha

alcanzado su objetivo, porque por fin ya no se pregunta solo si es posible continuar, sino cuánto le importa realmente hacerlo.

Por supuesto, estar dispuesto a asumir ese coste no hace aceptable cualquier petición. Esta posibilidad se refiere exclusivamente a la situación que acabamos de describir: se han alcanzado los objetivos del tratamiento y la modificación solicitada no es necesaria, pero es precisa, clínicamente aceptable y razonablemente realizable. Si considero que el movimiento es inútil, impredecible o potencialmente perjudicial, no sigo adelante, por mucho que el paciente esté dispuesto a pagar; del mismo modo, si el paciente sigue diciendo de forma genérica «*no me gustan*» sin poder identificar qué querría modificar, todavía no tenemos un objetivo sobre el que plantear una nueva fase. El coste no convierte en indicado un movimiento que no lo está: solo entra en juego una vez que hemos establecido que esa modificación puede realizarse, pero no es necesaria para completar el tratamiento.

GUION OPERATIVO

Cuando considero que se han alcanzado los objetivos del tratamiento, pero el paciente me señala otro detalle que le gustaría modificar, la conversación puede ser más o menos así:

> *«Miremos juntos de dónde partimos y cuáles eran los objetivos que habíamos establecido. Yo también veo el detalle que me señalas y podemos intentar modificarlo, pero, desde mi punto de vista, no hace falta otro refinamiento para completar el tratamiento, porque hemos alcanzado los objetivos que habíamos acordado.*
>
> *Si pensara que todavía hay algo que debemos corregir, sería el primero en proponerte otra serie de alineadores y, por supuesto, no tendría ningún coste adicional. En este caso, en cambio, estamos hablando de un perfeccionamiento adicional que tú deseas conseguir más allá del resultado ya alcanzado.*
>
> *Si para ti este detalle es lo bastante importante como para querer continuar, podemos valorarlo, siempre que podamos definir exactamente qué queremos modificar y que el movimiento sea clínicamente aceptable y razonablemente predecible. En mi consulta, esta fase adicional tiene un coste de 1 000 euros.*
>
> *No te estoy aconsejando que la hagas; al contrario, mi recomendación es parar. Simplemente te doy la posibilidad de decidir si este detalle es lo bastante importante para ti como para justificar una nueva inversión y unos meses más de tratamiento».*

Si, llegados a este punto, el paciente me pregunta *«Pero ¿usted cree que de verdad merece la pena?»*, mi respuesta debe ser coherente con lo que acabo de explicarle. Si considero que hemos alcanzado los objetivos y que el beneficio esperado es marginal, le digo exactamente eso. **El coste no sirve para vender el refinamiento, sino para hacer real la decisión de llevarlo a cabo.**

Por qué funciona este protocolo

- **Devuelve la perspectiva al punto de partida**

Con el paso del tiempo, el paciente tiende a acostumbrarse al resultado obtenido y a centrar progresivamente la atención en lo que aún podría mejorarse. Volver a sacar las fotografías iniciales no sirve para convencerlo de que debería estar satisfecho, sino para evitar que el último pequeño detalle se convierta en el único criterio con el que juzgar todo el tratamiento.

- **Evita sugerir que necesariamente queda algo por corregir**

La pregunta «¿Hay algo más que quieras cambiar?» lleva implícita una invitación a buscar. Por eso prefiero hacer primero mi evaluación clínica y solo después escuchar las observaciones que pueda tener el paciente. No reduzco su participación, pero evito convertir la revisión final en una búsqueda sistemática de la siguiente imperfección.

- **Convierte una posibilidad en una decisión**

Cuando se percibe que otro refinamiento está disponible sin consecuencias, incluso un beneficio muy pequeño puede parecer motivo suficiente para intentarlo. Introducir un coste cambia esta valoración porque vuelve a poner de manifiesto algunos aspectos que la posibilidad de continuar había ido dejando en segundo plano: el tiempo, el esfuerzo y, sobre todo, la importancia que el paciente concede realmente al detalle que desea modificar.

No se trata de convencerlo con dinero, sino de romper el automatismo del «podemos volver a intentarlo». Por eso, el importe debe ser lo bastante significativo como para exigir una decisión consciente, aunque, por supuesto, sigue siendo una decisión organizativa que cada profesional debe adaptar a su realidad.

- **Mantiene separados el deseo y la indicación clínica**

Que el paciente esté dispuesto a asumir el coste no cambia nuestro criterio clínico. Primero debemos establecer que la petición sea precisa, clínicamente aceptable y razonablemente realizable; solo después podemos hablar de una posible fase adicional. **Que haya más alineadores disponibles no es, por sí solo, una indicación para utilizarlos.**

BIBLIOGRAFÍA

Zhao G, Zhu F. Age matters in orthodontics: divergent motivations, perfectionism, and patient--clinician discord in treatment need assessment. *Front Med (Lausanne).* 2026;12:1714237.

Chaptini A, Ghoubril J, Moussallem M, Khoury E. Perception thresholds of dental and gingival asymmetries by orthodontists, dentists, and laypeople when observing close-up smile images using eye tracking technology. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2025;167(2):177-187.

Correa BD, Bittencourt MAV, Machado AW. Influence of maxillary canine gingival margin asymmetries on the perception of smile esthetics among orthodontists and laypersons. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2014;145(1):55-63.

Pachêco-Pereira C, Pereira JR, Dick BD, Perez A, Flores-Mir C. Factors associated with patient and parent satisfaction after orthodontic treatment: a systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(4):652-659.

Al-Omiri MK, Abu Alhaija ES. Factors affecting patient satisfaction after orthodontic treatment. *Angle Orthod.* 2006;76(3):422-431.

Lee R, Hwang S, Lim H, Cha JY, Kim KH, Chung CJ. Treatment satisfaction and its influencing factors among adult orthodontic patients. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2018;153(6):808-817.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Con un paciente **D** tiendo a ser directo y a centrarme en la decisión: «Hemos alcanzado los objetivos que habíamos establecido. Podemos intentar modificar un poco más este detalle, pero no considero necesario otro refinamiento. Si aun así quieres continuar, podemos valorarlo como una fase adicional».

I

Influyente

Con un paciente **I** centro más la atención en el cambio global y en la estética social: «Mira cuánto ha cambiado tu sonrisa desde el principio. El detalle que me señalas existe, pero antes de continuar me gustaría que valoráramos qué importancia tiene realmente en comparación con el resultado global que hemos conseguido».

S

Estable

Con un paciente **S** intento, sobre todo, evitar que viva el final del tratamiento como si dejáramos algo a medias: «Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado y considero adecuado terminar aquí el tratamiento. Si este detalle sigue siendo muy importante para ti, podemos valorarlo de todos modos, pero no es algo que considere necesario corregir».

C

Concienzudo

Con un paciente **C** utilizo criterios más analíticos y verificables: «Hemos revisado los objetivos iniciales y los parámetros clínicos que habíamos establecido. El detalle que observas es real y podemos definirlo con precisión, pero el beneficio previsible de otro refinamiento es limitado. Por tanto, podemos valorar juntos si realmente tiene sentido continuar».

CAPÍTULO 11

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Cuando el paciente sigue pidiendo continuar después de que hayamos alcanzado los objetivos o expresa insatisfacción sin identificar una modificación concreta.
OBJETIVO	Distinguir un tratamiento incompleto de una petición adicional y seguir adelante solo si hay un objetivo clínicamente adecuado y verificable.
QUÉ HACER	1. Valorar si se han alcanzado los objetivos acordados. 2. Comparar las fotografías iniciales con la situación actual y mostrar el cambio conseguido. 3. Identificar la petición: ¿qué diente, qué movimiento, qué resultado debería ser diferente? 4. Si no se ha alcanzado uno de los objetivos acordados, completar el tratamiento. 5. Si la petición es genérica o clínicamente inadecuada, no iniciar una nueva fase. 6. Si hay un detalle real, modificable y clínicamente aceptable, pero no es necesario corregirlo para completar el tratamiento, valorar una fase adicional. 7. Definir el objetivo, el beneficio esperado, los límites y el posible coste antes de seguir adelante. Estar dispuesto a pagar no hace adecuada una petición que no lo es.
QUÉ COMPROBAR	Los objetivos iniciales, el resultado actual, la precisión de la petición, el beneficio previsible y la comprensión de los criterios con los que consideraremos concluida la posible fase adicional.

CAPÍTULO

12

El paciente del 95 %

«Lo mejor es enemigo de lo bueno».

— VOLTAIRE

Hay pacientes que, en cuanto se sientan en el sillón, nos hacen ver que tenemos por delante un tratamiento complejo. Y luego hay otros que nos producen justo la sensación contraria. Sonríen y casi nos preguntamos por qué han venido: ya tienen los dientes rectos, la oclusión es buena, la sonrisa es agradable y puede que incluso hayan llevado ortodoncia antes. A primera vista, parece que hay muy poco que corregir. Entonces el paciente señala un incisivo ligeramente rotado, un pequeño espacio o un diente apenas fuera de posición y dice:

«Doctor, solo quiero arreglar esta cosita».

Con el tiempo he aprendido que precisamente ese **solo** debería ponernos en alerta de inmediato.

Nosotros vemos un pequeño movimiento y tendemos, como es natural, a pensar en un tratamiento pequeño: pocos alineadores, poco tiempo, poca dificultad. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, algunos de los tratamientos que parecen más sencillos desde el punto de vista biomecánico pueden llegar a ser de los más delicados de gestionar, porque, cuando la situación inicial ya es muy buena, incluso el detalle más pequeño adquiere una importancia completamente distinta.

Barry Glaser ha descrito muy bien esta situación con la expresión **«Tiny Touch-Up Patient»**. A partir de esa misma observación, con el tiempo empecé a llamar a estos pacientes **pacientes del 95 %**: pacientes que llegan ya muy cerca del resultado que desean y nos piden que intervengamos solo en ese pequeño margen que aún los separa de su objetivo.

Imaginemos a dos pacientes. El primero llega a la consulta con un problema evidente: dientes visiblemente torcidos, un apiñamiento importante o, en cualquier caso, una situación que claramente desea cambiar. Al final del tratamiento, el resultado nunca será perfecto, porque la perfección no es natural y, en realidad, no existe, pero la mejoría será tan evidente que el paciente no tendrá que buscarla: le bastará comparar el antes y el después para darse cuenta de cuánto ha cambiado su sonrisa. El segundo paciente, en cambio, entra en nuestra consulta con una sonrisa que ya es muy bonita y los dientes prácticamente rectos. No busca una gran transformación: ha venido precisamente por ese pequeño detalle que sigue viendo y que le gustaría corregir.

Y esa es la diferencia que cambia por completo la perspectiva. En el primer paciente, la mejoría es grande, evidente y se aprecia en muchos aspectos de la sonrisa; en el paciente del 95 %, en cambio, todo el valor del tratamiento se concentra en un detalle muy pequeño. Lo que para nosotros puede ser una corrección mínima, para él es el único motivo por el que ha decidido empezar un tratamiento: **ese 5 %, para él, representa el 100 % del problema**. Por eso considero que el paciente del 95 % puede ser más delicado que muchos casos aparentemente complejos: **tenemos poco margen para mejorar y muchísimo que preservar**.

Y es precisamente esa palabra, *solo*, la que puede condicionarnos también a nosotros. Si el paciente considera que el problema es pequeño, fácilmente empezamos a considerar que el tratamiento también lo es. *«Facilísimo»*, *«hacen falta pocos alineadores»*, *«no es nada»* son frases aparentemente tranquilizadoras que he dejado de utilizar. En cuanto decimos que algo será facilísimo, ya no estamos describiendo solo la biomecánica: estamos creando una expectativa. El paciente puede interpretar esa frase como una garantía de que el resultado que desea será

sencillo de conseguir y perfectamente predecible, cuando sabemos de sobra que un movimiento biológico no se vuelve perfectamente predecible solo por ser pequeño.

Hay otro aspecto que conviene aclarar desde el principio: que el paciente vea un solo diente fuera de posición no significa necesariamente que el tratamiento consista simplemente en mover ese diente hasta el lugar correcto. Para rotar un incisivo podríamos necesitar crear espacio; para cerrar un pequeño diastema, quizá tuviéramos que controlar la inclinación de los dientes vecinos y, para mantener una buena oclusión, podríamos tener que intervenir también sobre otros dientes o incluso sobre ambas arcadas. Además, un diente puede no responder exactamente como estaba previsto, puede ser necesario un refinamiento y pueden entrar en juego el torque, los contactos con los dientes vecinos, los tejidos periodontales o limitaciones anatómicas que el paciente no tiene por qué conocer cuando nos pide «*mover apenas este diente*». Es importante explicarlo de antemano, porque nuestro objetivo sigue siendo corregir ese detalle, pero para hacerlo correctamente quizá tengamos que intervenir también en dientes que el paciente considera que ya están perfectamente colocados. Si no lo hemos aclarado desde el principio, puede vivir cualquier movimiento que vaya más allá de ese único diente como algo que no había pedido. **El tamaño aparente del problema, por sí solo, no nos dice lo fácil que será conseguir exactamente el resultado que tenemos en mente.**

El mismo malentendido puede darse en el plano económico. El paciente ve un solo diente que hay que mover y puede pensar que, al tratarse de algo pequeño, el tratamiento también tiene que costar necesariamente poco. Por supuesto, cada compañero establecerá libremente su propio modelo económico, pero pocos alineadores no significan automáticamente poco valor ni poca responsabilidad: incluso un tratamiento pequeño requiere diagnóstico, planificación y responsabilidad clínica. **El paciente no está comprando cuatro, seis o diez alineadores: se está sometiendo a un tratamiento de ortodoncia.**

Definir el objetivo antes de empezar

Con estos pacientes considero fundamental ir más despacio precisamente cuando todo parece invitarnos a darnos prisa. Antes de empezar tengo que entender con precisión qué quiere cambiar el paciente, no de forma genérica, sino muy concreta. Examino con él las fotografías, el escaneo y la situación clínica, le pido que me señale exactamente qué es lo que no le gusta e intento comprender qué resultado imagina. Después le hago una pregunta que considero fundamental: **«Si consiguié-**

ramos corregir exactamente esto y todo lo demás quedara tal como está hoy, ¿estarías satisfecho?»

Es una pregunta muy sencilla, pero a menudo permite saber enseguida si la petición se limita de verdad a ese detalle. Si la respuesta es un sí rotundo, hemos identificado un objetivo concreto y compartido. Si, en cambio, responde «*Sí… pero quizá, ya que estamos, también podríamos…*», probablemente esa pequeña corrección no sea lo único que el paciente querría cambiar, y es mucho mejor descubrirlo antes de empezar. En los casos más delicados, considero útil que lo acordado llegue incluso a **compartirse con el paciente y a quedar firmado por él**, no para convertir la relación médico-paciente en algo legal o defensivo, sino sencillamente para que, con el paso del tiempo, siga estando claro por qué empezamos el tratamiento y qué resultado nos propusimos alcanzar.

Si el paciente quiere rotar ligeramente un incisivo, tomaremos como referencia esa rotación; si quiere cerrar un pequeño espacio, será el cierre de ese espacio. Puede parecer una distinción trivial, pero establecer con precisión la meta también significa establecer cuándo podremos dar por terminado el tratamiento. **Si no sabemos qué tiene que ocurrir para poder decir «hemos terminado», cada mejoría corre el riesgo de convertirse simplemente en el punto de partida de una nueva petición.**

De hecho, una vez alcanzado el objetivo inicial, puede suceder que el paciente se fije en algo que antes le pasaba inadvertido. Esto no significa necesariamente que estemos ante una persona que nunca está satisfecha: puede ser sencillamente una consecuencia del cambio conseguido. La cuestión es distinguir lo que falta para alcanzar el objetivo acordado de una nueva petición. Si el paciente había venido para cerrar un espacio y ese espacio no se ha cerrado del todo, aún estamos completando el tratamiento; si, en cambio, lo hemos cerrado tal como acordamos y ahora aparece otro detalle que quiere modificar, estamos hablando de algo distinto. El paciente rara vez lo plantea así. Lo más habitual es que diga: «*Ya que estamos…*». Y es precisamente ese *ya que estamos* lo que puede convertir un pequeño retoque en un proceso sin un final claro.

Hay un caso que probablemente me enseñó más que ningún otro lo peligroso que puede ser confundir el deseo de complacer a un paciente con la decisión clínicamente más adecuada, y que todavía hoy considero uno de los episodios más estresantes de mi experiencia profesional. Nadia era la madre de uno de mis pequeños pacientes, al que había tratado por una clase III con un expansor maxilar. Estaba muy satisfecha con el resultado obtenido por su hijo y, durante una de sus revisiones, me dijo casi en broma: «*Doc, tarde o temprano tendremos que hacer algo*

también con mis dientes». Le pregunté qué era lo que no le gustaba y me explicó que, en conjunto, su sonrisa le parecía bien, pero notaba la arcada superior un poco estrecha y, sobre todo, no le gustaba la posición del incisivo lateral superior derecho, el 12, ligeramente lingualizado respecto a los demás dientes. En las fotografías, ese diente quedaba más en sombra y parecía más oscuro, y era precisamente ese detalle lo que le molestaba.

Como ya estaba en la consulta, le propuse hacer un escaneo para entender mejor la situación. Fue precisamente ese escaneo el que nos mostró que el caso era menos sencillo de lo que podía parecer si solo mirábamos el incisivo lateral: Nadia presentaba una tendencia a la clase III, una tendencia a la mordida cruzada en el lado derecho, en la zona de los premolares y el primer molar, y cierto apiñamiento en la arcada inferior. Le expliqué que, si queríamos plantear un tratamiento de ortodoncia completo, tendríamos que tener en cuenta ambas arcadas y corregir el equilibrio oclusal en su conjunto. Ella, sin embargo, fue muy clara: el apiñamiento inferior no le importaba nada porque *«total, los dientes de abajo no se veían»*, mientras que lo que de verdad quería era llevar más hacia vestibular ese incisivo lateral superior que quedaba en sombra en las fotografías. Así que acepté realizar un tratamiento limitado a la arcada superior con una modalidad comercial limitada a 20 alineadores. El objetivo era preciso y relativamente sencillo: corregir la posición del 12 sin convertir esa petición en un tratamiento de ortodoncia completo al que la paciente, en aquel momento, no quería someterse.

Tras unos diez o doce alineadores, en poco más de tres meses, conseguimos exactamente lo que Nadia me había pedido. El incisivo lateral estaba en la posición correcta, la sonrisa había mejorado y ella estaba muy satisfecha. Le pregunté expresamente si le gustaba el resultado y me confirmó que sí, de modo que, respecto al objetivo por el que había venido inicialmente, el tratamiento podría haberse dado por concluido. Pero fue justo entonces cuando Nadia empezó a mirar su sonrisa de otra manera: comenzó a fijarse más en la zona posterior derecha y me dijo que le gustaría ver la arcada un poco más amplia en la zona de los premolares, para reducir lo que percibía como un corredor bucal demasiado evidente. Le expliqué por qué no me parecía buena idea limitarse a expandir la arcada superior: por un lado, tendríamos que mantener una relación adecuada con la arcada inferior, pues de lo contrario nos arriesgaríamos a crear contactos prematuros; por otro, al expandir los premolares crearíamos inevitablemente espacios difíciles de gestionar. Pero Nadia insistía. No quería una gran expansión, me decía, *«solo un poquito, lo que se pueda hacer»*.

Y ahí fue donde cometí el error. Me parecía que la conocía, había tratado a su hijo, hasta entonces la relación había sido excelente y Nadia siempre me había parecido una persona razonable. Por eso decidí acceder a su petición y le propuse hacer un nuevo escaneo, explicándole que prepararía una simulación extremadamente prudente, con la mínima expansión que consideraba compatible con la oclusión. Cuando volvió para ver el setup, ocurrió algo que hoy reconozco de inmediato como una de las señales más importantes del paciente del 95 %: miró la simulación y me dijo que le gustaría un poco más de expansión. Modifiqué ligeramente el setup y le mostré que, si aumentábamos el movimiento, podríamos crear espacios y alterar la relación con la arcada inferior, pero ella volvió a pedirme un pequeño aumento de la expansión. Le enseñé otra vez cuáles podían ser las consecuencias, insistiendo en el riesgo de crear contactos prematuros y en la necesidad de encontrar un término medio, hasta que me dijo que esa cantidad de expansión le parecía suficiente y aprobé el refinamiento.

Tres meses después, Nadia volvió extremadamente insatisfecha. La expansión de los premolares había creado pequeños espacios en los que tendía a meterse la comida y, al intentar ajustar la forma de la arcada, el canino superior derecho se había desplazado ligeramente hacia dentro y había desarrollado un contacto prematuro con el canino inferior. Entonces intenté corregir el problema con un segundo refinamiento, llevando el canino más hacia vestibular y modificando de nuevo la posición de los premolares, pero cada vez que corregía un aspecto aparecía otro: el canino mejoraba, pero cambiaban los contactos posteriores; ajustábamos los contactos y surgía algún otro detalle que a Nadia le resultaba molesto. Lo que había empezado como un pequeño retoque se estaba convirtiendo poco a poco en un tratamiento sin un final claro. En mi empeño por satisfacerla, llegué incluso a abrir, a mi costa, un nuevo caso para disponer de más series de alineadores y seguir buscando una solución que por fin la dejara contenta. Lo que al principio había sido un tratamiento de unos tres meses, concluido con una paciente satisfecha con el resultado obtenido en el incisivo lateral, se convirtió así en un proceso de quince a dieciocho meses.

Cada cita se volvía progresivamente más difícil, y una visita que normalmente habría durado diez minutos podía convertirse en una hora o incluso en una hora y media de discusiones. Nadia estaba cada vez más enfadada, yo cada vez más estresado y la relación, que al principio había sido excelente, se deterioraba visita tras visita. Todavía recuerdo perfectamente lo que sentía cuando veía aparecer su nombre en la agenda: sabía que me esperaba una cita larga y difícil y, antes incluso de que llegara a la consulta, ya notaba cómo crecía una tensión que acababa acom-

pañándome durante todo el día. Seguía recordándole que, antes de empezar aquella segunda fase, le había explicado varias veces por qué no consideraba oportuno expandir solo la arcada superior. Su respuesta, sin embargo, fue probablemente una de las lecciones más importantes que me ha dado un paciente:

«Sí, doctor, pero el médico eres tú. Tendrías que haberme dicho que no».

Con el tiempo tuve que admitir que, en eso, Nadia tenía razón. No porque yo no hubiera entendido la biomecánica del caso, pues la había entendido perfectamente y se la había explicado, sino porque, una vez establecido que aquella petición no era clínicamente adecuada, la responsabilidad de mantener ese límite seguía siendo mía. El paciente puede insistir, puede decirnos que acepta el riesgo, puede pedirnos «*solo un poquito*», pero seguimos siendo nosotros quienes decidimos si debe realizarse ese movimiento. La situación estuvo muy cerca de convertirse en un verdadero conflicto médico-legal: Nadia pidió otra valoración y le explicaron que, para corregir adecuadamente la situación, sería conveniente tratar ambas arcadas y abordar el caso en su conjunto; en la práctica, justo el tipo de tratamiento que le había propuesto al principio y que ella había rechazado.

Al final, para evitar que la situación empeorara aún más, decidí devolverle todo lo que había pagado. El balance fue duro desde todos los puntos de vista: había asumido personalmente el coste de dos casos, había devuelto todos los honorarios, había dedicado una cantidad enorme de tiempo clínico y de energía del equipo, y un tratamiento que podría haber terminado con un resultado excelente después de tres meses había durado más de un año. Nadia estaba insatisfecha, yo también, y difícilmente una paciente que al principio había depositado tanta confianza en la consulta seguiría hablando de nosotros con el mismo entusiasmo con el que lo había hecho después del tratamiento de su hijo. Pero el mayor coste, al menos para mí, no fue económico: fue el estrés generado por una situación que yo mismo había contribuido a crear en mi intento de complacer a una paciente, pese a saber desde el principio que aquella expansión limitada a la arcada superior no era la solución que habría elegido desde el punto de vista clínico.

Visto con perspectiva, es muy fácil identificar el momento en que debería haberme detenido: fue la cita posterior a la primera serie de alineadores, cuando Nadia estaba satisfecha y el incisivo lateral por el que había venido se encontraba en la posición correcta. Habíamos alcanzado el objetivo acordado y todo lo que vino después no fue la finalización de aquel tratamiento, sino el comienzo de uno nuevo que yo mismo no consideraba clínicamente adecuado y que, aun así, acepté en mi intento de complacerla. Ese es exactamente el peligro del paciente del 95

%: no tanto el pequeño movimiento por el que acude inicialmente a nosotros, sino la posibilidad de que, una vez alcanzado ese objetivo, la meta cambie y nosotros sigamos persiguiéndola hasta perder de vista la diferencia entre escuchar lo que el paciente desea y acceder a una petición que ya no consideramos clínicamente adecuada.

Hoy, ante la misma situación, mi respuesta sería muy distinta: «*Entiendo perfectamente qué te gustaría mejorar y también entiendo por qué ahora, al mirar tu sonrisa de otra manera, eso te molesta más. El problema es que, para intentar conseguir ese cambio, tendría que alterar un equilibrio que hoy funciona bien y no estoy seguro de que sea la mejor opción para ti. Si quieres, podemos estudiar juntos un tratamiento más completo que tenga en cuenta también este aspecto; si no, respecto al objetivo por el que empezamos, creo que podemos dar el tratamiento por terminado*». Esta experiencia me enseñó una regla que hoy considero fundamental para tratar a los pacientes del 95 %: **escuchar al paciente significa tomarse en serio lo que desea, pero no significa hacer necesariamente lo que nos pide.**

Preservar el 95 %

El caso de Nadia cambió profundamente mi forma de abordar a estos pacientes. Antes de preguntarme cómo conseguir el movimiento que me piden, hoy intento entender qué me arriesgo a alterar al hacerlo. Una situación inicial muy buena encierra una paradoja: tenemos poco que ganar, porque el defecto que queremos corregir es pequeño, pero podemos tener mucho que perder, porque alrededor de ese defecto hay dientes, contactos y relaciones oclusales que ya funcionan correctamente. Por tanto, cada movimiento debe aportar un beneficio que justifique lo que nos vemos obligados a modificar para realizarlo.

La primera comprobación es si está indicado el tratamiento, porque lo que se percibe como un problema de posición no siempre depende realmente de la posición del diente. Una diferencia entre dos incisivos puede deberse a la forma de las coronas, a los bordes incisales, a la encía, al desgaste, al color o, sencillamente, a cómo incide la luz sobre dos superficies distintas. En estos casos, seguir moviendo un diente puede no resolver en absoluto lo que molesta al paciente, mientras que una pequeña corrección restauradora, un remodelado del borde incisal o, en casos seleccionados, una intervención en los tejidos gingivales pueden dar un resultado mucho más proporcionado. La pregunta que debemos hacernos es, por tanto: **¿estoy intentando corregir con ortodoncia algo que realmente corresponde a la ortodoncia?**

Pero incluso cuando la respuesta es sí, un movimiento pequeño sigue siendo un movimiento biológico. Con los alineadores podemos programar en la pantalla rotaciones de unos pocos grados, extrusiones de unas décimas de milímetro, cambios de torque o cierres de espacios extremadamente precisos, pero lo que vemos en el software sigue siendo un proyecto y la respuesta clínica no se vuelve matemáticamente predecible solo porque el movimiento sea pequeño. Esto cobra aún más importancia cuando ese movimiento es precisamente el único motivo por el que el paciente ha decidido empezar el tratamiento.

También debemos pensar desde el principio en la estabilidad. En un paciente al que se le ha corregido un problema importante, una mínima variación en la posición de un diente puede incluso pasar inadvertida; en un paciente que ha venido exclusivamente para cerrar medio milímetro de espacio o corregir una pequeña rotación, esa misma recidiva puede suponer la reaparición exacta del motivo por el que había decidido tratarse. **Por tanto, la retención no puede ser un detalle que se comente al final, sino que debe formar parte de la conversación inicial.**

El paciente nos está pidiendo que corrijamos el 5 %. Nosotros tenemos la responsabilidad de no perjudicar el 95 % que ya tiene.

GUION OPERATIVO

Con un paciente de este tipo prefiero abordar la cuestión antes incluso de empezar, porque dejar las cosas claras al principio casi siempre evita conversaciones mucho más difíciles al final:

> *«Tu situación de partida ya es muy buena, y eso es positivo. Precisamente por eso debemos definir con mucha precisión qué quieres cambiar, porque me estás pidiendo que intervenga en un pequeño detalle dentro de una situación que ya funciona bien. Primero tenemos que averiguar si lo que te molesta se debe realmente a la posición del diente y, si es así, ese será nuestro objetivo. Pero ten en cuenta que, aunque quieras corregir un solo diente, puede que necesitemos mover otros, crear espacio o trabajar en ambas arcadas para hacerlo correctamente sin alterar lo que ya funciona bien.*
>
> *Si decidimos empezar, definiremos juntos el resultado que queremos conseguir y también cuándo podremos dar el tratamiento por concluido. Si alcanzamos ese objetivo, habremos conseguido aquello por lo que empezamos. Si por el camino te fijas en otro detalle, por supuesto lo valoraremos juntos, pero será una nueva petición y tendremos que ver si realmente tiene sentido intervenir. Y precisamente*

> *porque estamos corrigiendo algo muy pequeño, también debemos pensar desde el principio en cómo mantener el resultado a lo largo del tiempo».*

El tono debe seguir siendo positivo. No intentamos asustar al paciente ni establecer una serie de cláusulas defensivas; simplemente dejamos claro que aceptamos corregir **un objetivo definido**, no iniciar un proceso de perfeccionamiento sin final.

Por qué funciona este protocolo

- **Define la meta antes de empezar**

En el paciente del 95 %, el detalle que desea corregir representa una parte mínima de su sonrisa, pero casi todo el motivo por el que ha decidido empezar el tratamiento. Definirlo con precisión permite al profesional y al paciente saber desde el principio qué intentan conseguir y, sobre todo, reconocer cuándo han alcanzado ese objetivo.

- **Pone en perspectiva el significado de la palabra «solo»**

Un problema pequeño no implica necesariamente un tratamiento sencillo. Explicar desde el principio que puede que tengamos que incluir otros dientes, crear espacio o intervenir en ambas arcadas evita que cada movimiento necesario se interprete como algo inesperado. **La magnitud del problema percibido no determina necesariamente la complejidad del tratamiento necesario para corregirlo.**

- **Protege lo que ya funciona bien**

Partir de una situación muy buena cambia la relación entre el beneficio esperado y lo que debemos preservar. Antes de aceptar la petición, debemos comprobar no solo si el movimiento es posible, sino también si está indicado desde el punto de vista ortodóncico y si el beneficio esperado justifica los cambios necesarios para conseguirlo.

- **Define a la vez el resultado y la estabilidad**

En el paciente del 95 %, una pequeña recidiva puede equivaler a la reaparición de todo el problema percibido. Hablar de la retención antes del tratamiento deja claro, por tanto, que corregir ese detalle es solo una parte del proceso: la otra consiste en conseguir mantener el resultado.

BIBLIOGRAFÍA

Haouili N, Kravitz ND, Vaid NR, Ferguson DJ, Makki L. Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2020;158(3):420-425.

Kokich VO Jr, Kiyak HA, Shapiro PA. Comparing the perception of dentists and lay people to altered dental esthetics. *J Esthet Dent.* 1999;11(6):311-324.

Al-Moghrabi D, Littlewood SJ, Fleming PS. Orthodontic retention protocols: an evidence-based overview. *Br Dent J.* 2021;230(11):770-776.

Pachêco-Pereira C, Pereira JR, Dick BD, Perez A, Flores-Mir C. Factors associated with patient and parent satisfaction after orthodontic treatment: a systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(4):652-659.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Con el paciente **D** voy enseguida al resultado y a los límites del tratamiento: «*La situación ya es muy buena. Definamos exactamente el detalle que quieres corregir y el resultado que queremos conseguir. Puede que también tengamos que incluir otros dientes para hacerlo correctamente, pero nuestro objetivo seguirá siendo el que hemos acordado. Una vez alcanzado, el tratamiento habrá concluido*».

I

Influyente

Con el paciente **I** doy más protagonismo a la imagen de la sonrisa y a acordar juntos el resultado: «*Partimos ya de una situación muy bonita y precisamente por eso quiero proteger todo lo que funciona bien. Enséñame exactamente qué detalle te gustaría mejorar: lo definiremos juntos y lo documentaremos para que, al final, podamos comparar el resultado con lo que querías conseguir. Cuando hayamos alcanzado ese objetivo, el tratamiento habrá concluido y después será fundamental mantener el resultado*».

S

Estable

Con el paciente **S** recalco sobre todo que no queremos trastocar una situación que ya funciona bien: «*Partimos de una situación muy favorable y el objetivo no es cambiarlo todo, sino intervenir con prudencia en este detalle y mantener estable lo que funciona bien. Antes de empezar definiremos juntos qué quieres conseguir y te explicaré qué dientes podría ser necesario incluir, para que no te lleves sorpresas durante el tratamiento*».

C

Concienzudo

Con el paciente **C** utilizo una estructura más analítica: «*Primero hay que analizar el detalle que me señalas para entender a qué se debe realmente. Si es un problema de posición dental, valoraremos el movimiento necesario y su efecto sobre el espacio, los contactos y la oclusión; si se debe, en cambio, a la forma del diente o a los tejidos circundantes, podríamos considerar otra solución. Definamos, por tanto, el objetivo, los criterios con los que daremos el tratamiento por concluido y cómo mantendremos el resultado*».

CAPÍTULO 12

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Cuando el paciente parte de una situación ya favorable y pide corregir un detalle, presentándolo como una intervención mínima.
OBJETIVO	Corregir el detalle cuando esté indicado, protegiendo lo que ya funciona bien y definiendo de antemano el punto de llegada.
QUÉ HACER	1. Identificar exactamente el diente, el detalle y el resultado deseado. 2. Comprobar que el problema se debe a la posición dental y que el movimiento está indicado desde el punto de vista ortodóncico. 3. Valorar qué dientes, contactos y equilibrios habrá que modificar y cuáles deberán preservarse. 4. Explicar que una petición limitada puede requerir movimientos más amplios de lo que el paciente imagina. 5. Definir y documentar el objetivo y los criterios para dar el tratamiento por concluido, distinguiéndolos de posibles peticiones nuevas. 6. Dejar claro que un movimiento pequeño sigue siendo biológico y no permite prometer una precisión matemática. 7. Planificar la retención desde el principio: una recidiva mínima puede hacer reaparecer todo el problema percibido.
QUÉ COMPROBAR	Origen del defecto, indicación clínica, efectos sobre la oclusión, expectativas, consecución del objetivo y mantenimiento del resultado. No subestimar el «solo»: ese detalle puede representar el 100 % del motivo por el que el paciente quiere tratarse.

CAPÍTULO

13

Cuando terminar no significa haber acabado

«Finis coronat opus».

— PROVERBIO LATINO MEDIEVAL

Durante años observé en mis pacientes algo que no lograba explicarme del todo. Tenía la sensación de que algunos resultados obtenidos con alineadores tendían a presentar recidivas con más facilidad que los de los casos que había tratado con aparatos fijos. No ocurría en todos los casos ni afectaba a todos los movimientos del mismo modo, pero, en mi experiencia, eran sobre todo las rotaciones y algunos movimientos verticales, como las intrusiones y las extrusiones, los que atraían mi atención.

Al principio se trataba solo de una impresión clínica y, precisamente por eso, no podía convertirla automáticamente en una conclusión. La primera explicación que

consideré fue la más inmediata: quizá no estaba observando un problema de estabilidad, sino simplemente movimientos que eran más difíciles de completar con alineadores. La literatura nos recuerda, de hecho, que la eficacia del tratamiento no es la misma para todos los tipos de movimiento y que el control de algunas rotaciones, del torque y de los movimientos verticales puede suponer un reto mayor que el de otros desplazamientos.

Sin embargo, esa explicación no justificaba del todo lo que veía, porque no estaba observando únicamente dientes que no habían alcanzado la posición programada. En muchos casos habían alcanzado correctamente esa posición; la dificultad aparecía después, cuando había que mantenerla.

Empecé entonces a preguntarme si no estaría viendo el problema desde una perspectiva equivocada. Quizá la pregunta no era solo **cómo había movido ese diente**, sino **cuánto tiempo le había dado para estabilizarse después de moverlo**.

Cuando movemos un diente mediante ortodoncia, no estamos simplemente cambiando las coordenadas de su corona dentro de la arcada, sino modificando un sistema biológico formado por hueso, ligamento periodontal y tejidos gingivales, que deben adaptarse progresivamente a la nueva posición. Por tanto, el final del movimiento ortodóncico y el de la reorganización biológica no coinciden necesariamente.

Los estudios clásicos sobre la estabilidad tras el tratamiento han mostrado que los distintos tejidos no se reorganizan todos a la misma velocidad. El ligamento periodontal tiende a reorganizarse en unos tres o cuatro meses, mientras que las fibras colágenas gingivales pueden necesitar entre cuatro y seis meses. Algunos componentes de las fibras supracrestales pueden tardar aún más: los estudios histológicos clásicos los describen como no completamente reorganizados **232 días después de concluir el movimiento ortodóncico**, sobre todo tras la corrección de rotaciones.

Precisamente este último dato me llamó la atención: **232 días son casi ocho meses**. Esto no significa que todos los dientes necesiten casi ocho meses para estabilizarse ni que la literatura proponga el protocolo que desarrollé más adelante. Pero sí me ayudó a comprender mejor una idea fundamental: **un diente puede haber terminado de moverse mucho antes de que los tejidos que lo rodean hayan completado su adaptación a la nueva posición.**

En ese momento empecé a pensar también en una diferencia muy sencilla entre los aparatos fijos y los alineadores. Con los aparatos fijos, una rotación puede corregirse por completo en las primeras fases del tratamiento, igual que la curva de Spee puede aplanarse o un movimiento vertical completarse mucho antes de retirar el aparato. Sin embargo, el tratamiento continúa: pasamos a arcos más rígidos,

aplicamos mecánicas sagitales, controlamos los espacios y refinamos la oclusión, mientras ese diente permanece durante meses dentro de un sistema que limita su desplazamiento.

Por tanto, cuando finalmente retiramos el aparato, puede haber pasado mucho tiempo desde que concluyó ese movimiento concreto. Fue entonces cuando empecé a plantear una posible explicación de lo que observaba: **con los aparatos fijos, parte de la estabilización podría producirse mientras el tratamiento sigue en curso.**

Con los alineadores, en cambio, ese intervalo puede ser mucho más breve. Una rotación, una intrusión o una extrusión pueden programarse hasta los últimos alineadores y, si es necesario, corregirse de nuevo durante un refinamiento. Así, podemos llegar al final del tratamiento activo prácticamente en el mismo momento en que estamos completando precisamente uno de los movimientos que consideramos más delicados.

Esto me llevó a mirar la duración del tratamiento desde otra perspectiva. **Dieciocho meses de tratamiento no significan necesariamente dieciocho meses de estabilización para cada movimiento que hemos realizado.** Dos pacientes pueden haber seguido ambos un tratamiento de dieciocho meses, pero un incisivo podría llevar nueve meses en su posición definitiva en el primero y solo unas semanas en el segundo.

Esta sigue siendo una hipótesis clínica mía, no un mecanismo demostrado por la literatura. Sin embargo, junto con lo que sabemos sobre los tiempos de reorganización de los tejidos, me llevó a cambiar la forma en que concluía mis tratamientos.

De esta reflexión nació mi protocolo de estabilización.

Nueve meses que antes no existían

Antes, cuando estaba satisfecho con el resultado, el proceso era muy sencillo: terminaba el tratamiento activo, realizaba el escaneo para los retenedores y pedía al paciente que los utilizara por la noche, según el protocolo que describiré en el capítulo siguiente. En la práctica, pasaba casi directamente de usar los alineadores unas veintidós horas al día a llevar los retenedores por la noche unas diez horas.

Llegó un momento en que dejé de hacerlo. Si los tejidos necesitaban tiempo para reorganizarse, me parecía poco coherente completar los últimos movimientos y, justo después, reducir drásticamente las horas durante las que esos dientes se mantenían en la posición recién alcanzada. Así que introduje entre el tratamiento activo y la retención definitiva una fase que antes no existía: **la fase de estabilización**.

En mi práctica dura nueve meses en total. Esta duración no procede de un estudio que haya demostrado que nueve meses sean el periodo ideal, sino de una decisión clínica que fui tomando con el tiempo, a partir de lo que observaba en mis pacientes y del largo periodo de reorganización biológica descrito para algunos tejidos supracrestales, que puede llegar hasta los **232 días** de los que hemos hablado.

Pero entonces tenía que decidir cómo organizar esos nueve meses. No quería que se convirtieran simplemente en un largo periodo de espera, sino que acompañaran al paciente de forma progresiva desde las veintidós horas aproximadas de la fase activa hasta las diez horas aproximadas de la futura retención nocturna. Por eso los dividí en **tres fases consecutivas de tres meses**, cada una con un objetivo concreto.

Tres meses para estabilizar. Tres meses para reducir gradualmente. Tres meses para favorecer el asentamiento.

Así nació la secuencia que sigo utilizando hoy, el **Protocolo de estabilización Pasciuti 3-3-3**, que incluye un total de 24 alineadores de estabilización. Sin embargo, lo reservo para los pacientes que reúnen las condiciones clínicas adecuadas y colaboran lo suficiente: si la falta de colaboración hace poco realista añadir otros nueve meses de alineadores, concluyo la fase activa y paso directamente a la retención.

Los primeros tres meses: estabilizar

Los primeros doce alineadores se utilizan exactamente igual que los alineadores activos anteriores: uno por semana, unas veintidós horas al día. Para el paciente, aparentemente cambia muy poco, porque mantiene la rutina a la que se acostumbró durante el tratamiento; desde el punto de vista terapéutico, en cambio, el objetivo cambia por completo. Ya no busco modificar la oclusión ni completar nuevos movimientos clínicamente significativos, sino mantener lo conseguido y dar a los tejidos un primer periodo para adaptarse a la posición alcanzada.

Los tres meses siguientes: reducir gradualmente

Una vez utilizados los primeros doce alineadores, empiezo a reducir progresivamente las horas de uso. El alineador número 13 se utiliza veintiuna horas al día; el número 14, veinte horas; el número 15, diecinueve y así sucesivamente, reduciendo una hora con cada cambio semanal hasta llegar al alineador número 24, que se utiliza diez horas al día.

De este modo, el paso de una cobertura casi continua al uso nocturno no se produce de golpe: cada semana añadimos una hora sin alineador y acompañamos progresivamente al paciente hacia la fase siguiente.

Los últimos tres meses: favorecer el asentamiento

Cuando el paciente llega al alineador número 24, el programa vuelve a cambiar. Ya no tiene que sustituirlo, sino que sigue utilizando **ese mismo alineador durante los tres meses siguientes**, solo por la noche, unas diez horas.

En ese momento han transcurrido seis meses desde que concluyeron los movimientos activos y ya no quiero únicamente mantener los dientes en la posición alcanzada: también quiero dejar más margen a la función para que la oclusión pueda encontrar progresivamente su equilibrio.

Siempre he pensado que la tarea del ortodoncista no consiste en construir una oclusión en la pantalla y luego intentar inmovilizarla indefinidamente en esa posición. Nuestro objetivo es colocar los dientes en las mejores condiciones para que, una vez terminados los movimientos ortodóncicos, la masticación, los contactos y la función también puedan contribuir a su asentamiento.

Por eso, durante los últimos tres meses, ya no hay ningún material interpuesto entre las arcadas durante el día y los dientes vuelven a entrar en contacto al ejercer su función, lo que favorece ese asentamiento progresivo de la oclusión que denominamos **asentamiento oclusal**.

La decisión de mantener el mismo alineador durante los tres meses es intencionada. Un material termoplástico sometido a un uso repetido no conserva necesariamente con el tiempo las mismas características mecánicas que tenía cuando era nuevo. Fenómenos viscoelásticos como la relajación de tensiones (*stress relaxation*) modifican progresivamente las fuerzas que ejerce el material.

No considero que esta modificación progresiva de las propiedades mecánicas del alineador sea la causa del *asentamiento oclusal*, ni mi protocolo se ha estudiado experimentalmente para demostrar una relación de este tipo. **La decisión de mantener el mismo alineador forma parte, más bien, de una estrategia en la que el alineador debe dejar progresivamente de comportarse como algo que intenta controlar de forma rígida cada detalle de la oclusión**, pero seguir protegiendo durante la noche la posición alcanzada.

Al término de esta fase han transcurrido **nueve meses desde que concluyeron los movimientos activos**. Solo entonces doy por concluido el periodo de estabilización y realizo un nuevo escaneo para fabricar la férula de retención definitiva.

En la práctica: cómo obtengo los 24 alineadores de estabilización

Sin embargo, hay un problema muy práctico: decidir utilizar veinticuatro alineadores de estabilización no significa necesariamente que se puedan pedir veinticuatro

copias pasivas de la misma posición final. Los sistemas comerciales pueden limitar la posibilidad de solicitar secuencias tan largas sin movimientos programados.

Con el tiempo desarrollé una estrategia de planificación que me permite obtener la secuencia necesaria para el protocolo. Al final del tratamiento realizo un nuevo escaneo y solicito un refinamiento; cuando recibo el nuevo setup digital, elimino todos los movimientos dentales propuestos y devuelvo, en esencia, la planificación a la posición alcanzada al final del tratamiento anterior.

Sin embargo, así solo se produciría un alineador por arcada. Para obtener los veinticuatro alineadores selecciono el último diente de cada arcada, generalmente un segundo o tercer molar, y programo intencionadamente en cada uno un movimiento clínicamente insignificante, como **0,2 mm de intrusión** o un movimiento radicular mínimo de torque o tip.

De este modo, el software detecta un movimiento y genera una secuencia de alineadores. Entonces intervengo en la secuenciación de movimientos y ralentizo intencionadamente esa mínima activación hasta distribuirla entre los **veinticuatro alineadores** necesarios para el protocolo.

Desde el punto de vista digital, estos alineadores no son completamente pasivos, porque en el setup queda programada una microactivación en un solo diente posterior de cada arcada. **Desde el punto de vista clínico, sin embargo, esa microactivación es irrelevante para el tratamiento:** se introduce únicamente como recurso de planificación para obtener el número de alineadores necesario para el protocolo.

Este procedimiento es una solución técnica que utilizo en mi práctica con el sistema con el que trabajo; no es un procedimiento indicado por el fabricante ni un protocolo validado por la literatura y, naturalmente, debe adaptarse a las características del sistema utilizado y de cada caso.

Pero queda un problema que no es biomecánico, sino de comportamiento. El paciente está sentado frente a nosotros, mira su sonrisa y está satisfecho; nosotros también lo estamos. Después de meses de tratamiento, por fin le decimos la frase que lleva tanto tiempo esperando: «*Hemos terminado*». Sin embargo, pocos minutos después le explicamos que tendrá que seguir utilizando los alineadores otros nueve meses.

Su reacción es comprensible: «*¿Cómo que otros nueve meses? ¿No habíamos terminado?*»

El problema está precisamente en la palabra *terminado*. **Hemos terminado de mover los dientes, pero aún no hemos terminado el tratamiento.** Hemos alcanzado el resultado, pero todavía tenemos que protegerlo mientras los tejidos se adaptan a la nueva posición.

Si presentamos la estabilización como algo que viene después del tratamiento, casi como un añadido que el paciente puede afrontar ya con más libertad, corremos el riesgo de reducir nosotros mismos su colaboración. Por eso prefiero presentarla desde el principio como una fase que sigue plenamente integrada en el tratamiento: **ya no tenemos que conseguir el resultado, tenemos que evitar perder lo que acabamos de conseguir.**

GUION OPERATIVO

Cuando presento la fase de estabilización al paciente, lo primero que intento es evitar un malentendido: no le estoy diciendo que el tratamiento no haya funcionado ni que necesitemos otros nueve meses para conseguir el resultado. Al contrario, parto precisamente de que ya lo hemos alcanzado.

> *«Hoy hemos alcanzado el resultado que queríamos. Los dientes han llegado adonde queríamos llevarlos, así que, a partir de ahora, ya no tenemos que moverlos. Pero hay algo importante que debes entender: que un diente haya llegado a la posición correcta no significa que ya sea estable en esa posición. Los tejidos que lo rodean necesitan tiempo para reorganizarse y, sobre todo al principio, si dejáramos de protegerlo de golpe, podríamos permitir que empezara a moverse de nuevo.*
>
> *Sería una pena haber llegado hasta aquí, después de todo el tiempo y el esfuerzo que hemos invertido, conseguir el resultado que queríamos y arriesgarnos a perder una parte justo ahora. Por eso considero que estos nueve meses siguen formando parte del tratamiento: ya no tenemos que mover los dientes, pero sí conservar lo que hemos conseguido mientras se estabiliza.*
>
> *Lo haremos de forma gradual. Durante los primeros tres meses seguirás utilizando los alineadores veintidós horas al día, exactamente como has hecho hasta hoy; en los tres meses siguientes reducirás el tiempo de uso una hora por semana hasta llegar a diez horas; durante los últimos tres meses utilizarás el último alineador solo por la noche.*
>
> *Así, cada tres meses daremos un paso adelante: primero estabilizamos, luego reducimos gradualmente el tiempo de uso y, por último, dejamos más margen para el asentamiento. Pasados nueve meses haremos un nuevo escaneo y, si todo sigue en la posición que hemos conseguido, pasaremos a la retención definitiva. El trabajo difícil ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que evitar perder lo que hemos conseguido».*

De este modo, no me limito a pedirle al paciente que siga utilizando los alineadores, sino que doy un significado concreto a lo que le pido que haga. Decir solo *«tendrás que seguir otros nueve meses»* podría hacer que percibiera la estabilización como una prolongación incomprensible de un tratamiento que considera terminado. El mensaje que quiero transmitir es otro: **hemos alcanzado el resultado, pero aún tenemos que estabilizarlo**.

Como en los demás protocolos, aquí también puedo adaptar el mensaje mediante las tres palancas del **resultado, el tiempo y la inversión**, sin cambiar lo que le pido que haga. En esta fase, la palanca más natural probablemente sea el resultado: *«Hemos alcanzado el resultado. Ahora tenemos que protegerlo mientras se estabiliza».* Con algunos pacientes puedo destacar el tiempo que ya hemos dedicado al tratamiento: *«Hemos trabajado durante meses para llevar los dientes a esta posición. No tendría sentido arriesgarnos a perder en unas semanas parte de lo que hemos conseguido».* Con otros puedo apelar a la inversión total, entendida no solo en términos económicos, sino también de constancia y esfuerzo: *«Has invertido mucho para llegar hasta aquí. Estos nueve meses sirven para proteger esa inversión».* La consecuencia clínica no cambia. Lo que cambia es aquello que decido destacar ante la persona que tengo delante.

Por qué funciona este protocolo

- **Convierte el resultado en algo que proteger**

En la estabilización, el resultado ya no es algo que el paciente tenga que alcanzar, sino algo que ya posee. Por tanto, entran en juego la *aversión a la pérdida* y el *efecto dotación*: **ya no le pedimos que colabore para conseguir algo, sino para evitar perder lo que ha conseguido.**

- **Cambia la forma de presentar los nueve meses**

El *encuadre* modifica el significado que se atribuye a una misma petición. **«Otros nueve meses de tratamiento»** pueden parecer una prolongación del tratamiento; **«nueve meses para proteger el resultado»** convierten, en cambio, ese periodo en una fase con un objetivo concreto.

- **Mantiene la continuidad del hábito**

Durante los primeros tres meses, el paciente mantiene la misma rutina que en la fase activa; solo después reduce el tiempo de uso, una hora por semana. Por tanto, el cambio no es brusco ni depende de indicaciones vagas, sino que es **gradual, previsible y medible**.

■ **Divide un periodo largo en objetivos fáciles de entender**

Nueve meses pueden parecer mucho tiempo. En cambio, cada una de las tres fases consecutivas de tres meses tiene un objetivo fácil de reconocer: **estabilizar, reducir gradualmente y favorecer el asentamiento**. El paciente sabe en todo momento en qué punto se encuentra y cuál será el siguiente paso.

BIBLIOGRAFÍA

Melrose C, Millett DT. Toward a perspective on orthodontic retention? *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998;113(5):507-514.

Haouili N, Kravitz ND, Vaid NR, Ferguson DJ, Makki L. Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2020;158(3):420-425.

Albertini P, Mazzanti V, Mollica F, Pellitteri F, Palone M, Lombardo L. Stress Relaxation Properties of Five Orthodontic Aligner Materials: A 14-Day In-Vitro Study. *Bioengineering (Basel).* 2022;9(8):349.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Con el paciente Dominante prefiero ser directo y centrarme en el resultado y el control:

> *«Hemos alcanzado el resultado. Ahora tenemos que asegurarnos de no perder parte de lo que hemos conseguido. Durante nueve meses seguimos el protocolo 3-3-3 y después pasamos a la retención definitiva».*

I

Influyente

Con el paciente Influyente puedo destacar más lo que ve y el resultado que acaba de conseguir:

> *«Mira hasta dónde hemos llegado. Ya tenemos la sonrisa que queríamos. Estos nueve meses sirven para protegerla mientras se estabiliza: sería una verdadera pena dejarlo justo ahora».*

S

Estable

Con el paciente Estable destaco sobre todo la continuidad y la gradualidad:

> *«Nada cambia de golpe. Durante los primeros tres meses sigues exactamente como hasta hoy; después empezaremos a reducir el tiempo de uso gradualmente. Cada paso será progresivo y te llevará hacia el uso solo nocturno».*

C

Concienzudo

Con el paciente Concienzudo puedo utilizar una explicación más racional y biológica:

> *«Los movimientos han terminado, pero la reorganización de los tejidos requiere más tiempo. Por eso dedicamos nueve meses a esta fase, durante la cual mantenemos al principio las horas de uso y después las reducimos progresivamente antes de pasar a la retención definitiva».*

CAPÍTULO 13

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Después de alcanzar los objetivos de la fase activa, en pacientes clínicamente aptos y que colaboran lo suficiente. Es el protocolo del autor, no una pauta validada universalmente.
OBJETIVO	Proteger el resultado y hacer gradual el paso de las horas de uso de la fase activa a la retención nocturna.
QUÉ HACER	1. **Estabilizar — primeros tres meses.** Alineadores 1-12, cambio semanal, veintidós horas al día: mantener la posición alcanzada. 2. **Reducir gradualmente — siguientes tres meses.** Alineadores 13-24, cambio semanal: reducir el uso de veintiuna a diez horas al día, una hora por semana. 3. **Favorecer el asentamiento — últimos tres meses.** Utilizar el mismo alineador 24 durante diez horas cada noche, manteniendo la protección nocturna y dejando más margen para la función. 4. **Pasar a la retención.** Después de nueve meses, realizar un nuevo escaneo y preparar los retenedores definitivos. El proceso comprende veinticuatro alineadores y tres fases de tres meses. Si no es realista que el paciente mantenga el uso durante otros nueve meses, concluir la fase activa y pasar directamente a la retención definitiva.
QUÉ COMPROBAR	La idoneidad clínica, la colaboración, el ajuste de los dispositivos, el mantenimiento de la posición y la evolución del asentamiento oclusal. La reducción de las horas de uso debe seguir el plan acordado.

CAPÍTULO

14

La entrega de los retenedores

«Una onza de prevención vale una libra de cura».

— BENJAMIN FRANKLIN

La entrega de la férula de retención definitiva marca el inicio del mantenimiento a largo plazo y puede llegar en dos momentos distintos. En los pacientes aptos y colaboradores, sigue a los nueve meses del protocolo de estabilización; en los pacientes para los que esa fase no está indicada, llega directamente al término del tratamiento activo. En ambos casos es un paso menos llamativo que retirar los ataches o entregar el último alineador, pero igual de decisivo. Durante meses, a veces durante años, hemos construido juntos un resultado. Le hemos pedido al paciente que utilice los alineadores, respete los cambios, utilice los elásticos, acuda a las revisiones y siga nuestras indicaciones, hasta llegar por fin al día que esperaba desde el principio, aquel en el que pronunciamos una frase aparentemente inocente:

«Hemos terminado».

Para el paciente, esas dos palabras pueden significar mucho más de lo que imaginamos, porque puede interpretarlas como el fin de las normas y los horarios que debía seguir, como el momento en que las férulas quedan definitivamente atrás y, sobre todo, como la confirmación de que el resultado obtenido ya está consolidado y no puede perderse.

Por eso procuro no presentar nunca la entrega de la férula de retención como el final del tratamiento y prefiero explicar claramente que lo único que termina es una fase del proceso:

> *«Hoy termina la fase previa a la retención definitiva: en tu caso han sido los nueve meses de estabilización» —o, cuando el protocolo no estaba indicado, «la fase activa del tratamiento»—. «A partir de ahora empieza el mantenimiento a largo plazo. Conservar el resultado dependerá sobre todo de ti y de la regularidad con que utilices la férula de retención».*

La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia por completo el significado de lo que está ocurriendo, porque desde ese día la responsabilidad cotidiana de conservar el resultado pasa progresivamente a manos del paciente.

Precisamente porque considero que este traspaso de responsabilidad es un momento fundamental del tratamiento, en el momento de la entrega de los retenedores le pido al paciente que lea y firme un consentimiento informado específico para la fase de retención. No se trata de una simple indicación incluida en el consentimiento inicial para el tratamiento ortodóncico ni de una recomendación dada deprisa al terminar la última revisión, sino de un documento específico para esta nueva fase, que entregamos al paciente y le pedimos que firme cuando recibe los retenedores definitivos.

En el consentimiento se explica por qué es necesaria la retención, cómo deberá utilizarse el retenedor, qué hacer si se pierde o se rompe y cuáles pueden ser las consecuencias de un uso insuficiente, pero, sobre todo, se formaliza ese traspaso de responsabilidad que acabo de explicarle verbalmente al paciente y que resumo en una frase muy sencilla:

«Si colocar los dientes en la posición correcta ha sido tarea nuestra, mantener el resultado conseguido será tarea tuya».

La firma, por tanto, no es solo un trámite formal ni un instrumento de protección médico-legal; para mí supone, sobre todo, el cierre de un momento de comunicación en el que primero explico al paciente qué cambia a partir de ese día, después le doy la información necesaria para gestionar correctamente esta nueva fase y, por

último, le pido que confirme que la ha entendido. No es una forma de culparlo de antemano por si algo sale mal, sino que sirve para dejar clara una responsabilidad cuando todavía estamos en las mejores condiciones para hacerlo: **antes de que surja un problema.**

Antes de dar por terminada la entrega, compruebo que la férula de retención encaje por completo y hago algunas fotografías intraorales con el dispositivo colocado. Las conservo junto con el escaneo final para contar con un punto de partida documentado. Si en el futuro la férula de retención deja de encajar correctamente, no tendremos que basarnos en recuerdos contradictorios para compararla, porque podremos ver cómo encajaba el día de la entrega, comprobar qué ha cambiado y decidir qué solución es clínicamente adecuada. Por tanto, las fotografías no sirven para demostrar que el paciente no ha utilizado la férula de retención, sino para evaluar la situación actual de forma más objetiva.

Todo esto cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que la estabilidad ortodóncica no puede considerarse un resultado adquirido de una vez por todas. Después del tratamiento existe una tendencia a la recidiva y, con independencia de ella, la dentición sigue cambiando a lo largo de la vida; por tanto, la retención debe considerarse parte integrante del tratamiento y su protocolo debe adaptarse a la situación clínica, a los movimientos realizados y a las características de cada paciente.

En la literatura no existe un único protocolo de retención válido para todos los pacientes, pero cada vez hay más conciencia de la necesidad de mantenerla durante mucho tiempo. En una encuesta realizada entre ortodoncistas especialistas, por ejemplo, entre el 67 y el 78 % de los encuestados recomendaban a sus pacientes la retención de por vida.

En mi protocolo sigo esa misma filosofía y, por tanto, considero la retención una fase permanente del tratamiento, lo que no significa, naturalmente, que la misma férula tenga que durar toda la vida. El dispositivo puede desgastarse, deformarse, romperse o perderse y, cuando sea necesario, habrá que sustituirlo, pero lo que no cambia es la necesidad de seguir protegiendo con el tiempo el resultado conseguido.

La férula tiene una vida útil. La retención, no.

Diez horas, todas las noches

Cuando doy una pauta a un paciente, sobre todo si le pido que la siga durante toda la vida, prefiero explicarle por qué. En mi protocolo, las férulas de retención deben utilizarse **todas las noches durante al menos diez horas**, aproximadamente desde

las 21, después de cenar, hasta las 7 de la mañana, antes de desayunar. También en este caso, la cifra no responde solo a la costumbre clínica, sino que encuentra un respaldo interesante en la literatura.

İshakoğlu y Çokakoğlu estudiaron a 42 pacientes que utilizaban retenedores termoplásticos equipados con microsensores, lo que les permitió medir objetivamente el tiempo real de uso en lugar de basarse únicamente en lo que declaraban los pacientes. Al cabo de doce meses, dividieron a los pacientes en dos grupos según su tiempo medio de uso diario, inferior a nueve horas o igual o superior a nueve horas, y observaron una mayor pérdida de alineación en quienes utilizaban la férula de retención menos de nueve horas al día. Los autores concluyeron, por tanto, que un tiempo medio inferior a nueve horas no bastaba para mantener la irregularidad dentro de límites clínicamente aceptables y recomendaron al menos nueve horas diarias para mantener la alineación anterior.

Es importante interpretar bien este dato, porque no significa que exista un umbral biológico absoluto por el que, a las ocho horas y cincuenta y nueve minutos, los dientes se muevan y, a las nueve horas, permanezcan inmóviles. Además, el estudio se refiere a una muestra específica de pacientes tratados con extracciones de cuatro premolares, y la diferencia estadísticamente significativa entre los grupos correspondía a la alineación anterior inferior; aun así, nos aporta una información clínicamente muy útil, pues sugiere que **un tiempo medio de uso inferior a nueve horas puede no ser suficiente para mantener adecuadamente la alineación anterior inferior**.

A partir de este dato, en mi protocolo prescribo diez horas, no porque exista un estudio que demuestre que constituyen un umbral biológico universal, sino porque considero razonable añadir un pequeño margen a las nueve horas indicadas por el estudio y, al mismo tiempo, dar al paciente una pauta sencilla, concreta y fácil de recordar: **diez horas, todas las noches, durante toda la vida**.

Esto no significa que, si diez horas son suficientes, utilizar la férula de retención veinte o veintidós horas tenga que garantizar necesariamente una estabilidad aún mayor. De hecho, la evidencia disponible no demuestra una ventaja significativa del uso a tiempo completo frente a un uso adecuado a tiempo parcial. Thickett y Power compararon en un ensayo clínico aleatorizado el uso a tiempo completo y a tiempo parcial de retenedores termoplásticos y, al cabo de doce meses, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos protocolos en la mayoría de las medidas estudiadas; las revisiones de la literatura apuntan en la misma dirección e indican que el uso a tiempo parcial de los retenedores removibles puede

ser suficiente, aunque subrayan que la calidad general de la evidencia sigue siendo limitada.

Por tanto, el mensaje no es que diez horas sean la dosis perfecta para todos los pacientes y todas las situaciones clínicas, porque la retención sigue siendo un ámbito en el que no existe un único protocolo aceptado universalmente. Lo que quiero transmitir al paciente es algo mucho más sencillo: una vez terminado el tratamiento activo, **no le estoy pidiendo que siga utilizando durante toda la vida una férula veintidós horas al día, como hacía con los alineadores**, sino que convierta la retención en una rutina nocturna sostenible.

Sin embargo, decirle al paciente «*utilízala por la noche*» deja todavía demasiado margen para la interpretación, porque para unos la noche dura nueve horas y para otros, seis; algunos se ponen la férula de retención al acostarse, otros justo antes de dormirse, y otros pueden considerar normal saltarse una noche porque, al fin y al cabo, la pauta que recibieron era simplemente *por la noche*. Por eso prefiero convertir una indicación genérica en una rutina precisa: **21-7**. A las nueve de la noche, después de cenar, se pone la férula y a las siete de la mañana, antes de desayunar, se la quita, con lo que cumple las diez horas prescritas. Naturalmente, no atribuyo ningún significado biológico a las nueve de la noche ni a las siete de la mañana; la ventaja es sobre todo conductual, porque asociar una acción a momentos reconocibles que se repiten cada día facilita que se convierta en un hábito.

Esto cobra especial importancia si tenemos en cuenta que el cumplimiento de la pauta de retención tiende a empeorar con el paso del tiempo. Kacer y sus colaboradores analizaron el uso de los retenedores durante los dos primeros años después del tratamiento activo y observaron que, mientras que en los tres primeros meses el 69 % de los pacientes declaraba utilizarlos todas las noches, entre los meses 19 y 24 el porcentaje de pacientes clasificados como colaboradores según los criterios del estudio había descendido al 45 %, y el 19 % declaraba que ya no los utilizaba. Eran datos aportados por los propios pacientes mediante un cuestionario y, por tanto, no una medición objetiva de su comportamiento, pero la tendencia que muestran resulta muy reconocible en la práctica clínica: **con el paso del tiempo, la colaboración tiende a disminuir**.

El verdadero reto, por tanto, no es convencer al paciente de que utilice la férula de retención la misma noche en que se la entregamos, cuando tiene el resultado ante sus ojos, el recuerdo del tratamiento aún está reciente y el valor de lo que ha conseguido resulta muy evidente. Tenemos que ayudarle a crear un hábito que perdure cuando esa sonrisa se haya vuelto normal, cuando el tratamiento sea ya un recuerdo

y cuando nosotros ya no estemos presentes cada pocas semanas para recordarle qué debe hacer. **Por eso prefiero una rutina precisa a una recomendación genérica.**

Las horas perdidas no se recuperan

Hay otro mensaje que considero fundamental transmitir ya el día de la entrega. El paciente no debe hacerse a la idea de que la pauta de diez horas funciona como una especie de cuenta corriente en la que, si una noche no utiliza la férula de retención, basta con utilizarla más tiempo al día siguiente para recuperar las horas perdidas, porque el problema no son las horas en sí, sino lo que puede ocurrirles a los dientes durante el tiempo en que no se mantienen en su posición.

Si uno o varios dientes empiezan a cambiar de posición, la geometría de la dentición deja de coincidir perfectamente con aquella para la que se fabricó la férula de retención. Por tanto, cuando el paciente intenta volver a ponérsela, puede notar que le aprieta más o darse cuenta de que ya no encaja igual, y justo entonces puede surgir un razonamiento aparentemente lógico, pero potencialmente peligroso: «*Me aprieta, así que la utilizaré un poco más y volverá a colocarme los dientes en su sitio*».

No quiero que el paciente utilice por su cuenta la férula de retención como si fuera un nuevo alineador, porque esa férula se fabricó **para mantener una posición**, no para realizar un nuevo movimiento ortodóncico planificado. Si los dientes ya no están en la posición para la que se fabricó, el dispositivo puede empezar a ejercer fuerzas que no se han previsto como parte de un tratamiento y, precisamente por eso, el día de la entrega le doy una regla muy sencilla:

> «*Si pasas unos días sin utilizarla y, cuando vuelves a ponértela, notas que te aprieta mucho, no pienses que puedes recuperar esas horas simplemente llevándola más tiempo. Esta férula se ha fabricado para mantener tus dientes en la posición en la que están hoy, no para hacer nuevos movimientos ortodóncicos. Si ya no encaja bien o tienes que forzarla, llámanos*».

No hace falta explicarle al paciente toda la biomecánica que puede entrar en juego cuando una férula de retención ya no se ajusta a la posición de los dientes; es mucho más importante evitar que se forme una idea equivocada y hacerle entender desde el día de la entrega que **las horas perdidas no se recuperan: lo que debemos evitar es que se pierda la posición**.

Cuando una férula de retención se pierde o se rompe

Hay, además, un problema aparentemente trivial al que me he enfrentado muchas veces a lo largo de los años: el paciente pierde la férula de retención, llama a la

clínica y pregunta simplemente *«¿Me pueden hacer otra?»*. Hasta ahí, nada raro; el problema puede surgir cuando descubre que fabricar una nueva férula de retención tiene un coste.

Para entender su reacción, debemos volver a cómo le hemos explicado las cosas durante el tratamiento activo. Un paciente tratado con alineadores puede haber recibido decenas de férulas, puede haber perdido o roto alguna y puede haber pasado por una o varias fases de refinamiento sin percibir directamente el coste de cada dispositivo, sobre todo cuando el paquete contratado incluía alineadores adicionales. Así, poco a poco, puede haber establecido en su mente una asociación muy sencilla: **férula = incluida en el tratamiento**.

Cuando le entregamos una férula de retención transparente, a sus ojos se parece muchísimo a lo que ha utilizado hasta ese momento. Para nosotros, su función ha cambiado por completo, mientras que para él sigue siendo una férula y, si no cambiamos explícitamente esa idea, no podemos sorprendernos de que, cuando la pierde o la rompe, piense que también debe sustituirse gratis.

Una vez más, el mejor momento para abordar el problema no es cuando el paciente llama para decir que la ha perdido, sino **antes de que la pierda**. En el consentimiento específico que le pido que firme se indica claramente que sustituir la férula de retención en caso de pérdida o rotura tendrá un coste, pero no quiero que ese coste se perciba como un castigo ni como una penalización por un despiste: el paciente está pagando, sencillamente, la fabricación de **un nuevo dispositivo**.

Durante el tratamiento había contratado una terapia que incluía determinadas prestaciones y determinados dispositivos, pero esa fase ha terminado y no puede convertirse en la promesa implícita de fabricar gratuitamente retenedores de repuesto durante toda la vida. Si la retención debe acompañar al paciente a lo largo del tiempo, tenemos que explicarle desde el principio que los dispositivos pueden desgastarse, romperse o perderse y que, cuando haya que sustituirlos, fabricar una nueva férula de retención tendrá un coste. También esto forma parte del traspaso de responsabilidad que empezamos a plantear en el momento mismo de la entrega.

GUION OPERATIVO

Todos estos conceptos deben ser científicamente correctos, pero no deben convertir la última revisión en una clase universitaria. El paciente debe salir de la clínica recordando unas pocas cosas muy claras y, por eso, la conversación puede ser mucho más sencilla que el razonamiento que hay detrás.

> *«Hoy termina la fase que precede a la retención definitiva: en tu caso, ha sido la fase de estabilización de nueve meses» —o, cuando ese protocolo no estaba indicado, «la fase activa del tratamiento»—. «A partir de ahora empieza el mantenimiento a largo plazo, y conservar el resultado dependerá sobre todo de ti y de la regularidad con que utilices la férula de retención. Esta fase dura toda la vida; yo siempre digo en broma que la retención es como los diamantes: es para siempre».*

Entonces paso a la pauta concreta e intento darle al paciente una regla que pueda recordar sin margen para interpretaciones:

> *«La regla es muy sencilla: diez horas, todas las noches. Lo más fácil es ponerte la férula de retención a las nueve de la noche, después de cenar, y quitártela a las siete de la mañana, antes de desayunar. De nueve a siete: son diez horas. No tienes que utilizarla todo el día; tienes que utilizarla bien todas las noches».*

Justo después le explico qué podría pasar si no sigue esa rutina, porque quiero que sepa cómo actuar antes de encontrarse en esa situación:

> *«Y ten en cuenta una cosa: las horas no se recuperan. Si te saltas alguna noche y, cuando vuelves a ponerte la férula de retención, notas que te aprieta mucho o que ya no encaja como antes, no pienses "la utilizaré más y todo volverá a estar bien". Esta férula se ha fabricado para mantener los dientes donde están hoy, no para hacer un nuevo tratamiento. Si no encaja bien o tienes que forzarla, llámanos enseguida».*

En ese mismo momento aclaro también qué deberá hacer si la pierde o se rompe y, sobre todo, evito que más adelante pueda surgir un malentendido sobre el coste de sustituirla:

> *«Si pierdes la férula de retención o se rompe, llámanos enseguida y no esperes unos días pensando que no va a pasar nada, porque desde ese momento los dientes dejan de mantenerse en la posición que hemos conseguido. Recuerda también que, si tenemos que fabricar una nueva, tendrá un coste: el tratamiento activo ha terminado y, a partir de hoy, gestionar la retención forma parte de tu responsabilidad para mantener el resultado».*

Por último, vuelvo al motivo por el que le doy todas estas indicaciones, porque no quiero que el paciente salga recordando solo una serie de reglas, sino que entienda, sobre todo, qué es lo que esas reglas protegen:

> *«Lo más importante es esto: hoy te entregamos un resultado que hemos conseguido juntos; a partir de ahora, tu tarea es conservarlo. Si dejas de utilizar los retenedores y los dientes se mueven, podría no bastar con fabricar otra férula y, si quieres recuperar el resultado obtenido, podría ser necesario un nuevo tratamiento ortodóncico, que sería un nuevo tratamiento con un nuevo coste».*

Solo después de esta explicación le pido que lea y firme el consentimiento específico para la retención. En ese momento, la firma no representa el comienzo de la información, sino su conclusión, porque el paciente ha visto el resultado, ha entendido que la fase clínica guiada ha terminado pero que el mantenimiento continúa, conoce su responsabilidad, sabe cuántas horas al día y durante cuánto tiempo debe utilizar la férula de retención, sabe qué hacer si la pierde, se rompe o deja de encajar correctamente y conoce las posibles consecuencias de la falta de cumplimiento terapéutico. Así hemos abordado todas estas situaciones cuando todavía podíamos hacerlo de la mejor manera: **antes de que se convirtieran en un problema.**

Por qué funciona este protocolo

Cambia el significado de la retención. Decirle al paciente que el tratamiento no ha terminado, sino que empieza una nueva fase, cambia su forma de entender la retención. El retenedor no se presenta como un accesorio que utilizar mientras se acuerde, sino como el instrumento con el que deberá proteger a lo largo del tiempo un resultado que ya tiene y en el que ha invertido tiempo, energía y dinero. Aquí confluyen **el cambio de encuadre, la saliencia del resultado y la aversión a la pérdida**.

Convierte una recomendación en una conducta concreta. «*Diez horas, todas las noches, de 21 a 7*» deja mucho menos margen para la interpretación que «*utilízala por la noche*». Además, asociar el momento de ponerse y quitarse la férula de retención a dos momentos reconocibles del día ayuda a convertir la pauta en una rutina estable. Aquí confluyen **la reducción de la ambigüedad y la intención de implementación**, conceptos que ya hemos explicado en capítulos anteriores y que no hace falta volver a desarrollar aquí.

Traspasa la responsabilidad antes de que surja un problema. El paciente sabe desde el día de la entrega qué hacer si se salta algunas noches, si la férula de retención le aprieta, deja de encajar correctamente, se pierde o se rompe, y sabe que un posible nuevo tratamiento necesario para corregir una recidiva constituiría una nueva terapia. Definir estas reglas cuando el resultado es estable y aún no existe ningún conflicto permite abordar los posibles problemas futuros partiendo de responsabilidades ya compartidas.

Deja claro el compromiso. El consentimiento específico solo se firma después de haber explicado la pauta, las responsabilidades, los posibles problemas y los costes. Por tanto, la firma no sustituye a la comunicación, sino que cierra y formaliza lo que se ha hablado, incluido el hecho de que sustituir una férula de retención perdida o rota supone pagar el coste de un nuevo dispositivo, no una sanción.

BIBLIOGRAFÍA

İshakoğlu S, Çokakoğlu S. Evaluation of relapse with thermoplastic retainers equipped with microsensors. *Angle Orthod.* 2022;92(3):340-346.

Thickett E, Power S. A randomized clinical trial of thermoplastic retainer wear. *Eur J Orthod.* 2010;32(1):1-5.

Kacer KA, Valiathan M, Narendran S, Hans MG. Retainer wear and compliance in the first 2 years after active orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2010;138(5):592-598.

Al-Moghrabi D, Littlewood SJ, Fleming PS. Orthodontic retention protocols: an evidence-based overview. *Br Dent J.* 2021;230:770-776.

Meade MJ, Millett D. Retention protocols and use of vacuum-formed retainers among specialist orthodontists. *J Orthod.* 2013;40(4):318-325.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Con un paciente Dominante, el mensaje puede ser directo, breve y centrado en el control del resultado: «*Hemos conseguido el resultado que queríamos. A partir de hoy, mantenerlo está en tus manos: diez horas, todas las noches*».

I

Influyente

Con un paciente Influyente puede ser más eficaz destacar la sonrisa y el resultado estético conseguido: «*Mira la sonrisa que hemos conseguido. Ahora tenemos que hacer que siga así: diez horas, todas las noches*».

S

Estable

Con un paciente Estable puede ser útil destacar, sobre todo, la sencillez de la rutina: «*No tienes que hacer nada complicado: después de cenar te pones la férula de retención y por la mañana, antes de desayunar, te la quitas. Lo importante es convertirlo en un gesto que repitas todas las noches*».

C

Concienzudo

Con un paciente Concienzudo funcionan especialmente bien una pauta precisa y la explicación científica que la respalda: «*La pauta es de diez horas cada noche. No es una cifra elegida al azar: se basa en los datos que tenemos sobre el mantenimiento de la alineación después del tratamiento*».

CAPÍTULO 14

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Al entregar la férula de retención definitiva, después de la fase de estabilización o directamente tras concluir la fase activa.
OBJETIVO	Establecer una rutina de mantenimiento precisa y aclarar las responsabilidades, cómo gestionar los problemas y los costes de sustitución.
QUÉ HACER	1. Comprobar que la férula de retención se coloca correctamente, fotografiarla en posición y conservar el escaneo final. 2. Explicar que termina la fase activa y empieza el mantenimiento del resultado. 3. Prescribir, según el protocolo descrito, diez horas todas las noches, durante toda la vida. Como referencia práctica: de 21 a 7. 4. Aclarar que las horas perdidas no se recuperan simplemente utilizando la férula de retención más tiempo por cuenta propia los días siguientes. 5. Pedir al paciente que contacte con la clínica si la férula de retención le aprieta mucho, no encaja correctamente o tiene que forzarla. 6. Pedirle que avise cuanto antes si la pierde o se rompe y explicarle el coste del nuevo dispositivo. 7. Advertirle de que, si los dientes se mueven, una nueva férula de retención podría no bastar y podría ser necesario un nuevo tratamiento. 8. Después de la explicación, pedirle que lea y firme el consentimiento específico.
QUÉ COMPROBAR	El ajuste del dispositivo y que el paciente haya entendido la pauta, la duración, sus responsabilidades, cómo gestionar los problemas y las condiciones económicas.

CAPÍTULO

15

Una cita virtual a la semana

«Cuando puedes medir aquello de lo que hablas y expresarlo en números, sabes algo sobre ello».

— LORD KELVIN

Durante un tratamiento con alineadores, pueden pasar muchas cosas entre una revisión en la clínica y la siguiente. El paciente cambia las férulas por su cuenta, las utiliza según sus hábitos y a menudo tiene que valorar él solo si siguen ajustándose correctamente a los dientes. Si un alineador empieza a perder ajuste, es decir, deja de adaptarse perfectamente a la superficie dental, puede que no se dé cuenta o que decida pasar de todos modos al siguiente, simplemente porque ya han transcurrido los días previstos. Una reducción de las horas de uso también puede parecer al principio que no tiene consecuencias, sobre todo cuando el paciente está convencido de que puede compensarla utilizando más los alineadores los días inmediatamente anteriores a la revisión.

Pero, si no volvemos a ver al paciente hasta pasados cuatro o seis meses, esa pequeña pérdida de ajuste puede haberse extendido a toda la secuencia. En ese momento ya no tenemos que recuperar solo el primer movimiento que no llegó a producirse, sino también las consecuencias del uso de los alineadores siguientes, diseñados dando por hecho que todos los dientes habían alcanzado la posición planificada.

Precisamente para reducir ese intervalo sin observación, en mi clínica utilizo **Dental Monitoring**, un sistema que permite seguir a distancia la evolución de un tratamiento ortodóncico. Mediante una aplicación instalada en el móvil y un dispositivo específico que ayuda a mantener los labios y las mejillas separados de los dientes, el paciente toma una serie guiada de imágenes de su boca.

En el lenguaje cotidiano llamamos a este procedimiento *escaneo*, aunque no se trata del mismo escaneo intraoral tridimensional que realizamos en la clínica para registrar las arcadas y planificar los alineadores. El escaneo de Dental Monitoring es, más exactamente, una serie guiada de fotografías que el paciente toma con su propio móvil y que permite al sistema y al equipo clínico observar a distancia el ajuste de los alineadores y la evolución del tratamiento.

Según mi protocolo, el paciente realiza este escaneo una vez a la semana, antes de pasar a la siguiente férula. Las imágenes nos permiten observar el ajuste de los alineadores y valorar si los dientes mantienen el tracking, es decir, si su posición real sigue siendo compatible con la prevista en la secuencia planificada. **En función de lo que observamos, el paciente recibe la indicación de pasar a la siguiente férula o de seguir utilizando la actual.**

Por tanto, el cambio semanal deja de ser una simple fecha marcada en el calendario. El paciente no pasa automáticamente al siguiente alineador solo porque hayan transcurrido siete días, sino que espera a que el control a distancia confirme que se dan las condiciones necesarias para continuar.

Dental Monitoring no sustituye la valoración del ortodoncista ni permite conocer todo lo que ocurre en la boca del paciente. Sin embargo, permite reducir considerablemente el tiempo que transcurre desde que aparece un problema hasta que podemos detectarlo. Así, una pérdida inicial de ajuste puede abordarse cuando todavía es limitada, antes de que afecte a más dientes y comprometa una parte mayor de la secuencia.

Dental Monitoring es, ante todo, una herramienta clínica que permite seguir el tratamiento de forma más continua incluso cuando las citas presenciales están más espaciadas. Sin embargo, al utilizarlo me di cuenta de que cumple también una

segunda función, especialmente importante en el contexto de este libro: **hace más visibles algunos aspectos de la colaboración del paciente.**

Cuando entrego los alineadores, explico al paciente que el seguimiento a distancia nos permitirá, en muchos casos, programar las citas en la clínica cada cuatro a seis meses, adaptando, por supuesto, la frecuencia a las necesidades clínicas de cada tratamiento. Pero eso no significa que el tratamiento quede sin supervisión durante todo ese tiempo, porque entre una cita y otra recibimos las imágenes semanales y podemos seguir de forma continua su evolución.

Así, cada escaneo se convierte en una especie de pequeña cita virtual. El paciente tiene que acordarse de realizarlo, seguir correctamente el procedimiento y esperar la indicación que recibe a través del sistema antes de cambiar de férula. A las citas tradicionales se suman controles más breves, pero también mucho más frecuentes, de modo que la reducción de las visitas a la clínica no supone una disminución de la responsabilidad.

El escaneo semanal me permite observar el ajuste de los alineadores, pero también la puntualidad con la que el paciente sigue el protocolo. La regularidad con la que envía las imágenes, el cumplimiento de las indicaciones recibidas y la respuesta a los mensajes son comportamientos que pueden documentarse; del mismo modo, su ausencia también nos aporta información.

Me ha ocurrido más de una vez que, tras entregar el sistema a un paciente, observé cómo, después de un primer periodo de uso regular, los escaneos se hacían cada vez menos frecuentes hasta interrumpirse por completo. En la siguiente revisión, los alineadores ya no se ajustaban correctamente y, sin embargo, la explicación era casi siempre la misma:

«Yo los he usado siempre».

En el pasado, una afirmación así podría haber dado pie a una discusión que no habría llevado a ninguna parte. El paciente habría seguido sosteniendo que había colaborado y yo solo habría tenido el mal ajuste de los alineadores para poner en duda su versión. Con el seguimiento a distancia, en cambio, puedo adoptar un enfoque completamente distinto, porque **no tengo que elegir de inmediato entre creer al paciente y acusarlo de no ser sincero.**

Reconstruir el momento en que se perdió el tracking

Cuando el paciente afirma que ha utilizado correctamente los alineadores, no abro el historial de Dental Monitoring diciendo: *«Ahora vamos a ver si es verdad».* Una frase así convertiría de inmediato la conversación en un juicio y haría que el paciente se

sintiera acusado y defendiera su versión de los hechos. Prefiero presentar el análisis de los escaneos como una investigación clínica conjunta, con la que podemos buscar entre los dos el periodo en que el tratamiento empezó a desviarse de lo planificado:

> *«Vamos a mirar juntos todos los escaneos que has hecho en las últimas semanas. Así podremos identificar la semana en que el tracking empezó a empeorar e intentar entender qué pudo pasar».*

A menudo añado también una posible explicación concreta, porque quiero que el paciente comprenda que no busco una confesión, sino un hecho real que pueda ayudarnos a interpretar lo que estamos observando:

> *«A lo mejor descubrimos que pasó justo la semana de la boda de tu mejor amigo. Quizá ese día pasaste muchas horas sin los alineadores y, a partir de entonces, un diente empezó a no seguir perfectamente el movimiento previsto. Vamos a ver juntos si conseguimos reconstruir lo que pasó».*

El ejemplo de la boda ofrece al paciente una salida de la confrontación entre «*Los he usado siempre*» y «*No te creo*». Una boda, una fiesta, un día de viaje, una cena especialmente larga, una enfermedad o una semana muy complicada pueden recordarse más fácilmente que el total de horas durante las que se han utilizado los alineadores. Una pregunta genérica como «*¿Has utilizado los alineadores?*» produce casi inevitablemente una respuesta igual de genérica: «*Sí, siempre*». En cambio, al vincular la pregunta a un momento concreto, el paciente puede darse cuenta, por ejemplo, de que se quitó los alineadores durante la comida de la boda y no volvió a ponérselos hasta bien entrada la noche. Ya no estamos hablando de su colaboración en términos abstractos, sino reconstruyendo un comportamiento real en un momento que puede reconocer.

Entonces abro el historial de Dental Monitoring y repaso con el paciente las semanas anteriores. En algunos casos conseguimos identificar el periodo en que el ajuste empezó a empeorar y podemos relacionarlo con un episodio concreto, con una reducción de las horas de uso, con un uso insuficiente de los mordedores para alineadores o con un movimiento que no llegó a producirse pese a una colaboración aparentemente adecuada. Otras veces, sin embargo, descubrimos que los escaneos necesarios para hacer esa reconstrucción sencillamente no existen: el historial está vacío o presenta interrupciones muy evidentes y, cuando el paciente responde «*No puede ser, los he hecho todos*», no necesito acusarlo directamente, porque la ausencia de datos muestra que no se ha seguido el protocolo acordado.

Esto no significa necesariamente que el paciente no haya utilizado correctamente los alineadores. Significa, sin embargo, que ha interrumpido el canal de supervisión acordado y que, aunque el uso hubiera sido adecuado, sin datos actualizados no hemos podido comprobar el ajuste, valorar el tracking ni confirmar que se dieran las condiciones para continuar con la secuencia. Llegado ese punto, le explico:

> *«Ese es precisamente el problema. Si tuviéramos un escaneo de cada semana, podríamos identificar el periodo en que el ajuste empezó a empeorar e intentar entender qué pasó. Como algunos escaneos no se han realizado, hemos perdido la posibilidad de darnos cuenta e intervenir a tiempo. Ahora tenemos que valorar cuánto tracking se ha perdido y ver si todavía es posible continuar con estos alineadores o si habrá que modificar el plan de tratamiento. En cualquier caso, a partir de ahora tendremos que retomar tanto el uso correcto de los alineadores como los escaneos semanales; de lo contrario, correríamos el riesgo de encontrarnos otra vez en la misma situación».*

No puedo saber con certeza si el paciente miente deliberadamente o si ha reconstruido su comportamiento de una forma más aceptable para él. Puede que recuerde las semanas en que utilizó correctamente el sistema y olvide aquellas en que no lo hizo, o que confunda la intención de realizar un escaneo con el recuerdo de haberlo hecho de verdad. Para la gestión clínica, sin embargo, el resultado no cambia: no se ha seguido el protocolo acordado y no hemos podido identificar a tiempo el periodo en que el ajuste empezó a empeorar.

Por tanto, el seguimiento a distancia no impide que el paciente mienta ni elimina los mecanismos mediante los que la memoria reconstruye el comportamiento pasado, pero reduce el margen para que el relato del paciente se convierta en la única versión disponible.

Hay, además, pequeños detalles que, aunque no constituyen mediciones reales de la colaboración, pueden decirnos algo sobre los hábitos del paciente. Uno de los más interesantes tiene que ver con los elásticos ortodóncicos. Cuando los prescribo, no pido al paciente que los mantenga puestos durante el escaneo en casa; de hecho, sería mucho más sencillo quitárselos, porque limitan la apertura de la boca y pueden hacer más incómodo el procedimiento. Lo más lógico sería, por tanto, quitarse los elásticos, realizar el escaneo y volver a ponérselos inmediatamente después.

Sin embargo, algunos pacientes realizan el escaneo con los elásticos todavía puestos, no porque quieran demostrarme que colaboran ni porque les haya dado esa indicación, sino simplemente porque se olvidan de quitárselos. Los elásticos

se han convertido en una presencia tan habitual en su día a día que empiezan el procedimiento sin pensar siquiera en la posibilidad de retirarlos.

Para mí, este comportamiento es una señal muy significativa, aunque, por supuesto, un escaneo realizado con los elásticos puestos no demuestra que el paciente los haya utilizado durante todas las horas prescritas, porque, al menos en teoría, podría habérselos puesto poco antes. Pero cuando veo que alguien asume espontáneamente la dificultad añadida de hacer el escaneo con los elásticos puestos, considero ese comportamiento un indicio creíble de que realmente forman parte de su vida cotidiana. No se trata de una prueba aislada, sino de una señal espontánea que adquiere valor precisamente porque no parece preparada para mostrársela al médico.

Así, Dental Monitoring me permite observar no solo el movimiento de los dientes, sino también algunos fragmentos del día a día del paciente durante el tratamiento. Un escaneo realizado puntualmente, una respuesta inmediata a una indicación o un elástico que el paciente se ha olvidado de quitarse pueden convertirse en pequeños indicadores de la calidad de su colaboración. **Sin embargo, son indicadores, no mediciones**, y es importante dejar muy claro este límite, porque Dental Monitoring no lleva un cronómetro dentro del alineador y no puede saber con exactitud cuántas horas al día se ha utilizado. Por tanto, no puede afirmar que un paciente haya usado el alineador dieciocho horas en vez de veintidós.

Lo que sí podemos observar de forma continuada es el ajuste de los alineadores, la progresión del tratamiento y la posible aparición de una pérdida de tracking. Si los alineadores se usan menos de lo necesario, algunas consecuencias de esa falta de constancia pueden hacerse visibles con el tiempo, aunque lo que observamos no nos permite calcular matemáticamente las horas de uso.

En la comunicación con el paciente utilizo esta posibilidad para ayudarle a asumir su responsabilidad, porque quiero que sepa desde el principio que lo que sucede entre dos citas no quedará completamente fuera de nuestra vista. Al mismo tiempo, evito atribuir al sistema una precisión que no tiene y empleo una formulación que distingue claramente entre medir directamente las horas de uso y observar sus posibles consecuencias clínicas:

> *«El sistema no lleva un cronómetro, así que no puede decirnos exactamente cuántas horas has utilizado el alineador. Pero los escaneos semanales nos permiten observar de forma continuada el ajuste y la progresión del tratamiento. Si los alineadores se usan menos de lo necesario, las consecuencias de esa falta de constancia suelen hacerse visibles con el tiempo».*

Esta distinción también es importante porque no se puede atribuir automáticamente a la falta de colaboración que un diente no se mueva. Puede haber dificultades biomecánicas, problemas con un atache, características anatómicas o una respuesta biológica distinta de la prevista. Por tanto, el seguimiento a distancia debe ayudarnos a iniciar una conversación y plantear hipótesis clínicas, no a dictar sentencia automáticamente contra el paciente. **Su verdadero valor no reside en demostrar que el paciente se ha equivocado, sino en permitirnos detectar antes cuándo algo no funciona según lo previsto y comprender, cuando sea posible, por qué.**

El protocolo durante la fase activa

En mi clínica, el protocolo establece que el paciente haga un escaneo una vez a la semana, antes de cambiar de alineador, y que espere la indicación que recibe antes de pasar al siguiente. Cuando el ajuste no es adecuado, puede ser necesario mantener el mismo alineador unos días más, aumentar las horas de uso o utilizar más los mordedores para alineadores.

Si el problema no se resuelve, podemos adelantar la revisión en la clínica y valorar si todavía se dan las condiciones para continuar con la secuencia o si es necesario interrumpirla, realizar un nuevo escaneo intraoral y planificar un refinamiento. Las citas presenciales suelen programarse cada cuatro a seis meses, aunque la frecuencia siempre se adapta a las necesidades de cada caso.

El mismo principio se aplica cuando se envía el escaneo, pero las imágenes no son lo bastante claras para permitir una valoración fiable. Si ocurre alguna vez, repetimos juntos el procedimiento y comprobamos si hay alguna dificultad técnica. Si el problema persiste, el paciente debe acudir a una revisión en la clínica. Cuando el seguimiento a distancia no es viable, programamos revisiones clínicas más frecuentes y podemos entregar menos alineadores cada vez: **la autonomía no puede mantenerse sin una vía de supervisión fiable.**

De este modo, el cambio semanal deja de ser un simple plazo. La idea que le surge espontáneamente al paciente, *«Ha pasado una semana, así que puedo cambiar de alineador»*, se sustituye por un principio más acertado: *«Ha pasado una semana y puedo cambiar de alineador si se dan las condiciones clínicas para continuar».*

El seguimiento durante la retención

El mismo principio puede mantenerse incluso después de concluir la fase activa. Como vimos en el capítulo anterior, entregar un aparato de retención significa confiar progresivamente al paciente la responsabilidad de proteger el resultado conseguido, pero eso no implica necesariamente que, a partir de ese momento, haya que dejarlo completamente solo. En mi clínica ofrezco la posibilidad de continuar el seguimiento durante la fase de retención mediante un programa opcional que combina el seguimiento a distancia con una forma de garantía del mantenimiento del resultado.

El programa cuesta **500 euros al año** y se puede mantener hasta tres años. Teniendo en cuenta que los paquetes de tratamiento que utilizo permiten producir alineadores adicionales durante los cinco años posteriores al inicio de la terapia y que la fase activa suele durar un año y medio o dos años, a menudo queda un periodo de unos tres años en el que podemos seguir atendiendo al paciente e intervenir, cuando se den las condiciones previstas, si se produce una recidiva, sin un nuevo coste de producción de los alineadores, siempre que ese coste siga incluido en el paquete comercial.

La palabra *garantía*, sin embargo, debe utilizarse con cuidado, porque podría dar a entender que la clínica corregirá automáticamente cualquier desplazamiento dental futuro, independientemente de lo que haga el paciente. Ese no es el sentido del programa. La garantía forma parte de un acuerdo en el que el paciente también asume compromisos concretos: debe utilizar el aparato de retención según las indicaciones recibidas, realizar regularmente los escaneos solicitados a través de Dental Monitoring, acudir a las revisiones programadas y comunicarnos con prontitud la pérdida o rotura del aparato, o cualquier problema de ajuste.

Durante esta fase pido un escaneo con Dental Monitoring una vez al mes y añado al programa una sesión de higiene bucodental profesional cada seis meses. En esa cita, las higienistas también realizan un escaneo intraoral tridimensional, que puede compararse con el registrado al finalizar el tratamiento y nos permite comprobar con el tiempo la estabilidad de la posición de los dientes. Por tanto, el paciente no compra simplemente la promesa de que, si algo se mueve, se corregirá gratis, sino que entra en un sistema de vigilancia en el que la prevención, las revisiones y la responsabilidad personal siguen funcionando juntas.

Si el paciente ha cumplido las condiciones acordadas y, pese a ello, se produce una recidiva que requiere una nueva intervención ortodóncica, podemos intervenir sin cobrarle de nuevo el tratamiento, naturalmente dentro de los límites temporales

y clínicos previstos en el programa. En cambio, si no ha utilizado los aparatos de retención según lo prescrito, ha interrumpido los escaneos mensuales, no ha acudido a las revisiones o ha dejado pasar meses antes de comunicar un problema, deja de cumplirse la condición sobre la que se había establecido esa garantía.

Esto es importante porque incluso un programa de garantía puede resultar contraproducente si se percibe como un traspaso de toda la responsabilidad a la clínica. El mensaje no debe ser «*Pase lo que pase, nosotros nos encargaremos*», sino más bien «*Si tú sigues haciendo tu parte, nosotros seguiremos haciendo la nuestra*». Así, la garantía se convierte en una responsabilidad compartida: el paciente protege el resultado mediante el uso de los aparatos de retención, los escaneos y las revisiones acordadas, mientras que nosotros mantenemos un sistema que nos permite detectar pronto cualquier cambio e intervenir cuando sea necesario.

También desde el punto de vista económico prefiero presentar el programa de esta manera. Los **500 euros anuales** no son simplemente el precio de un posible nuevo tratamiento, sino que incluyen un programa de prevención y supervisión que continúa durante la retención, así como sesiones de higiene bucodental.

Dental Monitoring desempeña así un papel en dos momentos muy distintos del tratamiento. Durante la fase activa nos permite reducir el tiempo que una pérdida de tracking puede pasar inadvertida; durante la retención puede ayudarnos a detectar pronto un cambio en el resultado. En ambos casos, sin embargo, el principio sigue siendo el mismo: **el seguimiento solo funciona si hay alguien que observa y alguien que sigue proporcionando la información necesaria para que se le pueda observar.**

GUION OPERATIVO

Dental Monitoring forma parte de la comunicación con el paciente en distintos momentos del tratamiento y, precisamente por eso, el guion debe cambiar según la situación. En el momento de la entrega, sirve sobre todo para establecer las reglas del sistema; cuando se pierde el tracking, debe ayudarnos a reconstruir lo ocurrido sin convertir la conversación en una acusación; si no se han realizado los escaneos, debe dejar clara la consecuencia de la falta de supervisión; durante la retención, por último, debe aclarar que el programa de seguimiento y garantía solo funciona si ambas partes asumen su responsabilidad.

En el momento de la entrega

> *«Antes de cambiar cada alineador, tendrás que hacer un escaneo con el móvil y esperar la indicación que recibas. Si todo va bien, podrás pasar al siguiente alineador; si, por el contrario, un diente necesita más tiempo, podremos pedirte que sigas utilizando el actual y darte indicaciones concretas.*
>
> *El sistema no lleva un cronómetro, así que no puede decirnos exactamente cuántas horas has utilizado los alineadores. Sin embargo, los escaneos semanales nos permiten observar de forma continuada el ajuste y la progresión del tratamiento. Si los alineadores se usan menos de lo necesario, las consecuencias de esa falta de constancia suelen hacerse visibles con el tiempo.*
>
> *Por tanto, tendrás menos citas en la clínica, pero una responsabilidad muy concreta: el escaneo semanal forma parte del tratamiento exactamente igual que el uso de los alineadores».*

Cuando se ha perdido el tracking

> *«Veamos juntos los escaneos de las últimas semanas. Así podremos identificar en qué periodo empezó a empeorar el tracking e intentar entender qué pudo haber pasado. A lo mejor descubrimos que precisamente esa semana hubo una boda, un viaje u otra ocasión durante la cual los alineadores estuvieron fuera de la boca más tiempo del previsto».*

Cuando no se han realizado los escaneos

> *«Si tuviéramos un escaneo de cada semana, podríamos identificar en qué periodo empezó a empeorar el ajuste e intentar entender qué pasó. Como no se han realizado algunos escaneos, hemos perdido la posibilidad de darnos cuenta e intervenir a tiempo.*
>
> *Ahora tenemos que valorar cuánto tracking se ha perdido y determinar si todavía podemos continuar con estos alineadores o si será necesario modificar el plan de tratamiento. En cualquier caso, a partir de ahora tendremos que retomar tanto el uso correcto de los alineadores como los escaneos semanales; de lo contrario, correríamos el riesgo de volver a encontrarnos en la misma situación».*

Para proponer el programa durante la retención

> *«A partir de hoy, la estabilidad del resultado dependerá sobre todo del uso del aparato de retención. Puedes gestionar esta fase por tu cuenta o apuntarte a nuestro programa de seguimiento y garantía durante los próximos tres años.*
>
> *En mi clínica, el programa cuesta 500 euros al año e incluye dos sesiones de higiene, una cada seis meses, el seguimiento mediante un escaneo mensual desde casa y la comparación periódica entre la posición actual de los dientes y la alcanzada al finalizar el tratamiento.*
>
> *Si cumples el protocolo y, pese a ello, detectamos un desplazamiento, valoraremos sin demora cómo intervenir y, cuando se den las condiciones previstas en el programa, no se te cobrará un nuevo tratamiento ortodóncico.*
>
> *Para mantener activo el programa tendrás que utilizar correctamente el aparato de retención, realizar el escaneo mensual y acudir a las dos sesiones de higiene previstas. No se trata solo de una cobertura económica, sino de un sistema que nos permite detectar rápidamente si algo está cambiando».*

Por qué funciona este protocolo

- **Hace visible lo que sucede entre dos revisiones**

El escaneo semanal transforma el largo intervalo entre dos revisiones en una sucesión de pequeñas citas digitales en las que el paciente sabe que podemos observar regularmente cómo avanza el tratamiento. Al mismo tiempo, recibir información con frecuencia permite relacionar más claramente su comportamiento con las posibles consecuencias clínicas: si el ajuste empieza a empeorar, podemos intervenir cuando el problema aún es limitado, en lugar de descubrirlo muchos meses después.

- **Permite reconstruir lo ocurrido en vez de acusar**

Cuando se pierde el tracking o no se han realizado los escaneos previstos, no hace falta convertir la conversación en una confrontación entre la versión del paciente y la del médico. El historial disponible permite reconstruir juntos lo ocurrido y, al relacionar el cambio con episodios concretos como una boda, un viaje o una semana especial, ayuda al paciente a recordar detalles más precisos que si le preguntamos en general por las horas de uso. De este modo, el paciente puede reconocer que tal vez haya colaborado menos sin sentirse acusado de haber mentido de entrada.

■ **Deja claros los límites del sistema**

Dental Monitoring no mide directamente las horas de uso, y que un diente no se mueva no demuestra automáticamente una falta de colaboración. Reconocer abiertamente estos límites hace que el seguimiento resulte más creíble e impide que se convierta en una herramienta para demostrar que el paciente se ha equivocado. Así conserva su función más útil: detectar pronto una desviación y ayudarnos a comprender sus posibles causas.

■ **Convierte el seguimiento en una responsabilidad compartida**

El seguimiento solo funciona si ambas partes cumplen su cometido: la clínica debe revisar la información recibida e intervenir cuando sea necesario, mientras que el paciente debe realizar los escaneos, seguir las indicaciones y mantener abierta la vía de supervisión. Este principio se hace aún más evidente durante la retención, cuando la garantía no elimina la responsabilidad del paciente, sino que la incorpora a un acuerdo recíproco y verificable.

BIBLIOGRAFÍA

Hansa I, Semaan SJ, Vaid NR. Clinical outcomes and patient perspectives of Dental Monitoring® GoLive® with Invisalign®—a retrospective cohort study. Progress in Orthodontics. 2020;21:16.

Moylan HB, Carrico CK, Lindauer SJ, Tüfekçi E. Accuracy of a smartphone-based orthodontic treatment-monitoring application: a pilot study. The Angle Orthodontist. 2019;89(5):727-733.

Hansa I, Katyal V, Ferguson DJ, Vaid NR. Outcomes of clear aligner treatment with and without Dental Monitoring: a retrospective cohort study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2021;159(4):453-459.

Sangalli L, Alessandri-Bonetti A, Dalessandri D. Effectiveness of dental monitoring system in orthodontics: a systematic review. Journal of Orthodontics. 2024;51(1):28-40.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Con el paciente Dominante conviene presentar Dental Monitoring como una herramienta que permite detectar rápidamente un problema, tomar una decisión y reducir el riesgo de retrasos:

> *«Con los escaneos semanales podemos saber rápidamente si el tratamiento avanza como debe e intervenir antes de que un pequeño problema retrase el resultado».*

I

Influyente

Con el paciente Influyente es útil destacar la sencillez, el contacto con el equipo y la posibilidad de recibir confirmaciones frecuentes sin tener que volver continuamente a la clínica:

> *«Cada semana nos enviarás las imágenes y seguiremos en contacto a través de la aplicación, así podrás saber si todo va bien sin tener que venir a la clínica cada vez».*

S

Estable

Con el paciente Estable es importante subrayar la continuidad del seguimiento y la presencia constante del equipo, para evitar que interprete el mayor intervalo entre citas como una falta de atención:

> *«Aunque las citas estén más espaciadas, no te dejaremos solo. Revisaremos regularmente los escaneos y te guiaremos en cada paso».*

C

Concienzudo

Con el paciente Concienzudo es preferible ofrecer un protocolo preciso y definir claramente la frecuencia, el procedimiento, los criterios para cambiar de alineador y los límites del sistema:

> *«Tendrás que hacer un escaneo una vez a la semana, antes de cambiar de alineador. Según el ajuste, recibirás la indicación de pasar al siguiente o de seguir utilizando el actual. El sistema no calcula las horas de uso, pero nos permite documentar de forma continuada la evolución clínica».*

CAPÍTULO 15

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Durante la fase activa y, para quienes se apunten, en el programa opcional de retención.
OBJETIVO	Detectar pronto las desviaciones y mantener una supervisión continua entre las revisiones en la clínica.
QUÉ HACER	***Fase activa*** 1. Pedir un escaneo semanal antes del cambio y esperar la indicación para continuar. 2. Si el ajuste no es adecuado, valorar un uso más prolongado del alineador, recordar las horas prescritas y el uso de los mordedores para alineadores cuando esté indicado y, después, hacer un seguimiento. 3. Si el problema persiste, adelantar la revisión y valorar si continuar, realizar un nuevo escaneo o hacer un refinamiento. 4. Si faltan escaneos o su calidad es insuficiente, restablecerlos; si es necesario, aumentar las revisiones y reducir el número de alineadores entregados. 5. Programar, por lo general, revisiones cada cuatro-seis meses, adaptándolas al caso. ***Retención — programa opcional*** 1. Acordar la duración y el coste: en el protocolo descrito, hasta tres años, 500 euros al año. 2. Pedir escaneos mensuales desde casa; revisión, higiene y escaneo intraoral cada seis meses. 3. Supeditar la garantía a que el programa siga activo, al uso correcto del aparato de retención, a los escaneos, a las revisiones y a la comunicación rápida de los problemas.
QUÉ COMPROBAR	La calidad y regularidad de los escaneos, el ajuste, el progreso y la respuesta a las indicaciones. El seguimiento no mide las horas de uso ni sustituye todas las revisiones presenciales. Durante la retención, comprobar que se cumplen las condiciones de la garantía.

CAPÍTULO

16

Cuando hay que terminar de verdad

«Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo».

— ECLESIASTÉS 3,1

Durante mucho tiempo, terminar un tratamiento antes de alcanzar todos los objetivos me parecía una rendición. Si quedaba algo por corregir, consideraba casi mi deber encontrar otra manera de conseguirlo. El tratamiento llevaba mi nombre y seguía viendo el resultado incompleto como una responsabilidad personal, incluso cuando la colaboración del paciente había sido insuficiente.

La mayor dificultad llegaba cuando sabía lo que quería conseguir, pero el paciente seguía sin utilizar los alineadores o los elásticos con la regularidad necesaria. Habíamos aclarado las indicaciones, abordado las dificultades e intentado reconducir el tratamiento, sin lograr un cambio lo bastante estable. Podía planificar otra

serie, modificar los ataches o proponer revisiones más frecuentes, pero ninguna de esas medidas podía compensar por sí sola la colaboración que seguía faltando.

En aquellas situaciones, cada nuevo intento me permitía aplazar una decisión que me costaba aceptar. Mientras el tratamiento seguía abierto, el resultado incompleto aún parecía provisional. Darlo por concluido significaba reconocer que una parte de los objetivos no se había alcanzado y que no podía alcanzarla solo con mi trabajo clínico.

Este capítulo aborda precisamente ese momento: cuando, después de reevaluar las causas del estancamiento e intentar recuperar la colaboración, la implicación del paciente sigue siendo insuficiente para el tratamiento. Puede quedar una corrección incompleta, una rotación o contactos por mejorar: objetivos que aún tienen valor clínico, pero que requieren una participación con la que no podemos contar.

¿Cómo decidimos si ofrecer una última oportunidad, cambiar de método o concluir la fase activa?

Para responder, hay que considerar a la vez lo que falta y la posibilidad real de conseguirlo. Debemos valorar la importancia de los objetivos pendientes, la situación clínica actual y el comportamiento observado tras los intentos de recuperar la colaboración. Saber que el resultado podría ser mejor no basta, por sí solo, para justificar otra fase si sigue faltando la colaboración necesaria.

He aprendido que tomar esta decisión forma parte de la responsabilidad del ortodoncista tanto como la planificación inicial. Exige ser transparentes sobre el resultado, hablar de las alternativas y reconocer cuánto podemos conseguir en las circunstancias actuales, sin vivir cada objetivo pendiente como un fracaso personal.

Cuando aún hay margen para recuperar la colaboración, podemos ofrecer una última oportunidad. Pero debe tener unas condiciones precisas y un momento de evaluación; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse simplemente en otra reanudación.

EL GUION OPERATIVO

El guion operativo consta de cinco partes: definir una ventana de recuperación, valorar si el tratamiento ha vuelto a progresar, considerar un cambio de método, decidir si concluir la fase activa y, en ese caso, cerrarla de forma concreta. Los pasos posteriores a la evaluación dependen de la respuesta clínica y de las alternativas adecuadas para el paciente.

1. Definir la ventana de recuperación

Antes de proponer la ventana de recuperación, vuelvo a valorar las posibles causas del estancamiento y compruebo que el paciente haya recibido instrucciones claras y coherentes. Debo distinguir una colaboración insuficiente de las dificultades relacionadas con la planificación, la respuesta biológica o la comprensión de las indicaciones.

Acuerdo con el paciente qué debe hacer, durante cuánto tiempo debe hacerlo, qué datos clínicos utilizaremos para evaluar el resultado y qué alternativas valoraremos si el progreso sigue siendo insuficiente. Es lo que llamo **ventana de recuperación**.

La duración depende del caso y del movimiento que debamos observar. El plazo debe acordarse desde el principio, junto con indicaciones concretas sobre el uso de los alineadores y los elásticos, los cambios de alineador, los escaneos de seguimiento y las revisiones.

La conversación puede empezar así:

> *«Quiero comprobar contigo si podemos reconducir el tratamiento, pero esta vez tenemos que establecer claramente cómo evaluaremos el resultado. Hasta la próxima revisión tendrás que utilizar los alineadores y los elásticos según las indicaciones, respetar los cambios de alineador y realizar los escaneos acordados.*
>
> *En la revisión compararemos el ajuste y el movimiento conseguido. Si vemos un progreso suficiente, podremos continuar. Si, en cambio, seguimos en la misma situación, tendremos que valorar un método distinto o, si las condiciones clínicas lo permiten, concluir la fase activa».*

Esta última parte es fundamental. Si no explicamos de antemano qué pasará si no hay un progreso suficiente, al llegar la revisión volveremos a sentir la tentación de conceder otra oportunidad. **Una última oportunidad que se renueva automáticamente pierde su sentido.**

2. Cuándo podemos continuar con los alineadores

En la revisión valoro el ajuste, comparo los escaneos y observo el movimiento conseguido, interpretando estos datos junto con el resto de la información clínica. Las declaraciones del paciente ayudan a reconstruir el curso del tratamiento, pero no sustituyen la comprobación de su eficacia.

Si el comportamiento ha cambiado y el tratamiento ha vuelto a progresar, podemos continuar con los alineadores. No debemos exigir que el paciente se haya vuelto

perfecto. Debemos comprobar que su colaboración sea suficiente para alcanzar los objetivos pendientes y que el progreso justifique continuar.

Una breve mejoría en los días previos a la revisión puede no ser suficiente. La ventana debe permitirnos observar una constancia adecuada para lo que aún queremos conseguir. Si el seguimiento o las revisiones más frecuentes han ayudado a recuperar la colaboración, mantengo ese apoyo durante el tiempo necesario para consolidarla.

3. Si debemos cambiar de método

Cuando el objetivo sigue estando indicado, pero el paciente no consigue cumplir las exigencias de los alineadores, podemos valorar una opción terapéutica que dependa menos de las horas de uso. Un tratamiento puede estar indicado desde el punto de vista clínico y resultar difícil de mantener en la vida cotidiana de la persona. Prefiero explicarlo así:

> *«Los alineadores pueden conseguir el movimiento que necesitamos, pero exigen una regularidad de uso que hasta ahora no hemos logrado mantener. Hemos intentado varias veces reconducir el tratamiento y hoy tengo que reconocer que este método está resultando difícil de encajar en tu vida cotidiana. Si todavía quieres alcanzar los objetivos pendientes, podemos valorar un aparato que dependa menos de las horas de uso. Te explicaré qué posibilidades ofrece y qué implicación requiere, para que puedas decidir si quieres afrontar esta nueva fase».*

El cambio exige una nueva valoración. Debemos hablar de las indicaciones, los límites, los riesgos, los plazos y la inversión, y aclarar también qué colaboración será necesaria con el nuevo aparato. Cambiar de método terapéutico no garantiza automáticamente el resultado.

Si proponemos una nueva fase, ya sea con un método distinto o empezando de nuevo con los alineadores, también debemos aclarar sus condiciones económicas. Los escaneos, la reevaluación clínica, la planificación, los aparatos, las citas y el tiempo del equipo suponen un trabajo real, aunque el paquete contratado con la empresa todavía permita pedir más series de alineadores.

Los posibles nuevos honorarios deben ser coherentes con lo acordado al principio y con los motivos para empezar de nuevo. Un refinamiento normal dentro del tratamiento y la repetición de tareas que han resultado ineficaces por una colaboración persistentemente insuficiente requieren valoraciones distintas.

No existe una cifra universal. El importe depende del trabajo necesario, los costes, la complejidad de la nueva fase y las condiciones comunicadas y acordadas. No debe aparecer de repente en medio de un conflicto: la posibilidad de una nueva inversión debe explicarse con antelación y hablarse con precisión antes de continuar.

El pago, sin embargo, no demuestra que la colaboración vaya a cambiar. El paciente puede aceptar el coste y mantener los mismos hábitos. Por tanto, las condiciones económicas deben ir acompañadas de un plan concreto, con las conductas necesarias y los criterios para evaluarlas.

Antes de empezar de nuevo, debemos aclarar tanto el trabajo necesario como lo que hará que esta fase sea distinta de las anteriores.

4. Si debemos concluir la fase activa

Si valoramos darla por concluida, debemos distinguir los motivos que nos llevan a tomar esa decisión.

En una primera situación, el resultado alcanzado es clínicamente aceptable, aunque no coincida del todo con el resultado ideal previsto. Lo que queda pendiente tiene una importancia limitada y el beneficio previsible de otra fase parece escaso en relación con el tiempo y la implicación que exigiría.

En una segunda situación, quedan objetivos clínicamente relevantes, pero el paciente no puede o no quiere asumir las condiciones necesarias para alcanzarlos. Puede rechazar el cambio de método, no aceptar la nueva inversión o no estar dispuesto a asumir la implicación necesaria.

En ese caso, podemos valorar dar por terminado el tratamiento aceptando un resultado de compromiso, siempre que la situación en la que quede el paciente sea clínicamente aceptable y hayamos examinado y explicado los riesgos. La diferencia está en el motivo por el que nos detenemos: en el primer caso, consideramos que lo que falta no justifica otra fase; en el segundo, reconocemos el valor de los objetivos pendientes, pero el paciente decide no afrontar el camino necesario para alcanzarlos.

El compromiso debe ser comprensible. Debemos describir lo conseguido, lo que queda pendiente, las alternativas propuestas y las posibles consecuencias de la decisión. Si la situación presenta riesgos inaceptables, limitarse a entregar un aparato de retención no resuelve el problema: hay que proponer una solución adecuada y gestionar un posible rechazo, garantizando la continuidad de la atención necesaria.

Para abordar esta conversación, utilizaría un guion como este:

> *«El resultado que hemos alcanzado todavía no se corresponde del todo con el que habíamos previsto, y quiero ser transparente al respecto. Hemos intentado continuar varias veces, pero hoy no veo motivos suficientes para esperar que otra serie de alineadores, utilizándolos del mismo modo, dé un resultado distinto.*
>
> *Seguir alargaría el tratamiento sin una expectativa razonable de mejora. Por eso creo que debemos elegir otro camino.*
>
> *Si quieres alcanzar los objetivos pendientes, podemos valorar otro método. Te explicaré sus indicaciones, sus límites, la implicación necesaria, los plazos y los costes. Si, en cambio, valoramos concluir la fase activa, tendremos que comprobar que la situación alcanzada sea clínicamente aceptable y aclarar qué objetivos quedan pendientes.*
>
> *Te mostraré lo que hemos conseguido, lo que falta y qué consecuencias puede tener la decisión de detenernos. Si damos por concluida esta fase, retiraremos los elementos del tratamiento activo, prepararemos una férula de retención adecuada y programaremos las revisiones necesarias.*
>
> *Seguiremos ocupándonos de tu situación. Concluir esta fase significa reconocer los límites del tratamiento actual y decidir cómo proteger el resultado alcanzado».*

El paciente puede sentirse decepcionado, pedir otro refinamiento o decir que está dispuesto a continuar todo el tiempo que haga falta. Debemos escucharlo y comprender qué quiere conseguir. Su disposición, sin embargo, no significa automáticamente que esté indicado continuar.

La decisión surge del encuentro entre dos responsabilidades: el paciente decide qué implicación está dispuesto a asumir y qué propuestas acepta; el médico determina qué opciones son clínicamente viables y explica por qué.

El paciente también puede decidir no continuar. En ese caso, debe comprender qué queda pendiente, las posibles consecuencias y las alternativas disponibles. Hay que documentar su rechazo y darle las indicaciones necesarias para gestionar la situación en la que queda. Respetar esa decisión no significa considerar ideal el resultado alcanzado.

5. Cerrar el tratamiento de forma concreta

Cuando se decide concluir el tratamiento, la fase activa debe cerrarse de verdad. No basta con dejar de pedir alineadores ni con dejar al paciente con el último alineador a la espera de saber qué hará.

Documento la situación final, los objetivos pendientes, las alternativas propuestas y la decisión del paciente. Retiro los ataches y los elementos que no deben

permanecer, preparo la férula de retención y entrego indicaciones comprensibles, además de programar las revisiones necesarias.

Cuando concluyo el tratamiento por una colaboración insuficiente, no aplico el protocolo de estabilización descrito en los capítulos anteriores. Ese protocolo exige otros nueve meses de uso regular de los alineadores. Si esa constancia ha faltado durante la fase activa, no puedo basar la estabilización en la expectativa de que se mantenga precisamente ahora.

Por tanto, paso directamente a la retención y la adapto a la situación clínica en la que queda el paciente. Esta fase también exige colaboración: debemos aclarar cómo debe llevarse a cabo, cuáles son sus límites y qué revisiones requiere, sin dar a entender que el resultado se conservará independientemente del comportamiento del paciente.

Por último, todo el equipo debe conocer la decisión. Las citas y las comunicaciones deben reflejar el paso del tratamiento activo a la retención. El paciente debe saber qué ha terminado y qué atención seguirá recibiendo.

Por qué funciona este protocolo

- **Compromiso verificable**

La ventana de recuperación convierte una promesa genérica en una conducta concreta. El paciente sabe qué se le pide, durante cuánto tiempo debe hacerlo y cuándo se evaluará el resultado. El ortodoncista también dispone de un plazo para reevaluar el caso y evita así que la última oportunidad se prolongue sin tomar una decisión.

- **Evaluación clínica sin buscar una confesión**

Comparar el ajuste, los escaneos y el movimiento conseguido permite abordar el progreso del tratamiento sin centrar la conversación en la sinceridad del paciente. Lo que cuenta ayuda a reconstruir el curso del tratamiento, pero la decisión exige una evaluación clínica.

Los datos deben interpretarse teniendo en cuenta también las posibles causas biológicas y biomecánicas: la ausencia de movimiento no demuestra automáticamente una colaboración insuficiente.

- **Coherencia de las consecuencias**

Si cada plazo se aplaza y cada evaluación lleva a empezar de nuevo, la consecuencia anunciada pierde sentido. Tomar una decisión cuando llega la fecha acordada da credibilidad a los límites del tratamiento.

Esto también vale para el ortodoncista: haber definido de antemano las alternativas le ayuda a evitar que la dificultad de la conversación lo lleve a conceder automáticamente otra serie de alineadores.

Alternativas comprensibles

Presentar las distintas posibilidades ayuda al paciente a comprender que el tratamiento puede cambiar de rumbo. Podemos continuar con los alineadores cuando la recuperación de la colaboración sea suficiente, valorar otro método o concluir el tratamiento cuando sea clínicamente adecuado.

La claridad de las alternativas permite al paciente expresar sus preferencias y prioridades. El ortodoncista conserva la responsabilidad de determinar qué opciones puede proponer y explicar sus beneficios y límites.

Inversión consciente

Cuando una nueva fase supone un coste, aclararlo con antelación deja claro el trabajo necesario y las condiciones para empezar de nuevo. El paciente puede valorar cuánto le importa el resultado y qué implicación está dispuesto a asumir.

El pago no garantiza una mayor colaboración. La nueva inversión debe ir acompañada de un plan concreto, con las conductas necesarias y los criterios para evaluarlas.

Continuidad de la atención

Explicar qué atención seguirá recibiendo el paciente tras concluir el tratamiento ayuda a reducir el temor a que lo abandonemos. La retención, las revisiones y las indicaciones adecuadas hacen tangible esa continuidad.

La documentación deja constancia de los motivos de la decisión; informar al equipo evita que unas citas o unos mensajes contradictorios hagan que el paciente perciba que el tratamiento sigue abierto.

Un tratamiento que sigue abierto sin conseguir progresar ya no solo consume tiempo y recursos. Poco a poco empieza a desgastar también a las personas que siguen llevándolo adelante.

BIBLIOGRAFÍA

Gross AM, Samson G, Dierkes M. Patient cooperation in treatment with removable appliances: a model of patient noncompliance with treatment implications. *American Journal of Orthodontics.* 1985;87(5):392-397.

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine.* 2012;27(10):1361-1367.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Utilizo una comunicación directa, centrada en la decisión y las alternativas:

> *«El tratamiento no está progresando lo suficiente y no considero útil repetir otra serie en las mismas condiciones. Podemos valorar otro método o, si la situación clínica lo permite, concluir la fase activa y proteger el resultado con una férula de retención adecuada».*

Destaco los criterios para elegir y el beneficio previsible, y evito explicaciones que nos desvíen del tema.

I

Influyente

Reconozco el entusiasmo que acompaña a cada nuevo comienzo y vuelvo a centrar la atención en la constancia:

> *«Cada vez empezamos de nuevo con mucha motivación, pero luego cuesta mantener la rutina. Antes de volver a empezar, debemos elegir un camino que puedas seguir también después de las primeras semanas».*

Mantengo un tono positivo y vinculo la motivación a un plan concreto y verificable.

S

Estable

Insisto en la continuidad de la atención y acompaño al paciente en la decisión:

> *«Seguiremos ocupándonos de tu situación. Ahora debemos valorar si cambiamos de método o concluimos esta fase, protegiendo lo conseguido y programando las revisiones necesarias».*

Dejo espacio para las preguntas y aclaro qué aspectos de la atención continuarán después de concluir el tratamiento.

C

Concienzudo

Me apoyo en datos, comparaciones y criterios:

> *«Hemos comparado los escaneos, el ajuste y los movimientos conseguidos. El progreso sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos pendientes. Te mostraré lo que hemos conseguido, lo que queda pendiente y las alternativas disponibles, con sus respectivos límites».*

Explico con transparencia los elementos en los que se basa la propuesta y distingo los datos observados de las previsiones.

CAPÍTULO 16

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	Cuando el tratamiento está estancado y hay que decidir si continuar, cambiar de método o concluirlo.
OBJETIVO	Tomar una decisión clínicamente adecuada y garantizar la continuidad de la atención.
QUÉ HACER	1. Reevaluar la planificación, la respuesta clínica y la colaboración, distinguiendo entre dificultades temporales y conductas persistentes. 2. Comprobar que las instrucciones sean comprensibles y coherentes para todo el equipo. 3. Cuando esté indicado, acordar una ventana de recuperación con las conductas necesarias, su duración, los criterios para evaluarla y las alternativas. 4. Evaluar el cambio mediante el ajuste y los movimientos conseguidos: una nueva promesa no basta. 5. Continuar si las condiciones mejoran; valorar otro método si sigue estando indicado alcanzar los objetivos pendientes; concluir el tratamiento cuando sea adecuado, aceptando únicamente resultados de compromiso clínicamente sostenibles. 6. Documentar los objetivos alcanzados y los pendientes, las alternativas y la decisión del paciente; aclarar los posibles nuevos costes. 7. Si se concluye el tratamiento, retirar los elementos del tratamiento activo, preparar los retenedores y programar las revisiones. Si la colaboración es insuficiente, el protocolo prevé pasar directamente a la retención, sin fase de estabilización. 8. Adaptar las citas y las comunicaciones del equipo a la decisión.
QUÉ COMPROBAR	Las causas del estancamiento, la respuesta durante la ventana de recuperación, la viabilidad de las alternativas, la aceptabilidad del resultado de compromiso y la comprensión de los siguientes pasos. Concluir la fase activa no significa interrumpir la atención.

CAPÍTULO

17

El coste que aún no habíamos contado

«Hay que conceder descanso a la mente: tras reposar, se levantará mejor y más aguda».

— SÉNECA

Hay días en los que todo parece haber ido bien. Has empezado puntual, has atendido a ochenta pacientes, has resuelto problemas, entregado nuevos alineadores, revisado tratamientos que avanzan exactamente como habías previsto y visto a padres satisfechos, chicos que colaboran y adultos encantados con su sonrisa. Puede que incluso hayas conseguido terminar casi a tu hora, lo que en un día así ya puede considerarse una pequeña victoria.

Luego cierras la puerta de la clínica, te despides del equipo, te subes al automóvil y vuelves a casa, y justo entonces ocurre algo extraño: ese día has atendido a ochenta

pacientes y con la gran mayoría todo ha ido bien, pero no son ellos los que tienes en la cabeza. Son esos dos o tres que te han consumido una cantidad de energía totalmente desproporcionada respecto al tiempo que has pasado con ellos.

Está el que te ha asegurado que ha llevado los alineadores con perfecta regularidad, mientras que el ajuste contaba una historia completamente distinta; el que, una vez más, no ha traído los alineadores y te ha obligado a reconstruir lo que podría haber ocurrido en las últimas semanas; el que, después de meses de colaboración cuestionable, exige un nuevo refinamiento como si fuera la continuación natural del tratamiento. O está esa paciente que acaba de terminar el tratamiento, con un resultado que consideras clínicamente excelente, que al ver las fotografías y el escaneo reconoce que en la pantalla los dientes parecen perfectamente rectos, pero luego añade que, cuando se mira al espejo, sigue viendo algo que no le gusta.

Todos salieron de la clínica hace rato, pero alguno se ha subido al automóvil contigo.

Esta es probablemente una de las consecuencias de la falta de colaboración de las que menos se habla. En los capítulos anteriores hemos intentado medir muchas otras, hablando de tiempo, citas, escaneos, refinamientos, materiales, costes y horas de trabajo del equipo. Hemos visto que una serie adicional de alineadores no es simplemente una caja que llega a la clínica y que detrás de cada tratamiento que hay que retomar existe una cantidad de trabajo invisible que difícilmente aparece en nuestras cuentas.

Pero hay un coste que hasta ahora aún no habíamos contado, porque no aparece en el programa de gestión, no podemos incluirlo en las cuentas de la clínica y nadie nos presenta una factura a final de mes: es **la energía mental** que consumimos cada vez que tenemos que volver a afrontar situaciones que habríamos preferido no tener que gestionar. Cada paciente al que debemos repetirle las explicaciones, cada cita en la que tenemos que reconstruir lo que ha ocurrido realmente, cada promesa de colaboración que sabemos que ya se ha hecho otras veces, cada petición que consideramos irrazonable y cada decisión que nos vemos obligados a tomar de nuevo consume una pequeña parte de nuestros recursos.

Una sola situación de este tipo tiene poca importancia y, sencillamente, forma parte de nuestro trabajo. El problema surge con la repetición y, sobre todo, con la desproporción. No son necesariamente los ochenta pacientes de un día los que nos desgastan: setenta o setenta y cinco de ellos pueden dejarnos con más energía de la que teníamos por la mañana, porque ver que un tratamiento avanza bien, a un niño contento o a un paciente que por fin sonríe es una de las razones por las que seguimos amando este trabajo. En cambio, pueden ser esos dos o tres pacientes los

que, aunque ocupen una pequeña parte de la agenda, consiguen ocupar una parte enorme de nuestros pensamientos. Cuando esto se repite durante semanas, meses y años, lo que parecía una simple molestia cotidiana puede convertirse en algo muy distinto.

La literatura odontológica lleva muchos años estudiando el estrés profesional y el burnout, y sería simplista, además de científicamente incorrecto, buscarles una única causa. Las horas de trabajo, la presión del tiempo, los aspectos económicos, la gestión de la clínica, las relaciones con los colaboradores y las responsabilidades clínicas y administrativas son solo algunos de los factores que pueden contribuir a la carga de trabajo. Sin embargo, entre ellos aparece una y otra vez algo directamente relacionado con el tema de este libro: la dificultad de la relación con algunos pacientes.

Los estudios realizados sobre el equipo odontológico han mostrado que los llamados pacientes difíciles pueden suponer una verdadera demanda laboral y que una mayor exposición a este tipo de relaciones se asocia con el agotamiento emocional y el burnout. En un estudio realizado con más de seiscientos dentistas, los profesionales estimaban incluso que alrededor de una cuarta parte de sus pacientes podían considerarse, de algún modo, problemáticos o difíciles de tratar, y la percepción de tener una mayor proporción de estos pacientes mostraba una relación especialmente significativa con el burnout.

Esto no significa, por supuesto, que un paciente difícil provoque burnout, y mucho menos que debamos considerar difícil a todo paciente que colabora poco. Sería una conclusión que la literatura no permite sostener y que tampoco tendría ningún sentido en nuestra práctica diaria, porque la mayoría de los pacientes que olvidan un elástico, dejan de llevar los alineadores durante unas horas o pasan por una temporada en la que colaboran menos nunca supondrán un problema importante para nosotros.

La cuestión se vuelve interesante cuando determinadas situaciones dejan de ser ocasionales y empiezan a repetirse, exigiendo continuamente tiempo, atención, decisiones, negociaciones y, a veces, la gestión de conflictos. En ese momento ya no son solo incidencias clínicas, sino que pasan a formar parte de la carga de trabajo, porque que un paciente no lleve un alineador no significa únicamente que lo tenga unas horas menos en la boca: puede traducirse en una cita más larga, una nueva explicación, un escaneo no previsto, un cambio en la agenda, una llamada de recepción, una conversación con uno de los padres o con el paciente, una nueva planificación y, en ocasiones, una discusión sobre quién debe asumir el coste de lo que haya que hacer.

Así, una conducta aparentemente sencilla puede desencadenar una cascada de consecuencias que afecta a muchas personas y consume una cantidad de recursos enormemente superior a la que vemos si solo miramos la boca del paciente.

Antes incluso de que el problema llegue hasta nosotros, alguien puede haber tenido que atender el teléfono, buscar una nueva cita en una agenda ya llena, llamar al paciente que no se ha presentado o recordarle lo que se había acordado. En muchos casos es precisamente recepción quien recibe primero la insatisfacción, la protesta o la frustración del paciente, cuando nosotros ni siquiera sabemos aún que hay un problema.

La literatura sobre el equipo odontológico muestra que el personal de recepción, los auxiliares, los higienistas, los responsables de la gestión de la clínica y los profesionales clínicos pueden verse expuestos de distintas maneras a las consecuencias de las relaciones difíciles con los pacientes. Los estudios cualitativos describen algo que probablemente muchos hemos observado sin ponerle nunca un nombre preciso: la tensión generada por un solo paciente puede extenderse por toda la clínica. La recepcionista recibe una llamada difícil y habla de ello con la auxiliar; la auxiliar avisa al dentista antes de la cita; el dentista entra en la consulta sabiendo ya que tendrá que afrontar una conversación complicada y, si la cita dura más de lo previsto, el retraso acaba afectando también a los siguientes pacientes.

Así, un problema que empezó en la boca de una persona puede alterar la jornada de muchas otras, y por eso proteger al equipo no puede consistir simplemente en enseñarle a aguantar mejor a los pacientes difíciles. Significa, sobre todo, evitar, cuando sea posible, que cada situación se afronte como si fuera la primera vez que ocurre.

Afrontar cada situación desde cero significa pedirle al equipo que busque una respuesta y al dentista que vuelva a tomar una decisión. Creo que buena parte del desgaste nace precisamente ahí: además de gestionar las consecuencias de la conducta del paciente, tenemos que decidir cada vez cómo proceder. El paciente no ha llevado los alineadores y debemos decidir si dejamos que continúe o nos detenemos; no ha utilizado los elásticos y tenemos que valorar hasta qué punto podemos fiarnos de lo que nos cuenta; el ajuste no es correcto en un solo diente y debemos elegir entre hacer un nuevo escaneo de inmediato o continuar; ha desaparecido durante un año y hoy llama diciendo que quiere retomar el tratamiento, así que debemos decidir por dónde empezar y qué costes tendrá que asumir; ya se ha sometido a varios refinamientos y sigue pidiendo que cambiemos detalles que consideramos clínicamente irrelevantes, lo que nos obliga una vez más a establecer dónde está el límite.

Por separado, son problemas sencillos y un profesional con experiencia es perfectamente capaz de resolverlos. El problema surge cuando tenemos que resolverlos cientos de veces, quizá intentando recordar qué habíamos decidido seis meses antes con un paciente similar, explicando al equipo por qué esta vez actuamos de otra manera y preguntándonos después si no habría sido mejor elegir otro camino.

Aquí cobra interés un modelo muy utilizado en la literatura sobre el estrés laboral, el modelo de demandas y recursos laborales, que distingue, simplificando mucho, entre las exigencias que el trabajo nos impone continuamente, las demandas laborales, y los recursos de los que disponemos para afrontarlas, los recursos laborales. Las primeras requieren y consumen energía, mientras que los segundos ayudan a gestionarlas manteniendo el control, la motivación y la eficacia. Este modelo también se ha estudiado específicamente en dentistas, y algunos estudios longitudinales realizados con miles de profesionales han mostrado la relación entre unas demandas laborales elevadas y el burnout y, por otro lado, el papel positivo de los recursos laborales a la hora de mantener la implicación profesional.

Al leer estos trabajos me di cuenta de que, sin pretender atribuir al término un significado científico que los estudios no han demostrado directamente, en nuestra práctica diaria también podemos considerar un protocolo como un recurso: si una situación se repite y ya hemos decidido cómo afrontarla, no tenemos que volver a empezar de cero cada vez.

Por eso existen los protocolos de este libro

Llegados a este punto, por fin podemos mirar atrás y ver desde otra perspectiva todo lo que hemos construido en las páginas anteriores. Si has leído este libro desde el principio, te has encontrado con muchos protocolos, muchos guiones y probablemente también con alguna norma que, al menos al principio, quizá te haya parecido rígida: hemos hablado del paciente que no lleva los alineadores, del que no utiliza los elásticos, del que pierde el ajuste o no utiliza la férula de retención, del que desaparece y vuelve mucho tiempo después, del que necesita un refinamiento fisiológico y del que, en cambio, nos obliga a repetir una fase del tratamiento porque no ha colaborado, hasta llegar al paciente que sigue pidiendo algo cuando nosotros creemos que ya hemos alcanzado el resultado.

Para cada una de estas situaciones hemos intentado decidir de antemano qué hacer, no porque queramos convertir la medicina en un reglamento ni porque haya que tratar a todos los pacientes de la misma manera. Un protocolo nunca debe sustituir el juicio del dentista y siempre habrá situaciones en las que sea correcto

hacer una excepción; la diferencia fundamental es que esa excepción debería ser una decisión consciente por nuestra parte, no la consecuencia de no haber decidido qué hacer.

Después de tantos años de trabajo, esta distinción se ha vuelto fundamental para mí, porque un protocolo no solo me indica cómo tratar al paciente, sino que me evita tener que inventar de nuevo, cada vez, cómo gestionar el mismo problema. Del mismo modo, un guion no sirve solo para encontrar las palabras adecuadas: sirve para que esas palabras no dependan de lo cansado que esté, de la hora del día, de si voy con retraso o de cuánto haya conseguido ponerme nervioso ese paciente y, sobre todo, permite que todos en la clínica hablen el mismo idioma.

Si en recepción ya saben qué ocurre cuando un paciente desaparece, no tienen que venir a preguntármelo cada vez; si el equipo sabe cómo gestionamos un refinamiento debido a la falta de colaboración, no tiene que interpretar la situación; si el paciente conoce desde el principio las consecuencias de determinadas conductas, la conversación posterior resulta más sencilla, porque no estamos inventando una norma cuando aparece el problema, sino aplicando algo que ya habíamos acordado.

Todo esto no hace que desaparezcan los pacientes difíciles ni impedirá que alguno deje de colaborar, pero puede ahorrarnos buena parte del esfuerzo que supone gestionar esas situaciones. Y quizá por eso, al llegar al final del libro, considero los guiones y los protocolos no solo herramientas organizativas o clínicas, sino una forma de protección: permiten que el piloto y la tripulación sepan qué hacer incluso cuando el pasajero decide comportarse de una manera que esperábamos que no se diera.

Esta protección empieza también por reconocer los límites de nuestro control. Con los alineadores hemos desarrollado herramientas extraordinarias para planificar el movimiento dental: planificamos décimas de milímetro, grados de torque, intrusiones, expansiones, secuencias, ataches y la secuenciación de movimientos, y pasamos horas ante una simulación intentando prever lo que ocurrirá meses después en la boca de una persona.

Podemos diseñar el mejor tratamiento posible, pero no podemos llevar los alineadores por el paciente; podemos explicarle lo importantes que son los elásticos, pero no podemos estar con él cada noche para comprobar que se los ha puesto; podemos recordarle las citas, pero no podemos obligarlo a acudir; podemos mostrarle fotografías, escaneos y resultados, pero no podemos decidir por él si estará satisfecho y, sobre todo, no podemos obligarlo a contarnos siempre exactamente lo que ha pasado.

Creía que mejorar como profesional significaba conseguir controlar cada vez más cosas y, en parte, sigo pensándolo, porque la experiencia clínica sirve precisamente para aumentar nuestra capacidad de prever, prevenir y gestionar lo que puede ocurrir. Pero hay otra forma de experiencia que probablemente se adquiere más despacio: aprender a reconocer qué cosas nunca podremos controlar y dejar de gastar energía intentándolo.

Cuando empecé a escribir este libro, pensaba que sería, sobre todo, un libro sobre la colaboración del paciente. Al llegar al final me di cuenta de que también se había convertido en un libro sobre nosotros y sobre lo que podemos hacer para facilitar un tratamiento que, por su propia naturaleza, depende en buena medida de la conducta de otra persona.

Todos los guiones, las normas, los costes, los protocolos y las estrategias descritos en las páginas anteriores no tienen como objetivo castigar a quien no colabora ni tampoco crear una clínica en la que no haya excepciones. Sirven para establecer límites claros, responsabilidades comprensibles y consecuencias previsibles, de modo que la relación con el paciente pueda seguir siendo lo más tranquila posible incluso cuando algo no va como habíamos previsto. Sirven, desde luego, para proteger el resultado clínico, el tiempo de la clínica y el trabajo del equipo, pero después de escribir este libro creo que también sirven para proteger algo que durante muchos años casi di por sentado: el placer de hacer este trabajo.

Porque, a la larga, el riesgo no es solo perder unas horas o tener que pedir unos cuantos alineadores más. El riesgo es permitir que un porcentaje muy pequeño de nuestros pacientes ocupe un porcentaje demasiado grande de nuestra energía, hasta el punto de olvidar que la inmensa mayoría de las personas a las que hemos atendido ese mismo día nos han dado satisfacciones, han confiado en nosotros, han colaborado y quizá nos han recordado exactamente por qué elegimos esta profesión.

Así que, después de ochenta pacientes, me gustaría poder volver a casa acordándome sobre todo de ellos. No porque los demás no existan o porque haya que ignorar los problemas, sino porque esos problemas deben tener un lugar, un momento y una respuesta. Cuando hemos creado un sistema capaz de darles respuesta, podemos aligerar la carga que seguimos llevándonos a casa incluso después de terminar el trabajo.

Quizá el verdadero éxito de todos los protocolos descritos en este libro no se mida solo por el número de refinamientos que nos permiten evitar, el tiempo que liberan en la agenda o los costes que ayudan a contener. También se mide por las decisiones que ya no tenemos que tomar, las discusiones que ya no tenemos que improvisar, las

llamadas que el equipo ya sabe cómo gestionar y la tranquilidad con la que podemos aceptar que hay una parte del tratamiento que nunca dependerá por completo de nosotros.

Al final, quizá todo este libro pueda resumirse así: no podemos impedir que el paciente se olvide, deje de colaborar, desaparezca, cambie de opinión o nos cuente una versión de los hechos distinta de la realidad. Pero podemos decidir de antemano qué hacer cuando ocurra, protegiendo el tratamiento, nuestra clínica, a las personas que trabajan con nosotros y, sobre todo, el placer de seguir haciendo este trabajo.

Porque no podemos impedir que el paciente mienta, pero sí podemos evitar que su mentira se venga a casa con nosotros.

BIBLIOGRAFÍA

Alvenfors A, Velic M, Marklund B, Kylén S, Lingström P, Bernson J. «Difficult» dental patients: a grounded theory study of dental staff's experiences. BDJ Open. 2022;8:24.

Blinkhorn AS. Stress and the dental team: a qualitative investigation of the causes of stress in general dental practice. Dent Update. 1992;19(9):385-387.

Goetz K, Schuldei R, Steinhäuser J. Working conditions, job satisfaction and challenging encounters in dentistry: a cross-sectional study. Int Dent J. 2019;69(1):44-49.

Gorter RC, Albrecht G, Hoogstraten J, Eijkman MAJ. Work place characteristics, work stress and burnout among Dutch dentists. Eur J Oral Sci. 1998;106(6):999-1005.

Gorter RC, Freeman R. Burnout and engagement in relation with job demands and resources among dental staff in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol. 2011;39(1):87-95.

Hakanen JJ, Bakker AB, Demerouti E. How dentists cope with their job demands and stay engaged: the moderating role of job resources. Eur J Oral Sci. 2005;113(6):479-487.

Hakanen JJ, Schaufeli WB, Ahola K. The Job Demands-Resources model: a three-year cross--lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work Stress. 2008;22(3):224-241.

Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry. 2016;15(2):103-111.

Panagioti M, Panagopoulou E, Bower P, et al. Controlled interventions to reduce burnout in physicians: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2017;177(2):195-205.

Wilson RF, Coward PY, Capewell J, Laidler TL, Rigby AC, Shaw TJ. Perceived sources of occupational stress in general dental practitioners. Br Dent J. 1998;184(10):499-502.